ZDRAVÍ2030

STRATEGICKÉ ANALÝZY POTŘEB REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ

– Aktualizovaná verze KONCEPCE s vyhodnocením dosažených cílů k 1. 8. 2025



Praha, 1. srpna 2025

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚZIS ČR *Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR*
Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

STRATEGICKÉ ANALÝZY POTŘEB RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ: KONCEPCE PODLOŽENÁ DOSTUPNÝMI DATY

Aktualizovaná verze Koncepce s vyhodnocením dosažených cílů k 1. 8. 2025, Verze 2.0, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1. 8. 2025

Editoři

Válek Vlastimil, prof., MUDr. CSc., MBA, EBIR
Dušek Ladislav, prof., RNDr., Ph.D.

Kolektiv autorů (abecedně)

Bartůňková Markéta, Ing.
Blaha Milan, Ing. Ph.D.
Boráň Tomáš, MUDr.
Dušek Ladislav, prof., RNDr., Ph.D.
Dvořáček Jakub, Mgr.
Foltýn Petr, Bc.
Fošum Matyáš, Mgr.
Grygarová Kateřina, Mgr., Bc.
Hejduk Karel, PhDr.
Chloupková Renata, Mgr.
Jarkovský Jiří, RNDr., Ph.D.
Klimeš Daniel, RNDr., Ph.D.´
Klugar Miloslav, PhDr., Ph.D.
Komenda Martin, RNDr., Ph.D.
Macková Barbora, MUDr.
Májek Ondřej, RNDr., Ph.D.
Maříková Irena, MUDr., MBA
Michálek Jan Ing.
Ngo Ondřej, Mgr.
Pavlík Tomáš, RNDr., Ph.D.
Pláteník Václav, MA, MLL
Pokorná Andrea, prof., PhDr., Ph.D.
Policar Radek, JUDr.
Rögnerová Helena, Ing.
Rovný Daniel, Ing.
Slabý Ondřej, prof. RNDr., Ph.D.
Soukupová Jitka, RNDr.
Strnadová Alice, Mgr., MBA
Svobodová Ivana, Mgr.
Škampová Venuše, Ing., Mgr.
Těšitelová Vladimíra, JUDr., Mgr., LL.M.
Troch Tomáš, Mgr.
Válek Vlastimil, prof., MUDr. CSc., MBA, EBIS
Velík Jakub, PharmDr., Ph.D.
Zapletal Jan, Mgr.
Zvolský Miroslav, MUDr.

Mezinárodní recenzenti metodických materiálů NIKEZ

Prof. Holger J. Schünemann, Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact a Department of Medicine na McMaster University v Kanadě a na Humanitas University v italském Miláně
Prof. Zachary Munn, ředitel Health Evidence Synthesis, Recommendations and Impact (HESRI) na School of Public Health na University of Adelaide
Dr. Marge Reinap, Evidence for Policy, Evidence to Policy Development, Division of Country Health Policies and Systems, WHO Regional Office for Europe

Navržení recenzenti pro verzi 2.0 (abecedně)

Dvořák Vladimír, MUDr., Ph.D., předseda Rady poskytovatelů MZ ČR
Repko Martin, doc., MUDr., Ph.D., předseda Asociace děkanů lékařských fakult
Svačina Štěpán, prof., MUDr., DrSc., MBA, předseda ČLS JEP



https://nzip.cz/koncepce2025

Obsah

Obsah ... 3
Předmluva ... 6
Cíle a obsah předložené koncepce ... 7
Úvod ... 9
Obecné teze určující celkové zaměření Koncepce ... 12
Analýza současného stavu, determinanty budoucího vývoje a specifika České republiky ... 15
Kapitola I. Prevence a veřejné zdraví ... 20
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce ... 20
Koncepce primární prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví ... 22
Konsolidace a modernizace systému ochrany veřejného zdraví – zázemí pro plánování, koordinaci a kontrolu ... 25
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 ... 26
Kapitola II. Sekundární prevence a Národní screeningové centrum ... 35
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce ... 35
Koncepce sekundární prevence a zázemí pro plánování a rozvoj programů prevence v ČR 38
Dosažené výsledky Národního screeningového centra od roku 2022 ... 44
Plánované aktivity NSC v následujícím období ... 46
Realizované kroky a plnění cílů koncepce do roku 2025 ... 48
Kapitola III. Dostupnost, kvalita a standardizace péče ... 51
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce ... 51
Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) https://nikez.mzcr.cz/ ... 53
Nově implementovaný komplexní systém posilování a hodnocení kvality péče a bezpečí pacientů ... 54
Respekt k právům pacientů namísto přebujelé administrativy ... 57
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 ... 57
Kapitola IV. Modely organizace péče ... 60
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce ... 60
Vývoj a implementace systému CZ-DRG pro akutní lůžkovou péči v ČR ... 62
Nutná podpora dlouhodobé péče a komunitní ošetřovatelské péče ... 65
Nutné posílení systému péče o duševní zdraví ... 67
Nezbytné posílení sociálně-zdravotního pomezí ... 68
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 ... 69

Kapitola V. Ekonomika a optimalizace úhrad 74
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce 74
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 77
Kapitola VI. Léková politika 83
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce 83
Cenová a úhradová regulace léčivých přípravků 85
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 87
Kapitola VII. Zajištění personálních kapacit – kapacity a vzdělávání lékařů 95
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce 95
Realizované kroky a cíle koncepce do 8/2025 97
Závěr a shrnutí klíčových výsledků 104
Kapitola VIII. Zajištění personálních kapacit – kapacity a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 110
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce 110
Opatření realizovaná pro personální stabilizaci nelékařských zdravotnických profesí 113
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 126
Kapitola IX. Elektronizace zdravotnictví 128
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce 128
Dobudování infrastruktury eHealth a centrálních služeb 131
Poskytování dat a digitálních služeb občanům 133
..... 136
Interoperabilita poskytovatelů zdravotních služeb 140
Zvyšování kybernetické bezpečnosti 141
Digitální gramotnost a osvěta – vzdělávání v éře eHealth 141
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 142
Kapitola X. Legislativa a dotační politika jako nástroj změny 144
Analýza stávajícího stavu a východiska koncepce 144
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 148
Kapitola XI. Zdravotnický výzkum 153
Analýza stávajícího stavu a východiska koncepce 153
Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 155
Institucionální podpora pro výzkumné organizace MZ ČR 156
Účelová podpora zdravotnického výzkumu v ČR 157
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na období 2024–2030 159

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky 160
Evropská partnerství v oblasti zdraví 162
Národní autority v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu 162
Financování zdravotnického výzkumu 164
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 165
Kapitola XII. Komunikace 167
Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce 167
Národní zdravotnický informační systém (NZIS) 172
Národní zdravotnický informační portál (NZIP) 174
Systém syntetických dat NZIS 176
Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025 177
Vybrané literární zdroje 180

Předmluva

Vážené kolegyně a kolegové, zástupci odborné i laické veřejnosti,

dovoluji si vám s odstupem jednoho a půl roku předložit dokument „Strategické analýzy potřeb resortu zdravotnictví: koncepce podložená dostupnými daty“, tentokrát v aktualizované verzi s vyhodnocením dosažených cílů a jejich efektů.

Při dokončování původní verze dokumentu jsem v dubnu 2024 vyslovil přání, aby se Koncepce přeměnila v „živý“ dokument, který bude široce diskutován laickou i odbornou veřejností, a na základě podnětů bude doplňován a rozvíjen. To se skutečně stalo, a nejen formou písemně zaslaných připomínek čtenářů. Jednotlivé kapitoly Koncepce a jejich datové přílohy byly předneseny na desítkách konferencí a byly podkladem pro mnoho seminářů, kulatých stolů a v neposlední řadě i výukových materiálů. Zkušenosti a podněty z těchto interakcí jsou v nově aktualizované verzi plně zohledněny.

Každá kapitola vedle analýz výchozího stavu nyní obsahuje výčet již realizovaných kroků a dosažených cílů k 1. 8. 2025, doplněný o aktualizované datové podklady. Tak jako ve verzi 1.0, dokument zcela záměrně neřeší jednotlivé obory zdravotní péče, pokud neslouží jako ilustrace širších a systémových problémů k řešení. Cílem Koncepce bylo zejména nastavit jasný plán a harmonogram pro klíčová opatření a zdůvodnit jejich potřebu a význam exaktními daty.

Výčet již splněných cílů nebo dosud realizovaných opatření by byl velmi dlouhý a čtenáři jej najdou na konci každé aktualizované kapitoly. Těší mně, že nejde o nějaký konečný seznam kroků splněné a ukončené mise, neboť tato práce nikdy neskončí. Každá kapitola opět kriticky zdůrazňuje přetrvávající nedostatky a slabá místa v systému organizace péče a nastavuje další cíle pro nadcházející období. Věřím, že se takto podařilo vytvořit životaschopný dokument, který je přijímám jako apolitický a odborný nástroj pro zlepšování dostupnosti a kvality péče. To je moje vize řízení a rozvoje zdravotnictví, kterou jsem po celou dobu svého mandátu jako ministr ctil. Podporoval jsem a dále rozvíjel životaschopné projekty svých předchůdců a věřím, že řada námi dosažených cílů bude takto podporována i v budoucnu.

Právě z pohledu dlouhodobé udržitelnosti provedených změn a implementovaných opatření jsou zřejmě nejdůležitější agendy, které se v průběhu plnění Koncepce podařilo úspěšně institucionalizovat. Zmínil bych zejména ustavení Rady Vlády ČR pro veřejné zdraví, řádně ukotvené a Vládou ČR schválené Národní screeningové centrum a zejména od roku 2023 plně funkční Národní institut kvality a excelence zdravotnictví neboli NIKEZ. Činnosti NIKEZ je v aktualizované koncepci věnován významný prostor, neboť jde o těleso, které řadu agend významně propojuje a také celou misi internacionalizuje.

Vážené kolegyně a kolegové, předmluvu k úvodní verzi Koncepce jsem končil rčením, že zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme. A že to samé platí o českém zdravotnictví. Dnes jsem o tom přesvědčen ještě mnohem více, ale také jsem si jistý, že jsme české zdravotnictví neztratili a neztratíme. Pevně věřím, že předložená koncepce nám v tom pomůže. Přeji příjemné čtení a opět se těším na zpětnou vazbu!

Jménem kolektivu autorů,

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví

Cíle a obsah předložené koncepce

Cílem této publikace je předložit analyticky podložený rozbor stavu českého zdravotnictví v kapitolách zásadních pro jeho udržitelnost a další rozvoj. Aktualizovaná verze vyhodnocuje v rámci každé kapitoly cíle stanovené v období 2022–2023 do roku 2025 a na konkrétních datech dokládá současný stav. Oproti první verzi publikace z dubna 2024 je počet kapitol vyšší, větší důraz je kladen na systém ochrany veřejného zdraví (kapitola 1) a nově je detailně zpracován systém organizace zdravotnického výzkumu (kapitola 11).

Analytická část jednotlivých kapitol je pojata stručně a nesměřuje ke komplexnímu podchycení všech aspektů dané problematiky, spíše se zaměřuje na identifikaci slabých míst a potenciálních rizik. V návaznosti na to je v každé kapitole doplněn výčet konkrétních kroků a realizovaných opatření dle původního plánu do roku 2025. Na závěr každé kapitoly je stručně shrnut dosažený stav a výsledky za hodnocené období 2022–2025, případně další cíle na nadcházející období.

Obsah dokumentu je členěn do následujících kapitol:

- **Kapitola I. Prevence a ochrana veřejného zdraví**
  - Důraz na zlepšení zdravotního stavu populace, podpora prevence ve všech jejích formách, podpora zdravotní gramotnosti
- **Kapitola II. Sekundární prevence a Národní screeningové centrum**
  - Programy sekundární prevence, organizované populační programy screeningu – hodnocení jejich výkonnosti, kvality
- **Kapitola III. Dostupnost, kvalita a standardizace péče**
  - Zásadní krok k posílení kvality péče: ustavení Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ)
- **Kapitola IV. Modely organizace péče.**
  - Optimalizace struktury sítě lůžkových zařízení, zvládnutelná míra centralizace. Podpora dlouhodobé a ošetřovatelské péče.
- **Kapitola V. Ekonomika a optimalizace úhrad**
  - Optimalizace systému úhrad a důsledné využívání nového systému CZ-DRG v akutní lůžkové péči
- **Kapitola VI. Léková politika**
  - Zajištění dostupnosti léčiv, cenová a úhradová regulace léčivých přípravků
- **Kapitola VII. Zajištění personálních kapacit**
  - Kapacity a vzdělávání lékařů
- **Kapitola VIII. Zajištění personálních kapacit**
  - Kapacity a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
- **Kapitola IX. Elektronizace**
  - Koncepce, harmonogram a průběžné výsledky budování systému eHealth
- **Kapitola X. Legislativa a dotační politika**
  - Legislativa a dotační politika jako nástroj změny

- **Kapitola XI. Zdravotnický výzkum**
    - Koncepce organizace, financování a hodnocení zdravotnického výzkumu v ČR
- **Kapitola XII. Komunikace**
    - Dostupnost informací pro občany, posílení zdravotní gramotnosti, koncepce otevírání dat a její výstupy

Ve výše uvedeném přehledu kapitol má relativně zvláštní postavení kapitola č. 3, která mimo jiné shrnuje ustavení zcela nového Národního institutu kvality a excelence ve zdravotnictví (NIKEZ). Aktivity a programové cíle NIKEZ jsou přehledně rozděleny do kapitol s kvartálním harmonogramem plnění až do roku 2025. V tomto smyslu je NIKEZ tělesem, které z velké části koordinuje plnění cílů celé strategie a primárně se zaměřuje na udržitelnost plně dostupných a kvalitních zdravotních služeb v ČR. NIKEZ byl ustaven rozhodnutím ministra zdravotnictví dne 19. 1. 2023 za účelem zabezpečení činností souvisejících s řízením a hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. NIKEZ pracuje v rámci řídících struktur Ministerstva zdravotnictví ČR jako vývojové a metodické centrum, jehož primární činností je optimalizace, rozvoj a zajištění udržitelnosti národního systému posilování a hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Více informací, včetně programových cílů NIKEZ a jejich průběžné plnění lze nalézt na portálu **https://nikez.mzcr.cz.**

Předložený dokument je doplněn řadou datových a analytických příloh, které jsou publikované v plně dostupné formě na portálu: **https://nzip.cz/koncepce2025.** Formát elektronické publikace umožní snadnou a potřebnou aktualizaci analytických podkladů a rovněž flexibilní zpravodajství o již splněných cílech a dosažených výstupech. Každá sekce (kapitola) zmíněného portálu nadto umožňuje interaktivní zadávání podnětů a námětů od čtenářů a uživatelů, čímž se strategie hlásí k otevřené odborné diskuzi a případnému průběžnému doplňování.

Úvod

https://nzip.cz/koncepce2025#uvod



Aktualizovaná verze koncepce obsahuje 12 kapitol s ambicí pokrýt všechny zásadní dimenze determinující dostupnost, výkonnost, kvalitu a nákladovou efektivitu zdravotních služeb. Každá kapitola je nově zakončena vyhodnocením cílů stanovených po roce 2022 a vymezení dalších dílčích cílů minimálně do konce roku 2025. Koncepce kapitol důsledně dbá na doložení všech faktů a efektů přijatých opatření formou datových a analytických příloh. U nově vybudovaných institucionálních subjektů (zejména Národní institut kvality a excelence zdravotnictví – NIKEZ, Rada vlády pro veřejné zdraví, Národní screeningové centrum – NSC) jsou doloženy i cíle a dosavadní výsledky činnosti.

Zásadním cílem a klíčovým prvkem Koncepce zůstává zajištění dostupnosti a kvality péče jako garance stability systému.

Aktualizovaná verze Koncepce dokládá, že postupnou implementací navržených opatření ve všech hlavních oblastech koncepce již je dosaženo a nadále bude dosahováno zlepšení dostupnosti a kvality péče. Dostupnost a kvalita přitom představují vzájemně propojené a neoddělitelné dimenze funkčního a efektivního systému zdravotních služeb. Dostupností péče se v předložené koncepci nemyslí pouze místní či časová dostupnost určitého místa poskytování služeb, ale také včasnost poskytnutí správné péče na místě k tomu řádně vybaveném a určeném. Jde tedy o naplnění požadavku na „**včasné poskytnutí péče pacientovi ve správný čas a na správném místě**“. Ke slovu „včasné“, resp. lépe ke spojení „včasná diagnostika“ se váže i velký prostor, který je věnován prevenci, zdravotní gramotnosti a programům screeningu (**kapitoly 1 a 2**). V této oblasti se podařilo nejen udržet a zkvalitnit již dlouhodobě běžící programy, ale úspěšně zavést i řadu nových preventivních opatření a programů, včetně plošných organizovaných screeningů.

K posílení dostupnosti a kvality péče přímo či nepřímo směřuje většina kapitol Koncepce s v nich popsaných a vyhodnocených realizovaných opatření. Mezi nejdůležitější nepochybně patří:

- **Implementace komplexního systému hodnocení kvality péče** od interního hodnocení na úrovni samotných poskytovatelů, přes opatření standardizující obsah péče až po externí, na datech založené, hodnocení indikátorů (**kapitola 3** koncepce: programové cíle Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví).

    - **Hlavní přínos pro pacienty:** státem garantovaný, plně transparentní, systém kontroly kvality a dostupnosti péče, doplněný pravidelně publikovanými výsledky. Snadný přístup k datům o dostupností určitého typu péče a o výsledcích kontrol kvality.
- **Nový, centrálně garantovaný, systém tvorby, aktualizací a implementace doporučených postupů (DP) a operativních doporučení (OD)** jako zásadní opatření k standardizaci obsahu diagnostických a léčebných postupů (**kapitola 3** koncepce: dosud chybějící metodika, centrální evidence a systém kontroly DP/OD).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** definované diagnostické a léčebné postupy s garancí relevantních odborností a ministerstva zdravotnictví, snadno dostupné i v podobě srozumitelné pro laickou veřejnost. Definované postupy určující optimální dostupnost péče, případně optimální trajektorii pacienta v systému a s tím související nároky na péči v určeném rozsahu.
- **Postupná restrukturalizace sítě poskytovatelů** s cílem zvýšit dostupnost relevantních služeb pro demograficky stárnoucí populaci, posílit jednodenní péči, dlouhodobou ošetřovatelskou péči a komunitní ošetřovatelské služby (**kapitola 4** koncepce: nové modely organizace péče, příprava na populační změny a měnící se potřeby pacientů).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** zlepšení dostupnosti vysoce efektivní a žádané chirurgické péče v jednodenních režimu, zlepšení dostupnosti ošetřovatelských služeb včetně posílení sociálně-zdravotního pomezí.
- **Implementace komplexních modelů organizace péče, integrujících více na sebe navazujících kroků a segmentů péče** – např. včasnost diagnostiky a následné akutní péče u závažných stavů, posílení dostupnosti a vzájemné návaznosti ambulantní péče primární a specializované, modely organizace dlouhodobé péče či péče v závěru života apod. (**kapitoly 2 až 5** koncepce: integrované modely organizace péče a jejich úhradové krytí).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** lepší „prostupnost“ systému zdravotních služeb, zkrácení čekacích lhůt na vyšetření a výkony, zlepšená dostupnost péče o dlouhodobě nemocné, zajištěná s respektem k specifickým podmínkám jednotlivých regionů.
- **Nové metodické postupy pro účinnou a kontrolovatelnou centralizaci vysoce specializované péče** a pro úhradovou bonifikaci nově definovaných „center excelence“ (**kapitola 5** koncepce: nová metodika centralizace péče, včetně relevantních úhradových mechanismů).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** státem garantovaná dostupnost nákladné a vysoce specializované péče na vysoce erudovaných, motivovaných a dobře vybavených pracovištích. Garance „neodmítnutí“ péče indikovanému pacientovi.
- **Zlepšení dostupnosti léčiv a zdravotnických pomůcek**, včasná informovanost občanů a poskytovatelů o problémech s dostupností (**kapitoly 5 a 6** koncepce: technická i legislativní opatření včetně zajištění dostupnosti vysoce inovativních, „centrových“ léků a léků pro vzácná onemocnění).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** zlepšení dostupnosti léků a zdravotnických prostředků, včasná informovanost při plošných výpadcích včetně řešení alternativními léky a postupy.

- **Zajištění potřebných personálních kapacit a personální stabilizace systému** zdravotních a zdravotně sociálních služeb (**kapitoly 7 a 8** koncepce: posílení kapacit vzdělavatelů lékařů i NLZP, zlepšení průchodnosti systémem vzdělávání, důraz na posílení personálních kapacit v ohrožených profesních skupinách).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** zvýšení dostupnosti péče ve smyslu jejího personálního zajištění (aktuálně např. v segmentu registrujících dětských lékařů, dětské psychiatrie apod.), zkrácení čekacích lhůt.
- **Posílení informovanosti pacientů cestou elektronizace** a s ní spojených nástrojů (**kapitola 9** koncepce: vývoj nových aplikací a nástrojů usnadňujících přístup pacienta k datům o jeho zdraví, konzumaci služeb, dostupnosti služeb apod.).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** EZKarta jako zcela nová aplikace přístupu k elektronickému zdravotnictví a k elektronické zdravotní dokumentaci pacienta, elektronické nástroje umožňující centrální objednávání na preventivní a jiná vyšetření apod.
- **Legislativní změny posilující roli zdravotních pojišťoven a postavení pacienta v systému**, nové úhradové mechanismy a změny (**kapitola 10** koncepce: redefinice vztahu pojišťovna – poskytovatel, pojišťovna – pacient s cílem usnadnit klíčové reformy systému a zlepšit komfort pacientů).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** snadná dostupnost informací o stavu sítě a efektivní řešení při nedostatku určitých služeb pro pacienty ze strany zdravotních pojišťoven, individuální účty pojištěnce s bonifikací za účast v preventivních programech a za odpovědný přístup k vlastnímu zdraví, posílení vztahu pacient – pojišťovna.
- **Posílení zdravotní gramotnosti a informovanosti široké veřejnosti cestou vývoje centrálně garantovaných informačních nástrojů**, včetně map poskytovatelů s atributy reálné dostupnosti služeb (**kapitoly 1 a 12** koncepce: nové nástroje pro informování široké veřejnosti, systémy otevírání a sdílení zdravotních dat apod.).
    - **Hlavní přínos pro pacienty:** plně dostupná data o reálné dostupnosti a kapacitách poskytovatelů, včetně hodnocení jejich výsledků a kvality péče, státem odborně garantované zdravotní informace na Národním zdravotnickém informačním portále.

Pokud má pacient problémy se zajištěním dostupnosti péče, nadále se poměrně často obrací namísto na zdravotní pojišťovnu např. na municipality či přímo stát. Přestože v tomto ohledu dochází k postupnému zlepšování povědomí veřejnosti, je nezbytné, aby role zdravotních pojišťoven spočívající v povinnosti zajištění péče byla dále zdůrazňována a posilována. To se týká i budování sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, která je mnohdy nerovnoměrná a zhoršuje tak přístup pacientů k potřebné péči. Jedním z již vyvinutých, otestovaných a implementovaných nástrojů, o který Koncepce opírá řešení v této oblasti, je co nejširší zpřístupnění relevantních dat a informací široké veřejnosti (kapitoly 2, 9 a 12 koncepce). V zásadě jsou v této oblasti nově implementovány tři základní přístupy a s nimi spojené reálné nástroje. Všechny tři přístupy jsou plně funkční a jejich další vývoj bude pokračovat:

- **Individualizovaný a vysoce zabezpečený přístup občanů k vlastním zdravotním záznamům** a s tím spojená případná notifikace nebo možnost objednávání se na vyšetření. Informovanost občanů. Nositelem této modality je centrálně vyvinutá aplikace EZKarta, která již v současnosti takto zpřístupňuje data o očkování, preventivních prohlídkách a zapojení ve screeningových vyšetřeních.
- **Plošné otevření relevantních dat** o dostupnosti péče, čekacích lhůtách na vyšetření, výkonnosti a kvalitě poskytovatelů. Nositelem této modality je Národní zdravotnický informační portál (nzip.cz), na kterém jsou již dnes plně dostupná data o kvalitě a výkonnosti poskytovatelů v různých segmentech péče (např. porodnictví, počty chirurgických výkonů v akutní péči apod.)
- **Srozumitelné zpřístupnění informací o standardizovaných doporučených postupech pacientům.** Tuto agendu nově zavedl Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) na základě široce mezinárodně recenzované metodiky.

Obecné teze určující celkové zaměření Koncepce

Všechny veřejné systémy vyspělých států hledají co nejlepší organizační strukturu a finanční modely, které by umožnily nasměrovat minimálně 7–10 % HDP do zdravotnických a zdravotně sociálních služeb. Uplatněné principy a efektivní postupy se mohou v jednotlivých zemích značně lišit, přestože většina systémů zdravotní péče spadá do jedné ze dvou širokých kategorií, a to buď Bismarckův nebo Beveridgeův systém.

Bismarckův model (např. Německo, Francie, Japonsko) zdravotní péče je historicky nejstarším zdravotnickým systémem, založeným na veřejném a povinném zdravotním pojištění, kterým je uplatňován plošný princip vzájemné solidarity pojištěnců. Jde o pojištění z velké části nezávislé na základním daňovém systému. Provádí jej neziskové organizace (zdravotní pojišťovny) na základě smluv s poskytovateli zdravotních služeb z veřejného nebo soukromého sektoru. Zejména v evropských zemích je pravidlem státní garance za zdravotní péči pro všechny obyvatele, existuje zde velké množství pojišťovacích organizací, které jsou nezávislé na poskytovatelích zdravotní péče. Často zmiňovanou výhodou je relativně vysoká kvalita poskytované péče, která je ale spojena s vyšší cenou, jejímž důsledkem naopak může být snížená dostupnost péče pro některé skupiny obyvatelstva z finančních důvodů.

Beveridgeův model (např. Spojené království, Španělsko) zdravotní péče je postavený na financování a poskytování péče v rámci jednoho organizačního systému, tj. financující orgány a poskytovatelé jsou zcela nebo částečně sdruženy v rámci jedné organizace. Jde o centrálně řízený systém, který je příjmově součástí daňového systému a jeho přímou součástí jsou i poskytovatelé zdravotní péče. Tento systém tzv. národní zdravotní služby klade důraz na individuální odpovědnost občanů, zdravotní péče nemusí být garantována plošně pro všechny, ale formou státních zdravotních programů pro vybrané sociální skupiny (seniory, sociálně slabé skupiny apod.). Fakticky se jedná o centralizované státní zdravotnictví.

Neexistuje sice žádný jednoduchý ideální model organizace zdravotnických služeb, ale většina zdravotnických systémů, které se řídí Beveridgeovým modelem zdravotní péče, si vede špatně. Náklady tohoto systému jsou většinou poměrně nízké a často formálně nabízí širokou

dostupnost pro všechny účastníky. Zdravotní služby ale mají nezřídka nízkou kvalitu nebo je na jejich čerpání potřeba značná čekací doba. Nicméně i Bismarckův systém má řadu nevýhod, mimo jiné vysoké náklady na administraci a management systému či obtížně optimalizované vztahy mezi pacienty, poskytovateli a pojišťovnami. Oba modely organizace péče ale spojuje vysoká závislost na výběru daní a na efektivitě jejich přerozdělování.

V České republice byl bohužel nastavením z 90. let minulého století zaveden systém, který je neoptimální kombinaci obou systémů. Systém ČR byl v 90. letech koncipován primárně jako Bismarckův (pluralita zdravotních pojišťoven, relativní nezávislost na poskytovatelích zdravotních služeb, financování mimo základní daňový systém) s prvky modelu Beveridgeova (nárok pojištěnce a výše úhrad definovány státem, stát ovládá největší zdravotní pojišťovnu i největší poskytovatele zdravotních služeb). Přestože doposud tato kombinace vykazuje v mezinárodním srovnání relativně dobrou efektivitu, je stále více zřejmé, že postupně naráží na vlastní limity spočívající v obtížné ekonomické udržitelnosti a s tím spojeném zhoršování dostupnosti hrazené zdravotní péče. Většina opatření přijatých v této koncepci směřuje k odstranění tohoto nevyhovujícího nastavení a k posílení mechanismů nutných pro dlouhodobou udržitelnost vysoce solidárního systému veřejného zdravotního pojištění.

Systém zdravotní péče musí být citlivý, efektivní a dostatečně výkonný. Nesmí postrádat tzv. SMART cíle, tedy cíle specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické, časově specifické. Systémy veřejné zdravotní péče jsou v jistém smyslu velmi konkrétní reprezentací toho, co „sociální Evropa“ ztělesňuje: univerzálnost, solidaritu, blahobyt a inkluzivnost. Když se Evropa na počátku 90. let 20. století posunula směrem k větší politické integraci, mnozí doufali, že princip solidarity, který formoval mnoho národních systémů zdravotní péče, by mohl být začleněn do celoevropského schématu robustní veřejné zdravotní péče. Avšak taková míra formální integrace by vyžadovala významnou, až heroickou a pravděpodobně nedosažitelnou, míru institucionální a politické reformy. Namísto toho historická trajektorie zdravotnických systémů jednotlivých států vedla k řadě různých modelů financování, poskytování a regulace péče.

Vzhledem k tomu, že zdravotnické systémy mnoha členských států Evropské unie jsou podstatnou součástí jejich veřejného sektoru (a často i jejich veřejné kultury), jsou chaoticky zapleteny do širších otázek národní suverenity. Zatímco vize integrujícího evropského systému zdravotní péče byla široce podporována na abstraktní úrovni, ve skutečnosti se státy odmítaly vzdát kontroly nad svými zdravotnickými systémy. Vítězily obavy, že „europeizace“ zdravotnictví by mohla vyústit v systém, který by se neopíral o solidaritu, ale o liberalizaci a neúprosný tah tržních sil. V důsledku toho byl učiněn jen slabý pokus o přímou harmonizaci národních systémů zdravotní péče. Systémy zdravotní péče členských států zůstávají formálně pod vnitrostátní, nikoli unijní, jurisdikcí a artikulace „sociální Evropy“ v oblasti zdravotní politiky se proto jeví jako poměrně omezené téma k diskusi. Proto je nutné sledovat a hodnotit osvědčené postupy a zavádět je do českého systému zdravotní péče po vzoru zemí s nejlepšími systémy. K tomuto cíli bude napomáhat svou činností Národní institut kvality a excelence zdravotnictví, který i přes krátkou dobu své existence dokázal svoji činnost významně provázat s klíčovými mezinárodními institucemi.

Stárnutí populace povede ke změnám v kategoriích pojištěnců, kdy se bude dále zvyšovat počet těch osob, za něž odvádí pojistné na zdravotní pojištění stát (tzv. státní pojištěnci), a naopak

bude stagnovat počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, které se již v současnosti na financování systému podílí téměř 70 % jeho celkových příjmů. S ohledem na demografický vývoj lze přitom očekávat, že poměr osob ekonomicky aktivních se bude oproti tzv. státním pojištěncům, kteří naopak čerpají s ohledem na objektivní skutečnosti (starobní důchodci, invalidní důchodci, děti včetně novorozenců) více péče, nadále snižovat. Bez přijetí potřebných opatření včetně legislativních změn povede tato situace nutně k vyčerpání zdrojů zdravotního pojištění.

S postupujícím demografickým stárnutím populace je tak zejména nutné posilovat princip solidarity, kdy každý občan přispívá do základního fondu veřejného zdravotního pojištění dle stanoveného podílu z vyměřovacího základu a zdravotní péči čerpá dle svých potřeb. Stěžejním cílem pro další dekádu bude udržení všeobecné dostupnosti péče. Pacienti budou stále více nárokovat péči od lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotní péče, kteří jsou přidruženi ke zdravotnickému systému. Nepochybně musíme v dalších dekádách počítat s významným nárůstem zdravotních potřeb v důsledku demografického stárnutí populace a nárůstu nemocnosti. Přesto stále víme jen velmi málo o tom, jak zlepšit výkonnost zdravotnického systému. Možné jsou dva principiální směry postupu:

- Za prvé lze pokračovat v odklonu od plateb za služby směrem ke kapitaci nebo, což je její „chudý bratranec“, ke sdíleným úsporám. Nelze ale očekávat, že zdravotnické systémy budou samy od sebe usilovně pracovat na optimalizaci nabídky nemocničních lůžek nebo úzce odborně zaměřených a orientovaných lékařů, pokud jsou tyto segmenty příjmovými středisky, nikoli nákladovými středisky. Optimalizace totiž nevyhnutelně znamená průběžnou restrukturalizaci sítě poskytovatelů, spojenou i se snižováním nabídky v méně potřebných segmentech péče. Obdobně platí, že investice do aktivit, které dlouhodobě zlepšují zdraví populace, mají jen malou hodnotu, když se péče hradí primárně na základě centrálně stanoveného poplatku za službu a finančně se uzavírá ke konci každého kalendářního roku. Nejen z těchto důvodů je strategie spoléhající na „vnitřní“ kultivaci zdravotnických systémů bez vnějších analýz a tlaku spíše iluzorní. Zejména ve světě, jemuž stále více dominují rozsáhlé celonárodní zdravotnické systémy, je absence mechanismů vnější kontroly a odpovědnosti velmi nebezpečnou cestou.
- Za druhé lze systémy pozvolna kultivovat k vyšší efektivitě pomocí analýz a benchmarkingu. To znamená systematicky připravovat výroční zprávy o výkonnosti systému zdravotní péče s informacemi o celkových nákladech na péči, o výsledcích a kvalitě, ale také o rozdílech v péči a její dostupnosti pro znevýhodněné skupiny. Omezení naší schopnosti měřit to, na čem záleží, a následně přizpůsobit výsledky riziku tak, abychom neomezili péči sloužící sociálně znevýhodněným skupinám, by nás mělo vést k obezřetnosti při používání tohoto hodnocení k přímočaré úpravě plateb. Používání silných pobídek k odměňování výkonu je velmi nebezpečné, když výkon, který lze měřit, je jen malou podmnožinou výkonu, na kterém lidem záleží. Přesto na analýzy tohoto typu nelze rezignovat, neboť mají značný motivační a kultivující potenciál. Žádný zdravotnický systém nebude chtít být na spodních příčkách srovnávacích hodnocení, a i bez platebních pobídek budou systémy pracovat na zlepšení svého postavení. Pokud například měříme a vykazujeme rozdíly v péči a výsledcích v rámci zdravotnických

systémů, zdá se pravděpodobné, že systémy budou pracovat na snižování rozdílů. Bude ovšem zapotřebí mnohem vyšší úrovně veřejných investic do měření a zlepšování výkonnosti, aby se využil potenciál, který umožňuje rostoucí dominance zdravotnických systémů.

Hodnocení stability, kvality a efektivnosti systémů zdravotní péče je založeno na ukazatelích týkajících se financí, lidských zdrojů, dostupnosti a kvality zdravotnických služeb. Všechny tyto faktory jsou klíčovými komponentami určujícími stabilitu systému zdravotní péče. Jejich hodnota určuje efektivitu fungování systému a následně i úroveň zabezpečení občanů zdravotními službami.

Lze shrnout, že systém zdravotní péče v každé zemi by měl být přizpůsoben tak, aby vyhovoval současným zdravotním potřebám dané společnosti a aby byl připraven na změny a vývoj potřeb v střednědobém časovém horizontu. Financování systému by mělo pocházet z mnoha zdrojů, a to jak ve formě veřejných, tak soukromých vstupů. Poměr veřejných a soukromých výdajů by měl být koncipován tak, aby nezhoršoval dostupnost potřebné péče pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, neboť její odkládání vede nezřídka ke zhoršování zdravotního stavu pacienta a následnému navýšení výdajů systému na řešení mnohem závažnějšího zdravotního stavu. Důležitými prvky systému vždy bude nemocniční infrastruktura (zejména počet lůžek) a také počet, dostupnost a reálná úvazková kapacita zdravotnického personálu. Predikovaný rostoucí nedostatek počtu zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších výzev, kterým čelí subjekty s rozhodovací pravomocí ve zdravotnických systémech většiny zemí světa. Zejména na systému vzdělávání zdravotnických profesionálů a opatřeních k personální stabilizaci služeb lze demonstrovat, že správné fungování systému vyžaduje velmi komplexní opatření a spolupráci více resortů a mnoha institucí.

Z těchto důvodů nelze zde předloženou koncepci rozvoje zdravotní péče v ČR vnímat pouze jako resortní dokument. Ve skutečnosti tyto analýzy v mnoha směrech přesahují hranice resortu zdravotnictví a usilují o iniciaci a rozvoj meziresortní spolupráce. Jako příklad lze uvést opatření směřující k personální stabilizaci zdravotnického systému, na kterých se nevyhnutelně musí podílet i systém vzdělávání, motivační pobídky pro zdravotníky od krajských a regionálních samospráv a samozřejmě také zdravotní pojišťovny. Strategie rovněž předkládá zcela novou koncepci daty podložené spolupráce resortu zdravotnictví a resortu práce a sociálních věcí. Spolupráci mnoha institucí vyžadují v podstatě všechna navržená opatření směřující k dlouhodobé udržitelnosti vysoké kvality a dostupnost zdravotních služeb.

Analýza současného stavu, determinanty budoucího vývoje a specifika České republiky

Vybrané analytické studie k této problematice jsou přílohami č. 1 až 4 této úvodní kapitoly. Tyto studie přinášejí jeden v ČR zcela nový, velmi podstatný, rozměr – dokládají v letech 2022 až 2025 dosažené plné propojení dat resortů MZD a MPSV. Velmi slabá provázanost a prostupnost sociálně – zdravotního pomezí a v této oblasti zcela chybějící reprezentativní data byly faktory, které v minulosti zásadně limitovaly efektivní plánování kapacit a zajištění komplexní dostupnosti sociálně zdravotní péče. Posledních 30 let neměla Česká republika

ambici oba odpovědné resorty ke spolupráci a sdílení dat přivést a taková data mít. Přiložené analýzy jsou dokladem, že tato situace je minulostí a propojená data obou resortů již slouží svému účelu.

V dokumentu předložené aktualizované analýzy a návrhy opatření vycházejí především z dlouhodobé koncepce určené metodickými materiály a cíli programu „Zdraví 2030“, dále ze srovnávacích studií WHO, OECD a také z detailních analytických materiálů některých zemí EU. K reformám financování zdravotnictví a změnám ve fungování systému totiž přistupuje většina evropských zemí a aplikované přístupy jsou do značné míry obdobné. Je k tomu řada objektivních důvodů, které odhalila v plné nahotě pandemie COVID-19. Pokud chceme zabránit tzv. amerikanizaci zdravotnictví, pak je to bez zásadních změn fungování systému nemožné. Cílem je udržet pro všechny občany dostupnou a kvalitní péči, zajistit pro ně primární péči a bezbariérový přístup ke všem zdravotním a preventivním programům.

Klíčovými determinanty budoucího vývoje českého zdravotnictví jsou zejména:

- Stárnutí populace
    - Česká populace, stejně jako evropská populace, stárne. V následujících dvou dekádách musíme počítat s vývojem, kdy se počet obyvatel ve velmi pokročilém věku (80+) až zdvojnásobí. Stárnoucí populace vyžaduje posílení geriatrické péče a následné péče, narůstá význam dlouhodobé ošetřovatelské péče, pokud možno co nejvíce dostupné v přirozeném sociálním prostředí pacientů. To obecně znamená více lůžek následné péče a méně lůžek akutní péče, posilování komunitních ošetřovatelských a sociálně zdravotních služeb. Situace se začne rapidně zhoršovat od roku 2030, do té doby se změně situace musí přizpůsobit struktura části lůžkového fondu a včetně podpory geriatrické péče, musí dojít k razantnímu posílení kapacit dlouhodobé ošetřovatelské péče. Velmi významnou komponentou systému zdravotních služeb musí být funkční a kapacitně dobře připravené segmenty přednemocniční péče a péče v závěru života u chronických pacientů.
- Zdravotní stav populace
    - Zdravotní stav české populace není dobrý, což nevyhnutelně navyšuje přímé i nepřímé náklady veřejného zdravotního pojištění a systémů sociální podpory. Dlouhodobě i v mezinárodním srovnání evidujeme zkrácenou dobu života ve zdraví, zejména u mužů, dále vysoký podíl předčasných úmrtí (včetně úmrtí na preventabilní choroby) a vysokou zátěž chronickými nemocemi, jejichž prevalence začíná významně narůstat již v populačních skupinách ve věku 45+. Tento stav je výzvou k posilování prevence ve všech jejích formách, s důrazem na prevenci primární a na programy včasného záchytu vážných onemocnění. Rovněž je nezbytné investovat do posilování zdravotní gramotnosti obyvatel, a to již u dětí předškolního věku.
- Personální kapacity
    - K ošetření pacientů bude třeba stále více zdravotníků, zejména v dosud poněkud opomíjených segmentech péče. Moderní technologie, personalizovaná medicína a nové terapeutické postupy tento problém výrazně

prohloubily. Posunula se též pozice tzv. rodinných lékařů, kdy lékař pro stanovení diagnózy potřebuje stále lepší a složitější technické a laboratorní vybavení. Tím pádem dochází ke vzniku tzv. sdružených praxí, rozvíjí se jednodenní péče a celý systém zdravotních služeb se produkcí postupně posouvá k jiným segmentům než akutní lůžková péče. Na to musí reagovat postupná restrukturalizační opatření, programy posilování kapacity škol vzdělávajících zdravotníky a implementace komplexních systémů integrované a dlouhodobé péče.

- Ekonomické aspekty
    - Rozvoj diagnostických a léčebných technologií nevyhnutelně zvyšuje náklady zdravotních služeb. Na to musí reagovat systém veřejného zdravotního pojištění všemi dostupnými mechanismy, jejichž cílem musí být zlepšování zdravotního stavu obyvatel (např. bonifikace pojištěnců zapojených do prevence, zvyšování efektivity systému, centralizace péče, optimalizace trajektorií pacientů systémem) a také tlakem na snižování jednotkových nákladů léčby. V opačném případě je vážně ohrožena finanční udržitelnost solidárního systému služeb. Příkladem může být rozvoj segmentu personalizované medicíny, kde se s nástupem nových generací léků výrazně zdražuje léčba. To se týká nákladů jednak na tzv. centrovou léčbu, které v posledních deseti letech začaly exponenciálně narůstat, a také nákladů na léčbu vzácných onemocnění. Jen v posledním roce přibylo více než 100 nových molekul, které vedou k léčebným postupům s jednotkovou cenou vyšší než 100 milionů korun.
    - Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat vztahu vstupu nových technologií a léčivých přípravků, které mají potenciál nahradit dosavadní méně účinnou či finančně nákladnější léčbu. Z dosavadních zkušeností plyne, že investice do nových přístupů nepřináší automaticky úsporu v jiné části systému. Např. podpora jednodenní chirurgie či domácí péče nevedou k signifikantním úsporám v akutní či následné lůžkové péči, pokud oba systémy nekoordinovaně fungují vedle sebe a dokonce jsou ve vzájemné kompetici. V budoucnu bude ale zcela nezbytné, aby nastavení úhradových mechanismů rychle reagovalo na tyto inovace, např. velmi slibné výsledky ve výzkumu léčivých přípravků na Alzheimerovu chorobu mohou znamenat významné úspory v následné péči o pacienty s tímto onemocněním. S tím ovšem přichází silný apel k implementaci integrovaných modelů péče optimalizujících návaznost různých segmentů služeb a nastavujících nejlepší možnou trajektorii pacienta v systému.
- Zdravotní péče obecně bude čím dál více integrovaná a provázaná, zdravotně-sociální péče, paliativní péče a primární péče v kombinaci se změnami v elektronizaci zdravotnictví umožní poskytování služeb ve vzájemném souladu a zároveň umožní redukci péče s nízkou přidanou hodnotou.
- Struktura příjmů a stabilita zdravotnického systému
    - Stárnutí populace bude nevyhnutelně navyšovat počet tzv. státních pojištěnců, tedy občanů, kteří nepřispívají do veřejného zdravotního pojištění a péči za ně platí stát přerozdělením daní. V ČR je to v současné době téměř 60 % obyvatel, kteří zdravotní pojištění neplatí, ale péči čerpají. Péči tak přímo či nepřímo

financuje v rámci solidárních zdravotního pojištění zbývajících 40 % obyvatel. Počet i populační podíl státních pojištěnců přitom v následujících dvou dekádách významně naroste. Proto, aby nedošlo ke zhroucení solidárního „Bismarckova“ systému zdravotního pojištění, jsou nutné zásadní reformy.

- Současně v Evropě narůstá počet zdravotníků, především lékařů, kteří nemají zájem vstupovat do systému zdravotního pojištění, tedy mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale dávají přednost platbám od pacientů v hotovosti. V některých oborech je tento trend již naprosto běžný (estetická chirurgie, částečně stomatologie). Obecně rovněž platí, že mladí zdravotníci již nejsou ochotni trávit ve zdravotnických zařízeních většinu svého života. Tím narůstá tlak na efektivní využívání času lékaře a také odborného nelékařského zdravotnického personálu.

Je evidentní a exaktními daty doloženo, že vstupní nastavení české populace a českého zdravotnictví ve výše uvedených determinujících oblastech není ideální. Od roku 1989, kdy postupně začal fungovat systém pojišťoven, se nepodařilo vytvořit plně funkční a efektivní vztah pojištěnec (občan) – zdravotní pojišťovna. Pokud má pacient problémy s dostupností či kvalitou péče, pak se primárně většinou neobrací na „svoji“ pojišťovnu, ale na municipality nebo na stát. Očekává, že péči (lékaře) mu zajistí stát a ne „jeho“ pojišťovna. Stát samozřejmě v dané oblasti svůj díl odpovědnosti jistě má, zejména v dlouhodobém plánování kapacit, zajištění vzdělávání zdravotnických profesionálů a v motivačních pobídkách pro studium i pro zdravotnickou praxi. Problém je ale také na straně pojišťoven, které se k této odpovědnosti nehlásí nebo hlásí velmi neochotně a často nebudují síť smluvních poskytovatelů, kterou by svým pojištěncům nabídly. Výrazně viditelný je tento problém již dnes při zajišťování služeb praktického lékaře nebo zubního lékaře.

Na druhou stranu je ovšem nutné konstatovat, že pojišťovny v tomto systému stojí ve velmi složité pozici, protože do vztahu pojišťovna–pojištěnec vstupoval opakovaně a naprosto nepředvídatelně stát. Narovnání tohoto systému je jednou ze základních podmínek další kultivace zdravotní péče. Pojišťovny velmi málo motivují svoje klienty k prevenci a aktivnímu přístupu ke zdravému životnímu stylu a k zájmu o svoje zdraví. Neexistuje ani systém bonusů, ani malusů. Není žádná kontrola nadužívání či dokonce zneužívání zdravotní péče. Stejně tak je značně omezená kontrola kvality poskytované péče, zejména v ambulantních segmentech. Pojišťovny se tak zatím stále pouze omezeně podílejí na budování infrastruktury dostupné péče pro svoje pojištěnce, a nutno dodat, že často v důsledku jimi nezaviněného nastavení systému a legislativy.

Česká republika rovněž dlouhodobě nerealizovala svoji národní lékovou politiku. Odolnost českého trhu proti výpadkům léků byla a je proto velmi slabá a výpadky se cyklicky opakovaly a opakují. Navíc řada výrobců léků měla na českém trhu téměř monopolní postavení, což ještě více oslabovalo odolnost celého systému. V ČR nadto není zajištěná výroba naprosté většiny léků. Léková politika SÚKL nebyla dlouhodobě orientovaná na zvýšení odolnosti trhu, zajištění dostupnosti léků a plánované řešení jejich výpadků. Elektronizace v oblasti přehledu o lécích též velmi vázla.

Ve všech výše zmíněných oblastech bylo a je třeba přijmout více či méně zásadní reformní opatření s cílem připravit systém zdravotních služeb na nevyhnutelný demografický vývoj populace a na dosud nebývalou změnu ve struktuře poptávaných služeb.

Analýzy současného stavu a predikce budoucích trendů a potřebných kapacit jsou dokumentovány v přílohách.

Kapitola I. Prevence a veřejné zdraví

Důraz na zlepšení zdravotního stavu populace, podpora prevence ve všech jejích formách, posilování zdravotní gramotnosti

https://nzip.cz/koncepce2025#prevence

Kapitola na bázi provedených analýz z roku 2022 představuje novou koncepci primární prevence, ochrany a podpory veřejného zdraví, která se nově opírá i o pevné institucionální zázemí, tedy nově ustavenou Radu vlády pro veřejné zdraví a plně funkční mezioborový Národní institut pro zvládáme pandemií (NIZP). Kapitola shrnuje hlavní priority a úkoly podpory veřejného zdraví ČR a konkrétní kroky k jejich plnění, včetně již publikovaných národních strategických dokumentů.

Aktualizace textu k datu 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Úmrtnost z důvodů preventabilních a léčitelných příčin je v ČR přibližně o 25 % vyšší, než je průměr EU. Podle analýz publikovaných Evropskou komisí a OECD tak existuje významný prostor pro prevenci, veřejně-zdravotnické intervence a včasné poskytování efektivních zdravotních služeb zaměřených na včasný záchyt vážných onemocnění[1]. Účinná opatření mohou zahrnovat jak primární prevenci, tedy snižování rizikových faktorů a podporu zdraví, tak sekundární prevenci, tedy screening a včasnou diagnostiku vážných onemocnění.

Zvyšující se naděje dožití české populace totiž nepředstavuje pouze prodloužení věku ve zdraví, stárnoucí populace bohužel trpí ve značné míře chronickými nemocemi. Chronická nemocnost v populaci narůstá již od 45. roku života a téměř 68 % seniorů starších 65 let trpí minimálně jednou vážnou chronickou nemocí[2]. Senioři často tráví velkou část závěru života v nemocnici, jsou často i zbytečně vyšetřovaní, a to vše navíc probíhá v akutní lůžkové péči. Preventivní programy, přestože jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nabízené v širokém rozsahu, nejsou populací dostatečně využívané. Občané se o svoje zdraví starají nedostatečně a pojišťovny je v tomto směru významně nemotivují.

[1] https://www.oecd.org/czechia/czechia-country-health-profile-2023-24a9401e-en.htm
[2] zdravotní stav české populace - výsledky studie EHES 2019

Česká populace patří i dle mezinárodních srovnání mezi ty výrazně zatížené negativními faktory životního stylu. Postupně se zvyšuje prevalence nadváhy nejen u dětí, ale obecně u celé populace. Naprosto nedostatečná je pohybová aktivita. Obecně se zhoršuje zdraví veřejnosti („public health“), což následně vede k vyšší nemocnosti dospělých a zejména seniorů, předčasným úmrtím a kratší délce života ve zdraví. Cílem je**,** aby každý pečoval o svoje zdraví, za podpory státu a ostatních stakeholderů – zaměstnavatelé atd.

Uvedené faktory jsou jednoznačnou výzvou pro posilování prevence ve všech jejích formách, od prevence primární až k cíleným personalizovaným programům včasného záchytu onemocnění v rizikových skupinách osob, včetně tvorby prostředí vstřícného pro realizaci zdravého životního stylu. Neméně intenzivní pozornost musí být věnována zdravotní gramotnosti obyvatel. Je až paradoxní, že při vysoké dostupnosti mnoha preventivních programů, v drtivé většině plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, čelíme jejich nedostatečnému využívání podstatnou částí populace. Cílem všech programů posilujících zdravotní gramotnost musí být pochopení, že „zdraví je hodnota“, kterou je třeba posilovat po celý život.

Důležité podněty pro kritické hodnocení současného stavu veřejného zdraví v České republice přinesla i epidemie koronaviru (SARS-CoV-2), která ukázala veřejné zdravotnictví ČR jako značně nepřipravené a nefunkční. Stejně, jako jsme se toho hodně naučili o viru, naučili jsme se také hodně o tom, co funguje a co je třeba změnit v oblasti veřejného zdraví. Zkušenosti z tohoto období ukazují, že je nezbytné investovat značné úsilí do populační zdravotní bezpečnosti (epidemiologická a hygienická surveillance) (dále jen „zdravotní bezpečnost“) a zároveň zlepšovat celkový zdravotní stav populace. Aby byl náš stát odolný a připraven řešit zdravotní hrozby současnosti i budoucnosti, je zásadní, aby vybudoval funkční systém veřejného zdravotnictví, který bude efektivně koordinovat aktivity v oblasti primární prevence a zdravotní péče současně. I když jsou tyto dvě dimenze samozřejmě propojené, předložená koncepce posilování zdravotní bezpečnosti a zlepšování veřejného zdraví je rozděluje, aby mohla jednoznačně určit účinná opatření zlepšující situaci v každé z nich.

Druhou rovinou historické determinace stavu veřejného zdraví v ČR, tou časově vzdálenější, je vývoj od vzniku novodobého systému ochrany veřejného zdraví. Během uplynulého více než 70letého období došlo k mnohým generačním posunům ve vnímání zbytnosti či nezbytnosti veřejného zdraví. Avšak pouze jednou se změnil i přístup k získání pregraduálního vzdělání odborných pracovníků v ochraně veřejného zdraví a tento proces pregraduální výchovy nových odborných pracovníků stále nebyl dokončen. Nedochází k dostatečnému respektování vývoje nové odborné a vědní linie oboru „Public health“. Česká ochrana veřejného zdraví naráží po odborné stránce na národní limitace generované nízkou zdravotní gramotností, nedostatkem preventivních nástrojů, dostatečně rychle se neprodlužující dobou života ve zdraví a délkou života. Orgány ochrany veřejného zdraví v ČR tvoří geograficky hustou síť s velmi významným personálním zastoupením. Historicky ale nedošlo k dostatečnému rozvoji této organizace dle potřeb společnosti, existující infrastruktura nemá potřebnou akceschopnost a nevychovává nové generace odborníků.

Koncepce primární prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví

V posledních letech se ukazují negativní tendence ve vývoji zdravotního stavu obyvatel České republiky, které se projevují zejména zpomalováním růstu naděje dožití. Délka života prožitého ve zdraví je kratší než ve vyspělých zemích Evropy. Možnosti dostupné zdravotnické péče a nových technologií jsou do značné míry vyčerpány a jejich další extenzivní růst je ekonomicky neudržitelný a nepřináší očekávaný efekt v ovlivnění zdraví obyvatelstva. K tomu přistupuje rychle se měnící životní styl, který přináší řadu negativních zdravotních důsledků: narůstá podíl obézních, nedostatečná pohybová aktivita, roste průměrná hodnota krevního tlaku v populaci, nedaří se redukovat podíl kuřáků, vysoká spotřeba alkoholu, vzrůstá počet nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, včetně alarmujícího nárůstu onemocnění diabetem typu II. U diabetu můžeme při současné prevalenci, tedy více než 1 milion nemocných, hovořit o epidemii tohoto onemocnění. Efektivním řešením této situace je jednoznačně primární prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví.

Primární prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví patří k významným a nezbytným nástrojům péče o zdraví obyvatelstva. Jde o úsilí, jehož smyslem je omezovat výskyt nových případů onemocnění, chránit zdraví a životy obyvatel, prodlužovat život ve zdraví. Současně je nástrojem připravenosti společnosti na současné i budoucí zdravotní krize, a to jako biotické, chemické či jiné etiologie. Připravenost na zdravotní hrozby pojímá mezinárodní přístupy Mezinárodního zdravotního řádu či nařízení Evropské unie k připravenosti na hrozby. Stavem zdraví obyvatel ČR je ovlivněna i situace na pracovním trhu, zdraví snižuje ekonomické náklady společnosti, a to jak na zdravotní péči, tak další socioekonomické náklady za nemoc. Primární prevence nemocí ve svém důsledku přispívá k rozvoji a odolnosti společnosti jako celku.

Nutnost posílení prevence ve všech jejích formách a posilování zdravého životní stylu zdůrazňuje jak Programové prohlášení vlády České republiky ze dne 6. 1. 2022, tak Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 – Zdraví 2030, stejně jako prohlášení NERV ze dne 1. 7. 2025:

- https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/#zdravotnictvi
- https://zdravi2030.mzcr.cz
- https://vlada.gov.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_Budoucnost-financovani-zdravotnictvi_pracovni-material-tematicke-skupiny-Zdravotnictvi.pdf

V České republice není v současnosti oblast veřejného zdraví systémově ukotvena způsobem, který je běžný ve vyspělých státech EU. Řada agend je projektově i institucionálně roztříštěna, systém organizace postrádá koncepční vedení. Z těchto důvodů je nutné, aby odborná problematika veřejného zdraví byla koncentrována do silného a odborně zajištěného Národního institutu pro veřejné zdraví. Takovou roli v ČR je připraven plnit Státní zdravotní ústav, který od svého vzniku až po současnost pokrývá celé spektrum agend podle zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2000. Musí však být ke splnění tohoto náročného a odpovědného úkolu náležitě finančně stabilizován tak, aby stát disponoval moderně vybavenou a stabilní institucí, která bude systém veřejného zdravotnictví zastřešovat v plném rozsahu kontroly zdravotní bezpečnosti a zdravotních rizik, tj. rizik infekčních, environmentálních, chemických, aj. Kromě špičkové laboratorní, diagnostické a výzkumné

kompetence by taková instituce měla plnit nezastupitelnou roli jak v komunikaci s odborníky, tak i se širokou veřejností.

V souvislosti se zdravotními hrozbami nového typu a povinností ČR implementovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2371 ze dne 23. listopadu 2022 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU, je žádoucí podpořit inovativní přístupy pro zajištění krizové připravenosti celého systému veřejného zdravotnictví, včetně zvýšení laboratorní kapacity, např. v oblasti molekulárně-biologické diagnostiky a biomonitoringu jako datové a diagnostické základny pro kontinuální hodnocení zdravotních rizik. Je nezbytné zajistit modernizaci národních referenčních laboratoří a pracovišť, kde je prováděna identifikace mikroorganismů a identifikace a kvantitativní stanovení vysoce toxických látek v potravinách či spotřebních výrobcích, sledování zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí. Nové přístupy vyžadují hodnocení nanomateriálů, výrobků obsahujících recyklované materiály, materiálů vyráběných inovativními postupy v rámci přechodu z lineární na oběhovou (bezodpadovou) ekonomiku, zejména za použití odpadů.

Tyto činnosti vychází také z požadavků Evropské komise a jejích vědeckých výborů, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a respektují celosvětový koncept *„One Health*“ – Jedno zdraví.

Významnou součástí veřejného zdraví je i vědecká a výzkumná činnost včetně publikační, stejně jako účast v pregraduální, specializační i postgraduální výuce pracovníků ve zdravotnictví i mimo něj. Nadále je nutné podporovat a rozšiřovat navázanou spolupráci všech zdravotních ústavů s akademickými pracovišti. Výzkumné zaměření SZÚ směřuje vždy k výsledkům s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v expertní praxi, metodickém řízení a referenční činnosti. V souladu s posláním SZÚ představuje jeho výzkumná činnost kombinaci základního a aplikovaného výzkumu v tematicky široké škále činností interdisciplinární povahy, zaměřených na rozvoj poznání komplexních souvislostí mezi zdravím a nemocí, vnějších i vnitřních faktorů ovlivňujících fyziologické mechanismy. Cílem výzkumu podporovaného v této oblasti je zlepšení ochrany a podpory veřejného zdraví z hlediska snižování rizik pro zdraví člověka, zajištění dostatku dat pro rozhodování při tvorbě podkladů pro zdravotní politiku státu.

Nezbytným předpokladem úspěšné realizace primární prevence, ochrany a podpory zdraví je vytvoření **institucionální infrastruktury na resortní i meziresortní úrovni**, dále spolupracující na úrovni samospráv a v neposlední řadě ve významných výrobních segmentech, u zaměstnavatelů. Na resortní úrovni se jedná zejména o Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), krajské hygienické stanice, další pracoviště státní hygienické služby, zdravotní ústavy, zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě zdravotnická zařízení, jak nemocniční, tak ambulantní.

Pro úspěšnou realizaci koncepce primární prevence, ochrany a podpory zdraví je rovněž nezbytné zajistit právní zakotvení a účinnou implementační oporu. Novelizace již existujících právních norem, zejména novelizaci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) musí více reflektovat komplexní šíři veřejného zdraví. To znamená, že zohlední a popíše úlohu státu, orgánů ochrany veřejného zdraví i samosprávy v podpoře zdraví, ve strategiích a politikách veřejného zdraví, jejich přijímání, realizaci i hodnocení, ve sledování a analýze zdravotního stavu a jeho determinant. Soustava orgánů ochrany veřejného zdraví se musí poučit ze zkušeností nabytých během epidemie covid-19 a napravit nedostatečně efektivní a nejednotné řízení. Struktura musí zavést prvky celostátního řízení, včetně auditních mechanismů, které budou zajišťovat jednotný celostátní i regionální přístup všech zapojených institucí. Novelizovaný zákon č. 258/2000 Sb. musí rovněž přinést strukturální reformu systému ochrany veřejného zdraví s cílem připravit se na budoucí nové hrozby jako jsou nové infekční nemoci, environmentální hrozby nebo biologická nebezpečí.

Nezbytným předpokladem plnění mezinárodních i národních závazků ČR v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví je nezávislost, nestrannost a transparentní financování z veřejných zdrojů. Je zcela zásadní najít udržitelný vícezdrojový způsob financování Státního zdravotního ústavu (Národního institutu veřejného zdraví). Finanční zajištění činnosti musí být podporováno efektivní personální politikou a motivací k přípravě nového špičkově vzdělaného zdravotnického, ale i nelékařského personálu.

Základními prioritami účinných opatření řešících zdravotní problémy populace jsou:

1. Dostatečná pohybová aktivita populace
2. Správná výživa a stravovací návyky populace
3. Podpora duševního zdraví
4. Omezení zdravotně rizikového chování: zejména konzumace tabáku, včetně nových forem e-cigarety, bylinné výrobky určené ke kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, používání drog, včetně tzv. psychomodulačních látek, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních – zvláště HIV/AIDS, virových hepatitid a dalších pohlavních nemocí).
5. Prevence úrazů
6. Snižování nerovností ve zdraví
7. Vakcinační programy a screeningové programy
8. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
9. Zajištění chemické bezpečnosti jak výrobků určených spotřebitelům, ale i výrobkům pro profesionální použití.

Zdraví nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, školách a na pracovištích, všude tam, kde lidé žijí a pracují, odpočívají a stárnou. Zdraví zlepšují nebo zhoršují ty okolnosti, které na populaci působí v běžném životě, a právě tam je těžiště péče o zdraví. I když je důležité, aby každý sám pečoval o své zdraví, je zřejmé, že to samo nestačí. Péče o zdraví musí být provázena sdílenou odpovědností všech složek společnosti pod odbornou koordinační rolí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda, parlament, všechny úrovně veřejné správy, organizace a instituce i podnikatelská sféra by měly vnímat hodnotu zdraví a najít své místo v ochraně i rozvoji zdraví obyvatel ČR. Cílem je zlepšení kvality života obyvatel, prodloužení délky života ve zdraví všemi dostupnými

prostředky a tím snížení nákladů nejen na zdravotní péči, ale i dalších socioekonomických nákladů spojených s nemocí, stejně jako zlepšování stavu životního a pracovního prostředí jako efektivního způsobu prevence zdravotních problémů, především formou primární zdravotní prevence.

Konsolidace a modernizace systému ochrany veřejného zdraví – zázemí pro plánování, koordinaci a kontrolu

K problematice prevence vážných onemocnění a podpory života ve zdraví neoddělitelně patří agenda veřejného zdraví. V této oblasti stojí před českým zdravotnictvím řada významných kroků a úkolů, neboť značnou organizační a manažerskou nedostatečnost orgánů ochrany veřejného zdraví odhalila epidemie covid-19. Chybí základna a metodika jednotného organizačního a manažerského řízení celého systému.

Krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy v těchto oblastech nikdy optimálně nespolupracovaly a hygienická služba se zaměřovala spíše na kontroly, vydávání povolení a restriktivní opatření. Již stávající právní řád ovšem stanovuje dostatečné mandáty pro regionální řízení veřejného zdraví, a to ve spolupráci s krajským úřadem. Nicméně efekt aktivit odpovědných organizací na zlepšování zdraví veřejnosti byl dlouhodobě nedostatečný a nezbytná spolupráce s jinými resorty (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR či Ministerstvem zemědělství ČR) vázla nebo neexistovala.

Jako první krok se díky aktivnímu přístupu Vlády ČR podařilo, podobně jak je běžné v dalších evropských zemích, získat meziresortní přesah a možnost přípravy a koordinace aktivit veřejného zdraví na nejvyšší úrovni a vládním usnesením č. 602/2024 dne 4. září 2024 byla zřízena **Rada vlády pro veřejné zdraví.**

Rada vlády pro veřejné zdraví je složená z odborníků na jednotlivé oblasti problematiky veřejného zdraví z akademické sféry, z ministerstev, zástupců samospráv a dalších stakeholderů. Cílem je věnovat maximum pozornosti všem aktivitám, které povedou k prodloužení života ve zdraví a inspirovat se i praxí v zahraničí. Například studie *Prioritizing Health* poradenské společnosti *McKinsey & Company* publikovaná v roce 2020 ukazuje, že širším využitím již vyzkoušených zdravotních intervencí je možné do roku 2040 snížit globální zátěž způsobenou nemocemi o přibližně 40 %. Více než dvě třetiny tohoto zlepšení lze dosáhnout preventivními opatřeními, a to s poměrně nízkými náklady (McKinsey Global Institute, 2020)[3].

Logickým a dalším nutným krokem ke zlepšení veřejného zdraví tedy musí být konsolidace všech existujících složek veřejného zdraví do jednoho systému. Na základě existující Rady vlády pro veřejné zdraví je nutné vytvořit v této pozici nezávislý odborný subjekt – Národní institut veřejného zdraví, podobně jak tomu je v mnoha ekonomicky vyspělých státech Evropy. Evropské národní veřejné zdravotní instituce jako RKI (Německo), Santé publique France, Public

[3] https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/prioritizing-health-a-prescription-for-prosperity

Health Agency of Sweden, RIVM (Nizozemsko), Sciensano (Belgie) či NIPH–NIH (Polsko) slouží jako pilíře národní zdravotní bezpečnosti a prevence, kombinují epidemiologický dohled, výzkum, osvětu i poradenství vládám a veřejnosti.

Národní institut veřejného zdraví vznikne konsolidací Státního zdravotního ústavu, obou zdravotních ústavů a Státní hygienické služby, jako nástupnického dozorového orgánu, jež vznikne propojením stávajících čtrnácti krajských hygienických stanic. Taková reforma směřuje k vytvoření uceleného nezávislého systému, který bude efektivně koordinovat aktivity veřejného zdraví, např. v oblasti stravování, pohybu, boje proti závislostem a podpory zdravého životního stylu, tedy v oblastech známých pod pojmem primární prevence, předcházení vzniku nemoci a prodloužení života ve zdraví se zapojením rodiny, škol, zaměstnavatelů, samospráv a státu. Zajistí dozor a kontrolu dodržování legislativy platné pro veřejné zdraví.

Institut bude odborným nezávislým zázemím pro vznik podkladů pro zdravotní politiku státu a pro řešení existujících a nově vznikajících hrozeb veřejného zdraví, které budou vyhodnocovány na základě práce s daty a vyhodnocování rizika ze systému monitoringu a z krizových situací spojených se zdravotním stavem populace. Bude velmi úzce spolupracovat, rozvíjet registry a analyzovat data sbíraná do registrů spravovaných ÚZIS ČR v oblastech souvisejících s veřejným zdravím. Realizace kroků vedoucích k podpoře veřejného zdraví jako je podpora prevence, osvěty a zdravotní gramotnosti cestou efektivnější komunikace témat směrem k odborníkům, politikům a veřejnosti je cestou ke zmírnění negativního dopadu nemoci na ekonomiku státu i jednotlivce.

Národní institut veřejného zdraví bude koordinovat nejen schopnost reakce na celostátní zdravotní hrozby, ale také se bude podílet na průběžné spolupráci s mezinárodními zdravotnickými organizacemi a koordinaci v oblasti preventivních strategií, včetně propagace zdravého životního stylu, očkovacích programů a preventivních opatření zaměřených na snižování výskytu neinfekčních chronických onemocnění. Jeho kontinuální činnost povede k ucelenému a efektivnímu přístupu ve snaze o zvýšení kvality a délky života občanů České republiky prožité ve zdraví.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Czech Public Health (PHCZ):

hlavní identifikované priority a realizovaná opatření

Priorita I – Připravenost na hrozby pro veřejné zdraví **Cíl –** Posílení systému prevence, připravenosti a reakce na budoucí pandemie a další vážné hrozby pro veřejné zdraví	
Rámcové cíle a opatření	
A – Elektronizace systému hlášení infekčních onemocnění a laboratorních výsledků	Informační systémy jsou nezbytnou součástí systému epidemiologické bdělosti, jsou klíčovým nástrojem pro tzv. systém včasného

	varování, tj. pro efektivní monitoring hodnocení trendů a vývoje nákaz a jejich dopadů na veřejné zdraví, a tím pro řízení celého systému dohledu. Informační systémy jsou nedílnou součástí celého systému prevence, připravenosti a reakce na vážné zdravotní hrozby. Automatizovaný systém je nezbytnou součástí tzv. Early Warning and Response System - tj. systému včasného varování a reakce prostřednictvím monitoringu zdravotních hrozeb na základě klíčových indikátorů.
B – Zpracovat analýzu možných hrozeb pro Českou republiku v oblasti ochrany veřejného zdraví a její závěry promítnout do strategických materiálů v oblasti připravenosti na vážné zdravotní hrozby	Zpracování analýzy možných hrozeb v oblasti ochrany veřejného zdraví je klíčovým základem pro tvorbu strategických plánů prevence, připravenosti a reakce na vážné hrozby pro veřejné zdraví. Cílem je identifikace možných hrozeb, kvantifikace rizika a definování možných scénářů reakce na definované hrozby.
C – Zpravování strategického řídícího dokumentu Národní plán prevence, připravenosti a reakce na vážné zdravotní hrozby	S ohledem na vyhodnocení zkušeností z předchozích pandemií, současného vývoje globální bezpečnostní situace, a to zejména s ohledem na klimatické změny nebo probíhající válečné konflikty, a s tím spojené hrozby, jako jsou migrační vlny velkého rozsahu a hrozby použití chemických, biologických a nukleárních zdraní se nejeví jako vhodné mít připraven pandemický plán pouze na jednu specifickou oblast, ale je naopak vysoce žádoucí mít pro potřeby komplexního řešení celého spektra mimořádných událostí spojených s ohrožením veřejného zdraví v souladu s přístupem „all hazard approach“, který zahrnuje biologické, chemické nebo radiologické události ohrožující veřejné zdraví vypracován komplexní prevence, připravenosti a reakce na vážné zdravotní hrozby, který pokryje všechny tyto oblasti. Účelem je zajistit jednotný a účinný systém připravenosti a reakce při riziku ohrožení veřejného zdraví v důsledku mimořádných událostí spojených s ohrožením veřejného zdraví vlivem působení nejen činitelů biologického, ale i chemického nebo

	environmentálního původu, tak aby byly naplněny požadavky a potřeby, které mají jednotlivé subjekty ve vztahu prevenci, připravenosti a reakci na mimořádné události naplňovat, včetně řešení přeshraničních hrozeb. Cílem plánu je poskytnout jasné a srozumitelné interní pokyny a postupy ke koordinaci a řízení činností České republiky prostřednictvím zainteresovaných subjektů při řešení mimořádné události spojené s ohrožením veřejného zdraví. Hlavním cílem plánu bude pak v případě vzniku mimořádné události zmírněná očekávaných zdravotních, sociálních a ekonomických následků. Mezi hlavní cíle patří: - posílení národního systému rychlého varování a reakce za účelem včasné identifikace zdravotní hrozby; - rychlá identifikace ohnisek nákazy v populaci v případě mimořádné události biologického/infekčního původu a minimalizování rozšíření nákazy v populaci; - vymezení oblasti a stanovení opatření k minimalizaci dopadů mimořádné události a ochraně veřejného zdraví; - stanovení postupů pro řešení mimořádné události, dle míry rizika; - určení rolí a odpovědnosti jednotlivých subjektů zapojených do řešení mimořádné události, dle charakteru mimořádné událostí; - zajištění prevence; - zabezpečení léčby nemocných a léčby komplikací; - zabezpečení informovanosti zdravotnických pracovníků a veřejnosti.
D – Posílení kapacit odborného personálu pro monitoring zdravotních hrozeb	Vytvoření národní jednotky pro monitoring zdravotních hrozeb, včetně monitoringu zdravotních hrozeb v zahraničí s možným dopadem na ČR („Epidemic Inteligence Unit“).

Priorita II – Strategie v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví **Cíl –** Tvorba krátkodobých a dlouhodobých koncepcí v ochraně a podpoře veřejného zdraví se zaměření na zvýšení povědomí o důležitosti prevence (se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost)
Krátkodobé koncepce

Edukativní kampaně	Tvorba a realizace cílených edukačních kampaní tvořených ve multioborové spolupráci státních institucí, odborných lékařských společností se zapojením sociologů a sdílení kampaní prostřednictvím odborných společností, médií a sociálních sítí. Cílem je poskytnutí jasných a srozumitelných informací směrem k odborné a laické veřejnosti o aktuálních zdravotních hrozbách/probléme a možnostech prevence.
Workshopy a školení	Organizování workshopů a školení pro odborníky a laickou veřejnost, kde je vhodné dělení na různé věkové a sociální skupiny na téma zdravého životního stylu, důležitosti očkování a prevence specifických nemocí.
Podpora očkování	Tvorba vakcinační strategie s cílem podpory očkování jako základního nástroje prevence.
Dlouhodobé koncepce:	
Vzdělávací programy	Začlenění vzdělávacích programů do školních osnov, které budou děti informovat o zdravém životním stylu, prevenci a podpoře zdraví. Tvorba koncepce vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti ochrany a podpory zdraví prostřednictvím sociálního lékařství.
Zdravotní politika a legislativa (právní řád)	Vypracování a implementace zákonů a politik, které podporují zdravotní prevenci, podporu zdravého stravování ve školách a prevence nežádoucích událostí na pracovištích.
Výzkum a monitoring	Podpora vědeckého výzkumu v oblasti veřejného zdraví a vývoje nových léčivých přípravků a diagnostických metod. Sledování a analýza dat o zdravotním stavu populace pro lepší cílení preventivních opatření.

Podpora zdravotní gramotnosti	Rozvoj programů zaměřených na zvýšení zdravotní gramotnosti obyvatelstva.
Spolupráce s neziskovým sektorem	Spolupráce s neziskovými organizacemi a komunitními skupinami na projektech a iniciativách zaměřených na zdraví a prevenci. Základem úspěchu v ochraně a podpoře veřejného zdraví je komplexní přístup, který zahrnuje vzdělávání, legislativu, dostupnost služeb, výzkum a zapojení komunity. Aktivní účast veřejnosti a multioborová spolupráce jsou klíčové pro vytváření zdravější společnosti se silným důrazem na prevenci.
Rámcové cíle a opatření	
A – Tvorba Národní očkovací strategie	Očkování hraje klíčovou roli v ochraně veřejného zdraví a je jednou z nejúčinnějších metod prevence celé řady onemocnění, které jsou očkováním preventabilní a je tak nezbytné mít vytvořenu strategii jasně definující cíle, které mají být dosaženy a intervence, které je nezbytné aplikovat, aby definované cíle byly dosaženy. Vakcinační strategie esenciálně definuje: - konkrétní cíle, které mají být dosaženy na konci strategického období (5 let), - prioritní oblasti, které se skládají z nákladově vyčísleného souboru intervencí k dosažení stanoveného cíle a - cíle, které mají být naplněny v dlouhodobém horizontu (10 let). **Mezi hlavní strategické priority patří:** - zvýšení proočkovanosti populace, - zajistit dostupnost očkování, - zajistit dodávky očkovacích látek a jejich efektivní využívání pro plnění cílů vakcinační strategie, - pokračovat v posilování systémů monitorování bezpečnosti očkovacích látek, - udržet a zajistit důvěru veřejnosti/komunity v očkování prostřednictvím účinných komunikačních strategií, - posílit monitorování a hodnocení strategie prostřednictvím hodnocení a analýzy údajů z očkovacího registru a sledováním nemocí, kterým lze předcházet očkováním a

	- zajistit dostatečně kvalifikované pracovníky v oblasti očkování podporou účinného školení pro poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování.
B – Tvorba komunikačních strategií	Komunikační strategie plní důležitou roli v ochraně veřejného zdraví tím, že informují a motivují lidi k přijímání rozhodnutí v oblasti prevence. Prvním krokem je identifikace cílových skupin, a to prostřednictvím analýzy demografických charakteristik a preferencí cílových skupin. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými skupinami populace a přizpůsobit tomu obsah sdělení. Sdělení by měla být jasná a srozumitelná, a to pro různé věkové skupiny a socioekonomické úrovně**.** Je vhodné použití jednoduchého a přístupného jazyka bez složitých termínů a odborných výrazů. Pro zvýšení efektivity komunikace a jejího dosahu je nezbytné zapojení komunitních lídrů, organizací a skupin do komunikačních aktivit, aby zajišťovali důvěru a podporu veřejnosti. V některých oblastech pro zajištění přístupnosti sdělení je vhodná organizace komunitních setkání, workshopů a akcí, které umožňují interaktivní komunikaci a dialog mezi veřejností a odborníky. V neposlední řadě je nezbytná tvorba strategie krizová komunikace, a to v rámci připravenosti na řešení krizových situací prostřednictvím efektivní komunikace a informování veřejnosti o nebezpečích a opatřeních k ochraně zdraví.

Priorita III – Monitorování a hodnocení zdravotního stavu populace, využívání zdravotních služeb a sledování rizikových faktorů. Pro tvorbu a nastavené efektivních intervenčních programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví je nezbytné znát celou řadu informací o zdravotním stavu populace a dostupnosti zdravotních služeb. A to prostřednictvím:	
A – Monitorování a hodnocení zdravotního stavu populace	Sběr a analýza epidemiologických dat o výskytu nemocí, úmrtnosti a dalších zdravotních indikátorů. Monitorování trendů v prevalenci chronických onemocnění, infekčních nemocí atd.

	Hodnocení zdravotního stavu populace pomocí definovaných ukazatelů. Zhodnocení nerovností mezi různými socioekonomickými skupinami a geografickými oblastmi.
B – Využívání zdravotních služeb	Sledování dostupnosti zdravotních služeb a léčiv. Analýza využívání zdravotní péče podle typu služby, věku, pohlaví a dalších demografických charakteristik. Hodnocení kvality poskytované zdravotní péče a spokojenosti pacientů.
C – Sledování rizikových faktorů	Identifikace a sledování rizikových faktorů jako jsou například kouření, nezdravá strava, nedostatek fyzické aktivity, spotřeba alkoholu atd. Sledování environmentálních a sociálních faktorů, které mohou ovlivňovat zdraví populace.

Priorita IV – Intervenční programy v ochraně veřejného zdraví Intervenční programy v ochraně veřejného zdraví mají klíčovou roli v prevenci nemocí, podpoře zdravého životního stylu a snižování rizik spojených se zdravím v populaci. Tyto programy jsou navrženy tak, aby řešily konkrétní zdravotní problémy nebo rizikové faktory v populaci prostřednictvím cílených aktivit. Zaměřeny jsou na infekční nemoci, chronické nemoci, duševní zdraví, zdraví dětí a mládeže, či pracovní zdraví. Zde jsou některé klíčové aspekty a příklady intervenčních programů v ochraně veřejného zdraví:	
A – Prevence a edukace	
Edukativní kampaně	Informují veřejnost např. o důležitosti zdravého životního stylu, výživy, pravidelného cvičení, a o rizicích kouření, nadměrné konzumace alkoholu apod. v oblast prevence neinfekčních onemocnění nebo například o důležitost očkování jako prevence infekčních onemocnění.
B – Monitoring výskytu nemocí a screeningové programy	
B1. Monitorovací programy	Zaměřené na sledování a průběžné a dlouhodobé hodnocení rizikových faktorů, determinant zdraví. Např. sérologické přehledy, monitoring odpadních vod, strategické hlukové mapování, pylový monitoring a další typy dlouhodobého či opakovaného sledování.

B2.Sledování výskytu nemocí	Systémy, které monitorují a analyzují výskyt vybraných nemocí v populaci a umožňují rychlou reakci při mimořádných situacích, viz výše.
C – Životní prostředí	Programy zaměřené na zlepšení kvality životního prostředí, prostřednictvím snížení expozice škodlivým látkám a znečišťujícím látkám v životním prostředí.
D – Pracovní prostředí	Programy pro zlepšení pracovních podmínek, zahrnující opatření pro snížení rizikových faktorů spojených s fyzickou prací, ergonomií, a psychosociálním stresem.

Celkový souhrn zaměření realizovaných opatření

- Posílení systému veřejného zdraví s regionální dostupností a celostátním řízením (v celostátním designu),
- Nastavení systému pro koordinaci a prosazování opatření napříč resorty v oblasti prevence a širších faktorů ovlivňujících zdraví,
- Investice do kritických schopností a vytváření udržitelné pracovní síly pro jejich poskytování či pro zdravotní bezpečnost a zlepšování zdraví. Vznikla Pracovní skupina pro posílení vzdělávání v oblasti veřejného zdraví garantovaná Univerzitou Karlovou
- Podpora populačních i environmentálních programů monitoringu vč. zveřejnění evaluačních zpráv zavedených monitorovacích programů
- Příprava a podpora vzniku národních akčních plánů a strategií v oblasti veřejného zdraví: např. Národní očkovací strategie, Národní antibiotický program ČR, Národní kardiovaskulární plán, Národní akční plán Adaptace na změnu klimatu
- Koordinace činnosti a výstupů meziresortních pracovních skupin s výstupy pro metodické vedení v oblasti veřejného zdraví
- Koordinace spolupráce s odbornými společnostmi a odborníky celého spektra problematiky veřejného zdraví – činnost Národního institutu pro zvládání pandemie, jako subjektu mezioborové spolupráce a garanta odborných podkladů a stanovisek pro rozhodování o hrozbách veřejného zdraví.
- Podpora zvyšování zdravotní gramotnosti realizací tvorby edukačních materiálů, aktivní spoluprací a garancí obsahu Národního zdravotnického informačního portálu. Vznik Aliance pro zvyšování zdravotní gramotnosti za koordinace Státním zdravotním ústavem aj.
- Příprava a realizace projektů pro podporu datového zázemí a komunikace biologického monitoringu, monitoringu rizikových faktorů a prevence onemocnění
- Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci akčních programů EU4Health a Horizon 2020 (UNITED4Surveillance: posílení integrované surveillance infekčních nemocí v EU a posílení připravenosti na krize a reakci na pandemie, JAMRAI2: podporu v oblasti monitorování antimikrobní rezistence a infekcí souvisejících se zdravotní péčí, OH

SurVector: posílení surveillance nemocí přenášených vektory v rámci One Health, EU-WISH:Vytvoření mezinárodní spolupracující sítě pravidelného monitoringu významných cílů v odpadních vodách, PARC: harmonizace a inovace metod lidského biomonitoringu, rozšířená o vývoj nových spolehlivějších způsobů hodnocení zdravotních rizik chemických látek, JA-SAFE: usiluje o snížení užívání tabáku a pasivního kouření s cílem podpořit zdraví a vytvořit generaci bez tabáku v Evropě, JA SHIELD - Strategie zdravotních intervencí k odstranění rakoviny související s infekcí, PERCH: podpora očkování proti HPV a nová společná akce na podporu populačních screeningových programů, IS-SCOPE: Posílení kapacity a výkonnosti národních informačních systémů ochrany veřejného zdraví)

Další cíle strategie do roku 2025

1. Plně funkční Rada vlády pro veřejné zdraví jako Vládou ČR schválené těleso garantující koordinaci a udržitelnost monitoringu, programů prevence, zvyšování zdravotní gramotnosti a připravenosti na hrozby veřejného zdraví, včetně vybudovaného informačního zázemí
2. Připravené technické řešení systému hygienických registrů, které se stanou trvalou součástí monitoringu agend veřejného zdraví a zdravotního dozoru v těchto oblastech a budou sloužit jako podklad při navrhování vyhodnocování efektivity zdravotních politik, zejména preventivních programů a připravenosti na zdravotní hrozby.
3. Pravidelný a rutinně realizovaný systém kontroly kvality a nákladové efektivity preventivních programů, včetně očkovacích programů
4. Novela Zákona o veřejném zdraví, včetně definice Státní hygienické služby
5. Návrh nového institucionálního ukotvení systému veřejného zdraví v ČR – příprava vzniku Národního institutu veřejného zdraví
6. Vyvinutý a implementovaný zcela nový systém centrální evidence očkování, včetně agend posilující vztah populace k očkování
7. Implementovaný nový systém plně automatizovaného surveillance infekčních nemocí pod garancí nově ustaveného Národního institutu pro zvládání pandemií (NIZP)

ZDROJE:

1. Evropská strategie Global health https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7153
2. Health report OECD - https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/czechia-country-health-profile-2023_24a9401e-en#page1
3. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2371 ze dne 23. listopadu 2022 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2371
4. Roky dožité ve zdraví při narození EUROSTAT 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Healthy_Life_Years_at_Birth-7.png

Kapitola II. Sekundární prevence a Národní screeningové centrum

Včasný záchyt vážných onemocnění a podpora kvality organizovaných (populačních) programů screeningu

https://nzip.cz/koncepce2025#nsc

Kapitola na bázi provedených analýz z roku 2022 představuje novou zcela koncepci sekundární prevence, organizace a hodnocení kvality screeningových programů. Vláda České republiky v květnu 2025 schválila Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) orgánem odpovědným za koordinaci screeningových programů v České republice. Činnost NSC se nově opírá o koncepci udržitelnosti běžících programů sekundární prevence a naplňuje všechna pro danou oblast platná mezinárodní doporučení a směrnice. Kromě toho byly od roku 2022 spuštěny nové plošné screeningové programy a více než 20 programů je ve fázi projektové validace a pilotního testování. Nové datové analýzy dokládají, že screeningové programy v ČR začaly po roce 2022 posilovat ve své výkonnosti a pokrytí populace, na čemž má podíl i postupující elektronizace agend, včetně zpřístupnění dat občanům (nová aplikace EZKarta).

Aktualizace textu k datu 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Význam sekundární prevence a organizovaných programů včasného záchytu vážných onemocnění vyplývá již z populačních dat o nemocnosti obyvatel. Vážnější chronická nemocnost začíná narůstat již od 45. roku věku a ve věkové kategorií 65 je až 30 % českých občanů zatíženo více než dvěma vážnými chronickými chorobami. Od roku 2015 se zvýšila prevalence onkologických onemocnění o více než 27 % a prevalence léčených vážných kardiovaskulárních onemocnění narostla o více než 23 %. I z těchto důvodů je úmrtnost z důvodů preventabilních a léčitelných příčin v ČR přibližně o 25 % vyšší, než je průměr EU. To se týká i předčasné mortality způsobené zejména pozdním záchytem vážných onemocnění, tedy ve stádiích, kdy je šance na úplné vyléčení významně snížena. Podle analýz publikovaných Evropskou komisí a OECD tak existuje významný prostor pro prevenci, veřejně-zdravotnické intervence a včasné poskytování efektivních zdravotních služeb zaměřených na včasný záchyt

vážných onemocnění. Účinná opatření mohou zahrnovat jak primární prevenci, tedy snižování rizikových faktorů a podporu zdraví, tak sekundární prevenci, tedy screening a včasnou diagnostiku vážných onemocnění.

Preventivní a screeningové programy, přestože jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nabízené v širokém rozsahu, nejsou populací dostatečně využívané. Občané se o svoje zdraví starají nedostatečně a pojišťovny je v tomto směru významně nemotivují. Analýzou dlouhodobě zavedených screeningových programů karcinomu prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla se zabývaly evaluační zprávy publikované na Datovém portálu screeningových programů v roce 2022 (https://nsc.uzis.cz/data), výsledky jsou dále průběžně aktualizovány a publikovány na konferencích, webovém portálu a v odborných periodicích.

Jako doklad významu programů sekundární prevence slouží mamografický screening karcinomu prsu u žen běžící v ČR déle než 20 let. Díky mamografickému screeningovému programu se zvyšuje podíl časně zachycených karcinomů prsu a klesá úmrtnost, karcinom prsu je přesto stále druhou nejčastější nádorovou příčinou úmrtí (po nádorech plic) u českých žen. Screening ve dvouletém intervalu pokrývá přibližně 60 % žen ve věku 45-69 let, v některých okresech je však pokrytí pod 50 %. Většina žen přichází na screening se žádankou od gynekologa, role praktických lékařů je prozatím nižší. Téměř 60 % karcinomů prsu u žen ve věku nad 45 let je detekováno ve screeningu, téměř 70 % těchto nádorů je neinvazivních nebo ve stadiu I; takové nádory je možné velmi dobře léčit s téměř 100% nadějí na pětileté relativní přežití.

Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu u cílové populace mužů a žen ve věku od 50 let se ustálilo na úrovni přibližně 30 %. V tříletém intervalu dosahuje úplné pokrytí cílové populace vyšetřeními hodnot okolo 50 %. Míra účasti na navazující kolonoskopii po pozitivním screeningovém testu na okultní krvácení do stolice (TOKS) se v čase pohybuje pouze mezi 60 a 70 %. V rámci indikátoru pozitivita screeningového TOKS došlo v posledních letech ke zvýšení pozitivity až na úroveň 10 %, což se projevilo i na nárůstu průměrné čekací doby na navazující TOKS+ kolonoskopii. I přes identifikované rezervy screeningového programu dochází dlouhodobě ke zřetelnému poklesu incidence i mortality kolorektálního karcinomu.

Screeningem karcinomu děložního hrdla je v tříletém intervalu pokryto 80 % žen ve věku 25 až 49 let, u žen nad 60 let klesá pod 65 %, což je spojeno s pokročilými onemocněními v této věkové skupině. Mezi ženami podstupujícími ve věku 35 a 45 let preventivní prohlídku podstupuje 76 % nově dostupný ko-test citlivějším testem na virus HPV. Incidence a mortalita karcinomu děložního hrdla za posledních 10 let poklesla o čtvrtinu, mortalita je však stále vyšší než v zemích západní a severní Evropy.

Zhoubné nádory plic a prostaty patří mezi populačně nejzávažnější nádorová onemocnění v ČR. Karcinom plic představuje s více než 5 tisíci úmrtí ročně nejčastější nádorovou příčinu úmrtí. Přibližně 1500 mužů ročně podlehne karcinomu prostaty a v mužské populaci se tak jedná o třetí nejzávažnější nádorovou příčinu úmrtí. Aktuální vědecké poznatky podporují zavádění organizovaného časného záchytu karcinomu prostaty i plic. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic byl zahájen v roce 2022. Cílovou populací pro zařazení do programu jsou bývalí či současní kuřáci ve věku 55–74 let se zátěží alespoň 20 balíčkoroků.

Praktičtí lékaři odesílají osoby splňující vstupní kritéria k následnému vyšetření ambulantním pneumologem. Účastník je dále odeslán na screeningové nízkodávkové CT (LDCT) na akreditované radiologické pracoviště.

Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty byl zahájen v lednu 2024. Cílovou populací jsou muži ve věku 50–69 let. Screeningové vyšetření PSA může nabídnout praktický lékař nebo ošetřující urolog, další postup se liší dle změřené hladiny PSA. První hodnotitelné výsledku ukazují na vysokou záchytovost a smysluplnost tohoto screeningu. Více než 8,7 % mužů vykázalo potenciálně rizikovou hodnotu PSA a v programu bylo dosud zachyceno téměř 900 karcinomů

Kromě celoplošných organizovaných programů screeningu zhoubných nádorů mohou být časný záchyt a prevence nežádoucích zdravotních dopadů pozdě diagnostikovaných onemocnění přínosné i v dalších zdravotnických oblastech. Potenciál takových zdravotnických intervencí je tedy nezbytné systematicky zkoumat a následně zavádět v podobě celoplošných programů nebo doporučených postupů.

Význam screeningových programů na modelu onkologických onemocnění shrnuje následující tabulka.

Screening je zásadní součástí preventivních opatření v oblasti veřejného zdraví a má klíčový význam pro snižování incidence a mortality spojené s onkologickými onemocněními. Jeho hlavní důležitost spočívá v několika aspektech:	
A – Raná detekce	Screening umožňuje detekci onkologického onemocnění v raném stadiu, kdy ještě nemusí být přítomné žádné symptomy. Onemocnění odhalené v raných stádiích jsou obvykle lépe léčitelné a mají lepší prognózu. Například u rakoviny prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku, plic či prostaty může raná detekce významně zvýšit šance na úspěšnou léčbu a přežití.
B – Snížení mortality	Významným cílem screeningových programů je snížení úmrtnosti spojené s konkrétními typy onkologických onemocnění. Pravidelným screeningem a následnou včasnou intervencí je možné předejít pokročilým stádiím onemocnění a související vysoké mortalitě.
C – Snížení nákladů na léčbu	Léčba onkologických onemocnění v pokročilých stádiích je často mnohem náročnější a dražší než intervence v raných stádiích. Raná detekce a léčba mohou tedy vést k úsporám pro zdravotnické systémy tím, že se sníží potřeba nákladných léčebných postupů, jako jsou pokročilé chirurgické zákroky, radioterapie, nebo farmakoterapie včetně cílené léčby či moderní imunoterapie.
D – Zvýšení kvality života	Raná detekce a léčba rakoviny mohou vést k lepší celkové kvalitě života pro pacienty, jelikož se minimalizuje riziko vážných komplikací, bolesti a jiných nepříjemných příznaků spojených s pokročilým onemocněním. Pacienti, u kterých

	je rakovina diagnostikována a léčena v raném stádiu, mají často lepší fyzické a psychické prognózy.
E – Prevence určitých typů rakoviny	V některých případech může screening také identifikovat prekancerózní stavy nebo velmi raná stádia rakoviny, což umožňuje intervence, které mohou zabránit rozvoji onemocnění. Například pravidelné cytologické testy (PAP testy) posílené o detekci lidského papilomaviru mohou identifikovat prekancerózní změny na děložním hrdle, což umožňuje léčbu ještě před vznikem invazivní rakoviny.
Screeningové programy musí být pečlivě plánovány a implementovány s ohledem na doporučení založená na důkazech, aby byly efektivní a etické. Kritická je také informovanost a účast cílové populace, jakož i dostupnost následné diagnostické péče a léčby pro ty, u kterých screening odhalí možné onemocnění.	

Koncepce sekundární prevence a zázemí pro plánování a rozvoj programů prevence v ČR

Vláda České republiky v květnu 2025 schválila Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) orgánem odpovědným za koordinaci screeningových programů v České republice. Národní screeningové centrum (nsc.uzis.cz) tak představuje zázemí pro plánování a rozvoj programů prevence a screeningu v ČR. Screeningové programy zaměřené na sekundární prevenci vybraných zhoubných nádorů a jiných vážných onemocnění mohou být významně účinné nejen při snižování nákladné léčebné zátěže systému v.z.p, ale také při snižování úmrtnosti.

Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a kvality řízení screeningových programů v ČR je zásadní erudovaný multidisciplinární tým realizující své činnosti dle vědecky podložené a všeobecně akceptovaného metodického rámce. NSC vytvořilo sérii metodických dokumentů, které definují jednotlivé fáze životního cyklu programů časného záchytu onemocnění, které lze rozdělit do pěti nosných oblastí:

1. Hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu pro podložené zhodnocení jejich přínosů, rizik a nákladové efektivity (tzv. HTA pro screeningy).
2. Postup plánování programu časného záchytu a definice náležitostí pilotního projektu.
3. Soupis nezbytných atributů, podmiňujících implementaci národního programu (doporučený postup, měřitelné indikátory kvality odpovídající mezinárodním doporučením, kritéria pro sítě poskytovatelů atd.).
4. Soupis povinných kroků a atributů monitoringu národního programu.
5. Definice plánu evaluace, metodiky evaluace a evaluační zprávy pro národní program.

Tyto metodické dokumenty jsou aplikovány pro jednotné řízení screeningových programů v ČR a jsou dostupné na webovém portálu NSC. V roce 2024 došlo k aktualizaci metodiky hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu a byly provedeny kroky, aby tato metodika mohla být vydána jako certifikovaná metodika a stala se tak oficiálním návodem pro posuzování vhodnosti zavádění nových postupů pro časný záchyt onemocnění v ČR.

NSC je funkčně rozděleno do dvou oddělení. Jedno se věnuje řízení screeningových programů a tvoří ho projektoví manažeři, koordinátoři screeningových programů, zdravotní specialisté, finanční manažeři, odborníci na komunikaci apod. Druhé oddělení se věnuje sběru, správě, a hodnocení dat a tvoří ho datoví analytici a správci dat. V polovině roku 2025 tým NSC tvoří 40 kmenových zaměstnanců, 25 je součástí Oddělení řízení screeningových projektů a 15 je součástí Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů.

NSC poskytuje metodické, administrativní a analytické zázemí pro řídicí orgány, které jsou zřízeny za účelem odborného zajištění specifických oblastí. Rada Národního screeningového centra zaštiťuje tvorbu koncepčních doporučení v oblasti řízení programů časného záchytu a prevence onemocnění v ČR a kontroluje naplňování národních strategií v této oblasti. Rada NSC se podílí na formulaci strategie Národního screeningového centra. Předsedou Rady NSC je ministr zdravotnictví, místopředsedou je ředitel ÚZIS ČR a tajemníkem je vedoucí Národního screeningového centra. Rada NSC zasedá zpravidla dvakrát ročně a zápisy jsou veřejně dostupné. Řídicí komise screeningových programů jsou zřízeny pro všechny celoplošné screeningové programy příkazem ministra zdravotnictví. Úkolem těchto řídicích komisí je koncepční řízení screeningového programu, koordinace zapojených odborností a průběžný monitoring programu a dále se podílení na tvorbě sítě screeningových pracovišť. Aktuálně je aktivních 7 komisí, které se scházejí dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. V roce 2024 proběhlo celkem 20 jednání screeningových komisí. Všechny zápisy jsou veřejně dostupné. Pracovní skupiny jsou zřizovány pro zajištění odborné garance pilotních projektů nebo specifických oblastí, které NSC realizuje. Pracovní skupiny jsou zřízeny pro každý pilotní projekt, který NSC realizuje.

Soustavné budování komplexní datové základny screeningových programů patří mezi dlouhodobé cíle Národního screeningového centra. Datová základna se opírá o sjednocené datové zdroje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), které jsou doplňovány o další zdroje dat, např. ad hoc sběry dat v rámci pilotních screeningových projektů a programů časného záchytu či demografické údaje o obyvatelstvu zpracovávané Českým statistickým úřadem. V roce 2024 probíhala a v roce 2025 pokračovala příprava screeningových registrů pro jednotlivé populační screeningové programy, které se tak stanou součástí NZIS v rámci nově budovaného Národní registru preventivních a screeningových vyšetření.

NSC vybudovalo a průběžně rozvíjí Datový portál screeningových programů , který je určen pro jejich hodnocení a umožňuje přístup k analýzám výkonnosti a kvality těchto programů až na úrovni regionálních jednotek Správně definovaná, sesbíraná a zhodnocená data jsou velmi důležitým nástrojem pro hodnocení a případnou úpravu stávajících programů a pro hodnocení smysluplnosti zavádění programů nových tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich vysoká nákladová efektivita. V roce 2024 proběhla aktualizace dat a došlo k rozšíření o nové typy datových výstupů.

NSC poskytuje podrobné evaluační zprávy pro řízení kvality a dostupnosti zdravotní péče v oblasti preventivních a screeningových programů. V roce 2024 proběhla řada zásadních analytických výstupů, které mají dopad na organizace screeningových programů v ČR. Lze zmínit některé zásadní evaluace, které měly dopad na organizaci screeningových programů.

- V rámci screeningu karcinomu prsu proběhlo hodnocení dostupnosti mamografického vyšetření a výsledky široké odborné diskuse aktuálně vedou k řízené tvorbě systémových opatření pro zlepšení v této oblasti.
- V rámci screeningu kolorektálního karcinomu proběhlo hodnocení dostupnosti preventivní koloskopie, které vedlo k rozhodnutí o změnách ve strategii screeningu. Od roku 2025 došlo ke sjednocení intervalů TOKS od 50 let na 2 roky (do té doby bylo ve věkové kategorii 50–54 let vyšetření indikováno každý rok), od roku 2026 by mělo dojít ke snížení dolní věkové hranice na 45 let a stanovení horní věkové hranice pro screening na 75 let. V tomto screeningovém programu proběhla také analýza hodnocení výsledků TOKS prováděné praktickými lékaři v ordinaci pomocí tzv. POCT analyzátorů, byla zavedena nová metodika pro externí hodnocení kvality a dále bude rozvíjen reporting a audit ze strany Komise.
- V rámci screeningu karcinomu děložního hrdla bylo rozšířeno testování na papilomavirus v rámci tzv. ko-testingu, které je průběžně monitorováno a v této i dalších oblastech bude rozvíjen monitoring pro registrující gynekology a laboratoře ve screeningu.
- V rámci nově zavedených celoplošných pilotních screeningových programů probíhá průběžný monitoring, řídící komise jsou průběžně informovány a realizují vhodná opatření pro optimalizaci programu před jejich možnou transformací do dlouhodobých programů.

NSC poskytuje koordinační strukturu pro jednotné řízení celoplošných screeningových programů. Základním předpokladem řízení je vhodně nastavený monitoring těchto programů. Možnost evaluace programu jako takového, případně možnost hodnocení konkrétního poskytovatele zdravotních služeb poskytuje možnost zvyšování efektivity a hledání slabých míst a tvorbu systémových opatření pro podporu těchto screeningů. NSC koordinuje jak dlouhodobě zavedené screeningové programy karcinomu tlustého střeva a konečníku, karcinomu děložního hrdla a karcinomu prsu, tak nově zaváděné programy časného záchytu karcinomu plic (od roku 2022) a karcinomu prostaty (od roku 2024). NSC dále v roce 2024 intenzivně připravovalo program časného záchytu výdutě břišní aorty ke spuštění od roku 2025.

Mezi další aktivity NSC v oblasti populačních screeningů je možné zmínit aktivity v oblasti novorozeneckého laboratorního screeningu, kde došlo díky pilotnímu projektu realizovaného NSC k rozšíření o dvě závažná onemocnění SMA (svalová atrofie) a SCID (poruchy imunity). Od roku 2025 NSC koordinuje novorozenecký laboratorní screening. V roce 2024 dále probíhala kultivace screeningu sluchu novorozenců, screeningu sluchu v 5 letech a byl připravován pilot na optimalizaci screeningu sluchu osob od 50 let pro jeho realizaci v roce 2025. Dále probíhal monitoring preventivních vyšetření u dětí, a to poruch autistického spektra a dále očních vad, kde probíhá příprava nástrojů pro zvýšení efektivity tohoto screeningu. NSC se účastnilo diskusí nad vhodností zavedení systémových opatření u dalších postupů pro časný záchyt onemocnění, např. chronického selhání ledvin a dalších vážných onemocnění, což se promítlo do komplexního návrhu implementace doporučení odborné společnosti do praxe i formou nových zdravotních výkonů.

V roce 2024 proběhla řada rozesílek reportů na různé typy poskytovatelů zdravotních služeb. V květnu proběhla rozesílka reportů pro praktické lékaře v ČR stran pokrytí jednotlivými screeningovými výkony na jejich pracovišti (screeningu karcinomu kolorekta, prsu a děložního hrdla). Každý lékař obdržel 3 reporty – jeden pro cervikální, mamografický a kolorektální screening. Reporty byly vypracovány dle míry vykazování pokrytí jednotlivých ordinací. Celkem se jednalo o 4 378 rozesílek. Společně s reporty PL obdrželi i průvodní dopis a dotazník pro zpětnou vazbu ve vztahu ke screeningovým programům (odpověď poslalo 218 lékařů, tj. 5 % z celkového počtu oslovených). Mezi další reporty rozeslané v roce 2024 byly reporty pro praktické lékaře k programu časného záchytu karcinomu plic a ke stejnému screeningu i reporty pro plicní lékaře. V roce 2025 se plánuje rozeslání reportů pro radiologická pracoviště v rámci programu časného záchytu karcinomu plic a karcinomu prostaty, pro praktické lékaře pro děti a dorost stran pokrytí preventivními prohlídkami, pokrytím očkování a screeningových programů, pro ambulantní gynekology stran pokrytí screeningovými programy (screeningová cytologie a HPV vyšetření ve věkových kategoriích 35, 45 a 55 let, pokrytí kolorektálním a mamárním screeningem), a bude zopakován reporting pro praktické lékaře pro dospělé se zapracováním zpětné vazby z rozesílky roku 2024. Dále bude vytvořen reporting pro poskytovatele zdravotních služeb v rámci screeningu sluchu (novorozenecká a ORL pracoviště).

NSC realizovalo, realizuje a připravuje řadu projektů, které jsou v souladu s národními strategiemi v oblasti podpory zdraví a časného záchytu onemocnění. Mezi stěžejní projekty, které umožnily vznik a rozvoj NSC lze uvést projekty *Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění* (2017–2022) a *Datová základna realizace screeningových programů* (2017–2022) financované z Operačního programu Zaměstnanost. Na tyto projekty časově navázaly tři systémové projekty *Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění* (2023–2026), *Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra* (2023–2026) a *Inovativní podpůrný nástroj pro individualizaci preventivní péče* (2024–2028). Projekt Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality screeningu nádorů je financován z Národního plánu obnovy a ostatní projekty jsou financované z Operačního programu Zaměstnanost plus.

NSC se dále věnuje v rámci životního cyklu screeningových programů pilotnímu zavádění a hodnocení potenciálně vhodných opatření pro časný záchyt onemocnění, součástí těchto projektů je komponenta implementačního výzkumu. Projekty se zaměřují na těhotné ženy, na děti, na dospělou populaci, na optimalizaci stávajících screeningových programů, na časný záchyt rizikových faktorů a osob s vyšším rizikem vzniku onemocnění a dále projekty zaměřené na identifikaci a management onemocnění významně snižujících kvalitu života. NSC realizovalo a ukončilo 11 takových pilotních projektů časného záchytu onemocnění (2018–2022), aktuálně probíhá 10 pilotních projektů časného záchytu onemocnění (2023–2028). Všechny aktuální pilotní projekty jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost plus.

NSC se také aktivně účastní řady mezinárodních projektů. NSC se aktivně účastní v rámci vědeckého programu Horizon projektu PHIRI (Population Health Information Research Infrastructure, 2020-2023) ke sdílení a analýze dat o zdravotních systémech. V rámci zdravotnického akčního programu EU4Health se NSC podílí na realizaci rozsáhlého

celoevropského projektu EUCanScreen (European Joint Action on Cancer Screening, 2024-2028), jehož cílem je udržitelná implementace kvalitních screeningových programů. NSC se dále aktivně podílí na realizaci tří projektů zaměřených na podporu pilotování a rozvoje nových screeningových programů, jedná se o oblast screeningu karcinomu prostaty (PRAISE-U, 2023 až 2026) a oblast screeningu karcinomu plic (SOLACE, 2023–2026). Další projekt se věnuje oblasti monitorovaní screeningu karcinomu děložního hrdla a očkovaní proti HPV (lidskému papilomaviru), který může způsobit rakovinu děložního čípku a další vážná onemocnění (projekt PERCH, 2022-2025).

Realizace pilotních projektů je podstatnou částí činností NSC. Spolupracuje na nich s řadou odborných společností. Předměty projektů často vycházejí z dobré zahraniční praxe, doporučených postupů či vědeckých publikací. Cílem realizace pilotních projektů je získání dostatku podkladů pro zvážení vhodného nastavení postupu k časnému záchytu onemocnění v ČR, včetně přípravy modelů pro rozvahu nákladů a přínosů. V rámci ukončených pilotních projektů buď proběhla implementace daného postupu, nebo proběhly či probíhají postupné diskuse k vhodné formě zavedení zkoumaných postupů do praxe.

Důležitou součástí činnosti NSC je získávání příkladů dobré praxe v organizaci a poskytování programů časného záchytu onemocnění ze zahraničí, a naopak sdílení zkušeností s koordinací českých programů. NSC se účastní mezinárodních projektů a zároveň se zapojuje i do dlouhodobých iniciativ mezinárodních organizací a expertních sítí, jejímž výsledkem jsou i datové zdroje, které lze využít pro mezinárodní srovnávání strategií a výsledků. NSC spolupracuje s Eurostatem v oblasti statistických údajů v preventivních službách. NSC dále spolupracuje s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC), v minulosti např. na aktivitě Cancer Screening in Five Continents (CanScreen5), jejíž cílem je harmonizovaně shromáždit informace o charakteristikách a výkonnosti programů screeningu rakoviny na celém světě a šířit tyto informace pro lepší řízení programů a informovanou tvorbu politik. V neposlední řadě se NSC podílelo na přípravě Zprávy o stavu provádění programů screeningu zhoubných nádorů v Evropské unii, která bude v následujících letech aktualizována a do přípravy nového systému se NSC zapojilo v rámci spolupráce s projektem CanScreen-ECIS.

NSC se aktivně účastní v Mezinárodní síti pro screening nádorů (ICSN), která sdružuje odborníky, kteří usilují o snížení celosvětové zátěže zhoubnými nádory prostřednictvím programů screeningu rakoviny založených na důkazech. Již více než 15 let se čeští odborníci zapojují do sdílení zkušeností, přípravy společných publikací a účastní se pravidelných konferencí.

Odborníci z NSC se významně podíleli na přípravě českého předsednictví ve druhé polovině roku 2022, spolupořádali několik odborných konferencí (expertní konference k onkologii, konference PROSTAFORUM) a účastnili se pracovních skupin, které vedly k přijetí doporučení Rady EU o screeningu nádorových onemocnění v prosinci 2022.

NSC se také velmi intenzivně věnuje aktivitám pro podporu prevence onemocnění prostřednictvím elektronizace zdravotnictví. Aktivity NSC jsou tak úzce provázány s týmem Národního centra elektronického zdravotnictví a celou koncepcí elektronizace zdravotnictví.

V rámci elektronizace zdravotnictví Národní screeningové centrum stanovilo následující konkrétní cíle pro posilování sekundární prevence pro podporu zdraví obyvatel:

- Snižování bariér a posilování role jedince v péči o své zdraví (pacient ví na co má nárok, může se jednoduše objednat a vybrat screeningové pracoviště na základě rozvahy čekacích dob a vzdálenosti).
- Zpřístupňování informací lékařům a zvyšování jejich angažovanosti (zpřístupnit informaci, zda má daný pacient nárok na konkrétní vyšetření a sdílet informace o proběhlých vyšetřeních a jejich výsledcích mezi lékaři v reálném čase).
- Nastavení monitoringu a evaluace pro zajištění maximální efektivity (efektivní využití kapacit zdravotního systému a zajištění přímé trajektorie pacienta v systému vč. následných diagnostických a terapeutických úkonů).
- Efektivní využívání finančních zdrojů (omezení duplicitních vyšetření a zvýšení pokrytí screeningů s cílem dlouhodobé nákladové efektivity nejen pro zdravotní systém).

Konkrétní nástroje na podporu preventivních a screeningových programů prostřednictvím elektronického zdravotnictví jsou pak:

- EZKarta (informace o nároku na preventivní a screeningové vyšetření pro jednotlivce, informace o výsledku a základním doporučení, možnost notifikace o účasti na preventivním a screeningovém vyšetření, možnost notifikace o absenci navazující vyšetření apod.).
- Centrální rezervační systém pro všechna screeningové pracoviště s možností propojení s existujícími rezervačními systémy (možnost výběru času a místa, notifikace termínu a možnost pružného přeobjednání).
- Systém pro sdílení dat mezi lékaři v reálném čase (sdílení informace o provedeném vyšetření mezi jednotlivými lékaři, např. praktickým lékařem a registrujícím gynekologem, základní informace o výsledku návazného vyšetření, informace o absenci navazujících vyšetření apod.).
- Systém e-žádanky jako nositel důležitých informací ke screeningovým vyšetřením, např. hodnota výsledku testu na okultní krvácení před následnou kolonoskopií apod.
- Národní registry screeningových programů, jako součást Národního zdravotnického informačního systému (možnost přímého přenosu dat z ambulantních, nemocničních či laboratorních informačních systémů).

Posláním NSC je i předávat informace široké odborné i laické veřejnosti a vzdělávat na všech stupních vzdělání. NSC vytvořilo 2 e-learningové kurzy, jeden byl zaměřen na životní cyklus screeningových programů a druhý na datovou a informační základnu screeningových programů. NSC pořádá samo několik konferencí. Jedná se o konferenci PREVON, jejíž 10. ročních se uskuteční na podzim roku 2025. Na konferencích PREVON jsou pravidelně představovány novinky a aktuální informace o průběhu screeningových programů a souvisejících oblastí a diskutovány možnosti zlepšení dopadů preventivních a screeningových programů. NSC dále realizuje konference zaměřené na „datové audity“ vybraných screeningových programů. Pro program časného záchytu karcinomu prostaty je realizována konference PROSTAFORUM (v roce 2025 proběhne již 4. ročník), pro program časného záchytu

karcinomu plic je realizována konference PNEUMOFORUM (v roce 2025 proběhne 2. ročník) a pro časný záchyt karcinomu prsu se pracovníci NSC aktivně účastní konference Datový audit mamografického screeningu v praxi (v roce 2025 proběhne již 23. ročník). Pracovníci NSC se aktivně účastní významných mezinárodních konferencích jako jsou ISPOR (konference přední odborné společnosti pro ekonomiku zdravotnictví a výzkum výsledků na celosvětové úrovni), ICSN (konference International Cancer Screening Network – Mezinárodní sítě pro screening rakoviny), EAU (konference European Association of Urology – Evropské asociace urologie), ERS (konference European Respiratory Society – Evropské respirační společnosti) aj.

Někteří pracovníci NSC se také podílejí na výuce na lékařských a zdravotnických fakultách (Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví aj.) a podílejí se i na vedení studentských prací na všech akademických úrovních. NSC také umožňuje realizování studentských stáží apod.

Kolektiv NSC se v rámci vlastní vědecké činnosti nebo jako partner dalších vědeckých institucí podílí na výzkumných a publikačních aktivitách. V letech 2017-2024 bylo vydáno na 55 recenzovaných článků (Jimp/Jsc) se zapojením zaměstnanců NSC.

NSC spolupracuje s dalšími vědeckými institucemi nebo odbornými společnostmi, jako jsou např. Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta (společné pracoviště), Společnosti ČLS JEP a další odborná sdružení.

Národní screeningové centrum usiluje o výzkumné aktivity zejména v následujících oblastech:

- Populační a klinická epidemiologie
    - Epidemiologie zhoubných nádorů a populační zátěž
    - Individualizace programů časného záchytu a nové metody
- Modelování a výzkum výsledků zdravotního systému
    - Studie případů a kontrol
    - Matematické modely dopadu a nákladové efektivity
- Hodnocení zdravotnických technologií (HTA)
- Implementační výzkum
    - Pilotní projekty implementace screeningových programů

Dosažené výsledky Národního screeningového centra od roku 2022

Od roku 2022 dosáhlo NSC významných pokroků na poli podpory preventivních a screeningových programů. Odborníci z NSC se významně podíleli na přípravě doporučení Rady EU o screeningu nádorových onemocnění v prosinci 2022. Vláda České republiky v květnu 2025 schválila Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) orgánem odpovědným za koordinaci screeningových programů v České republice.

V rámci organizace dlouhodobě zavedených screeningových programů (karcinom tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla) došlo k nastavení funkční řídící a koordinační struktury v podobě nastavení interních operativních postupů a ustanovení nové pozice kmenových zaměstnanců v roli koordinátorů screeningových programů, ustanovení řídících

komisí screeningových programů a definování krajských koordinátorů pro kontrolu screeningových pracovišť a staly se tak mj. místy prvního kontaktu pro jednotlivá pracoviště (v rámci mamografického a kolorektálního screeningu). Byly nastaveny jasné indikátory kvality a systém zpětné vazby (reporting) pro jednotlivá pracoviště. V jednotlivých screeningových programech došlo na základě podrobné analýzy k dílčím úpravám screeningových strategií (změna intervalu a věku pro kolorektální screening, rozšíření HPV vyšetření pro kohortu žen v 55 letech a rozšíření věkové kohorty pro očkování proti HPV) či organizačních aspektů realizace screeningových programů (vyhodnocování a řešení časové a místní dostupnosti screeningových vyšetření a rozšíření sítě o další pracoviště provádějící preventivní vyšetření (pro mamografická a koloskopická pracoviště). Pro podporu stávající sítě pracovišť poskytující koloskopická vyšetření došlo k vypsání výzvy na podporu technické vybavení pracovišť.

Od roku 2022 byly spuštěny tři nové celoplošné programy časného záchytu onemocnění, konkrétně pro karcinomu plic (od r. 2022), karcinom prostaty (od r. 2024) a aneurysma břišní aorty (od r. 2025) včetně (HTA, budget impact do zdravotního pojištění, rozvaha kapacit apod.), nastavení úhradových mechanismů, monitoringu a podrobné evaluace. V rámci těchto nových programů byly využity zkušenosti z již zavedených programů a byla zajištěna informovanost laické i odborné veřejnosti. Dochází tak k postupnému navyšování zapojených lékařů a počtu vyšetřených osob. Všechny nové programy jsou zavedeny v pilotní iniciální pětileté fázi, v rámci které bude probíhat podrobné vyhodnocení a budou definovány kroky k optimalizaci těchto programů.

Pro nové programy a většinu stávajících programů došlo k vydání nových či aktualizovaných metodických doporučení ve Věstníku MZD. Pravidelně probíhají jednání řídích komisí, které řeší strategické i operativní úkoly a vydávaní doporučení pro vedení MZD. NSC poskytuje datové a odborné podklady pro rozhodování Komisí a vedení MZD.

Mezi další aktivity na podporu prevence lze zařadit aktivity v oblasti novorozeneckého laboratorního screeningu, kde došlo díky pilotnímu projektu realizovaného Národním screeningovým centrem v letech 2022 a 2023 k rozšíření od roku 2024 o dvě závažná onemocnění, konkrétně SMA (svalová atrofie) a SCID (poruchy imunity). Od roku 2022 dále probíhá kultivace screeningu sluchu novorozenců, screeningu sluchu v 5 letech a byl realizován pilot zaměřený na optimalizaci screeningu sluchu osob od 50 let. NSC se dále zaměřilo na monitoring preventivních vyšetření u dětí, konkrétně na poruchy autistického spektra a dále závažných očních vad (VZOV) u dětí. Právě v rámci podpory VZOV došlo k vytvoření nových signálních výkonů a nastavení úhradových mechanismů a vydání metodických doporučení ve Věstníku MZD a nastavení monitoringu a evaluace pro podporu efektivity programu. NSC se aktivně účastnilo diskusí nad vhodností zavedení systémových opatření u dalších postupů pro časný záchyt onemocnění u dospělých osob. Aktivně se podílelo na novelizaci vyhlášky o preventivních prohlídkách a dopomohlo k nastavení dílčích kroků na podporu implementace systematického vyšetřování chronického selhání ledvin včetně nastavení úhradových mechanismů, monitoringu a evaluaci pro podporu efektivity programu v dalším období.

V rámci rozvoje elektronizace zdravotnictví pro podporu prevence onemocnění NSC připravilo ve spolupráci s odbornými společnostmi datové struktury a technické funkcionality, které se stanou základem pro jednotlivé nástroje elektronizace zdravotnictví v oblasti konkrétních

screeningových a preventivních programů. Jedná se konkrétně o EZKartu, která bude obsahovat modul, který bude mj. informovat o nároku na preventivní a screeningové vyšetření pro jednotlivce, o výsledku a základním doporučení, dále bude umožňovat notifikace o účasti na preventivním a screeningovém vyšetření a případně o absenci navazující vyšetření apod. Dalším nástrojem bude Centrální rezervační systém pro všechna screeningové pracoviště s možností propojení s existujícími rezervačními systémy, který bude umožňovat výběr času a místa vyšetření, notifikace termínu a možnost pružného přeobjednání. Zásadním nástrojem pro zvýšení efektivity screeningových programů bude Systém pro sdílení dat mezi lékaři v reálném čase, který bude umožňovat sdílení informací o provedeném vyšetření mezi jednotlivými lékaři, např. praktickým lékařem a registrujícím gynekologem, základní informace o výsledku návazného vyšetření a případně informace o absenci navazujících vyšetření apod. V rámci podpory screeningových programů bude využíván i Systém e-žádanky jako nositel důležitých informací ke screeningovým vyšetřením, např. hodnota výsledku testu na okultní krvácení před následnou kolonoskopií apod. V oblasti monitoringu screeningových programů je zásadním milníkem vznik Národních registrů screeningových programů, které budou součástí Národního zdravotnického informačního systému.

NSC od roku 2022 intenzivně pracuje na využití výsledků pilotních projektů realizovaných v předchozím období a na realizaci nových pilotních projektů, a to ve spolupráci s širokou skupinou odborníků a dalších zainteresovaných subjektů. Kromě pilotních projektů realizuje NSC několik systémových projektů, bez kterých by nebylo možné realizovat systematické a komplexní kroky na podporu preventivních a screeningových programů. Kromě národních projektů NSC zahájilo a realizovalo řadu mezinárodních projektů, které zajišťují soulad národních aktivit s mezinárodními doporučeními a současně čeští odborníci z Národního screeningového centra napomáhají kultivaci této oblasti v rámci mezinárodního společenství.

NSC se od roku 2022 aktivně zapojilo v rozvoji vědy a publikace odborných článků. Od roku 2022 bylo publikováno 23 mezinárodních odborných článků s účastí odborníků z NSC. Byla založena tradice odborných setkávání v rámci několika odborných konferencí. Odborníci NSC se aktivně zapojili do programu významných mezinárodních konferencí jako European Respiratory Society Congress, European Association of Urology congress, ISPOR Europe conference nebo Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. Tímto se NSC dostalo za poslední období do role uznávaného partnera pro mezinárodní instituce a zahraniční odborníky pro tvorbu partnerských spoluprací.

Plánované aktivity NSC v následujícím období

Aktivity NSC v následujícím období souvisí s naplňováním strategických dokumentů MZ a plněním funkční náplně odboru.

V oblasti **podpory populačních programů screeningu zhoubných nádorů** NSC bude pokračovat v dopracování akčních plánů a jejich schválení a v realizaci dílčích úkolů na podporu kvality screeningů karcinomů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla vč. podpory očkování proti HPV dle schválených plánů.

V oblasti **organizační podpory nově zaváděných screeningových programů** NSC bude plnit dílčí úkoly pro podporu implementace metodických postupů, účasti pacientů a efektivní trajektorie pacientů v programech časného záchytu karcinomu plic, prostaty a výdutě břišní aorty v rámci jejich pilotní fáze realizace. Zejména u programu časného záchytu karcinomu plic provede podrobné vyhodnocení dosavadních výsledků včetně ekonomické rozvahy a HTA a zajistí širokou odbornou diskusi na další podobou programu po pilotní fázi.

V oblasti **posílení organizace novorozeneckého laboratorního screeningu** NSC vytvoří Komisi pro novorozenecký laboratorní screening a zajistí její efektivní fungování. Bude pokračovat v nastavování systému monitoringu novorozeneckého laboratorního screeningu a provede kroky k otestování resortního identifikátoru pro zvýšení efektivity předávání informací mezi porodnicí a screeningovou laboratoří.

V oblasti **posílení organizace programů prevence u dětí** NSC bude realizovat kroky k podpoře efektivity screeningu poruch sluchu, včasného záchytu očních vad a časného záchytu dalších onemocnění. V oblasti **posílení organizace programů prevence u dospělých** NSC bude realizovat kroky k efektivnímu využívání preventivních prohlídek, prevenci kardiometabolickorenálních onemocnění a dalších kroků k časnému záchytu vážných onemocnění v dospělém věku.

NSC bude pokračovat v **realizaci implementačního výzkumu**. Budou realizovány aktuálně řešené pilotní projekty ve spolupráci se všemi zainteresovanými odbornými společnostmi. Bude pokračovat vhodná aplikace výsledků projektů z předchozího programového období na základě odborných doporučení, konsensu všech zainteresovaných odborných společností, doporučení Rady NSC, rozhodnutí MZ a akceptace zdravotních pojišťoven. Také budou realizovány nově zahájené pilotních projekty zaměřených na podporu plicního zdraví v ČR a podporu diagnostiky a léčby karcinomu pankreatu včetně organizační podpory Komise pro podporu diagnostiky a léčby karcinomu slinivky břišní.

NSC bude pokračovat v **realizaci stěžejních projektů pro podporu screeningu v ČR**. NSC zajistí plnění klíčových aktivit tří stěžejních projektů na podporu screeningu v ČR (*Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra*, *Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění* a *Inovativní podpůrný nástroj pro individualizaci preventivní péče v České republice v oblasti vážných onemocnění*). Důležitou součástí je i zajištění udržitelnosti systémových procesů, které vzešly z realizace těchto projektů.

V oblasti **rozvoje prvků elektronizace pro podporu prevence a screeningu v ČR** NSC vytvoří a bude dále rozvíjet:

- národní registry pro jednotlivé preventivní a screeningové programy, které budou součástí NZIS a zajistí jejich pravidelné hodnocení a širokou odbornou diskusi,
- sdílený zdravotní záznam pro preventivní a screeningové programy,
- centrální rezervační systém pro možnost výběru pracoviště a termínu na preventivní a screeningové vyšetření,
- modul Preventivních a screeningových vyšetření v rámci EZKarty.

V oblasti **rozvoje mezinárodní spolupráce** v rámci akčního programu EU4Health NSC zajistí plnění projektů PRAISE-U, SOLACE, PERCH a EUCanScreen a bude pokračovat v rozvoji spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti sekundární prevence.

NSC dále zajistilo **etablování Národního screeningového centra**, jako koordinátora screeningových programů v ČR a tím mimo jiné naplnilo milník Národního plánu obnovy včetně zajištění jeho udržitelnosti.

Realizované kroky a plnění cílů koncepce do roku 2025

Celkový souhrn realizovaných opatření

- Iniciace a informační podpora orgánů pro řízení screeningových programů (Rada NSC, komise pro existující programy screeningu, komise k perspektivním programům časného záchytu)
- Podpora populačních programů screeningu zhoubných nádorů vč. zveřejnění evaluačních zpráv zavedených screeningových programů
- Podpora a zvyšování efektivity dalších preventivních postupů o těhotné ženy, děti a dospělé osoby
- Průběžná aplikace výsledků realizovaných pilotních projektů časného záchytu onemocnění
- Příprava nových perspektivních pilotních projektů časného záchytu onemocnění ve fázi implementačního výzkumu
- Příprava a realizace projektů pro podporu datového zázemí a komunikace screeningu a prevence onemocnění
- Posílení organizace novorozeneckého laboratorního screeningu a úspěšně dokončení pilotního programu screeningu SMA (spinální svalové atrofie) a SCID (vrozené těžké poruchy imunity), který je zaveden do běžné praxe od ledna 2024
- Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci akčního programu EU4Health (PRAISE-U: pilotování programu screeningu karcinomu prostaty, SOLACE: pilotování programu screeningu karcinomu plic, PERCH: podpora očkování proti HPV a nová společná akce EUCanScreen na podporu populačních screeningových programů)

Cíle strategie do roku 2025

1. Plně funkční Národní screeningové centrum jako mezinárodně uznávané a Vládou ČR schválené těleso institucionalizující a garantující udržitelnost běžících programů prevence a odpovědnou implementaci programů nových včetně vybudovaného informačního zázemí
2. Připravené technické řešení sběru dat základních prediktorů zdravotního stavu obyvatel u praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost, které se stanou trvalou součástí monitoringu stavu dospělé a dětské populace a budou sloužit jako podklad při navrhování vyhodnocování efektivity zdravotních politik, zejména preventivních programů.

3. Zavedený systém bonusů zdravotních pojišťoven umožňující individuální účty pacientů s vyhodnocováním účasti na preventivních programech
4. Pravidelný a rutinně realizovaný systém kontroly kvality a nákladové efektivity preventivních programů, včetně plošných screeningů

Specifické cíle v oblasti screeningových programů do roku 2025

1. Vytvořený proces pro zavádění nových screeningových programů včetně metodického ukotvení hodnocení zdravotnických technologií (HTA) pro screeningové programy
2. Spuštěný program screeningu aneurysmatu abdominální aorty od roku 2025
3. Implementovaný a funkční nový plošný program včasného záchytu nádorů prostaty
4. Plně funkční program časného záchytu karcinomu plic a vhodné provázání s časným záchytem chronických plicních nemocí vč. posílení intervence k zanechání kouření
5. Spuštěný pilotní program primární péče prevence obezity u dětí a dalších minimálně 5 inovativních programů prevence vážných onemocnění
6. Dokončený odborný návrh pro zavedení screeningu familiární hypercholesterolémie
7. Vyvinutý a implementovaný zcela nový informační sytém pro řízení a hodnocení preventivních programů, včetně sdíleného zdravotního záznamu pro screeningové a preventivní programy a centrálního systému objednávání občanů k prevenci
8. Vytvořená koncepce a technické zázemí pro organizaci novorozeneckého laboratorního screeningu
9. Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci akčního programu EU4Health

Vybrané publikace s účastí Národního screeningového centra ÚZIS ČR

- Chloupková R, Benáček P, Ngo O, Hejduk K, Májek O. Národní screeningové centrum: Datový portál screeningových programů [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2022. Dostupné z: https://nsc.uzis.cz/data. Vývoj: Národní screeningové centrum ÚZIS ČR. ISSN 2788-2888
- Beyer K, Leenen R, Venderbos LDF, Helleman J, Denijs F, Bramer W, Vasilyeva V, Briers E, Rivas JG, Chloupkova R, Majek O, Annemans L, Vynckier P, Basu P, Chandran A, van den Bergh R, Collen S, van Poppel H, Roobol MJ, On Behalf Of The Praise-U Consortium. Health Policy for Prostate Cancer Early Detection in the European Union and the Impact of Opportunistic Screening: PRAISE-U Consortium. Journal of Personalised Medicine 2024; 11(1): 84.
- Ngo O, Chloupková R, Cibula D, Sláma J, Mandelová L, Hejduk K, Hajdúch M, Minka P, Koudeláková V, Jaworek H, Trnková M, Vaněk P, Dvořák V, Dušek L, Májek O. Direct mailing of HPV self-sampling kits to women aged 50-65 non-participating in cervical screening in the Czech Republic. European Journal of Public Health 2024;34(2):361-367.
- Májek O, Babjuk M, Roobol MJ, Bratt O, Van Poppel H, Zachoval R, Ferda J, Koudelková M, Ngo O, Gregor J, Collen S, Hejduk K, Dušek L, Válek V. How to follow the new EU Council recommendation and improve prostate cancer early detection: the Prostaforum 2022 declaration. European Urology Open Science 2023; 53: 106-108

- Ngo O, Hejcmanová K, Suchánek Š, Pehalová L, Dušek L, Zavoral M, Bureš J, Seifert B, Hejduk K, Král N, Májek O. Coverage by examinations associated with early detection of colorectal neoplasia in the Czech Republic. European Journal of Public Health 2023; 33(3): 515-521.
- Ngo O, Chloupková R, Suchánek Š, Ambrožová M, Hejcmanová K, Dvořák P, Zavoral M, Hejduk K, Dušek L, Májek O. Výsledky z evaluace screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2023; 77(5): 385-393.
- Chloupková R, Ngo O, Suchánek Š, Zavoral M, Martykánová L, Hejduk K, Májek O. Program kolorektálního screeningu v České republice – hodnocení výkonnosti center za rok 2021. Gastroenterologie a hepatologie 2022; 76(5): 379-385.
- Cardoso R, Guo F, Heisser T, Hackl M, Ihle P, De Schutter H, Van Damme N, Valerianova Z, Atanasov T, Májek O, Mužík J, Nilbert MC, Tybjerg AJ, Innos K, Magi M, Malila N, Bouvier AM, Bouvier V, Launoy G, Woronoff AS, Cariou M, Robaszkiewicz M, Delafosse P, Poncet F, Katalinic A, Walsh PM, Senore C, Rosso S, Vincerzevskiene I, Lemmens VEPP, Elferink MAG, Johannesen TB, Korner H, Pfeffer F, Bento MJ, Rodrigues J, da Costa FA, Miranda A, Zadnik V, Zagar T, Marques ALD, Marcos-Gragera R, Puigdemont M, Galceran J, Carulla M, Chirlaque MD, Ballesta M, Sundquist K, Sundquist J, Weber M, Jordan A, Herrmann C, Mousavi M, Ryzhov A, Hoffmeister M, Brenner H. Colorectal cancer incidence, mortality, and stage distribution in European countries in the colorectal cancer screening era: an international population-based study. Lancet Oncology 2021; 22(7): 1002-1013.
- Pehalová L, Krejčí D, Svobodová I, Ngo O, Májek O, Mužík J, Dušek L. Epidemiologie novotvarů prsu v době organizovaného screeningového programu v České republice. Onkologie 2020; 14(4): 142-147.
- Májek O, Anttila A, Arbyn M, van Veen EB, Engesaeter B, Lonnberg S. The legal framework for European cervical cancer screening programmes. European Journal of Public Health 2019; 29(2): 345-350.

Kapitola III. Dostupnost, kvalita a standardizace péče

Zásadní krok k posílení kvality péče: ustavení Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ)

https://nzip.cz/koncepce2025#kvalita

V roce 2023 zahájil svou činnost nově ustavený Národní institut kvality a excelence zdravotnictví NIKEZ, ustavený za účelem zabezpečení činností souvisejících s řízením a hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. NIKEZ pracuje v rámci řídících struktur Ministerstva zdravotnictví ČR jako vývojové a metodické centrum, jehož primární činností je optimalizace, rozvoj a zajištění udržitelnosti národního systému posilování a hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Oblast hodnocení kvality tak získala dosud chybějící zastřešující institucionální a odborné zázemí a vedení. Plnou funkčnost NIKEZ dokládají konkrétní výstupy, mezi které patří mimo jiné zcela nová metodika akreditace a hodnocení kvality center vysoce specializované péče, nová metodika a elektronizace agend tvorby doporučených postupů, rozvoj systému hlášení nežádoucích událostí, a další. NIKEZ od roku 2023 vybudoval silnou síť pro mezinárodní spolupráci, včetně založení českých center Cochrane, Grade a JBI. Ustavení NIKEZ a mezinárodní obhajoba jeho metodických produktů vyvrcholila pořádáním globální konference Global Evidence Summit (GES 2024) v Praze.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Při péči o pacienty je nutné myslet na dostupnost a kvalitu péče, a to zejména v kontextu kvality života pacientů. České zdravotnictví potřebuje velmi naléhavě implementovat komplexní systém řízení a hodnocení kvality, včetně nastavených mechanismů standardizace obsahu zdravotní péče. To samozřejmě neznamená, že by se kvalita vůbec nesledovala nebo že by péče byla nekvalitní. Avšak v řadě dílčích aspektů je systém neoptimalizovaný a dílem i selhává. Jako příklad můžeme uvést dostupnost péče, která je nepochybně jedním z povinných parametrů funkčních systémů hodnocení kvality péče. V ČR stále vidíme velmi významné rozdíly v reálné regionální dostupnosti některých segmentů péče. Síť nemocnicích zařízení s urgentním příjmem poskytujících akutní péči a počet pracovišť s nasmlouvanými JIP je dle dostupných dat vůbec nejhustší v EU. Vytvoření stejné sítě dostupných ambulantních specialistů se ale řešilo jen minimálně a pouze v některých oborech. Výsledkem je asymetrická distribuce kapacit mezi

regiony, přičemž reálná kapacita některých velmi důležitých odborností v čase spíše klesá (psychiatrie, diabetologie). V případě primární péče, především co se týče stomatologie, praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, se tvorba dostupné sítě v minulosti neřešila vůbec.

Kvalita péče se přitom odvíjí od dostupnosti správné péče, ve správný čas a na správném místě. Součástí jejího řízení tak musí být i nastavování a sledování optimálních trajektorií pacienta systémem vzájemně na sebe navazujících služeb, implementace, dodržování a hodnocení doporučených postupů. Na konci celé hierarchie jsou pak samozřejmě indikátory výkonnosti a kvality jako měřitelné a hodnotitelné statistiky. Důraz na takto komplexní hodnocení kvality dostupné a obsahově standardizované péče ale nebyl kladen vlastně nikdy. Kvalitu poskytované péče komplexně nehodnotí ani stát, ani pojišťovny a ani odborné společnosti či ČLK. Různé žebříčky hodnocení nemocnic nemají s kvalitou poskytované péče nic společného a jsou většinou zavádějící a matoucí.

Jako příklad lze uvést radiologii. Před více než patnácti lety vznikly Národní radiologické standardy a formou klinických auditů začala probíhat kontrola poskytovatelů. Ministerstvo ale tento projekt nikdy nedokončilo a nedovedlo k implementaci. Dalšími dílčími kroky se postupně realizuje vydávání doporučených postupů. Agentura pro zdravotnický výzkum začala před řadou let realizovat spolu s ÚZIS projekt Klinických doporučených postupů. Tyto doporučené postupy jsou známé v mnoha zemích (např. Francie, Anglie, Německo) jako postupy definující nepodkročitelné standardy poskytované péče. Zatímco vyspělé zdravotnické systémy disponují až několika tisíci vydaných a sledovaných standardů, v ČR tato agenda řízeně vzniká až nyní. Dalšími příklady mohou být standardy pro akutní lůžkovou péči dle systému DRG, existují i standardy pro screeningová vyšetření, kde dokonce probíhá pravidelná kontrola kvality prováděného screeningu na jednotlivých pracovištích. Vzorovým příkladem jsou pravidelné audity mamografických screeningových pracovišť.

Problém je ale v komplexnosti systému hodnocení a v jeho důsledné implementaci, resp. vymahatelnosti. MZ nikdy nezavedlo komplexní systém hodnocení kvality, který by tyto jednotlivé dílčí kroky propojil. Stejně tak nikdy MZ nepřistoupilo k hodnocení pracovišť a nikdy nemělo ambici zveřejnit adresné informace o kvalitě péče. Například u center vysoce specializované péče, která musí být standardizovaná a nabízená v garantované kvalitě, je toto velmi zarážející. Tím pádem se občan – pacient neorientuje podle kvality poskytované péče, ale zajímá ho především dostupnost péče bez ohledu na poskytovanou kvalitu a obsah péče. Přitom monitorování základní úrovně péče ukazuje na významné rozdíly v kvalitě, a mnohdy i obsahu, péče mezi jednotlivými regiony nebo centry.

Proto je vitálně důležité připravit a implementovat konsolidovanější a ambicióznější systém k monitorování kvality a zlepšování zdravotní péče na systémové úrovni, aby byla zaručena její udržitelnost v budoucnosti. K tomu nezbytně potřebujeme centrální řídící strukturu, dostatečně personálně zabezpečenou a kompetentní k zajištění celého systému v potřebné komplexnosti a funkčnosti.

Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) https://nikez.mzcr.cz/

Viz též nové přílohy kapitoly č. 1–3.

Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) byl ustaven rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 19. 1. 2023 za účelem zabezpečení činností souvisejících s řízením a hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. NIKEZ pracuje v rámci řídících struktur Ministerstva zdravotnictví ČR jako vývojové a metodické centrum, jehož primární činností je optimalizace, rozvoj a zajištění udržitelnosti národního systému posilování a hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. NIKEZ je řízen Výkonnou radou, která sdružuje expertní vedení vybraných odborů a přímo řízených organizací ministerstva. Ústředním orgánem NIKEZ je Řídicí rada sdružující vedoucí zástupce všech resortních subjektů a institucí relevantních pro řízení a optimalizaci systému poskytování zdravotních a zdravotně sociálních služeb.

Všechny agendy řešené v rámci činnosti NIKEZ směřují k budování národního systému zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb a jejich hodnocení. Relativně široké zaměření činnosti NIKEZ vychází z vědecky prokázaného faktu, že efektivní je pouze komplexní systém hodnocení více ukazatelů, který zlepšuje dostupnost zdravotních služeb v místě a čase, a zároveň vede k účinné prevenci nežádoucích událostí a dalších projevů nekvality. Dosažení potřebné úrovně kvality musí být nadto přímo či nepřímo provázáno s úhradovými mechanismy, neboť jen tak lze pro kontinuálně zlepšující se systém zaručit dlouhodobou udržitelnost. Efektivní naopak není dílčí hodnocení jednotlivých indikátorů bez následných kontrolních mechanismů zaměřených na dostupnost, organizaci a úhradu péče; takové hodnocení do značné míry pouze administrativně zatěžuje klinickou praxi. Analýzy ekonomického zajištění zdravotních služeb a kapacit poskytovatelů proto musí být nedílnou součástí každého funkčního systému hodnocení, který navíc musí realisticky reflektovat aktuální zdravotní, technologickou a socioekonomickou situaci dané země.

Věcnou náplň činnosti NIKEZ a s tím související provozní agendy tak zajišťují příslušné odbory ministerstva a ministerstvem přímo řízené organizace. Výstupy jsou předkládány Řídicí radě NIKEZ a její náměty a připomínky ministerstvo přijímá jako velmi zásadní vstupy do strategických koncepčních programů a do připomínkových a recenzních řízení. Závěry činnosti NIKEZ jsou dále projednávány, případně schvalovány Vědeckou radou MZ ČR. Tímto způsobem ministerstvo posiluje nejen metodickou a publikační podporu v této oblasti, ale také informovanost napříč klíčovými institucemi resortu, odbornými společnostmi a profesními komorami.

Ustavení NIKEZ a implementace komplexního systému řízení kvality zdravotních služeb naplňují hlavní cíle programu Zdraví 2030, Národního plánu obnovy a Programového prohlášení vlády ČR. Jde zejména o následující oblasti:

- Zvyšování kvality péče včetně sledování indikátorů kvality
- Zvýšení podílu do praxe zavedených doporučených postupů, kompetencí a vzdělávacích plánů přizpůsobených aktuálním podmínkám a rozvoji oboru

- Vytvoření a rozvoj datové základny pro všechny relevantní dimenze hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
- Integrace ekonomických dat vztahujících se ke všem relevantním dimenzím příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění
- Příprava a aplikace modelů predikce ekonomických dopadů nových technologií a zavádění inovací ve zdravotnictví
- Vytvoření informačního systému postaveného na meziresortní integraci dat pro účely optimalizace dostupnosti a kvality zdravotně sociálních služeb
- Posílení meziresortní spolupráce při optimalizaci segmentu zdravotně sociálních služeb
- Vytvoření modelů udržitelného financování systémů integrované péče, komunitní psychiatrické péče a domácí péče

Metodická činnost NIKEZ je v oblastech týkajících se praktické implementace důsledně technologicky neutrální a nijak neomezuje zapojení relevantních institucí a subjektů do procesů posilujících kvalitu a bezpečí zdravotních služeb pro pacienty. V koncepci činnosti jsou samozřejmě jasně definovány role centrálních institucí resortu, centrální referenční datové zdroje a platné zákonné normy, které musí být respektovány. Naplňování vlastního systému hodnocení však zůstává široce otevřené pro všechny typy poskytovatelů, odborné společnosti, profesní komory či externí dodavatele hodnotících služeb. To platí zejména pro tvorbu a aktualizaci doporučených postupů, operativních doporučení a vývoj či hodnocení indikátorů kvality zdravotních služeb, které lze zajistit pouze se zapojením odborných společností, komor, poskytovatelů a dalších relevantních subjektů. Výstupy činnosti NIKEZ určují povinná pravidla hodnocení a nositele centrálních metodických a organizačních pravomocí, v implementaci však systém spoléhá na zapojení všech subjektů angažovaných v poskytování zdravotních a zdravotně sociálních služeb. Významným prvkem je rovněž zapojení pacientských organizací.

Nově implementovaný komplexní systém posilování a hodnocení kvality péče a bezpečí pacientů

Návrh koncepce vychází z vědecky prokázaného faktu, že efektivní je pouze komplexní systém hodnocení více ukazatelů, který posiluje dostupnost zdravotních služeb v místě a čase, a zároveň vede k účinné prevenci nežádoucích událostí a dalších projevů nekvality. Dosažení potřebné úrovně kvality musí být nadto přímo či nepřímo provázáno s úhradovými mechanismy, neboť jen tak lze pro kontinuálně zlepšující se systém zaručit dlouhodobou udržitelnost. Efektivní naopak není dílčí hodnocení jednotlivých indikátorů bez následných kontrolních mechanismů zaměřených na dostupnost, organizaci a úhradu péče; takové hodnocení do značné míry pouze administrativně zatěžuje klinickou praxi. Ekonomické zajištění zdravotních služeb a optimalizace kapacit poskytovatelů proto musí být nedílnou součástí každého funkčního systému hodnocení, který musí realisticky reflektovat aktuální zdravotní, technologickou a socioekonomickou situaci v populaci.

Klíčové komponenty, o které se nově navržený národní systém posilování a hodnocení kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů opírá:

- **Rozvoj legislativně ukotvené datové a informační základny**

- Systém hodnocení se opírá o dobudovaný Národní zdravotnický informační systém (NZIS), jehož komponenty mají pro hodnocení kvality zdravotních služeb legislativně ukotvený mandát. NZIS umožňuje jednak komplexní analýzy činnosti a výsledků péče poskytovatelů, jednak analýzy zaměřené na pacienty, tedy zejména hodnocení trajektorií pacientů v systému a reprezentativní hodnocení dostupnosti péče. Komponenty (dílčí registry) NZIS umožňují exaktní analýzy obsahu zdravotních služeb na úrovni záznamů jednotlivých případů, hodnocení krátkodobých i dlouhodobých výsledků péče a případných komplikací s péčí spojených. U závažných onemocnění a terminálních stavů chorob jsou dostupná plně reprezentativní data o mortalitě pacientů, případně data o úrovni přežití dosahovaného za určitý časový interval.

- **Standardizace obsahu péče a podpora integrovaných modelů péče, zejména tvorba a implementace doporučených postupů a operativních doporučení**
  - Základním nástrojem pro zlepšování kvality zdravotních služeb je implementace doporučených postupů, která je založena na garanci relevantních odborných společností. Doporučené postupy (DP) a Operativní doporučení (OD) založené na vědeckých důkazech garantují a posilují bezpečnost, kvalitu a rovný přístup ke zdravotním službám v ČR. DP a OD přímo podmiňují kontrolu kvality prostřednictvím nastavených a sledovaných indikátorů kvality v rámci oblastí medicíny, pro které jsou DP a OD vytvářeny a implementovány.
  - Implementace DP a OD je také podmínkou optimalizace mezioborové návaznosti péče a implementace integrovaných modelů péče. Konkrétními příklady jsou: zajištění rychlé a účinné diagnostiky vážných onemocnění po preventivních vyšetřeních nebo po záchytech ve screeningových programech; komplexní organizace komunitní psychiatrické péče; zajištění péče v závěru života u chronických pacientů s očekávatelným úmrtím.

- **Management interního hodnocení kvality péče: systém hlášení, hodnocení a prevence nežádoucích událostí, hodnocení spokojenosti pacientů**
  - Funkčnost „lokálních“ systémů managementu kvality je jedním z pilířů navržené koncepce, neboť zahrnuje zcela zásadní komponenty hodnocení a řízení poskytovaných zdravotních služeb:
    - Lokální sběr dat pokrývající zásadní segmenty péče u poskytovatelů a jejich hodnocení.
    - Ustavené pozice (příp. týmy) metodiků, manažerů kvality na lokální či regionální úrovni a jejich činnost.
    - Tvorbu metodických materiálů směřujících k odstranění slabých míst v systému a k posílení kvality, jejich zpětné hodnocení na základě dat.
  - Sledování nežádoucích událostí (NU) v klinické praxi, jejich incidence a vypořádání vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ze dne 9. června 2009 (2009/C 151/01). Navržená koncepce se v této oblasti opírá o funkční český Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU), který dlouhodobě pokrývá všechny výše uvedené oblasti.

- SHNU je jedinečným dlouhodobě ověřeným a funkčním systémem (kontinuální rozvoj od roku 2014). S ohledem na jeho koncepci sdíleného učení a šíření dobré praxe v podmínkách lůžkové péče (akutní, následné i dlouhodobé) je zcela unikátní i ve srovnání v rámci centrální Evropy. Zahrnuje jak kontinuální metodickou podporu s využitím jednotné terminologie (International Classification for Patient Safety) a nomenklatury nežádoucích událostí, tak zároveň vytváří dlouhodobě prostor pro prevalenční sběr dat a jistou formu benchmarkingu ve srovnatelných skupinách PZS. Zároveň poskytuje veřejně dostupná anonymizovaná data pro laickou populaci (příjemce péče, decizní sféru apod.). Právě metodická podpora a koncepční činnost ve spolupráci s oprávněnými zástupci PZS, snaha o kontinuální kultivační procesy a nerepresivní charakter spolupráce významně pozitivně ovlivňují primárně limitující faktor self-reportingu.

- **Systémy interního a externího datového hodnocení zdravotních služeb**
  - Číselné hodnocení ukazatelů výkonnosti, dosahovaných výsledků a kvality směřuje dle navržené koncepce k referenčním hodnotám umožňujícím srovnávání pozice poskytovatelů v dané dimenzi hodnocení.
  - Základem datových auditů je interní sebehodnocení, tedy srovnávání své pozice proti referenčním hodnotám ČR či mezinárodním.
  - Nosným prvkem nové formy externího datového hodnocení a komunikace budou Resortní referenční statistiky (RRS), u kterých se vzhledem k již potvrzenému legislativnímu zázemí předpokládá plné zveřejňování až na úroveň jednotlivých poskytovatelů. Resortní referenční statistiky jsou zcela novým institutem, který je upraven v § 73a zákona o zdravotních službách.
- **Institucionalizace hodnocení s primárním zaměřením na centra vysoce specializované péče**
  - Základní organizační jednotkou navrženého systému je Národní institut kvality a excelence ve zdravotnictví (NIKEZ) jako společné pracoviště MZ ČR a ÚZIS ČR. NIKEZ bude vybaven Výkonnou radou a (národní) Řídící radou, které budou ve spolupráci se všemi relevantními subjekty stanovovat priority hodnocení, nastavovat pravidla řízení a hodnocení a potvrzovat metodická doporučení. Závěry činnosti NIKEZ bude ročně projednávat a schvalovat Vědecká rada MZ ČR.
- **Posilování legislativního zázemí**
  - Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v současné době upravuje hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb externí osobou na základě oprávnění vydaného MZ (§ 98 až § 106) a dále interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (§ 47 odst. 3 písm. b). Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality (ISHK) dle cit. zákona stanovuje MZ ČR s povinností uveřejnit je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách. IHK je ve Věstníku MZ nyní postaveno výlučně na principu sebehodnocení s tím, že výstupy jsou určeny výhradně pro interní potřebu poskytovatele.

    - V první fázi tak návrh předpokládá úpravu a doplnění požadavků ze strany MZ ČR a jejich publikaci ve Věstníku MZ o dosud chybějící kontrolní mechanismus pro revizi naplňování IHK poskytovatelem, a to s nastavením pravidel pro možnost (dobrovolný proces) získání certifikace od MZ ČR.
    - Navazující fází by měla být změna zákona o zdravotních službách, upravující tzv. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, s posílením garance státu/MZ ČR za kvalitu poskytované péče konkrétními poskytovateli.
- **Komunikace, vzdělávání a informační servis**
    - Navržená koncepce pracuje se třemi základními komponentami (nosiči) pro publikaci a komunikaci výstupů hodnocení a analýz:
        - Samostatná řada Věstníků MZ ČR věnovaná doporučeným postupům, metodikám, hodnocení kvality a akreditacím / certifikacím
        - Národní zdravotnický informační portál (NZIP) jako zavedená platforma pro komunikaci hodnocení a statistik s odbornou a zejména laickou veřejností
        - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) jako systém umožňující vnitřní benchmarking poskytovatelů a komunikaci datových map s veřejností (dostupnost péče, regionální sítě apod.)

Respekt k právům pacientů namísto přebujelé administrativy

V kontextu zdravotnické praxe byla iniciativa na prosazování kvality a bezpečnosti péče, stejně jako princip informovaného souhlasu, často redukována na administrativní povinnost vyplňování rozsáhlých formulářů. Tato situace nepřináší přidanou hodnotu pacientům, frustruje lékaře a generuje nadměrnou byrokracii. Dalším cílem navržené koncepce je zjednodušení a standardizace procesu informovaného souhlasu, který povede k větší efektivitě a snížení administrativního zatížení, čímž se zlepší celková zkušenost jak pro pacienty, tak pro zdravotnické pracovníky.

V rámci posílení práv pacientů dojde k dalšímu rozvoji funkce nemocničního ombudsmana. Tato role je klíčová pro zajištění efektivního a spravedlivého řešení stížností v rámci zdravotnických zařízení. Ombudsman bude sloužit jako primární kontaktní bod pro zachycení pacientských stížností, čímž uleví zdravotnickému personálu a pacientům od administrativního a emocionálního břemene spojeného s vyřizováním sporů. Současně bude mít za úkol identifikovat a navrhovat zlepšení procesů v zdravotnických zařízeních, aby se zvýšila celková kvalita poskytované péče.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Programové cíle NIKEZ a jejich plnění detailně shrnuje příloha č. 3 kapitoly.

Obsah nové strategie resortu v oblasti kvality a standardizace péče zahrnuje zejména následující programové cíle:

1. Agenda EBM: Doporučené postupy / operativní doporučení
2. Management kvality, interní hodnocení sledování a prevence nežádoucích událostí
3. Metodika akreditace a hodnocení CVSP (center vysoce specializované péče)
4. Indikátory kvality, externí hodnocení, resortní referenční statistiky, HSPA
5. Datové hodnocení dostupnosti a kvality zdravotních a zdravotně sociálních služeb
6. Hodnocení výkonnosti a kvality programů prevence
7. Systém hodnocení a predikce potřebných personálních kapacit
8. Systém hodnocení nákladové a obsahové heterogenity akutní lůžkové péče, CZ-DRG

Cíle strategie do roku 2025 a jejich plnění

1. Ustavení NIKEZ a zajištění jeho plné funkčnosti ve výše uvedených dimenzích
    - NIKEZ byl ustaven a jeho činnost je plně funkční, včetně již pravidelné realizace a publikace nově vytvářených doporučených postupů a operativních doporučení
2. Naplnění programových cílů NIKEZ (viz příloha)
    - Programové cíle NIKEZ jsou plněny, jak dokládá příloha č. 3 kapitoly
3. Vydání nové metodiky akreditace a hodnocení center vysoce specializované péče a implementace nového systému interního a externího hodnocení kvality
    - Metodika akreditace a hodnocení CVSP byla nově vydána a je naplňována, mimo jiné např. při akreditaci center vysoce specializované chirurgické péče, komplexních onkologických center, traumacenter apod.
4. Zavedený systém vydávání řádně obsahově a metodicky garantovaných doporučených postupů a operativních doporučení, včetně systému jejich standardizované centrální evidence
    - Dle nově vydané a široce mezinárodně recenzované a obhájené metodiky jsou pravidelně vydávány nové DP/OD – viz též souhrn v příloze 2 kapitoly
5. Zavedený systém přípravy, hodnocení a aktualizace indikátorů výkonnosti a kvality, včetně publikace v podobě Resortních referenčních statistik
    - Dle nově vydaných metodik jsou vyhodnocovány a vydávány nové sady indikátorů kvality, mimo jiné podporující akreditaci center vysoce specializované péče
6. Nastavení auditů screeningových pracovišť, center, využití přístrojů schválených akreditační komisí, externích klinických auditů podle NRS, akreditovaných pracovišť
7. Pravidelná prezentace výsledků těchto auditů na konferenci NIKEZ a na stránkách MZ
    - Každoročně je pořádána již tradiční národní konference NIKEZ a tým NIKEZ se zapojuje a pořádá i významné mezinárodní akce a konference (nejvýznamnějším krokem pro internacionalizaci činnosti NIKEZ byla konference GES 2024)

Další cíle rozvoje NIKEZ v roce 2025

1. Příprava a vydání dalších sad doporučených postupů a operativních doporučení ve více než 150 schválených prioritních tématech

2. Rozvoj ustavené Centrální doporučených postupů a pokračování elektronizace řízení celé agendy
3. Rozvoj spolupráce zapojených datových institucí na publikaci indikátorů kvality a jejich vyhodnocení, včetně benchmarkingu poskytovatelů (Kancelář zdravotního pojištění, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR).
4. Posílení systémů pro interní hodnocení bezpečnosti a kvality zdravotních služeb na bázi ustaveného Systému hlášení nežádoucích událostí
5. Další kroky v komunikaci programů prevence a screeningu vážných onemocnění, zejména v oblasti zpětného předávání dat a benchmarkingu center, poskytovatelů – zejména praktických lékařů.

Kapitola IV. Modely organizace péče

Optimalizace struktury sítě lůžkových zařízení, zvládnutelná míra centralizace. Podpora dlouhodobé a ošetřovatelské péče.

https://nzip.cz/koncepce2025#organizace

Kapitola shrnuje hlavní prioritní opatření a realizované kroky k optimalizaci sítě poskytovatelů zdravotních služeb s cílem maximálně podpořit včasnou dostupnost kvalitní péče pro občany. Nastávající demografické stárnutí populace si v tomto směru vynutí řadu významných opatření od restrukturalizace lůžkového fondu přes optimalizaci centralizace vysoce specializované péče až po posilování kapacit sociálních a sociálně zdravotních služeb. Kapitola představuje zásadní a zcela nové, již legislativně ukotvené, propojování dat resortů MPSV a MZD. Tento dosud neexistující datový most mimo jiné umožnil přípravu a vydání nového Národního plánu podpory paliativní péče a Národního plánu rozvoje geriatrické péče. Obě tyto strategie jsou příkladem nově implementovaných modelů komplexní integrované péče v ČR.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Moderní zdravotnictví musí implementovat progresivní modely organizace péče založené na efektivní posloupnosti diagnostických a léčebných kroků (tzv. disease management programy) a na logické integraci různých segmentů péče. Obecně platí, že pacient by měl v lůžkových zařízeních trávit minimum času. Čas strávený v nemocnici a na lůžku kvalitu života nezvyšuje, naopak může představovat vyšší riziko nákazy či jiných zdravotních komplikací. S postupujícím demografickým stárnutím populace nabývají efektivní a komplexní modely organizace péče na významu. Dominantně je nutné podporovat ambulantní léči a domácí péči, či péči v sociálním prostředí pacienta, v různých formách. Pokud je nezbytná hospitalizace, pak by vše mělo probíhat co nejrychleji a primárně s ohledem na kvalitu. Pokud je například možné určité výkony provést v režimu jednodenní péče, znamená to pro pacienta jednoznačně vyšší komfort a bezpečí, než když je pacient dlouho hospitalizovaný. Proto ty výkony, které lze provádět v systému jednodenní péče musí být i v ČR, podobně jako je tomu v moderních zdravotnických systémech, prováděné v tomto režimu. V západní Evropě je celá řada výkonů, které jsou prováděny v režimu jednodenní medicíny, což výrazně zlevňuje fungování systému a zlepšuje komfort pacientů.

Nemocný, pokud nemůže být léčen ambulantně nebo v rámci jednodenní medicíny, musí mít vždy přístup k optimálnímu typu lůžka, jak to jeho stav vyžaduje. Akutní lůžka musí sloužit pro co nejkratší, efektivní a kvalitní péči o pacienty v akutním stavu. Z těchto lůžek, pokud to stav pacienta umožňuje, odchází nemocný domů, kde může čerpat systémem podpořenou domácí péči nebo být hospitalizovaný na lůžku následné péče. V posledních dnech života je naopak nutné podporovat pacienta a jeho rodinu paliativní péčí v různých režimech. Zvláště je pak nutno myslet na geriatrické pacienty, u kterých kvalita života představuje ještě významnější primární cílový parametr léčby. Vzhledem k stárnutí české populace nabývá toto téma na důležitosti, a proto je nutná i reforma a posílení geriatrické péče.

Objektivním faktem je, že potřeba a produkce akutní lůžkové péče (měřeno počtem hospitalizačních případů a objemem ošetřovacích dní) dlouhodobě a trvale klesá. České zdravotnictví tak následuje trend, který evidujeme ve všech vyspělých zemích. S postupujícím rozvojem technologií a s narůstající produkcí jednodenní péče bude tento pokles nadále pokračovat. V posledních 10 letech klesala celková produkce akutní lůžkové péče měřená počtem ošetřovacích dnů cca o 1,5 % ročně. Na tento trend však v posledních deseti letech nijak nereagovala struktura sítě poskytovatelů, ani lůžkový fond. Logicky tak nastává situace, kdy řadě nemocnic a jejich lůžkovým oddělením klesá obložnost a s ní také nákladová efektivita provozu. Nemocnice přitom v ČR většinou nejsou nijak strukturované. S výjimkou několika specializovaných pracovišť jsou si všechny nemocnice z podhledu úhrad za péči, personálu a struktury péče téměř rovny. To vše ještě podporuje velmi hustá síť urgentních příjmů. Akutní lůžková péče tak trvale odčerpává značné personální kapacity a síť nereaguje na rostoucí potřebu péče o stárnoucí populaci. Disponujeme vysokým počtem akutních lůžek, v řadě regionů přitom již nyní kriticky chybí lůžka následné péče.

Byť se hovoří o spádovosti a o nemocnicích vyššího typu, dle zákona nic takového neexistuje s výjimkou některých typů centrové péče. Ta ale byla často hrazena v centrech stejně jako mimo centra bez ohledu na kvalitu a výsledky péče. Úhradové mechanismy pro akutní lůžkovou péči nebyly dlouhá léta nijak revidovány a zakonzervovaly značné nerovnosti v sytému, které nemají oporu ani v produkci, ani v kvalitě péče. Byť by měly být nemocnice za stejnou péči ve stejné kvalitě stejně hrazeny, jsou v úhradách mezi nimi velké rozdíly. Ty jsou dány především tzv. základní sazbou, která se historicky vyvíjela často pod tlakem ad hoc zásahů a přinesla do systému velkou míru nespravedlnosti. Výkony pak nejsou hrazeny dle skutečných nákladů, a to ani centrové výkony (ve vyspělých zemích je takto hrazeno typicky 30–40 % výkonů).

Existuje celá řada výkonů, které se provádí v menším množství. Jsou to především výkony u onkologicky nemocných dětí, u pacientů se vzácným onemocněním, onkologických pacientů, transplantace a rozsáhlé chirurgické výkony, léčba cévních mozkových příhod a srdečního infarktu, včetně některých intervenčních výkonů na srdci cévách a dalších orgánech. Pokud se tyto výkony nekoncentrují na několik pracovišť (podobně jako se koncentrují transplantace do IKEM Praha a CKTCH Brno nebo léčba dětí s onkologickým onemocněním do FN Motol a FN Brno), jsou rozdíly v kvalitě péče o tyto pacienty veliké. Proto je nutné tyto výkony podle doporučení odborných společností centralizovat a v centrech je hradit nákladově. Přitom je nutné průběžně hodnotit kvalitu provádění těchto výkonů tak, aby byl systém otevřený a centra mohla jak vznikat, tak zanikat. Vedle ustavování tzv. „center koncentrace“ je nutné

zavést i institut „center excelence“, kdy jsou vybraná pracoviště bonifikována za nadprůměrné výsledky, dodržování doporučených postupů a kvalitu.

V ČR vedle sebe funguje od roku 1989 systém urgentních příjmů (ÚP) a lékařské pohotovosti (LPS). Dle zákona se na poskytování lékařské pohotovosti má podílet každý poskytovatel zdravotní péče. Avšak ve společnosti přitom přetrvává naprosto mylná představa, že to má být pouze praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. LPS zřizují kraje, a to v pracovní dny do 22 hod. resp. 23 hod., a o víkendech většinou od 7 hod. do 19 hod. Kde poskytovatel, kterého kraj určí, tuto LPS poskytuje, je na něm. Může to být na vlastním pracovišti poskytovatele (tedy např. v ordinaci lékaře na malém městě, nebo naopak na místě, které je vytvořené v nemocnici, kde je vyčleněna místnost, kde lékař LPS poskytuje).

Urgentní příjem je součástí lůžkových zařízení, která poskytují akutní péči. Na urgentní příjem obecně přiváží nemocné sanitka nebo vrtulník a jsou to pacienti s akutním postižením jako jsou úrazy, cévní mozkové příhody, infarkt, náhle vzniklá bolest břicha. Pacient, který dorazí na urgentní příjem, musí projít (pokud toto neproběhne již v sanitce) triáži, kdy speciálně vyškolená sestra pacienty třídí na ty, kteří potřebují opravdu ošetření na urgentním příjmu a na ty, kteří mají být ošetření na pohotovosti. Třídění je vysoce odborná činnost a existuje řada publikací, kde je jasně a na základě exaktních dat definované, který pacient patří na urgentní příjem a který ne. Bohužel ale toto třídění v řadě případů neprobíhá dostatečně a urgentní příjmy jsou stále více a více zatěžované neakutními pacienty (byť pacient sám sebe jako akutního vnímat může). To opět zvyšuje nároky na zajištění a fungování systému a na zajištění provozu urgentních příjmů v režimu 24/7/365.

V současnosti se pohotovosti postupně přesouvají do nemocnic tam, kde je urgentní příjem. Jednak tak lépe může probíhat třídění pacientů, a zejména, lékař na pohotovosti může využít laboratoře a komplementární vyšetření nemocnice, které v jeho ambulanci často nemusí být dostupné (typicky RTG snímek nebo ultrazvukové vyšetření). Pokud je pohotovost zajišťovaná ambulantně např. na poliklinice, tak v případě zejména dětských pacientů je až 90 a více procent pacientů odesíláno z pohotovosti na urgentní příjme do nemocnice.

Vývoj a implementace systému CZ-DRG pro akutní lůžkovou péči v ČR

Zásadním nástrojem, o který se strategie v oblasti řízení, optimalizace a financování kapacit akutní lůžkové péče opírá, je systém CZ-DRG. Systém byl vyvinut v letech 2015–2019 a od roku 2020 je v plném plošném nasazení a provozu. První verze CZ-DRG byla dokončena v roce 2018 a vydána jako oficiální klasifikační systém pro rok 2019 Českým statistickým úřadem sdělením o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG v referenční síti poskytovatelů akutní lůžkové péče (Sdělení ČSÚ č. 159/2018 Sb.).

Aktuálně je systém CZ-DRG vydán ve verzi 7.0 platné pro rok 2025, která je dostupná na webových stránkách https://www.mzcr.cz/stazeni-distribucniho-balicku-cz-drg-verze-7-0.

- CZ-DRG je systém pro klasifikaci a nákladové ocenění akutní lůžkové péče (ALP) v ČR, jehož vývoj zajišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR, a to na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Systém CZ-DRG představuje vzájemně provázaný soubor klasifikačních pravidel, metodických postupů a algoritmů, číselníků, informačních systémů a softwarových nástrojů, které jsou nezbytné pro jeho korektní fungování a které jsou kompletně vyvíjeny kolektivem ÚZIS ČR. Všechny metodické materiály a nástroje systému CZ-DRG jsou vyvíjeny a transparentně publikovány pod hlavičkou ÚZIS ČR jako organizační složky státu, přičemž držitelem licence ke všem komponentám CZ-DRG je Česká republika, konkrétně Ministerstvo zdravotnictví. Kompletní systém CZ-DRG je zveřejňován formou distribučního balíčku na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR na základě bezplatného licenčního ujednání.

Hlavní vývojové komponenty systému CZ-DRG jsou následující:

1. **Vytvoření a kultivace sítě referenčních nemocnic** (RN) – proces vývoje a implementace systému CZ-DRG se neobejde bez intenzivního zapojení části poskytovatelů ALP schopných na základě smluvního vztahu pravidelně předávat ÚZIS ČR data o produkci a ekonomice ALP. Síť RN je klíčová i z prospektivního hlediska, neboť je nezbytná pro hodnocení dopadů a trendů v poskytované péči a optimalizaci celého systému. V rámci vývoje CZ-DRG vznikla síť více než 40 RN (aktuální stav viz Věstník MZ ČR 4/2023), které dlouhodobě pokrývají svou produkcí přibližně 40 % ALP v ČR. Za období 2016-2022 byla v síti RN nasbírána data více než 5 milionů hospitalizačních případů (HP).
2. **Vytvoření klasifikačního systému ALP odpovídajícího potřebám a specifikům ČR** – klasifikační systém CZ-DRG vychází z rutinně sbíraných informací o ALP a primárních zdravotnických klasifikací pro ČR. V řadě klíčových prvků, které souvisí především s flexibilitou vnitřní struktury systému, se však vývoj CZ-DRG inspiroval principy použitými v mezinárodních DRG systémech jako jsou zejména německý G-DRG (a od něj odvozený SK-DRG), australský AR-DRG, severský Nord-DRG nebo francouzský systém GHM. Na vývoji klasifikace CZ-DRG tým ÚZIS ČR velmi úzce spolupracoval s odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
3. **Definice a implementace metodiky nákladového oceňování** – v rámci vývoje CZ-DRG došlo k vytvoření a plošné implementaci standardizované metodiky nákladového oceňování, která umožňuje k jednotlivým HP přiřadit náklady na základě produkčních a ekonomických údajů předávaných sítí RN. Sbírané údaje podléhají rozsáhlým validacím umožňujícím ověřit formální i obsahovou správnost předaných dat s cílem odfiltrovat případy s chybovým obsahem, které nejsou validní s ohledem na výpočet kalkulačních jednic (ocenění) a klasifikaci jednotlivých HP. Výsledky validací jsou taktéž pravidelně (několikrát ročně) komunikovány s RN k zajištění nápravných opatření vyplývajících z výsledků kontrol.
4. **Definice a implementace pravidel kódování akutní lůžkové péče** – pro dlouhodobé zajištění kvality sbíraných dat o ALP byla pro CZ-DRG vytvořena pravidla pro plošné kódování zdravotního stavu a popis důvodů a okolností hospitalizace, která jsou závazná pro kódování ALP i nad rámec pravidel uvedených v Instrukční příručce MKN-10.

DRG systémy jsou ve světě vyvíjeny a využívány především pro účely úhradových mechanismů ALP. Systém CZ-DRG je implementován do úhradových mechanismů ALP v ČR částečně již od roku 2020, od roku 2021 pak plně. Hlavní přínosy systému CZ-DRG s ohledem na proces úhrad ALP lze shrnout následovně:

1. **Odraz reálně poskytované ALP**: vytvoření struktury klasifikačního systému s adekvátním klinickým detailem, který odpovídá léčebným modalitám 21. století, včetně zohlednění vysoce specializované péče.
2. **Odraz reálné nákladovosti ALP**: kalkulace nákladovosti HP dle mezinárodně uznaných metodických postupů implementovaných v síti RN – každoroční aktualizace dat o produkci a ekonomice ALP.

Každoroční aktualizace metodických materiálů systému CZ-DRG probíhá podle harmonogramu, který zahrnuje vydání jeho pilotní verze pro použití v rámci dohodovacího řízení a následně po veřejném připomínkovém řízení vydání finální verze k 30. 9. daného kalendářního roku (dle § 41a zákona č. 48/1997 Sb.). **Systém CZ-DRG tak prochází neustálým vývojem, který se týká všech jeho komponent.** Vývoj a aktualizace CZ-DRG zahrnuje následující kroky:

- **Sběr a validace produkčních a ekonomických dat RN** – iterativní proces komunikace se zástupci jednotlivých RN nad předanými datovými soubory a jejich validace oproti platným metodikám a datovým zdrojům z registrů NZIS, centrálního uložiště výkazů a účetním výkazům,
- **Nákladové ocenění hospitalizačních případů** – kalkulace jednic pro jednotlivá nákladová střediska a postup vyčíslení a přiřazení relevantních nákladů dané RN ke konkrétním HP,
- **Příprava nové verze klasifikačního systému** – kultivace a aktualizace struktury klasifikace a klasifikačních pravidel včetně zohlednění změn v primárních klasifikacích,
- **Příprava aktualizovaných softwarových nástrojů** – přizpůsobení nástrojů Pre-Grouper a Grouper navrženým změnám v sestavení HP a změnám klasifikačního systému,
- **Příprava aktualizovaných číselníků a podkladů pro nasmlouvání** – doplnění předmětných číselníků včetně nově definovaných CZ-DRG markerů,
- **Výpočet nové sady nákladových indexů, tzv. relativních vah** a dalších podkladů pro účely přípravy úhradové vyhlášky na další kalendářní rok,
- **Školicí aktivity v rámci sítě RN** – individuální komunikace a návrhy řešení zjištěných nedostatků v předávaných datech,
- **Školicí aktivity v rámci sítě poskytovatelů ALP v ČR** – školení kódování zdravotních služeb pro zajištění standardizovaných a kvalitních dat o ALP napříč všemi poskytovateli v ČR,
- **Vývoj a aktualizace webových nástrojů** – aktualizace webového definičního manuálu na novou verzi CZ-DRG včetně interaktivního klasifikátoru pro virtuální HP.

Nutná podpora dlouhodobé péče a komunitní ošetřovatelské péče

Vedle optimalizace sítě urgentních příjmů a zajištění relevantní centralizace specializované akutní péče stojí české zdravotnictví před vážným úkolem posílit kapacitu dlouhodobé a následné lůžkové péče a zajistit její plynulou návaznost na péči akutní. Dlouhodobá lůžková péče zahrnuje služby specificky zaměřené na osoby, které se o sebe nemohou postarat například z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Stárnutí populace bude pro zdravotnické systémy představovat velkou výzvu právě v oblasti rostoucí poptávky po dostupné a kvalitní zdravotní péči o nejstarší pacienty. Pomineme-li finanční stránku dlouhodobé lůžkové péče, bude hlavní limitací v geriatrii dostupnost zdravotnického personálu, který se bude o pacienty ve vysokém věku starat.

Kapacitní zajištění tohoto segmentu péče je v ČR již v současnosti nedostatečné, což je patrné i z počtu smluvně zajištěných lůžek. I dle velmi konzervativních modelů chybí v dané oblasti minimálně 2–3 tis. lůžek, přičemž predikce do roku 2035 ukazují na další potřebu minimálně v objemu 8 tis. lůžek. Demografické stárnutí populace bude význam tohoto segmentu nepochybně zvyšovat a bude sílit tlak na restrukturalizaci lůžkového fondu zejména převodem akutních lůžek do režimu dlouhodobé ošetřovatelské péče. I odborná literatura většiny států EU hovoří o potřebě přechodu od globálního „modelu akutní péče“ k „modelu dlouhodobé péče“.

Zpráva WHO z roku 2016 („The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing“) zdůrazňuje potřebu přepracovat systémy péče o geriatrické pacienty, které zajistí pokrytí integrovaných služeb bez finanční zátěže, které se soustředí na potřeby a práva starších lidí, a poskytují péči založenou na společném cíli funkčních schopností. Identifikuje jednoduché strategie, které lze do těchto systémů začlenit, jako je použití komplexních hodnocení k identifikaci křehkých pacientů, prevence polypragmázie a posílení vazeb mezi dlouhodobou péčí a zdravotnickými službami.

Zásadně by měly být rozvíjeny systémy pro poskytování dlouhodobé péče. V 21. století neexistuje země, která by si mohla dovolit nemít komplexní systém dlouhodobé péče. Cílem těchto systémů by mělo být udržet úroveň funkčních schopností u starších lidí, kteří mají podstatnou ztrátu způsobilosti nebo jsou touto ztrátou vystaveni vysokému riziku, a zajistit, aby tato péče a podpora byla v souladu s jejich základními právy, základními svobodami a lidskou důstojností. Tyto systémy mají mnoho potenciálních přínosů nad rámec toho, že umožňují starším lidem závislým na péči žít důstojný život. Mezi tyto přínosy patří omezení nevhodného využívání akutních zdravotnických služeb, pomoc rodinám vyhnout se katastrofálním výdajům na péči a uvolnění příbuzných a blízkých osob pacienta tak, aby se mohli věnovat aspiracím přesahujícím poskytování péče, jako je vzdělávání a formální účast na trhu práce.

Sdílením rizik a zátěže spojených se závislostí na péči tak mohou systémy dlouhodobé péče přispět k posílení sociální soudržnosti. Tyto systémy mohou účinně vytvářet a kontrolovat pouze vlády. To však neznamená, že dlouhodobá péče je výhradně v kompetenci vlády. Systém musí být založen na výslovném partnerství s rodinami, komunitami, institucemi, dalšími poskytovateli péče a soukromým sektorem. Vlády mohou toto partnerství spravovat, zajišťovat

integraci napříč různými službami (včetně zdravotnictví), zajišťovat kvalitu služeb a přímo poskytovat služby těm, kteří je nejvíce potřebují (buď z důvodu jejich nízké vnitřní kapacity, nebo jejich socioekonomického postavení). Každý by měl mít možnost zestárnout v prostředí příznivém pro seniory. Proto je nutné v rámci reforem zajistit přístup k integrované péči zaměřené na starší osoby a sladit systém zdravotní péče s potřebami starších lidí.

Výše uvedené klade velmi závažné nároky na metodiky predikcí potřeb. Aby modely skutečně relevantně postihovaly budoucí vývoj potřeb populace, a zároveň vedly k efektivnímu uspořádání spektra služeb, musí zahrnovat i projekce dlouhodobých trajektorií pacientů v systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb a také na důkazech založené komplexní „disease management" programy. Je nezbytné definovat **„cestu pacienta"** ve smyslu transparentní, předvídatelné a pokud možno automatické trajektorie pacienta systémem, aby nezůstával v prodlevách mezi specializacemi, centry a periferiemi. S tím úzce souvisí důraz na „průvodcovskou" roli pojišťoven, elektronizaci agend sledujících trajektorie pacientů v systému a důsledná implementace klinických doporučených postupů. Odborná literatura hovoří o „**patient-centered care**", která nabývá na významu zejména u dlouhodobě chronicky nemocných pacientů, seniorů či pacientů na konci života.

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že skutečně robustní systém predikcí musí kombinovat a integrovat více klíčových dimenzí, které se nadto vzájemně významně ovlivňují. Např. existující a již vybudovaná infrastruktura poskytovatelů lůžkové péče determinuje potřebné personální kapacity nezbytné pro nasmlouvané spektrum a objem služeb. Velký počet poskytovatelů v daném segmentu péče tak může generovat až nesplnitelné personální požadavky, přičemž hustota sítě nemusí odpovídat skutečným potřebám dané populace a její nemocnosti.

Disbalance mezi různými segmenty péče pak v konečném důsledku vede k vzájemné redundanci nabízených služeb a také k nežádoucímu a neoptimálnímu nahrazování péče, která je v určité oblasti kapacitně podhodnocena. Příkladem může být suplování nedostatku dlouhodobé ošetřovatelské péče hospitalizacemi na akutním lůžku apod. Jakákoli asymetrie v oblasti blízké akutní péči pak nevyhnutelně vede k tlaku na zdravotnickou záchrannou službu a/nebo na urgentní příjmy, což dramaticky zvyšuje finanční náročnost systému.

Dlouhodobě udržitelná strategie rozvoje zdravotnictví tedy musí zahrnovat i posílení neakutní lůžkové péče a komunitní ošetřovatelské péče, včetně paliativní péče a sociálně zdravotních služeb. Lůžkový fond a personální kapacity pro následnou a dlouhodobou ošetřovatelskou péči jsou již v současnosti nedostatečné. Se stárnutím populace se nadto bude v dalších cca 20 letech potřeba služeb v těchto segmentech významně zvyšovat. Spodní hranice predikcí kalkulují s potřebou navýšit lůžkový fond v této oblasti do roku 2030–2035 o cca 4 700 lůžek. Pokud by měla být zachována alespoň stávající dostupnost péče, bude v důsledku stárnutí populace do roku 2030 zapotřebí navýšit lůžkový fond ošetřovatelských pracovišť 9U7 minimálně o cca +3 200 lůžek. Další navýšení o + 1 600 lůžek dlouhodobé a následné péče vyplývá již ze současných potřeb systému – jde o péči, kterou v současnosti zajišťují lůžka akutní.

Nevyvážené kapacity lůžkové péče v neprospěch následné a dlouhodobé péče jsou v mnoha regionech dále umocňovány nedostatečnou kapacitou komunitní ošetřovatelské péče, geriatrické péče a sociálně zdravotních služeb. V důsledku toho velký podíl dlouhodobé péče nebo péče v závěru života chronicky nemocných pacientů (tzv. očekávatelná úmrtí) neoptimálně saturují akutní lůžka. Situace v ČR je v tomto ohledu excentrická i v mezinárodních srovnáních.

Strategií MZ je posílení dostupnosti následné a dlouhodobé péče, včetně nově se rozvíjející nemocniční konziliární paliativní péče. Tyto projekty jsou již iniciovány, avšak musí trvale pokračovat – stále přetrvávají velké rozdíly mezi regiony a infrastruktura se buduje.

Součástí strategie je i systémová podpora a rozvoj paliativní péče ve všech jejích formách. Zdravotní služby relevantní pro péči v závěru života jsou podporovány zdravotními pojišťovnami a jejich úhrady i produkce rostou.

Stále však přetrvávají významné rozdíly mezi regiony a systém má velké personální limity. Z toho důvodu MZ připravuje i nový vládní program podpory vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků pro komunitní ošetřovatelskou péči.

Nutné posílení systému péče o duševní zdraví

V oblasti péče o duševní zdraví dochází k zásadním změnám v přístupu k lidem se zkušeností s duševním onemocněním, principů i metod práce s nimi, i v přístupu k duševnímu zdraví jako takovému. Důraz je přitom kladen na preventivních opatření a včasnou intervenci, stejně jako na zajištění komplexní podpory osob s duševním onemocněním. V současné době již byla realizována opatření zaměřená jak na etablování nových druhů služeb působících v komunitě, transformaci psychiatrických nemocnic s cílem zvyšovat kvalitu péče a přenášet v maximální možné míře péči o lidi se zkušeností s duševním onemocněním do běžného prostředí a doplňovat potřebnou akutní i specializovanou lůžkovou péči, ale také směrem k destigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním, zajištění prevence a propojování služeb ve zdravotnictví, sociální oblasti i školství.

Z dosavadních zkušeností se ukazuje jako problematické plnit nastavené cíle zejména s ohledem na nedostatek odborníků a zvyšující se počet osob v potřebou podpory či zdravotní péče. Nejvýznamnější v této oblasti je péče o děti a mládež. Dále doposud nebyla významněji řešena koncepce sítě akutní psychiatrické péče (lůžkové i ambulantní) a zajištění ochranného léčení, kdy je třeba řešit jak jednotný výkon (zejména u ochranného léčení) a také zajištění dostupné a včasné péče odpovídající potřebám pacientů.

Navázat je nutné i na aktivity podporující systém pro osoby s Alzheimerovou demencí a obdobnými onemocněními, kde není např. dostatečně nastaven systém péče o tyto osoby v resortu zdravotnictví i sociálních věcí, či aktivity směřující k prevenci sebevražd. U některých výše uvedených specifických oblastí je také zpravidla nedostatek relevantních dat – zejména pokud se týká dat u meziresortně zajišťovaných oblastí.

Vedle cílů a opatření stanovených ve Zdraví 2030 je potřeba zaměřit se v následujících letech zejména na

- vytvoření a realizaci koncepčních opatření pro akutní péči, ochranného léčení a pedopsychiatrické péči,
- rozložení kompetencí mezi různé profese – zavedení třístupňového modelu v psychoterapii do legislativy a praxe, vymezení vázané živnosti – část psychoterapeutické poradenství pro praxi mimo zdravotnictví,
- zajistit dostatečný počtu odborného personálu – projekt Ministerstva zdravotnictví zaměřený na odborníky v péči o dětské duševní zdraví, vzdělávání IPVZ – zajištění vzdělávání psychologů, připravovaný projekt na vzdělávání v psychoterapii pro podporu zavedení třístupňového modelu v psychoterapii, pokračující nabídka vzdělávání i pro další lékaře (např. praktické lékaře)

Nezbytné posílení sociálně-zdravotního pomezí

V ČR byl dlouhodobě podceňován systematický rozvoj sociálně zdravotního pomezí a souvisejících segmentů péče. Rozvoj této oblasti nebyl realizovaný jako spolupráce obou klíčových resortů, tedy MZ a MPSV, ale spíše jako boj těchto resortů. To se promítalo i do limitací rozvoje následné a paliativní péče, včetně systému hrazení těchto segmentů sociálně-zdravotní péče. Pro podrobnější analýzu situace chybí data především ze sociální oblasti a prakticky 30 let tu nebyla snaha vybudovat datovou základnu Ministerstva práce a sociálních věcí v obdobné podobě jako v resortu Ministerstva zdravotnictví, s Národním zdravotnickým informačním systémem spravovaným Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Součástí nové strategie Ministerstva zdravotnictví je vybudování datového mostu pro sekundární sdílení dat resortů MPSV a MZ a zároveň ustavení a personální zajištění společného kompetenčního analytického centra. Nově budovaný meziresortní systém sdílení dat sleduje zejména následující strategické cíle:

- Ustavit efektivní a co nejvíce automatizovanou platformu pro meziresortní sdílení a sekundární využívání dat, zejména v segmentech sociálně zdravotních služeb
- Umožnit komplexní mapování trajektorií pacientů mezi segmenty sociálních a zdravotních služeb, včetně hodnocení nákladovosti obou segmentů
- Vybudovat modely hodnocení sociálních dopadů zejména chronických onemocnění, včetně finanční náročnosti
- Vyvinout prediktivní modely potřeb sociálně zdravotní péče s ohledem na regionální specifika

Zdravotně sociální péčí se v nastavené koncepci spolupráce myslí péče na rozhraní mezi sociálním a zdravotním sektorem. Toto dělení je ovšem v řadě praktických situací nejasné a splývá, zdravotní a sociální služby se vzájemně v čase i rámci zapojených poskytovatelů překrývají. V řadě případů nelze jednoznačně vymezit, co je péče zdravotní a kdy se již jedná o péči sociální. Proto musí zejména kapacitní modely pracovat s predikcemi potřeb pro oba segmenty péče, typicky v oblasti péče o umírající, dlouhodobě nemocné pacienty s vysokým stupněm závislosti (například pacienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo nespecifickou demencí apod.).

Z důvodu nejasného vymezení potřeb a vzájemného překryvu, je pro účely metodických prediktivních modelů nezbytné k dané oblasti přistupovat z pohledu obou segmentů péče. Nově implementovaná strategie meziresortního sdílení dat tak v zdravotně sociální oblasti pracuje zejména s následujícími kohortami:

- Pacienti v pobytových sociálních službách, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní nebo akutní zdravotnickou péči či intervence
- Pacienti v ambulantně poskytovaných sociálních službách s potřebou dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče
- Pacienti v péči lůžkových zdravotnických zařízení, kterým je poskytována sociální podpora dle $ 52 zákona o zdravotních službách
- Pacienti s vysokým stupněm závislosti v domácím nebo ambulantním ošetřování, kteří potřebují dlouhodobou nebo nepřetržitou ošetřovatelskou péči (oblast kandidátní pro systém odlehčovací péče či služeb)

Pro účely modelování potřeb a kapacit pobytových sociálních služeb zahrnují modely co nejširší spektrum poskytovatelů, zejména:

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem
- domov pro osoby se zdravotním postižením,
- odlehčovací služby
- týdenní stacionáře
- chráněné bydlení

V segmentu ambulantně poskytované sociální podpory, kde může velkou roli hrát dostupnost zejména ošetřovatelské zdravotní péče, je nutné analyzovat zejména kapacitu a vývoj potřeb u následujících kategorií poskytovatelů:

- Centra duševního zdraví
- Denní stacionáře
- Centra denní služeb

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Obsah nové strategie resortu v oblasti restrukturalizace lůžkového fondu a posilování centralizace péče tvoří zejména následující oblasti a prioritní úkoly. Naprostá většina z nich je již splněna a v dalších krocích jsou agendy dále rozvíjeny. Níže uvedené body stručně shrnují hlavní úkoly a realizované výstupy, datové podklady jsou uvedeny v příloze č. 1 kapitoly.

Postupná reforma, resp. probíhající budování hierarchicky strukturované sítě nemocnic:

- Centrové nemocnice s centrovou péčí a akutní péčí, urgentním příjmem i LPS (tedy pohotovost). V každém kraji musí být alespoň jedna takováto nemocnice. Ve všech nemusí být všechna centra, nutný je ale provoz urgentního příjmu v režimu 24/7/365.
- Nemocnice poskytující akutní péči 24/7/365 bez centrové péče, musí zde být jak urgentní příjem, tak LPS (tedy pohotovost).

- Nemocnice, kde není urgentní příjem a je/není LPS (pohotovost). Provoz v režimu 24/7/365 zde nemusí být, pracoviště mohou být specializovaná nebo zaměřená na jednodenní medicínu.
- Nemocnice s následnou péčí (samostatné nebo součást jakékoliv nemocnice). U nich vždy funkční ambulance geriatrické.
- Zařízení paliativní péče.
- Vývoj a implementace modelů integrované péče včetně podpory nemocničních paliativních týmů a infrastruktury pro dlouhodobou péči navazující na lůžkovou akutní péči.

Hustota sítě poskytovatelů a rozsah poskytovaných služeb determinují potřebné personální kapacity. Implementovaná strategie MZD v této oblasti zahrnuje zejména:

- Zavedení směnného provozu v akutních lůžkových zařízeních s urgentními příjmy s cílem snižovat množství hodin přesčasů.
- Audit struktury lůžkového fondu a analýzu efektivity jeho využívání.
- Posílení centralizace specializované péče, akreditace center koncentrace a center excelence, zavedení systému pravidelného a daty podloženého měření výkonnosti a kvality center.
- Akreditace a reakreditace center vysoce specializované péče dle mezinárodních standard, tedy opřená o řádně recenzované a publikované doporučené postupy a pravidla medicíny založené na důkazech. Implementace exaktních indikátorů kvality pro hodnocení výkonnosti a kvality center.
- Posílení jednodenní péče.
- Zvýšení dostupnosti následné a dlouhodobé péče, postupná restrukturalizace lůžkového fondu s ohledem na regionální specifika.
- Důraz na optimalizaci a kapacitní zajištění sociálně zdravotních služeb.
- Pilotování nových modelů úhrad komunitní ošetřovatelské péče, včetně case-mix modelů pro domácí ošetřovatelkou péči.
- Podpora komunitní ošetřovatelské péče infrastrukturními opatřeními a úhradovými mechanismy

Vysoce kvalifikovaného zdravotnického personálu není a v dalších 20 letech nebude nadbytek. Strategie MZ zahrnuje zejména revizi a optimalizaci personální vyhlášky:

- U lékařských profesí vyhláška nyní nereflektuje specifika oborů, např. obory intenzivní vs. kožní oddělení nemocnic.
- Je nutné revidovat nastavení potřebných kapacit a kompetencí ošetřovatelských a dalších nelékařských profesí.
    - V roce 2025 již byl na základě provedených analýz schválen Vládní program podpory vzdělávání kapacitně ohrožených profesí NLZP.

Další opatření strategie MZ napravuje dlouhá léta přehlíženou nedostatečnou centralizaci péče. Strategie se zaměřuje zejména na úhradovou podporu centralizace péče:

- Pro většinu CZ-DRG skupin hrazených případovým paušálem (bez psychiatrie) jsou definována centra vysoce specializované péče, ve kterých by péče měla být prováděna, přičemž centralizace ale nově není podmínkou úhrady případovým paušálem.
- U některých skupin je definováno i více možností center. Úhradová motivace tak supluje nedostatky smluvní politiky. Pro rok 2023 bylo toto opatření omezeno na péči, kde již nyní vysoké procento koncentrace. V letech 2024–2025 proběhne rozšiřování na další péči.

V roce 2023 byla připravena zcela nová metodika akreditace center vysoce specializované péče, včetně metodiky hodnocení kvality péče. Metodika nově zavádí centra koncentrace a centra excelence.

- Součástí nastaveného hodnocení je i systém datových auditů prováděných na základě indikátorů výkonnosti a kvality péče, které budou publikovány v podobě tzv. resortních referenčních statistik.

V oblasti posilování systému péče o duševní zdraví se strategie soustředí především na opatření s následujícím cílem:

- Zvyšovat kvalitu služeb – zavést hodnocení péče v psychiatrii s ohledem na kvalitu a lidská práva, navázat na toto finanční bonifikaci služeb, pokračovat v transformaci psychiatrických nemocnic (z pohledu nabízených služeb, prostředí, proškolení personálu atp.)
- Zapojovat osoby, kterých se péče dotýká do systému, tedy nastavení sítě, hodnocení kvality, vzdělávání, podpory pacientů atp.
- Rozšiřovat koncept komunitních služeb do dalších regionů (zejména zvyšování počtu CDZ, ambulancí s rozšířenou péčí)
- Pokračovat v meziresortním provazování – podpora multidisciplinární spolupráce v rámci zajištění komplexní podpory a efektivní průchodnosti člověka jednotlivými systémy,
- Pokračovat v destigmatizačních aktivitách
- Zajistit odpovídající financování s ohledem na zvyšující se potřeby a možnosti zajištění péče
- Zajistit datové podklady pro další rozhodování a nastavování služeb a jejich sítě

Úspěšně probíhající vývoj nového informačního systému pro meziresortní sdílení a sekundární využívání dat resortu zdravotnictví a resortu práce a sociálních věcí

- Vybudování společného datového mostu a kompetenčního analytického centra mezi resorty MPSV a MZ
- Vývoj a implementace datové základy a informačního systému umožňujícího mapování dostupnosti sociálně zdravotních služeb a predikce jejich potřebné kapacity
- Vypracování a realizace koncepce otevírání a sdílení meziresortně propojených dat k sekundárnímu využití

Cíle koncepce do roku 2025 a probíhající plnění

- Proběhl audit kapacit a potřeb lůžkového fondu, infrastruktury lůžkové péče a realizovaná základní opatření k optimalizaci stavu – zejména posílení jednodenní péče, následné a dlouhodobé péče. Data jsou plně aktualizována na portálu nzip.cz (sekce datové zpravodajství) a slouží tak zdravotním pojišťovnám i samosprávám v dalších analýzách stavu a v přípravě potřebných kroků.
- Byla vydána a plně implementována nová metodika akreditace a reakreditace Center vysoce specializované péče, včetně institutu center koncentrace a center excelence.
- Byl vypracován a implementován systém zohlednění úspěšné centralizace péče v úhradové vyhlášce.
- Jsou vypracované variantní transformační plány pro nemocnice, která přecházejí z nepřetržitého provozu mnoha oborů do jiného režimu, zejména s posílením jednodenní péče, následné a dlouhodobé péče a komunitní péče.
- Je implementovaný systém interního a externího hodnocení kvality centrové péče, včetně pravidelného vydávání indikátorů kvality formou resortních referenčních statistik (zejména v oborech chirurgie, porodnictví, onkologie, iktová medicína a další).
- Proběhlá a kontinuálně probíhá akreditace a implementace nových CVSP, provedená revize a reakreditace klíčových segmentů centrové péče, zejména komplexní onkologická centra a další centra specializované onkologické péče, centra specializované kardiologické péče.
- Je ustavený funkční analytický meziresortní tým propojující data MPSV a MZ, implementovaný a funkční zcela nový reporting dat nad meziresortním úložištěm
- Je vyvinutý a implementovaný nový informační systém umožňující hodnocení dostupnosti, výkonnosti a nákladů všech relevantních segmentů sociálně zdravotních služeb.
- Je zavedený systém motivační úhrady nemocniční paliativní péče a komunitní vysoce specializované paliativní péče s implementací ve všech regionech ČR
- Proběhlo legislativní ukotvení a zavedení nové služby sociálně-zdravotní lůžkové péče
- Je dokončený a implementovaný systém selektivního přístupu komerčních pojišťoven k vyléčeným pacientům s vážnými onemocněními, zejména onkologickými („právo být zapomenut“)

Další plánované vývojové kroky systému CZ-DRG s předpokládanou realizací ke konci roku 2025

- **Rozšíření sítě referenčních nemocnic** – cílem je dosáhnout rozšíření aktuálně stabilní sítě RN, což povede k reprezentativnějšímu pokrytí oceňovaných zdravotních služeb u poskytovatelů ALP v ČR.
- **Začlenění jednodenní péče do systému CZ-DRG** – nezanedbatelné množství ALP je možné poskytovat v režimu jednodenní péče a současný systém nastavení zdravotního systému umožňuje v řadě oblastí účelové chování. Začlenění jednodenní péče do CZ-DRG je tak logickým krokem v rámci kultivace a optimalizace CZ-DRG.

- **Kultivace metodiky nákladového oceňování** – pilotní sběr dat o ošetřovatelské náročnosti na standardních lůžkových stanicích RN a následné využití společně s rozlišením kategorií pacienta pro přerozdělení nákladů dle ošetřovatelské náročnosti.
- **Portál referenčních nemocnic** – další vývoj sdíleného webového nástroje pro komunikaci a předávání a validaci dat RN s cílem rozšíření jeho struktury, funkcionalit a posílení kyberbezpečnosti.
- **Benchmarking ALP v rámci sítě RN** – rozšíření stávajících sledovaných ukazatelů k hodnocení efektivity a výkonnosti jednotlivých RN, např.:
    - vykazovaní zdravotnických prostředků u jednotlivých HP v CZ-DRG z pohledu pořizovacích nákladů a celkového objemu,
    - struktura pacientů na jednotlivých lůžkových pracovištích z pohledu náročnosti ošetřovatelské péče,
    - využívání přístrojové techniky.
- **Rozšíření validací dat a jejich distribuce v rámci validačního nástroje pro RN** – příkladem je propojení evidence vybrané zdravotnické techniky z účetnictví s vykazovanou produkcí.

Kapitola V. Ekonomika a optimalizace úhrad

Optimalizace systému úhrad, důsledné využívání systému CZ-DRG v akutní lůžkové péči a posílení transparentnosti dohodovacího řízení

https://nzip.cz/koncepce2025#ekonomika

Kapitola představuje novou koncepci Ministerstva zdravotnictví ve financování zdravotních služeb a shrnuje řadu opatření, která již byla implementována pro nápravu chronických problémů s financováním zdravotní péče. Jsou shrnuty konkrétní kroky k odstraňování nerovností v úhradách a pro posilování nákladové efektivity, vždy však se zřetelem na prioritizované nosné segmenty péče a kvalitu jejich služeb. Mezi významné priority patří například podpora primární péče, preventivních a screeningových programů, postupující centralizace vysoce specializované péče a další. Systém úhrad akutní lůžkové péče se již plně opírá o funkční systém CZ-DRG a směřuje k dalšímu sjednocování základních sazeb nemocnic.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Český systém financování lůžkové péče trpěl ještě v nedávné minulosti řadou zásadních problémů. Tím hlavním byly významné nerovnosti ve výši úhrad pro jednotlivé nemocnice. Ačkoliv byl v roce 2021 plošně implementován nový systém klasifikace hospitalizací a úhrad, tzv. systém CZ-DRG, historicky vzniklé rozdíly v úhradách přetrvávaly. Jednotlivé nemocnice dostávaly za stejnou péči různé úhrady, a dokonce péče o identické pacienty pojištěné u různých pojišťoven byla v rámci jedné nemocnice hrazena různými částkami. Tento systém kromě své inherentní nespravedlnosti poškozoval rovnost přístupu pacientů k péči, kdy čekací doby na zákroky mohly být kvůli různé úhradě ovlivněny pojišťovnou pacienta (nemocnice preferovaly pacienty s vyšší úhradou). Tento systém dále znemožňoval jakékoliv sledování efektivity a benchmarking nemocnic, kdy hospodářský výsledek nemocnice byl více ovlivněn historickou výší úhrad než kvalitou managementu a efektivitou poskytování péče. Neefektivita a nespravedlnost byla tolerována. Pro ilustraci, ještě v roce 2022 byl podíl akutní lůžkové péče hrazené tzv. jednotnou základní sazbou (tj. principem za stejnou péči stejná úhrada) pouhých 3,4 %. Nerovnosti v úhradách se pak v menším měřítku týkají i ambulantní péče.

Různé základní sazby nemocnic ale nejsou jedinou příčinnou neefektivity českého systému úhrad. V zahraničních zdravotních systémech se v posledních 20 letech začala významně prosazovat jednodenní péče, která namísto několikadenní hospitalizace umožňuje propuštění

pacienta po operaci do 24 hodin. Tento přístup je jednak významně levnější, ale zároveň je komfortnější a bezpečnější pro pacienty, kterým hrozí menší riziko nákazy v nemocnici, a dále vyžaduje menší množství práce zdravotnického personálu a méně přesčasů. Přes své výhody nebyla jednodenní péče v českém systému úhrad nikterak zakotvena, nebyla podporována, a tudíž se neprosazovala. Ještě v roce 2021 se některé výkony v ČR jednodenním způsobem prakticky neprováděly, jak ukazují srovnávací analýzy například v publikacích OECD.[4]

Zásadní neefektivity ale existují i v organizaci zdravotní péče. Již řadu let v ČR existují centra vysoce specializované péče (CVSP), která by měla zajišťovat a koncentrovat péči o pacienty s nejtěžšími diagnózami. V praxi je ale často i vysoce náročná péče prováděna mimo tato centra, často velmi neefektivně a hlavně za nižší kvality s horšími výsledky pro pacienty. CVSP tak ve vícero oblastech neplnila svoji roli a náročná lůžková péče nebyla v ČR řízena a koordinována. Podobně neřízená byla i návazná péče o pacienty, kteří již nevyžadují akutní nemocniční péči. Tito pacienti by měli být ošetřováni v zařízeních následné péče nebo by jim měla být poskytována domácí péče, zdravotně-sociální péče případně paliativní péče. Bohužel ale všechny tyto návazné typy péče byly v ČR historicky podfinancovány a neměly dostatečnou kapacitu zajistit adekvátní péči o pacienty, a tento problém se navíc stále prohluboval z důvodu stárnutí populace a zvyšování poptávky po této péči.

Organizační problémy jsou ovšem hlubší než jen v případě CVSP a návazné péče. Síť nemocnic a počty akutních lůžek již neodpovídají moderní době a reálné poptávce po péči. Objem a struktura lůžkového fondu nereaguje adekvátně na měnící se potřeby populace, vyvíjející se nemocnost a na technologický progres v diagnostice a léčebné péči. Řada nemocnic nyní provozuje oddělení s obložností pod 50 % a péče se přesunuje do ambulantního nebo jednodenního režimu. Špatná organizace a neefektivita poskytování péče pak také přispívá k enormnímu množství přesčasů. Problémy v organizaci péče lze ale spatřovat rovněž v primární a ambulantní péči, kdy pacient prostupuje systémem nekoordinovaně a řada onemocnění, kterým by šlo prevencí a ambulantní péčí předcházet, se tak léčí až v nemocničním prostředí.[5]

Primární a ambulantní péče je navíc stále dominantně poskytována v režimu sólo praxí s jedním lékařem a sestrou, namísto efektivnějších týmových praxí či center primární péče.

Řada těchto problémů je způsobena nefunkčními institucemi a mechanismy stojícími za financováním zdravotnictví. Z makroekonomického pohledu v minulosti problémy způsobovala příjmová stránka zdravotnictví, kdy platba za státní pojištěnce byla stanovována chaoticky ad-hoc a neumožňovala dlouhodobější plánování financování systému. Systém dohodovacího řízení, kde mají být úhrady domlouvány, se zároveň do určité míry vyčerpal a neumožňuje provádění systémových změn.

Všechny tyto problémy jsou dlouhodobě známé a historicky neřešené. **V současné době ale Ministerstvo zdravotnictví přichází s novou koncepcí financování zdravotnictví**

[4] OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
[5] OECD and European Observatory on Health Systems and Policies (2023), Czech Republic: Country Health Profile 2023.

a v posledních dvou letech již realizovalo řadu klíčových opatření pro nápravu chronických problémů s financováním zdravotní péče.

Základem všeho je finanční stabilita a předvídatelnost celého systému, proto jedním z klíčových opatření je přijetí automatické valorizace platby za státní pojištěnce, která zajistí odpolitizování příjmů zdravotnictví, umožní víceleté plánování a zároveň přinese stabilní a předvídatelný tok financí pro zdravotnictví v krátkodobém až střednědobém horizontu. Díky předvídatelnosti příjmů lze pak dělat reformní změny na výdajové stránce, počínaje způsobem, jakým jsou výdaje dohodovány. Dohodovací řízení potřebuje podporu, více dat a analýz a jasnou deklaraci veřejných priorit. Širší datová základna dostupná již na počátku dohodovacích jednání a změny v přerozdělení příjmů pojišťoven pomohou účastníkům řízení v dosahování dohod.

Na výdajové straně se v posledních čtyřech letech již podařilo napravit řadu problémů a vývoj úhradového systému bude dále pokračovat. Podařilo se podpořit dlouhodobě podfinancované ale klíčové komponenty systému: více financí pro následnou péči, paliativu, primární péči a zdravotně-sociální péči jsou nákladově efektivní investice, které umožní poskytovat péči pacientům tam, kde to je pro systém nejvýhodnější. Prevenci kromě podpory primární péče v budoucnu zlepší i změny ve fondech prevence zdravotních pojišťoven, kdy pojištěnci budou motivováni k péči o své zdraví prostřednictvím individuálních zdravotních účtů, které budou reflektovat účast pojištěnce na prevencích, screeningu apod.

I v oblasti dostupnosti péče je aktuálně řešena řada dlouhodobě problematických oblastí. Kriticky nedostupné služby jako péče o duševní zdraví, péče o děti a stomatologie jsou v současné době významně podporovány. Do budoucna bude prosazována větší odpovědnost zdravotních pojišťoven za zajištění dostupnosti péče, což je jejich zákonná povinnost. Na pojišťovny přejde povinnost zajistit pacientům pohotovostní péči, dále budou povinny pacientům důsledně hledat lékaře a budou muset sledovat čekací doby na zákroky. Zásadní změny se rovněž připravují ve stomatologii, kde budou pacientům z velké části hrazeny moderní léčebné metody, což významně zlepší dostupnost péče.

Zásadní obrat nastal v podpoře jednodenní péče, která byla poprvé zakotvena v úhradové vyhlášce a oblasti jako chirurgie, kardiologie, ORL, ortopedie nebo gynekologie budou čím dál častěji řešeny v jednodenním provedení. V rámci dohodovacího řízení vznikl nový segment jednodenní péče. Do budoucna bude tato podpora pokračovat a je v plánu i systémové ukotvení jednodenní péče v rámci referenční sítě poskytovatelů a prostřednictvím klasifikace analogické s CZ-DRG.

Postupně se snižují nerovnosti ve financování, v roce 2025 bude více než 25 % akutní lůžkové péče hrazeno jednotnou základní sazbou, a celkově se u akutní péče nerovnosti snižují. V příštích několika letech je strategickým cílem se dostat alespoň na 30 % péče hrazené jednotně dle reálných nákladů a začít s daty podloženým benchmarkingem nemocnic podle jejich ekonomických výsledků. I v ambulantní péči se úhradové nůžky zavírají, od roku 2024 jsou nemocniční ambulance včetně urgentních příjmů hrazeny novým modelem, který narovnává historické nespravedlnosti a v následujících letech bude dále kultivován.

Po třiceti letech dochází k skutečně kontrolované koncentraci vysoce specializované péče do center. Celý proces tvorby CVSP byl restartován, vznikla nová metodika rozlišující centra koncentrace a centra excelence a byl založen expertní tým, který na CVSP bude dohlížet. Od roku 2023 dochází k řízenému procesu koncentrace péče, kde specializovaná péče poskytovaná mimo centra je penalizována a do budoucna bude postupně docházet k úplnému odsmlouvání této péče. To v kombinaci s podporou jednodenní, následné a ambulantní péče vyvolá zásadní změny ve struktuře sítě nemocnic a akutních lůžek. Síť poskytovatelů akutní lůžkové péče bude donucena se přeorientovat na reálné potřeby pacienta a moderní způsoby poskytování péče.

V roce 2025 také konečně došlo k definici týmových praxí primární péče a jejich úhradové podpoře, čímž se postupně začne měnit způsob organizace primární (ale i ostatní ambulantní) péče. Týmové praxe přinesou lepší efektivitu a dostupnost péče nastaveným sdílením přístrojové techniky, zastupitelností lékařů, přenesením administrativy od zdravotníků na nelékařský personál a v neposlední řadě prodloužením ordinačních dob. Týmové praxe jsou ale jen prvním krokem reformy organizace primární péče, další významnou změnu přinese vznik multidisciplinárních týmových praxí (v zahraničí také známých jako centra primární péče), která kromě výhod týmových praxí budou mít navíc přesah do oblasti veřejného zdraví a komunitního duševního zdraví a budou zaměstnávat celý multidisciplinární tým profesionálů, který zajistí integrovanou a komplexní péči o pacienty.

Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat vztahu vstupu nových technologií a léčivých přípravků, které mají potenciál nahradit dosavadní méně účinnou či finančně nákladnější léčbu. Z dosavadních zkušeností plyne, že investice do nových přístupů nepřináší automaticky úsporu v jiné části systému. Např. podpora jednodenní chirurgie či domácí péče nevedou k signifikantním úsporám v akutní či následné lůžkové péči, pokud oba systémy nekoordinovaně fungují vedle sebe a dokonce jsou ve vzájemné kompetici. V budoucnu bude ale zcela nezbytné, aby nastavení úhradových mechanismů rychle reagovalo na tyto inovace, např. velmi slibné výsledky ve výzkumu léčivých přípravků na Alzheimerovu chorobu mohou znamenat významné úspory v následné péči o pacienty s tímto onemocněním. S tím ovšem přichází silný apel k implementaci integrovaných modelů péče optimalizujících návaznost různých segmentů služeb a nastavujících nejlepší možnou trajektorii pacienta v systému.

Zdravotní péče obecně bude čím dál více integrovaná a provázaná, zdravotně-sociální péče, paliativní péče a primární péče v kombinaci se změnami v elektronizaci zdravotnictví umožní poskytování služeb ve vzájemném souladu a zároveň umožní redukci péče s nízkou přidanou hodnotou. Do roku 2025 by tak české zdravotnictví díky změnám ve financování mělo být významně efektivnější, kvalitnější, a hlavně více zaměřené na potřeby pacientů.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Obsah nové koncepce resortu v oblasti optimalizace úhrad zahrnuje zejména:

1) Institucionální a systémové změny

a) Předvídatelnost a stabilita financování zdravotnictví

- Automatická valorizace platby za státní pojištěnce – návaznost na inflaci a růst reálné mzdy
- Částečné úpravy přerozdělení – narovnání přerozdělení za mimořádně nákladné pojištěnce

b) Podpora dohodovacího řízení

- Publikace oficiální příjmové predikce zdravotnictví
- Každoroční deklarace úhradových priorit resortu
- Iniciace diskuze o víceletém financování
- Zveřejňování otevřených dat dohodovacího řízení

c) Změny fondového hospodaření zdravotních pojišťoven

- Přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (účinnost od 2026)
- Významné posílení fondů prevence s cílem vzniku Individualizované nabídky preventivních bonusů pojišťoven
- Vznik nového fondu obecně prospěšných činností na podporu systémových změn a aktivit ve zdravotnictví (zaměřeno zejména na podporu dostupnosti péče v problematických odbornostech a lokalitách, pacientských organizací a zvyšování efektivity úhradových mechanismů)

2) Vyšší efektivita zdravotnictví

a) Podpora jednodenní péče

- Pilot v roce 2023; v letech 2024 a 2025 rozšíření odborností a výkonů, spolupráce s odbornými společnostmi, poskytovateli i pojišťovnami
- Vznik nového segmentu jednodenní péče v dohodovacím řízení
- Nastavení úhrad vychází z exaktní kalkulace dle CZ-DRG, motivuje k provádění v jednodenním režimu
- Podpora jednodenní péče i v nemocnicích – v rámci akutní lůžkové péče zaručen plynulý přechod mezi úhradou jednodenní péče a vícedenní péčí
- V novele zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnuta možnost vzniku referenčních sítí a klasifikace jednodenní péče

b) Podpora prevence a primární péče

- Navýšení úhrad primární péče – praktičtí lékaři, stomatologové
- Podpora screeningů + nové screeningy nádorů prostaty a aneurysmatu břišní aorty, časné záchyt očních vad dětí, screening sluchu
- Definice a úhradová podpora týmových praxí
- Navyšování kompetencí poskytovatelů primární péče – rozvolnění preskripčních omezení
- V rámci nové právní úpravy od 2026 významná změna v možnostech financování preventivních programů včetně individualizované bonifikace pojištěnců/pacientů za řádnou péči o vlastní zdraví

c) Odstraňování úhradových nerovností

- Sbližování základních sazeb CZ-DRG
- Navyšování podílu péče hrazené jednotnou základní sazbou dle reálných nákladů – v roce 2025 již přes 25 %
- Snižování historických nerovností ve financování ambulancí a urgentních příjmů
- Implementace doporučených postupů a operativních doporučení do úhrad

d) Centralizace vysoce specializované péče

- Nová metodika center vysoce specializované péče (CVSP)
- Koncentrace péče do CVSP, úhradové motivace
- Podpora center pro vzácná onemocnění (ERN)

e) Podpora a optimalizace systému CZ-DRG

- Podpora a rozvoj referenční sítě DRG
- Řešení nákladových heterogenit a výjimek
- Nová pravidla pro vysoce specializované poskytovatele
- Zkracování čekacích dob, nastavení správných motivací

3) Lepší dostupnost péče

a) Podpora péče o děti

- Ve všech ambulantních segmentech nové bonifikační výkony pro děti
- Podpora dětské psychiatrie, psychologie, stomatologie a praktických lékařů pro děti a dorost
- Úhradová deregulace péče o děti

b) Podpora péče o duševní zdraví

- Podpora transformace lůžkové psychiatrické péče – vznik akutních lůžek, transformace následných lůžek
- Úhradová podpora všech typů péče o duševní zdraví
- Podpora telemedicíny

c) Podpora péče po standardní pracovní době

- Nový úhradový model pro urgentní příjmy
- Nové bonifikační výkony za práci v noci, o víkendu a ve svátek; podpora LPS
- Převod odpovědnosti za zajištění LPS z krajů na zdravotní pojišťovny

d) Reforma stomatologie

- Přijetí komplexní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který významně zlepšuje dostupnost stomatologických služeb
- Významné navýšení úhrad, podpora moderních metod – konec amalgámu, částečná úhrada fotokompozitu
- Podpora endodoncie, ortodoncie a prevence

e) Podpora moderních a inovativních léčebných metod

- Úhrada robotických výkonů a dalších moderních metod
- Úhrada moderních lékových terapií, široká dostupnost léčby
- Úhrada genové terapie a léků na vzácná onemocnění

f) Úhrada přeshraniční péče

- Úprava úhrady přeshraniční péče zakotvena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění
- Zjednodušení administrativy, rozvolnění podmínek za účelem snadnějšího čerpání péče zejména v příhraničních regionech se zhoršenou dostupností v některých oborech zdravotních služeb
- Možnost uzavírání smluv se zahraničními poskytovateli zdravotních služeb

4) Vyšší zaměření péče na potřeby pacientů („patient-centered care")

a) Podpora paliativní péče

- Rozvoj paliativních týmů nemocnic
- Rozvoj kamenných i domácích hospiců
- Integrace se sociálně-zdravotním pomezím a péčí o duševní zdraví
- Reforma specializovaných paliativních ambulancí s návštěvní službou
- Podpora péče o děti a pacienty s neonkologickou diagnózou

b) Podpora sociálně-zdravotního pomezí

- Posílení financování péče v pobytových sociálních zařízeních, podpora integrace péče
- Vznik nových sociálně-zdravotních ošetřovacích dnů
- Podpora péče porodních asistentech v šestinedělí
- Umožnění tvorby referenční sítě poskytovatelů péče ve vlastním sociálním prostředí

c) Podpora následné, domácí a geriatrické péče

- Lepší průchodnost pacienta systémem – deregulace překladů na následnou péči
- Podpora navyšování kapacit následné a domácí péče
- Systém bonifikací pro zajištění vysokého kvalitativního standardu
- Nová koncepce geriatrie
- Postupná transformace části lůžek akutní péče na lůžka následné péče

d) Rozvoj telemedicíny

- Legislativní úprava telemedicíny – zákon i vyhláška upravující pravidla
- Rozvoj nových výkonů – duševní zdraví, srdeční selhání
- Lepší průchodnost nových telemedicínských zdravotnických prostředků

Aktuální vývoj v přehledu za období od ledna 2023 do roku 2025

Za poslední dva roky došlo k naplnění řady opatření z Koncepce úhrad do roku 2025. Jedním z hlavních nosičů reformních opatření je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

č. 48/1997 Sb., která je aktuálně projednávána v parlamentu ČR. Novela plní strategické cíle Koncepce v několika klíčových oblastech:

1. V oblasti institucionálních a systémových změn přináší novela změnu fondového hospodaření pojišťoven a zásadní posílení fondů prevence, které zvýší motivace pojištěnců k péči o vlastní zdraví. Zároveň dojde ke vzniku fondu veřejně prospěšných činností, ze kterého bude možné financovat aktivity zlepšující obecné fungování zdravotního systému v ČR a zlepšující zdraví obyvatel.
2. V oblasti zvyšování efektivity zdravotnictví novela umožňuje tvorbu referenčních sítí poskytovatelů v segmentech následné a dlouhodobé péče, u jednodenní péče, u péče ve vlastním sociálním prostředí a u nákladů na tzv. centrové léky. Data z referenčních sítí zlepší datovou základnu pro zdravotní politiku a umožní efektivní nastavení úhrad v těchto segmentech.
3. V oblasti dostupnosti péče novela přichází s několika zásadními reformami – ve stomatologii novela umožňuje částečnou úhradu moderních stomatologických metod, ale zároveň zachovává hrazenou základní variantu ošetření za situace zákazu amalgámových výplní. To zachová finanční dostupnost péče a zároveň bude motivovat nesmluvní poskytovatele k uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami a dojde tak ke zlepšení dostupnosti péče. V oblasti přeshraniční péče novela obsahuje možnost, aby zdravotní pojišťovny za účelem zajištění místní a časové dostupnosti hrazené zdravotní péče uzavíraly smlouvy také se zahraničními poskytovateli zdravotních služeb. A konečně novela vytváří nový institut zprávy o síti poskytovatelů zdravotních služeb, kterou zdravotní pojišťovny budou publikovat, což zvýší jejich odpovědnost za zajištění dostupnosti péče.
4. V oblasti péče zaměřené na potřeby pacientů dochází v novele k rozšíření kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků, což umožní lepší zacílení indikace zdravotní péče na potřeby pacientů – např. v oblasti fyzioterapie bude nově možné, aby fyzioterapeut sám rozvrhl konkrétní terapeutický plán zacílený na konkrétní potřebu pacienta.

Kromě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění došlo k naplňování cílů Koncepce i pomocí dalších nástrojů, ať už legislativních nebo nelegislativních.

Jednou ze systémových změn Koncepce je restart dohodovacího řízení. Pro tento cíl Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ÚZIS připravilo specializovanou datovou agendu zaměřenou na podporu dohodovacího řízení. Účastníci těchto jednání budou mít k dispozici open data o nákladech, produkci a pojištěncích, která zlepší transparentnost vyjednávání.

Ministerstvo zároveň zveřejňuje priority veřejného zájmu, finanční dopad Seznamu zdravotních výkonů nebo např. základní sazby konkrétních nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Úhradové vyhlášky na roky 2024 a 2025 dále prohloubily reformy Koncepce v oblastech efektivity a zaměřenosti péče na pacienty. Mezi hlavní změny patří následující opatření:

1. Další rozšíření jednodenní péče na oblast kardiologie v roce 2025 (včetně úprav a drobných rozšíření i v dalších oblastech).

2. Navýšení podílu péče hrazené jednotnou základní sazbou na 25 % v roce 2025 a zúžení risk-koridoru o dodatečných 5 %
3. Pilotní zavedení úhrady týmových praxí (zjednodušená varianta sdružených praxí) jako první krok ke vzniku center primární péče
4. Nové screeningové programy – např. screening aneurysmatu břišní aorty
5. Pokračující podpora následné péče a deregulace překladů z akutní do následné péče
6. Podpora péče porodních asistentek v šestinedělí – bonifikace u náročných porodů
7. Stanovení úhrady pro sociálně-zdravotní lůžka
8. Centralizace vysoce specializované péče – pro rok 2025 nově oblast chirurgie
9. Podpora geriatrické péče

Změny v úhradách usnadňují reformu nemocniční sítě a transformaci akutních lůžek na lůžka následné a dlouhodobé péče. Zdravotní pojišťovny během roku 2024 intenzivně jednaly s nemocnicemi o transformaci lůžek a u řady poskytovatelů došlo k dohodě na redukci akutních lůžek a vzniku lůžek následné péče. Další jednání budou pokračovat v následujících letech.

K zásadnímu posunu dochází i v oblasti telemedicíny. Pro tuto oblast již byla vydána vyhláška o telemedicíně, která definitivně legislativně ukotvuje pravidla pro poskytování této péče a umožní poskytovatelům, odborným společnostem i zdravotním pojišťovnám rozšiřování tohoto moderního způsobu poskytování péče.

Kapitola VI. Léková politika

Zajištění dostupnosti léčiv, cenová a úhradová regulace léčivých přípravků

https://nzip.cz/koncepce2025#leky

Kapitola shrnuje hlavní aspekty a kroky vedoucí k posílení lékové politiky resortu zdravotnictví, zejména v oblasti zajištění dostupnosti léčiv, kontroly jejich distribuce a bezpečnosti. Novelou zákona o léčivech účinnou od 1. 1. 2024 (v části od 1. 6. 2024), došlo k významnému rozšíření portfolia nástrojů, které mohou Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv využít k podpoře dostupnosti léčivých přípravků, potažmo k prevenci některých výpadků, což by mělo vést k zajištění vyšší odolnosti lékového trhu v České republice a současně ke zmírnění dopadů výpadků léčivých přípravků na pacienta. Další významnou agendou je rozvoj elektronizace v oblasti lékové politiky, zejména rozvoj systému eRecept a jeho aplikací pro odbornou i laickou veřejnost.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Zajištění dostupnosti léčiv

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, se dlouhodobě potýká s problémem výpadků dodávek humánních léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Výpadky léčivých přípravků a jejich následná nedostupnost na trhu v České republice je způsobována různými důvody – zejména výrobními nebo ekonomickými – kterým stát (příslušné správní úřady) nemůže předcházet, jelikož tyto důvody jsou na straně výrobců či držitelů rozhodnutí o registraci léčivého přípravku.

Do roku 2023 mohlo Ministerstvo zdravotnictví aktivně podpořit dostupnost léčiv pouze některými (formálně-administrativními) nástroji, např. povolením dočasně distribuovat, vydávat a používat léčivé přípravky registrované v jiném členském státě Evropské unie. Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) v případech nahlášení přerušení uvádění léčivých přípravků na trh prověřoval ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci možnost zajistit dostupnost v České republice nedostupného léčivého přípravku např. formou dovozu cizojazyčných balení.

Výše uvedené možnosti Ministerstva zdravotnictví a Ústavu však vyžadují čas v řádu minimálně několika týdnů (vyjma povolení dovozu cizojazyčných šarží a souhlasu s dovozem ze třetích

zemí), aby je bylo možné zrealizovat, a to s ohledem na nutnost vést správní řízení v daných věcech. V drtivé většině případů je však přerušení uvádění léčivých přípravků na trh držiteli rozhodnutí o registraci nahlášeno až současně s faktickým přerušením, a to i v případech, kdy držitel rozhodnutí o registraci věděl nebo mohl vědět o přerušení delší dobu, případně nebyl dodržen termín předpokládaného obnovení, který byl v některých případech i opakovaně prodlužován. Lze konstatovat, že stát (prostřednictvím věcně příslušných správních úřadů) nedisponoval dostatečně funkčními nástroji tak, by mohl operativě předcházet výpadkům léčiv, tj. zajistit, aby k těmto v ideálním případě vůbec nedocházelo a/nebo zvýšit připravenost České republiky právě pro případy výpadků léčiv.

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, je přitom odpovědná za zajištění zdravotní péče na svém území. Jedním z prvků zajištění zdravotní péče je zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice. V souladu s čl. 81 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, mají držitelé rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a distributoři léčivých přípravků povinnost zajistit odpovídající a stálé dodávky daného léčivého přípravku lékárnám a osobám oprávněným vydávat léčivé přípravky tak, aby byly pokryty potřeby pacientů v daném členském státě. Tato povinnost je implementována do současného znění zákona o léčivech.

S ohledem na nárůst počtu výpadků napříč členskými státy vydala Evropská komise v prosinci 2021 dokument „Future-proofing pharmaceutical legislation — study on medicine shortages“, ve kterém analyzovala situaci týkající se nedostatku léčivých přípravků na území Evropské unie, mj. popsala základní důvody a vyhodnocovala trendy a v neposlední řadě legislativní rámec stanovený Evropskou unií. Na základě této analýzy je možné identifikovat, že na území Evropské unie, potažmo v České republice (jak dokazují i data Ústavu, viz níže), významně narůstá počet nahlášených přerušení i ukončení uvádění léčivých přípravků na trh, čímž se stávají nedostupnými pro poskytování zdravotních služeb pacientům.

V České republice jsou hlášena přerušení a ukončení dodávek léčivých přípravků Ústavu. Z dat Ústavu vyplývá následující:

Typ hlášení	Q1	Q2	Q3	Q4	Celkem
Přerušení 2019	465	550	575	621	2 211
Ukončení 2019	119	157	185	191	652
Přerušení 2020	785	418	335	360	1 898
Ukončení 2020	183	130	148	167	628
Přerušení 2021	495	513	309	536	1 853
Ukončení 2021	280	120	160	184	744
Přerušení 2022	677	670	652	827	2 826
Ukončení 2022	243	247	194	255	939
Přerušení 2023	1 195	1 048	978	924	4 145
Ukončení 2023	202	316	259	267	1 044
Přerušení 2024	1059	1104	854	791	3808
Ukončení 2024	255	218	177	280	930

Je tedy zřejmé, že v letech 2022 a 2023 výrazně narostl počet hlášení o přerušení i ukončení uvádění léčivého přípravku na trh. Tento trend nárůstu dále nepokračoval v roce 2024, kdy došlo k mírnému snížení počtu oznámení. Nutno podotknout, že výše uvedená data nezohledňují v případě přerušení uvádění léčivého přípravku na trh dobu tohoto přerušení.

Jak již bylo uvedeno výše, příslušné správní úřady v České republice disponovaly pouze omezenými možnostmi, jak zabezpečit dostupnost léčivých přípravků v potřebném čase, pro které bylo oznámeno přerušení nebo ukončení uvádění na trh. Navíc je třeba uvést, že při takovém oznámení nebylo možné zjistit aktuální stav zásob předmětného léčivého přípravku na trhu v České republice, neboť takovou ucelenou informací o zásobách na trh (tj. i v distribuci a lékárnách) žádný úřad nedisponoval. Proto nebylo možné predikovat, zda množství, které bylo k dispozici u distributorů nebo v lékárnách, by mohlo pokrýt potřebu pacientů po dobu výpadku, či zda by bylo nezbytné aktivně podpořit dostupnost využitím některého z institutů k zajištění dostupnosti léčiv.

Stěžejními problémy tak byl nedostatek času a dat pro příslušné správní úřady na adekvátní reakci při přerušení nebo ukončení uvádění léčivých přípravků na trh v České republice a absence povinnosti pro držitele rozhodnutí o registraci saturovat trh po určitou dobu po oznámení přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh, což by zajistilo potřebný čas pro přijetí patřičných opatření ze strany státu.

Přímé nákupy léčivých přípravků

Od pandemie covid-19 a společného nákupu vakcín proti tomuto onemocnění uskutečněného ze strany Evropské unie, potažmo jednotlivých členských států, se zvyšuje zájem o možnost realizace společných nákupů členských států Evropské unie, a to z důvodů vyjednávacích a ekonomických s cílem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb. Současně existují různá (např. regionální) uskupení zemí, která společně vyjednávají a nakupují zejména inovativní, nákladné, léčivé přípravky pro své pacienty (např. Benelux).

V právním řádu České republiky není s výjimkou nákupu vakcín na covid-19 a léčivých přípravků významných z hlediska ochrany veřejného zdraví zakotvena možnost, jak se k takovým společným nákupům připojit a jak jednoduše zajistit splnění regulatorních požadavků na další zacházení s takovými léčivými přípravky.

Cenová a úhradová regulace léčivých přípravků

Oblast léčivých přípravků v trvalé úhradě

V reakci na možné ohrožení dostupnosti léčivých přípravků významných při poskytování zdravotních služeb z důvodu nepřiměřeně nízké maximální ceny výrobce byl v roce 2023 zaveden nový mechanismus deregulace ceny původce těch léčivých přípravků, u nichž panuje veřejný zájem na zachování dostupnosti na trhu v České republice. Podle této úpravy nepodléhá regulaci formou stanovení maximální ceny ten léčivý přípravek z příslušné ATC skupiny, u kterého je účinné písemné ujednání o nejvyšší ceně výrobce uzavřené ve veřejném zájmu mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku (nebo

dovozcem či tuzemským výrobcem léčivého přípravku, je-li jím dovážený nebo vyráběný léčivý přípravek používán na území České republiky v rámci specifického léčebného programu nebo jiným předkladatelem specifického léčebného programu). Do daného cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví byly zařazeny ATC skupiny, u nichž byly příslušné léčivé přípravky ohroženy nedostupností z důvodu stanovené nízké maximální ceny výrobce v řádu desetikorun. Po dobu účinnosti písemného ujednání mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotní pojišťovnou může být takový léčivý přípravek obchodován za cenu odpovídající dohodě o nejvyšší ceně výrobce.

Bariérou pro dostupnost poskytování primární zdravotní péče pak v některých případech může být i preskripční omezení pro předepisování léčivých přípravků, které je svěřeno do rukou lékařů pouze některých odborností. Cílová skupina pacientů (např. stav, stadium, předléčenost) je vymezena v případně stanoveném indikačním omezení.

Vysoce inovativní léčivé přípravky a léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

V praxi správní úřady u některých léčivých přípravků (zejména v oblasti onkologie) pozorují určitou diskrepanci v klinických kritériích pro jejich vyhodnocení jako vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP) oproti léčivým přípravkům pro jiná onemocnění. Stále častěji jsou podávány žádosti o stanovení úhrady pro volnou kombinaci vysoce inovativních léčivých přípravků, případně také pro volné kombinace VILP a léčivého přípravku pro vzácná onemocnění (LPVO). Avšak po přiznání úhrady dle žádosti o dočasnou úhradu nastává problém v případě, kdy ostatní přípravky z dané kombinace nemají stanovenu výši úhrady, ať už za daných podmínek, či vůbec, a není tak jasné, v jaké výši mají být hrazeny. Ani zdravotní pojišťovny, ani držitel rozhodnutí o registraci, ani pacient tak nemají právní jistotu ohledně úhrady.

S účinností od 1. 1. 2024 byly cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví nově upraveny situace týkající se léčivých přípravků dosud nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a pro jejichž úhradu z veřejného zdravotního pojištění je ve výjimečných případech žádáno podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce). Podle nové úpravy, pokud je zdravotní pojišťovně podán návrh na posouzení naplnění podmínek nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ve smyslu § 16 o veřejném zdravotním pojištění, podléhá takový léčivý přípravek regulaci ceny původce maximální cenou a regulaci maximální obchodní přirážkou v případě, že zdravotní pojišťovna pro tento léčivý přípravek podala Ústavu žádost o stanovení maximální ceny. Takovému léčivému přípravku bude stanovena maximální cena, přičemž v průběhu správního řízení o stanovení maximální ceny bude zachováno právo pojištěnce na poskytnutí daného léčivého přípravku.

Léčivé přípravky s úhradou dočasně stanovenou ve veřejném zájmu

Novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění účinnou od 1. 12. 2022 byla Ministerstvu zdravotnictví svěřena možnost mimořádným opatřením (obecné povahy), vydaným se souhlasem vlády České republiky, stanovit nebo změnit podmínky úhrady nebo stanovit

léčivému přípravku cenu pro konečného spotřebitele, a to za účelem zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Limitem této úpravy je, že se vztahuje pouze na léčivé přípravky významné z hlediska ochrany veřejného zdraví (antibiotika, antivirotika, vakcíny apod.), avšak nikoli na jiné léčivé přípravky významné pro poskytování zdravotních služeb (např. onkologické léčivé přípravky).

Hodnocení léčivých přípravků používaných pouze v lůžkové péči

V současné době není v legislativě upravena možnost zdravotně-ekonomického hodnocení léčivých přípravku, které jsou podávané pouze při hospitalizaci. Může se však jednati o nejmodernější léčbu, jejíž cena dosahuje až desítek miliónů korun na pacienta při vysoké míře nezralosti klinických dat, a proto je třeba zavést hodnocení přínosů a nákladů, který umožní systému zdravotního pojištění specifické okolnosti vyhodnotit.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Realizované kroky

Zajištění dostupnosti léčiv

Novelou zákona o léčivech účinnou od 1. 1. 2024 (v části od 1. 6. 2024), došlo k rozšíření portfolia nástrojů, které mohou Ministerstvo zdravotnictví a Ústav využít k podpoře dostupnosti léčivých přípravků, potažmo k prevenci některých výpadků, což by mělo vést k zajištění vyšší odolnosti lékového trhu v České republice a současně ke zmírnění dopadů výpadků léčivých přípravků na pacienta. Zároveň novela zákona o léčivech umožňuje doplnění reaktivního přístupu k výpadkům léčiv o aktivní složku, tj. aktivní kroky Ministerstva zdravotnictví a Ústavu k předcházení, resp. zmírňování dopadů výpadků léčiv na pacienta.

Základním nástrojem pro vytvoření dostatečného časového rámce pro zajištění alternativního řešení potenciálního výpadku je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit dodávku léčivého přípravku, který má stanovenou maximální cenu nebo úhradu z veřejného zdravotního pojištění i po dni faktického přerušení nebo ukončení uvádění na trh, a to v množství odpovídajícím spotřebě na 1 nebo 2 měsíce podle toho, zda se tento léčivý přípravek potýkal s výpadky již v minulosti.

Dalším důležitým pilířem účinné novely je systém rezervních zásob. Ministerstvo zdravotnictví může opatřením obecné povahy stanovit léčivé přípravky, u nichž mají distributoři povinnost vytvořit a udržovat zásobu odpovídající jejich měsíčním prodejům provozovatelům oprávněným k výdeji a do zahraničí. Na základě dalšího opatření obecné povahy distributoři uvolní léčivý přípravek ze systému rezervních zásob, pokud na trhu nebude dostatek dotčeného léčivého přípravku, aby byla zajištěna jeho dostupnost pro pacienty. Tento systém doplňuje povinnost držitele rozhodnutí o registraci (viz výše) a poskytne další čas pro případné hledání alternativního řešení situace. Je potřeba zdůraznit, že zařadit léčivý přípravek do systému rezervních zásob je možné pouze v případě, kdy existuje reálná možnost vytvořit na úrovni distribuce „nadzásobu“, nikoli tedy v období aktivního výpadku. Evropská unie vydala

seznam kritických léčiv[6] jehož hodnocení ve vztahu k národním potřebám bude jednou ze složek tvorby systému rezervních zásob.

Ústav bude po přijetí oznámení o přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh označovat léčivé přípravky, u nichž hrozí riziko faktické nedostupnosti pro pacienty v České republice, příznakem „omezená dostupnost“. Tento příznak s sebou nese zákaz distribuovat takový léčivý přípravek do zahraničí, povinnost distributorů dodat jej do 2 pracovních dnů od objednání do lékárny a možnost lékáren objednávat si pouze obvyklé množství, aby nedocházelo ke koncentraci dotčeného léčivého přípravku pouze do malého počtu lékáren ve velkých množstvích.

Novela reagovala i na nedostatečný datový základ, ze kterého by příslušné úřady mohly kvalifikovaně vytvářet odhady potřeby v období výpadku, a to tak, že u léčivých přípravků, u kterých má Ústav podezření na ohrožení dostupnosti léčivého přípravku, může vydat výzvu, dle které mu musí jednotlivé články dodavatelského řetězce nahlásit aktuální skladové zásoby daného léčivého přípravku. U léčivých přípravků označených příznakem „omezená dostupnost“ je stanovena povinnost pravidelných hlášení o skladových zásobách jednotlivých článků dodavatelského řetězce. Tím je zajištěna dostatečná informovanost Ústavu, zda zásoby na trhu v České republice jsou dostatečné pro překlenutí výpadku, či zda je nezbytné využít některý z nástrojů zajištění dostupnosti léčivých přípravků. Od 06/2024 do 06/2025 bylo označeno příznakem “omezená dostupnost” celkem 585 léčivých přípravků, u 229 z nich došlo i k odnětí příznaku. Z pohledu dopadu na transparentnost trhu a plošnou dostupnost je efekt tohoto opatření hodnocen pozitivně.

Přímé nákupy léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti řeší ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, zda by bylo možné jejich prostřednictvím za Českou republiku zabezpečit problematiku přímých nákupů léčivých přípravků, neboť v konečném důsledku zdravotní pojišťovny hradí poskytnutou zdravotní péči včetně takových léčivých přípravků. Současně je potřeba více zapojit zdravotní pojišťovny, neboť mají povinnost zajistit péči pro své pojištěnce.

Je však nezbytné podrobně analyzovat dopady na proveditelnost a dopady na zainteresované subjekty zejména z ekonomického ale i provozního hlediska.

Cenová a úhradová regulace léčivých přípravků

Oblast léčivých přípravků v trvalé úhradě

V rámci novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění je v části šesté zamýšleno zavedení nových pravidel umožňujících stanovit udržitelné maximální ceny pro důležité, obvykle málo nákladné, skupiny léčiv. Úprava by měla pomoci zejména lokálním producentům s nedostatečným počtem zahraničních referencí. Další úpravy a upřesnění postupů v rámci správních řízení vedených Ústavem cílí na odstranění některých administrativních bariér

[6] Availability of critical medicines | European Medicines Agency (europa.eu)

a zjednodušení vstupu léčivých přípravků na trh v České republice a jejich setrvání v systému veřejného zdravotního pojištění.

Oblast vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

V rámci novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění je zamýšleno upřesnění klinických kritérií pro vyhodnocení léčivého přípravku jako vysoce inovativního v souladu s doporučeními European Society For Medical Oncology (ESMO). V situacích, kdy jsou podány žádosti o úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku ve volné kombinaci s jiným VILP, případně LPVO, je záměrem, aby pro takovou kombinaci byly výše úhrad stanoveny ve stejný okamžik (ve společném správním řízení), čímž bude odstraněna nejistota v oblasti doléčení pacientů vysoce inovativním léčivým přípravkem po uplynutí platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady.

Oblast léčivých přípravků s úhradou dočasně stanovenou ve veřejném zájmu

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (účinná od 1. 12. 2022) svěřila Ministerstvu zdravotnictví kompetenci vydat pro léčivý přípravek významný z hlediska ochrany veřejného zdraví mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví takovému přípravku dočasně stanoví podmínky úhrady a cenu pro konečného spotřebitele, potažmo úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a to s předchozím souhlasem vlády s vydáním takového mimořádného opatření. Tímto institutem byla zajištěna dostupnost hrazených služeb pro pojištěnce u léčivých přípravků na covid-19 (p.o. antivirotika), které jsou určeny k podání u dospělých pacientů v domácím prostředí a antibiotických přípravků všech lékových forem v období plošných problému s jejich dostupností. U těchto léčivých přípravků standardní stanovení úhrady Ústavem nebylo možné, neboť dotčené léčivé přípravky nejsou v České republice registrované (ačkoliv jsou registrované v jiných zemích Evropské unie) a jejich distribuce, výdej a použití bylo povoleno opatřením podle zákona o léčivech.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (účinná od 1. 1. 2024) stanovila novou možnost, jak zajistit dostupnost nenahraditelných léčiv, respektive léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví. Na základě vybraných opatření či rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Ústavu, potažmo nařízení vlády může Ústav ve správním řízení zvýšit maximální cenu a úhradu či maximální cenu a úhradu léčivému přípravku stanovit a zajistit tak jeho dostupnost pro pacienty v České republice. Všechna opatření Ústavu se vydávají na maximální dobu 1 roku, ve většině případů (kromě případu, kdy dochází ke změně stávající maximální ceny a úhrady) s možností prodloužení. Pokud důvody, které k vydání takové opatření vedly, pominou, upravuje zákon možnost jeho předčasného zrušení.

Oblast hodnocení léčivých přípravků používaných pouze v lůžkové péči

V rámci novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění je v části šesté zamýšleno zavedení hodnocení přínosů a nákladů pro léčivé přípravky používané čistě při hospitalizaci (provedené Ústavem), a to na žádost zdravotní pojišťovny nebo držitele rozhodnutí o registraci.

Další cíle koncepce do roku 2025

Zajištění dostupnosti léčiv

- Stabilizovat situaci v oblasti zajištění dostupnosti léčiv a minimalizovat dopady výpadků na pacienty v České republice i za využití nových nástrojů umožňujících sbírat více dat a rovněž aktivněji zasahovat do lékového trhu.
- Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem prověří robustnost dodavatelských řetězců obzvláště ve skupinách léčivých přípravků zařazených na Unijní seznam kritických léčiv a na základě vyhodnocení zváží možnost zařadit ohrožené léčivé přípravky do systému rezervních zásob.

Přímé nákupy léčivých přípravků

- Dokončit analýzu a následně připravit legislativní návrh umožňující zajištění přímých nákupů léčivých přípravků.
- Vyhledávat možnosti zapojení se do společných nákupů Evropské unie, mezinárodních organizací nebo uskupení jiných států.

Oblast léčivých přípravků v trvalé úhradě

- Dokončit legislativní návrh novely části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění.
- Upravit proces stanovování maximálních cen a tím zvýšit atraktivitu českého lékového trhu.
- Nastavit pravidla procesu uvolnění preskripčních omezení.

Oblast vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

- Dokončit legislativní návrh úpravy společných správních řízení VILP ve volné kombinaci s jiným VILP.
- Upravit oblast smluvních ujednání s cílem snížení administrativní zátěže, zejména na straně poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s vykazováním VILP.

Oblast léčivých přípravků s úhradou dočasně stanovenou ve veřejném zájmu

- Prostřednictvím institutů umožňujících stanovit léčivému přípravku úhradu a její podmínky ve veřejném zájmu zmírnit finanční dopady na pojištěnce při výpadcích některých léčivých přípravků a při zajištění mimořádných dodávek.

Oblast hodnocení léčivých přípravků používaných pouze v lůžkové péči

- Dokončit legislativní návrh pro stanovení nových postupů hodnocení pro léčivé přípravky v rámci lůžkové péče.

Systém eRecept

Elektronická preskripce a zřízení informačního systému eRecept jsou legislativně zakotveny v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím systému eRecept lékař vystavuje pacientovi elektronický recept (eRecept), na jehož základě je v lékárně

vydán léčivý přípravek. Zřízený systém eRecept je jednou ze základních služeb v rámci eHealth a v ČR je od 1. ledna 2018 provozován povinně. Na základě § 81f zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jsou umožněny některé výjimečné situace, ve kterých lze i nadále vystavovat recepty v listinné podobě. Systém eRecept je zařazen mezi kritickou infrastrukturu státu a podléhá tedy těm nejpřísnějším bezpečnostním opatřením dle zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů. Systému eRecept se aktuálně zahrnuje centrální úložiště elektronických receptů (CÚER), centrální úložiště elektronických poukazů (CÚEP), centrální úložiště záznamů o očkování (CÚEO), centrální úložiště limitů doplatků (CÚLD), registr pro léčivé přípravky s omezením (RLPO), lékový záznam, správu souhlasů a další vyjmenované části.

Identifikátor eReceptu může být předán několika způsoby: na papírové průvodce, v SMS, v e-mailu, nebo pomocí mobilní či webové aplikace pacienta. Doručení identifikátoru eReceptu elektronickou cestou – SMS nebo e-mailem dosáhlo v roce 2024 téměř 55,8 milionu SMS a více jak 913 tisíc e-mailů.

V roce 2024 bylo vystaveno téměř 86 milionů eReceptů, vydáno bylo přes 85 milionů eReceptů, což jsou zatím nejvyšší počty od roku 2018. V červenci 2024 byla překonána hranice 500 miliónů vystavených eReceptů od počátku povinné epreskripce. Systém eRecept se stal již nepostradatelným nástrojem v oblasti poskytování zdravotnických služeb. K 31. prosinci 2024 bylo aktivně zapojeno 49 702 lékařů, 18 426 zdravotnických zařízení, 8 653 lékárníků a 2 743 lékáren.

Od spuštění elektronické preskripce dochází k průběžné aktualizaci webových stránek https://epreskripce.gov.cz/. V roce 2024 došlo ke kompletnímu redesignu stránek a doplnění jednotné domény gov.cz. Zde jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se eReceptu, lékového záznamu, evidence očkování, elektronického poukazu na zdravotnické prostředky, započitatelných doplatků a další novinky z prostředí eHealth.

Od spuštění systému eRecept jsou také k dispozici aplikace pro pacienty i zdravotnické pracovníky, v mobilní i webové verzi. Prostřednictvím aplikace pro pacienta má pacient možnost nahlédnout do přehledu jemu vystavených eReceptů, ePoukazů a aplikovaného očkování, u nichž došlo k jednoznačnému ztotožnění občana v Registru obyvatel (ROB). Rodič může zároveň nahlížet do eReceptů, ePoukazů a záznamů o očkování svých nezletilých dětí. V aplikaci může pacient nastavit souhlas či nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu (evidence eReceptů a záznamů očkování) nebo lékového záznamu svých nezletilých dětí. Pacientovi je také k dispozici kompletní historie přístupů k jeho datům, tedy který lékař či lékárník do seznamů jeho dat nahlížel. Od listopadu 2023 může pacient ve své aplikaci rovněž udělit či přijmout mandát k nahlížení na eRecepty či ePoukazy. Od roku 2025 má pacient ve své aplikaci přehled o čerpání započitatelných doplatků a svém ochranném limitu.

Od 1. června 2020 začal fungovat sdílený lékový záznam pacienta. Jde o jednu z klíčových funkcionalit informačního systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o lécích, které se nacházejí v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče pracovat lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti ve chvíli, kdy jim poskytují zdravotní službu. Pacient má právo kdykoliv projevit souhlas / nesouhlas s tím, aby

lékaři nebo lékárníci nahlíželi do jeho lékového záznamu, a to jak plošně, tak i konkrétnímu lékaři nebo lékárníkovi. Je také možné kdykoliv opětovně svůj souhlas / nesouhlas odvolat. Tyto změny je možné provádět prostřednictvím pacientské aplikace, nebo písemně dopisem.

Od 1. června 2020 má pacient rovněž možnost předat seznam všech svých identifikátorů eReceptů k výdeji v lékárně formou předložení strojově čitelného dokladu totožnosti – primárně občanského průkazu. Na základě předloženého dokladu pacienta má lékárník možnost získat seznam všech vydatelných eReceptů daného pacienta. Samotný výdej léčivých přípravků dále již probíhá standardním způsobem na základě získaných identifikátorů eReceptů.

Od 1. ledna 2022 byly povinně spuštěny elektronické recepty tzv. s modrým pruhem, tedy recepty na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek. Tyto recepty byly do konce roku 2021 vystavovány pouze v listinné podobě, od 1. ledna 2022 jsou naopak pouze v elektronické podobě. S tímto rozšířením souvisela i změna v předepisování konopí pro léčebné použití, které je od 1. ledna 2022 předepisováno pouze na recepty s příznakem vysoce návyková látka. Pro zajištění kontrolní činnosti, ke které mají oprávnění krajské úřady, je od ledna 2022 ze strany SÚKL zpřístupněna pracovníkům krajských úřadů aplikace, která umožňuje načíst a kontrolovat eRecepty s příznakem vysoce návyková látka vystavené v konkrétním kraji.

K záznamům o očkování mají dle platné legislativy přístup i krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy. Na základě legislativního oprávnění je tento přístup k údajům ve stanoveném rozsahu ze strany SÚKL zpřístupněn od ledna 2022.

Na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, byla zahájena elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky (ePoukazů) jako jedna ze součástí systému eRecept. Modul ePoukaz byl spuštěn od 1. května 2022. Evidence ePoukazů je v tuto chvíli nastavena jako nepovinná. ePoukaz svojí funkčností nahrazuje papírové poukazy na zdravotnické prostředky. Při vytváření modulu ePoukaz byla snaha o maximální využití stávajících funkcionalit systému eRecept a tím o co největší zjednodušení předepisování a vystavování ePoukazu. Elektronicky lze vystavit poukazy na všechny typy zdravotnických prostředků, tedy pro korekci zraku, pro pacienty s poruchou sluchu i všechny ostatní. Mezi hlavní procesy zastřešené systémem eRecept patří i schvalování ePoukazů ze strany zdravotních pojišťoven tam, kde to povaha předepisovaného zdravotnického prostředku vyžaduje. Modul ePoukaz umožňuje i zásilkový výdej zdravotnického prostředku tam, kde jsou splněny požadavky pro prodej na dálku stanovené nařízením o zdravotnických prostředcích.

V roce 2024 bylo vystaveno téměř 1 286 tisíc ePoukazů, počet předepisujících i vydávajících je již cca 10 tisíc.

V souvislosti se spuštěním ePoukazu se rozšířil i počet rolí uživatelů, kteří mohou přistupovat k systému eRecept. Kromě již zavedených rolí lékaře a lékárníka mohou ePoukazy předepisovat i jiní zdravotničtí pracovníci a vydávat je naopak mohou i farmaceutičtí asistenti, ortotici, protetici, optometristi, optici a ostatní výdejci. Všichni uživatelé systému eRecept mohou od května 2022 využít pro přístup k systému eRecept i Identitu občana, tedy přihlášení např. prostřednictvím bankovní identity, mobilního klíče eGovernmentu nebo občanského průkazu

s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem. Tuto možnost měli dosud pouze pacienti využívající svou pacientskou aplikaci.

Již od roku 2018 je SÚKL zapojen do projektu Deployment of Cross Border Services in the Czech Republic – NIX-ZD.CZ II. (ePrescription/eDispensation), kde je hlavním partnerem Kraj Vysočina. Projekt NIX-ZD.CZ II. se zaměřil na přeshraniční výměnu eReceptů a informací o vydaných lécích, v důsledku čehož se zvyšuje bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče a pacientský komfort. Přeshraniční výměna elektronické preskripce zpřístupňuje eRecept lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si může vyzvednout svůj lék v jakémkoliv jiném členském státu EU, který je v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu. Naopak v české lékárně si může vyzvednout lék pacient z té evropské země, která již v produkčním provozu také funguje.

V roce 2024 probíhal produkční provoz s Estonskem, Finskem, Chorvatskem, Lotyšskem, Polskem, Portugalskem, Řeckem a Španělskem. V těchto státech bylo v roce 2024 vydáno 1450 českých eReceptů. V následujících letech je plánováno postupné rozšíření o další země EU.

V listopadu 2023 byl spuštěn další modul systému eRecept – Registr mandátů. Pacient může jeho prostřednictvím udělit plnou moc k tomu, aby byl zastupován při jednáních spojených s přístupem k údajům evidovaným v systému eRecept zřízeném podle § 81 odst.1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Pacient (zmocnitel) se může nechat zastupovat zmocněncem v jednotlivých oblastech – eRecept, eOčkování, ePoukaz, Správa souhlasů. Registr mandátů slouží i pro nastavení přístupu k systému eRecept opatrovníkům za osobu, jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu.

V roce 2024 probíhala intenzívní příprava nového modulu pro evidenci započitatelných doplatků, co že agenda, kterou musí dle novelizované legislativy systém eRecept od 1. 1. 2025 zajišťovat. Podstatou je centralizace evidence limitů doplatků na léky, kterou nově zajišťuje SÚKL prostřednictvím systému eRecept. Cílem je zajistit větší transparentnost a efektivitu zejména v oblasti čerpání ochranných limitů započitatelných doplatků. Nový systém je legislativně ukotven v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a s tím související novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V lékárně má vydávající lékárník ze systému eRecept přehled o aktuálním stavu čerpání limitu, tedy informaci, zda ještě započitatelný doplatek pacient hradí, nebo již dosáhl roční ochranný limit a započitatelný doplatek tudíž již nehradí a doplatí jen rozdíl mezi cenou léčiva a započitatelným doplatkem.

Od 1. 1. 2025 poskytuje jediný závazný údaj o ochranném limitu pojištěnce a jeho čerpání systém eRecept. Pacienti od letošního roku v lékárně hradí započitatelné doplatky jen do výše svého ochranného limitu.

Význam systému eRecept je možné doložit i mnoha oceněními, která od roku 2018 získal. V rámci programu slavnostního setkání 21. ročníku konference ISSS/V4DIS bylo uděleno ocenění Český zavináč 2018 týmu oddělení eReceptu, jenž v rámci SÚKL pracoval na realizaci projektu eRecept. Projekt eRecept zvítězil v 16. ročníku soutěže IT projekt roku 2018 pořádaném Českou asociací informačních technologií (CACIO). Odborná hodnotitelská komise spolu s Řídícím výborem CACIO ocenily projekt jako takový a současně vyslovují uznání jak

tvůrci, tak uživateli projektu za dosažené výsledky. V roce 2022 se eRecept stal nejprospěšnějším projektem v oblasti eHealth a digitalizace českého zdravotnictví a získal ocenění na konferenci INMED, pořádané společností EEZY Publishing, s. r. o. V roce 2023 pak projekt „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace“ získal 3. místo v soutěži Egovernment The Best. V roce 2024 postoupil projekt Evidence započitatelných doplatků do užšího finále druhého ročníku ocenění Úřednický čin roku v kategorii Inovace ve službách veřejnosti.

Kapitola VII. Zajištění personálních kapacit – kapacity a vzdělávání lékařů

https://nzip.cz/koncepce2025#lekari

Problematika hodnocení dostupné kapacity lékařů a řešení její regionální dostupnosti je velmi dynamická. Z toho důvodu je tato kapitola od roku 2023 rozsáhle aktualizovaná a přináší zejména popis aktuálního pokroku v elektronizaci agend postgraduálního vzdělávání, tedy ve vývoji Systému Administrátor. Mezi další progresivní změny patří podpora a optimalizace systému rozdělování residenčních míst, s prioritizací segmentu primární péče. Nové datové analýzy shrnují mimo jiné první výsledky vládního programu podpory oboru Všeobecné lékařství, ve kterém lékařské fakulty v roce 2025 graduují o více než 300 nových lékařů více než v předchozích letech. Trvající vládní podpora tohoto programu otvírá nové možnosti pro optimalizaci úvazkových kapacit lékařů v regionech a pro podporu kapacitně nejvíce ohrožených oborů.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Plánování a distribuce kapacit lékařů, organizace, kvalita a efektivita jejich vzdělávání vyžadují v ČR velmi významné reformy. České zdravotnictví čelí významnému riziku nedostatku lékařů v řadě odborností, personální zajištění péče se nadto významně liší mezi regiony. Problém není v celkovém počtu nyní aktivních lékařů, ale v jejich nerovnoměrné distribuci mezi obory a regiony, a zejména v jejich demografickém stárnutí, které ohrožuje podstatnou část kapacit v dohledné budoucnosti.

Celkový počet lékařů v ČR v přepočtu na počet obyvatel přesahuje průměr EU a je srovnatelný s Rakouskem či Německem. Klíčovým problémem je však nerovnoměrné rozložení kapacit lékařů v rámci ČR, dále v rámci jednotlivých oborů a rovněž dlouhodobý nedostatek lékařů v primární péči. Problém nedostatečné a ubývající kapacity primární péče se bohužel týká i praktických lékařů pro děti a dorost. Dlouhodobé podceňování primární péče a její nedostatečná podpora ze strany zdravotních pojišťoven i státu vedla k tomu, že řada občanů ČR nemá svého praktického lékaře. Proto není možné nastavit standardní fungování systému tak, jak je to např. v Dánsku, Rakousku, Německu a dalších zemích – a sice, že pacient je k dalšímu vyšetření vždy odesílám cestou svého praktického lékaře. Řada pacientů tak vyhledává péči přímo u ambulantních specialistů nebo v nemocnicích, které tak do značné míry

suplují nedostupnost primární péče. To vede k opakování vyšetření a redundantní péči, což celý systém zdražuje.

Regionální rozložení kapacit lékařů na území ČR není symetrické. Jak z analýzy vyplývá, je v Praze a Brně jedna z nejvyšších koncentrací ambulantních specialistů na počet obyvatel i v mezinárodním srovnání. Přitom jsou obory, kde je ambulantních specialistů nedostatek, a to nejen regionálně, ale i v absolutních počtech. Naopak jsou obory, kde je jich nadbytek, a to nejen regionálně (Praha, Brno), ale opět i v absolutních počtech. Je proto nezbytné přistupovat k systému specializačního vzdělávání a regionálního nasmlouvání ambulantní péče plánovitě a usilovat o posílení rizikově oslabených odborností.

Velmi vysokou koncentraci úvazkové kapacity lékařů registrujeme v akutní péči a na akutních a JIP lůžkách. Je to dáno strukturou nemocniční sítě, dlouhodobě nedostatečnou podporou jednodenní medicíny, nedostatečným počtem následných lůžek a obecně opět sníženou dostupnosti primární péče. Dalším problémem je personální vyhláška, která nereflektuje oborová specifika a definuje pouze jeden typ akutních lůžek a jeden typ lůžek JIP. Ve srovnání s rokem 2010 pozorujeme absolutní růst úvazkové kapacity lékařů pouze v segmentu akutní péče, péče následná a dlouhodobá stagnuje na nízkých počtech aktivních lékařů.

Ve vzdělávání lékařů byly historicky základním problémem opakující se reformy systému vzdělávání. Proto je nutné systém kultivovat, zvýšit prostupnost vzdělávacích programů, zjednodušit jejich obsah a nerozšiřovat počty oborů, ani kmenů. Finančně je pak nutné podporovat především obory primární péče a dále malé obory, kde je kritický nedostatek lékařů jako je například dětská a dorostová psychiatrie a dětská neurologie. Je nutné srovnat kvalitu přípravy na akreditovaných pracovištích a rozšířit počet těchto pracovišť.

V ČR se prosadil před řadou let decentralizovaný systém akreditovaných pracovišť, na která může absolvent LF nastoupit (byť obecně v EU, USA a Japonsku převládá systém centralizovaný). Proto lékař, který na akreditované pracoviště do předatestační přípravy nastoupí, většinou po úspěšném složení atestace na tomto pracovišti zůstává. To ale vede k tomu, že velká pracoviště, kam se hlásí velká část absolventů lékařských fakult, stále zvyšují počty lékařů. Naopak pracoviště, kam se absolventi nehlásí, mají obecně dlouhodobé problémy s počtem lékařů.

Takto nastavený systém nutí všechny nemocnice, aby získaly akreditaci, pokud možno pro všechny svoje obory, jelikož již atestovaní nemocniční lékaři, kteří by měli zájem změnit pracoviště, na trhu fakticky nejsou. Systém, který je běžný v USA a některých zemích západní Evropy (anglosaský systém rezident – fellow – staff), v ČR není. Prakticky každý lékař, který po škole na akreditované pracoviště nastoupí, dostává ještě před atestací smlouvu na dobu neurčitou. Nicméně i v dalších zemích EU je systém kombinovaný a nejednotný, a proto je obtížné nějaký systém označit za tzv. „zlatý standard“.

Problémem je rovněž kvalita přípravy lékařů k atestaci. Na řadě pracovišť nefungují školitelé v adekvátním módu. Problematická je často náplň vzdělávacích programů a špatná prostupnost těchto programů.

Z výše uvedených důvodů znamená metodická reforma systému vzdělávání, zajištění jeho standardizovaného obsahu, dostupnosti a prostupnosti zásadní pilíře představené strategie v této oblasti. Proto MZ nově pověřilo IPVZ koordinací administrativního a metodického zajištění specializačního vzdělávání. Jedním ze zásadních přínosů nové strategie je i krok k zjednodušení a k plné elektronizaci agend souvisejících se vzděláváním lékařů – viz dále blíže popsaný vývoj nového informačního „Systému Administrace“ (neoficiální název projektu Administrátor.) Další ministerstvem realizované kroky jsou připraveny s vědomím faktu, že od roku 2019 úspěšně probíhá vládní program podpory vzdělávání lékařů. Lékařské fakulty dokázaly navýšit počet studujících až o 30 % a od školního roku 2025/26 tak dojde k nárůstu počtu absolventů oboru Všeobecné lékařství o více než 300 ročně. Je naprosto nezbytné tuto situaci využít k plánovitému posílení kapacit v nejvíce ohrožených oborech a regionech.

Realizované kroky a cíle koncepce do 8/2025

V rámci své působnosti se IPVZ v průběhu roku 2023–2025 podílel na přípravě a realizaci následujících opatření přímo vedoucích k personální stabilizaci zdravotnictví a zjednodušení systému specializačního vzdělávání:

1. Automatické přidělení 13. platové třídy po úspěšném absolvování základního kmene

Lékaři, kteří úspěšně absolvují základní kmen, se nově posouvají do 13. platové třídy. Změnu zakotvuje nový katalog prací MPSV, který nabyl účinnosti 1. ledna 2023.

2. Navýšení dotace na rezidenční místa

Rezidenční místa pro základní kmeny: Program není limitován finanční alokací, počtem podporovaných rezidenčních míst, ani termínem pro podávání žádostí o dotaci. Velkou výhodou je rovněž skutečnost, že akreditované zařízení podává žádost o dotaci na předem známého rezidenta, který je jeho zaměstnancem a opadá tak povinnost vyhlašovat na rezidenta výběrové řízení. Systém přidělování rezidenčních míst je tím také průchodnější, neboť místa jsou přidělována všem žadatelům, kteří splní formální podmínky žádosti. Tímto otevřeným pojetím tvoří program rezidenčních míst na základní kmeny určitý doplněk k alokačně výrazně objemnějšímu programu na financování celého specializačního vzdělávání. Tak jako v programu na celé specializační vzdělávání, byl i zde navýšen podíl dotace, který musí být určen na mzdu rezidenta, a to na 80 %.

Rezidenční místa pro specializační vzdělávání: Podpora je koncentrována na obory primární péče a obory péče o děti. V letech 2023 až 2025 bylo podporovány následující obory:

	Počet rezidenčních míst	Dotace na jedno místo za celé vzdělávání
Všeobecné praktické lékařství 2023	150	1 980 000
Všeobecné praktické lékařství 2024	140	1 800 000
Všeobecné praktické lékařství 2025	140	1 800 000
Pediatrie 2023	80	2 970 000
Pediatrie 2024	70	3 078 000
Pediatrie 2025	70	3 078 000

Dětská a dorostová psychiatrie 2023	10	2 970 000
Dětská a dorostová psychiatrie 2024	15	2 700 000
Dětská a dorostová psychiatrie 2025	14	2 700 000
Dětská neurologie 2023	10	2 970 000
Dětská neurologie 2024	10	2 700 000
Dětská neurologie 2025	10	2 700 000
Urgentní medicína 2023	10	3 300 000
Urgentní medicína 2024	5	3 000 000
Psychiatrie 2024	15	2 700 000
Psychiatrie 2025	16	2 700 000

V roce 2023 bylo podpořeno těchto 5 oborů:

- Všeobecné praktické lékařství – 150 míst
- Pediatrie – 80 míst (podpořena je pouze ta varianta vzdělávání, kde je ve specializovaném výcviku 12měsíční praxe v ordinaci PLDD)
- Dětská a dorostová psychiatrie – 10 míst
- Dětská neurologie 10 míst
- Urgentní medicína – 10 míst

V roce 2024 bylo podpořeno těchto 5 oborů:

- Všeobecné praktické lékařství – 140 míst
- Pediatrie – 70 míst (podpořena je pouze ta varianta vzdělávání, kde je ve specializovaném výcviku 12měsíční praxe v ordinaci PLDD)
- Dětská a dorostová psychiatrie – 15 míst
- Dětská neurologie 10 míst
- Urgentní medicína – 5 míst

V roce 2025 bylo podpořeno těchto 5 oborů:

- Všeobecné praktické lékařství 140 míst
- Pediatrie 70 míst (podpořena je pouze ta varianta vzdělávání, kde je ve specializovaném výcviku 24měsíční praxe v ordinaci PLDD)
- Dětská a dorostová psychiatrie 14 míst
- Psychiatrie 16 míst
- Dětská neurologie 10 míst

U všech oborů byla v letech 2023–2025 dotace zvýšena na 50 000 – 57 000 měsíčně, přičemž nejvyšší částky jsou vypláceny pro obor pediatrie.

Podíl dotace, který musí být určen na mzdu rezidenta byl navýšen na 80 %. Akreditované zařízení musí být schopno plnit požadavky na personální zajištění (vyhláška 99/2012 Sb.) při poskytování péče v daném oboru i bez rezidenta. Tzn. rezident je do zařízení přijat „nad rámec“ minimální personálního stavu. Toto opatření má vést k tomu, aby dotace byla využita skutečně na zajištění specializačního vzdělávání, nikoliv k pokrytí mzdových nákladů běžného provozu a bude větší pravděpodobnost, že školitel se bude rezidentovi skutečně věnovat.

IPVZ v rámci agendy rezidenčních míst lékařů i NLZP poskytuje podporu MZ v rámci svých personálních kapacit a podílí se na zlepšování metodických postupů v souladu s praxí. Dále se pořádá pravidelná celorepubliková školení pro žadatele o rezidenční místa a vykonává funkci kontaktního místa pro vyřizování dotazů týkajících se rezidenčních míst. Všechny dotace pro rok 2024 se podařilo proplatit v termínu stanoveném správcem rozpočtu MZ.

V agendě rezidenčních míst se také osvědčuje zapojení akreditačních komisí nejen do fáze hodnocení podaných žádostí o dotaci, ale také do přípravy metodiky dotačního programu, které tak lépe zohledňují specifika jednotlivých podporovaných oborů.

3. Pružné udělování výjimek při uznávání praxe na neakreditovaném pracovišti, pomoc se zajištění akreditačního řízení a setkání akreditačních komisí:

- Pokud pracoviště splňuje kritéria k získání akreditace v daném oboru, avšak nebylo v rozhodném období akreditováno, lze požádat ministra zdravotnictví o udělení výjimky a započítání odborné praxe realizované na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání tak, , aby se kolegům před atestací neprodlužovala doba do složení atestační zkoušky tím, že by museli praxi opakovat, a mohli ji získat co nejdříve po splnění všech podmínek specializačního vzdělávání. Takto lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny stanovené délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru.
- IPVZ zřídilo funkci koordinátora akreditačních komisí, který pomáhá MZ s administrativním zajištěním jednání akreditačních komisí, zajištění podkladů pro jejich rozhodování, zápisů z jednání atd.

4. Realizace projektu "Administrativní systém pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků":

- Projekt „Administrátor" byl zahájen v březnu 2023 v rámci Národního plánu obnovy s cílem zásadně zmodernizovat a zjednodušit administrativu specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR. Hlavním záměrem je vytvořit moderní, efektivní a uživatelsky přívětivý informační systém, který komplexně pokryje veškeré vzdělávací procesy – od evidence školenců a školitelů přes správu akreditací až po procesy evaluace a strategického řízení kapacit.
- Projekt řeší integraci a sladění všech dostupných datových zdrojů o personálních kapacitách a vzdělávání. K databázím integrovaným v rámci projektu patří například národní registry zdravotnických pracovníků (NR-ZP), registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), registry ÚZIS ČR, resortní informační systémy jako GINIS a JASU, i další klíčové evidence v rámci resortu. Nový systém tak umožní získat detailní a aktuální přehled o obsazenosti jednotlivých vzdělávacích programů s možností regionálního členění, což přispěje k přesnému zhodnocení současných a budoucích personálních kapacit ve zdravotnictví.
- Výstupy z tohoto systému budou využívány nejen pro operativní správu a monitoring vzdělávacích agend, ale také jako podklad pro strategické rozhodování na úrovni Ministerstva zdravotnictví i dalších správních orgánů. To zásadně zvýší kvalitu

a efektivitu plánování vzdělávání a přispěje k dostatečné personální stabilitě potřebné pro zajištění kvalitní zdravotní péče v celém Česku.

- Technicky je systém koncipován jako informační systém veřejné správy, a jeho vznik byl legislativně zakotven novelou zákona č. 95/2004 Sb., platnou od 1. července 2024. V zákoně (§ 43c až 43k) je přesně definován systém Administrace se všemi jeho moduly a funkcemi. Provozovatelem systému je IPVZ a systém je plně ve vlastnictví Ministerstva zdravotnictví.
- Na přípravě a vývoji systému se intenzivně podílí celá řada klíčových partnerů: technickou podporu zajišťuje ČVUT Fakulta informačních technologií, koordinaci a metodickou expertízu poskytuje ÚZIS a IPVZ, aktivně participují také všechny lékařské fakulty (LF) v České republice, pověřené organizace jako NCO NZO, spolky Mladých lékařů a lékárníků, a koordinátoři specializačního vzdělávání ve zdravotnických zařízeních řízených Ministerstvem zdravotnictví.
- Za sledované období projektu byly splněny všechny klíčové milníky, mezi které patří:
    - detailní analýza současného akreditačního řízení a specializačního vzdělávání,
    - audit a vyhodnocení plošných datových zdrojů,
    - zpracování legislativního návrhu novely zákona k zakotvení systému,
    - návrh a schválení nových procesů zpracování dat,
    - vyvinutí a spuštění základní datové platformy umožňující integraci s existujícími registry a evidencemi,
    - příprava a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rozšiřujících modulů, včetně přípravy na nezávislé kontroly a ex-ante posouzení.
- Projekt aktuálně vstupuje do hlavní fáze realizace:
    - kompletní vývoj modulů je naplánován od ledna 2025,
    - testovací provoz modulů a systému bude probíhat od června 2025,
    - pilotní provoz se uskuteční v době od srpna do října 2025 s dobrovolným zapojením vybraných lékařských fakult a zdravotnických zařízení,
    - školení uživatelů je plánováno na listopad a prosinec 2025,
    - ostrý provoz s plnou funkcionalitou systému je cílen na 1. ledna 2026.
- Po dokončení umožní systém Administrace plnou digitalizaci dosavadních administrativních procesů, což výrazně sníží administrativní zátěž nejen lékařů a školitelů, ale i institucí zodpovědných za organizaci a kontrolu vzdělávání. Všechny klíčové agendy budou řešeny v digitální podobě, včetně žádostí o akreditace, elektronického indexu školenců, plánování stáží, evaluace, reportingu a integrace s dalšími resortními informačními systémy.
- Systém bude vybaven otevřeným API, které zajistí snadnou a bezpečnou komunikaci s informačními systémy lékařských fakult i dalšími externími platformami, což povede k efektivnější výměně dat a minimalizaci duplicit. Napojení na Národní identitní autoritu (NIA) zajistí odpovídající úroveň autentizace a bezpečnost přístupu.
- Celkově projekt Administrátor představuje zásadní modernizační krok v systému zdravotnického vzdělávání, přinášející transparentnost, vysokou kvalitu služeb, rychlost a efektivitu administrativního řízení. Je to jeden z klíčových nástrojů pro zabezpečení udržitelného rozvoje personálních kapacit v českém zdravotnictví.

5. Ostatní projekty IPVZ jsou zaměřeny na dotované vzdělávání:

- jejich přehled tvoří samostatnou přílohu č. 3 této kapitoly.

6. Stanovování jasných kompetencí lékařů po absolvování základního kmene:

- Stanovení jasných kompetencí lékařů po absolvování základního kmene je upraveno mimo jiné vyhláškou č. 162/2023 Sb., která stanovuje činnosti, které může lékař vykonávat samostatně, tedy bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického. Tato vyhláška nabyla účinnosti od 1. 7. 2023 a rozšiřuje oprávnění lékařů například o specializované úkony v ambulantní péči dětí a dorostu, čímž přispívá k rozšíření kapacity primární péče v tomto segmentu.
- Vyhláška definuje konkrétní činnosti od indikace základních vyšetření a laboratorních metod přes předepisování léčiv až po výkon některých základních ošetřovatelských úkonů. Cílem je nejen zlepšení dostupnosti zdravotní péče dětem bez nutnosti nepřetržitého dohledu zkušenějšího lékaře, ale i zvýšení efektivity a ekonomičnosti služeb.
    - V současné době je v meziresortním připomínkovém řízení projednáván návrh vyhlášky, kterou se stanoví činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene otorinolaryngologického.
    - Dále je v meziresortním připomínkovém řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 561/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického.
- Kromě toho Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) shromáždil a nadále zpracovává návrhy odborných společností týkající se kompetencí po získání zvláštní specializované způsobilosti v nástavbových oborech. Tyto návrhy slouží k jasnému vymezení rolí a oprávnění lékařů v jednotlivých specializacích, což výrazně pomáhá stabilizovat personální situaci v daných oborech a zlepšuje transparentnost odbornosti.
- Celý přehled kompetenčních vyhlášek po absolvování základního kmene je k dispozici v samostatné příloze č. 4 dokumentu.
- Tato právní úprava a metodická opatření tak poskytují jasný a právně podložený rámec pro samostatný výkon lékařských činností po ukončení základního kmene, což je zásadní pro rozšiřování a zkvalitňování zdravotní péče, zejména v primární pediatrické péči. Současně pomáhají profesní stabilizaci lékařů a zajišťují lepší plánování a rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví.

7. Vědecká rada IPVZ:

- Vědecká rada IPVZ je složena ze všech děkanů LF v ČR, předsedy ČLS JEP a dalších klíčových stakeholderů zdravotnického vzdělávání včetně zástupce KOR s cílem

spolupracovat na tvorbě systému, realizaci a rozvoji postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, společného efektivního využívání lidských i materiálních zdrojů a společné participaci na vědecko-výzkumné činnosti. Hlavní důraz je kladen na koordinaci administrativních postupů specializačního vzdělávání, termínů jednotlivých zkoušek a výkladových stanovisek při uznávání praxe v rámci specializačního vzdělávání apod.

8. Vznik pracovní skupiny koordinátorů specializačního vzdělávání ve zdravotnických zařízení přímo řízených MZ:

- S cílem zajistit jednotný a kvalitní průběh specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních byla v roce 2023 zřízena pracovní skupina koordinátorů specializačního vzdělávání. Tato skupina funguje jako stabilní platforma pro metodické vedení, kontrolu a vzájemnou výměnu zkušeností mezi akreditovanými pracovišti, IPVZ a Ministerstvem zdravotnictví.
- Úkolem koordinátorů specializačního vzdělávání je dozor a odpovědnost za naplňováním zákonných podmínek specializačního vzdělávání v akreditovaném zařízením. Zodpovídají za určení školitele každému lékaři zařazenému do specializačního vzdělávání, za stanovení plánu absolvování jednotlivých část vzdělávacího programu, včetně časového harmonogramu. Zodpovídají za férové a transparentní podmínky výkonu specializačního vzdělávání, tzn. nepodmiňování absolvování programu nestandardními podmínkami ze strany zaměstnavatele. Součástí činnosti bylo zřízení kontaktního místa při Ministerstvu zdravotnictví pro přijímání a řešení připomínek, podnětů a stížností od školenců, školitelů i vedení pracovišť, což umožňuje rychlou reakci na problémové situace a pomáhá předcházet sporům
- Na základě podnětů od koordinátorů byla zpracována a zveřejněna jednotná výkladová stanoviska k nejčastějším otázkám aplikace zákona č. 95/2004 Sb. a prováděcích předpisů. Tato stanoviska slouží k sjednocení výkladu a postupů napříč všemi akreditovanými zařízeními, aby se ve srovnatelných situacích postupovalo shodně a předvídatelně.
- Díky činnosti koordinátorů se od roku 2023 podařilo zvýšit úroveň metodického vedení na pracovištích, odstranit řadu rozdílů ve výkladu zákonných povinností a vytvořit prostředí s jasnějšími pravidly pro všechny účastníky specializačního vzdělávání. Propojení této činnosti s digitálními nástroji od roku 2025 posílí jejich schopnost efektivně plnit kontrolní i podpůrnou roli a přispěje k celkové transparentnosti a kvalitě systému postgraduální přípravy.

9. Zjednodušení specializačního vzdělávání:

- Od 1. ledna 2024 byla zrušena doba platnosti tzv. průřezových teoretických povinných kurzů, mezi které patří kurz Lékařská první pomoc, kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a kurz Radiační ochrana. Tyto kurzy mají od tohoto data neomezenou platnost, a proto již lékaři v přípravě na atestaci nejsou omezeni nutností jejich opakovaného absolvování, což v minulosti vedlo často k odkládání termínu atestační

zkoušky. Informace o zrušení této doby platnosti byla oficiálně publikována ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

- Dále od 1. ledna 2025 nabyla účinnosti úprava vyhlášky č. 397/2020 Sb., která již zcela odstranila povinnost absolvovat tyto tzv. průřezové teoretické kurzy u základních kmenů. Následně Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 16/2025 tuto povinnost zrušil rovněž v rámci specializačního a nástavbového vzdělávání.
- Současně byla zrušena povinnost absolvovat dvouměsíční stáže v oborech vnitřní lékařství, chirurgie a anesteziologie a intenzivní medicína (tzv. kolečko), které nyní zůstávají pouze nepovinnou součástí vzdělávacích programů. Tyto stáže je možné nahradit odpovídající praxí v příslušném základním oboru, čímž dochází ke zvýšení flexibility a individualizace vzdělávacího procesu.
- V rámci pravidelné spolupráce probíhá setkávání s proděkany lékařských fakult pro specializační vzdělávání, jehož cílem je vzájemná výměna informací zaměřená na zjednodušení průběhu specializačního vzdělávání a efektivní organizaci atestačních i kmenových zkoušek. V této souvislosti MZD připravuje rovněž vznik pracovní skupiny, jejímž cílem bude sjednocování postupů jednotlivých lékařských fakult při administraci specializačního vzdělávání. Ve spolupráci se Sekcí mladých lékařů České lékařské komory a spolkem Mladí lékaři z.s. vznikají podklady a teze pro novelizaci zákonů č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb., přičemž klíčovým bodem je redefinice role školitele.
    - Je nezbytné, aby osoby, které budou mít přístup do Systému Administrace a vykonávat role spojené se správou vzdělávacích procesů, byly jednoznačně definovány, identifikovatelné a nezaměnitelné. Každá role by měla být v daném okamžiku vykonávána pouze jednou osobou a jasně by měly být stanoveny požadavky na kompetence těchto osob. Toto neznamená omezování pravomocí školitele vůči školenci, ale naopak jasné vymezení vztahu a podmínek pro transparentní, odpovědné a efektivní realizaci vzdělávacího procesu.
    - Aktuálně probíhá otevřená diskuse, zda není vhodné klást na školitele stejné nároky jako na osoby vykonávající dozor a dohled nad lékaři bez specializované způsobilosti, tedy například podmínku dosažení specializované způsobilosti, a zda neupravit současný počet školenců přidělených jednomu školiteli tak, aby byla zaručena kvalita vzdělávání.
- Dalším významným prvkem modernizace specializačního vzdělávání je implementace simulačního vzdělávání jako volitelné součásti. Lékařům ve specializační přípravě bude umožněno volitelně absolvovat definované výkony v akreditovaných simulačních centrech, což doplňuje praktické dovednosti a zvyšuje připravenost školenců na reálnou klinickou praxi.
- Spuštění Systému Administrace rovněž vyžaduje revizi vzdělávacích programů. Po projednání se Vzdělávací radou lékařů byl proto navržen nový formát vzdělávacích programů, který bude použitelný pro automatickou kontrolu jak plnění požadavků na akreditaci ze strany akreditovaných zařízení, tak jednotlivých částí vzdělávacích programů školenci. Nový formát bude schopen automaticky kontrolovat také vnitřní logiku obsahu, např. zda odpovídá požadavek na druh výkonů požadovaných po školenci výkonům, které jsou požadovány po akreditovaném zařízení v rámci akreditačního řízení apod.

- K lepší průchodnosti systému specializačního vzdělávání přispěje navrhovaná vyhláška o školitelích pro obory specializačního vzdělávání a pro nástavbové obory lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, která byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení v červnu 2025. Vyhláška upřesňuje kompetence a povinnosti školitelů a řeší legislativně dosud neukotvené nebo výkladově nejasné situace, ke kterým dochází ve specializačním vzdělávání, např. zda se mezi školence, kteří jsou přiděleni jednomu školiteli počítají lékaři na rodičovské dovolené nebo lékaři vysláni stáže apod.

10. Podpora primární pediatrické péče:

- V 5/2024 byl upraven vzdělávací program specializačního oboru pediatrie, kdy tato úprava umožnila školencům, aby na základě vlastní volby případně absolvovali celých 24 měsíců povinné odborné praxe v tzv. vlastním specializovaném výcviku u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo praktický lékař pro děti a dorost. Předpokládá se, že právě školenci, kteří absolvují tuto variantu vzdělávacího programu, zůstanou po úspěšné atestaci v segmentu primární pediatrické péče, čímž dojde k personálnímu posílení. Na tuto variantu specializačního vzdělávání se rovněž primárně zaměřují dotace na rezidenční místa.

11. Podpora stomatologické péče:

- Podpora primárně řeší úhradu stomatologických výkonů, smluvní vztahy, ale i zjednodušení přístupu non-EU zubních lékařů do našeho systému, aniž by byla snižována kvalita péče a nároky na jejich odbornost. Tato aktivita je podpořena realizací projektu „Jazyková a odborná příprava zdravotnických pracovníků ze zahraničí“ financovaným z OPZ+ a který si klade za cíl zlepšení jazykové a odborné přípravy zahraničních zdravotnických pracovníků a zvýšení úspěšnosti aprobačních zkoušek.

12. Revize aprobačního procesu:

- IPVZ bylo pověřeno tvorbou a následnou realizací vzdělávacího projektu Jazykové a odborné přípravy zahraničních zdravotníků. Analytická část tohoto projektu ukázala nutnost revize systému aprobačního testování. Byla zahájena příprava nových sad testovacích otázek odborníky na testování z UK na základě principu „single best answer“. Tyto otázky byly již pilotně nasazeny do jarního běhu aprobačních zkoušek v roce 2024 a byl sledován trend zvýšení úspěšnosti u písemné části zkoušek. K jeho posílení povede i samotná příprava na aprobační zkoušku. V rámci projektu je aktuálně připravován komplexní e-learningový program pro podporu lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ze zahraničí jak po jazykové, tak i po odborné stránce.

Závěr a shrnutí klíčových výsledků

V období 2023–2025 se podařilo realizovat řadu systémových kroků vedoucích k personální stabilizaci českého zdravotnictví a zefektivnění specializačního vzdělávání lékařů. Většina těchto opatření přímo reaguje na identifikované problémy v oblasti dostupnosti, kvality a nerovnoměrného rozložení personálních kapacit. Následující přehled shrnuje hlavní dosažené výsledky dle jednotlivých oblastí strategie:

Stabilizace postavení mladých lékařů:

- Zavedení 13. platové třídy po absolvování základního kmene, která zvyšuje atraktivitu specializační přípravy a uznává úroveň získaných kompetencí.
- Významné navýšení dotací na rezidenční místa, především v oborech s kritickým nedostatkem personálu (primární péče, pediatrie, dětská neurologie a psychiatrie).
- Průběžný systém přidělování rezidenčních míst bez termínových omezení – zjednodušení přístupu ke vzdělávání bez administrativních bariér.

Zjednodušení specializačního vzdělávání:

- Zrušení povinných kurzů a stáží, které nepřinášely přidanou hodnotu – vyšší flexibilita a individualizace vzdělávacích plánů.
- Možnost variability struktury povinné odborné praxe v základním kmeni, kdy je dána možnost přesunu až 6 měsíců z tzv. povinného kolečka (tj. z praxí v oboru vnitřní lékařství, chirurgie a anesteziologie a intenzivní medicína) do povinné odborné praxe specifické pro každý základní kmen. Délka vzdělávání v základních kmenech však zůstává stejná - 30 měsíců.
- Implementace simulačního vzdělávání jako volitelného nástroje pro nácvik klinických dovedností ve standardizovaném prostředí.

Vymezení kompetencí a metodická stabilita:

- Legislativní ukotvení kompetencí lékaře po základním kmeni – jasná pravidla pro samostatnou práci bez odborného dohledu.
- Zřízení vědecké rady IPVZ a sítě koordinátorů specializačního vzdělávání, které metodicky vedou akreditovaná zařízení a sjednocují výklad právních předpisů.
- Zavedení výkladových stanovisek MZ a zřízení kontaktního místa pro podněty ze strany školenců i školitelů.

Zahraniční pracovníci a aprobační systém:

- Realizace projektu jazykové a odborné přípravy zahraničních lékařů, který vede ke zvýšení úspěšnosti u aprobačních zkoušek a rychlejšímu zapojení do praxe.
- Zahájení revize systému testování – nové otázky typu „single best answer“, příprava e-learningového modulu.

Systémová digitalizace vzdělávání:

- Schválení novely zákona č. 95/2004 Sb., která zavádí Systém Administrace jako informační systém veřejné správy (účinnost od 1. 7. 2024).

Aktuální vývoj Systému Administrace k 08/2025

Dosavadní způsob evidence, koordinace a řízení specializačního a nástavbového vzdělávání lékařů byl roztříštěný, papírový a v mnoha ohledech zastaralý. Chyběl ucelený přehled o personálních kapacitách v reálném čase, nebylo možné efektivně predikovat budoucí potřeby ani cíleně řídit přetížené či ohrožené obory. Opatření se často přijímala reaktivně, nikoli na základě dat.

Systém Administrace, přináší zásadní změnu – **komplexní digitalizaci a integraci všech procesů** spojených se vzděláváním zdravotnických pracovníků, především lékařů. Jde o centrální informační systém veřejné správy, který:

- propojuje školence, školitele, akreditovaná zařízení, IPVZ i MZ,
- umožňuje plánovat, kontrolovat a vyhodnocovat vzdělávací procesy v reálném čase,

- vytváří přímé napojení na národní registry (NR-ZP, NRPZS, ÚZIS aj.),
- poskytuje výstupy pro strategická rozhodnutí, predikci potřeb a optimalizaci systému.

Systém Administrace představuje zásadní reformní krok v oblasti řízení specializačního a nástavbového vzdělávání lékařů v ČR. Projekt je realizován IPVZ od roku 2023, legislativně byl nový systém zakotven novelou zákona č. 95/2004 Sb. a na jeho přípravě a definici se aktivně podílejí další instituce jako MZd, ÚZIS, ČVUT, lékařské fakulty a další…

Klíčové cíle systému Administrace:

- Plná digitalizace agend akreditací, školenců, školitelů, plánování, evaluace a reportingu.
- Integrovaný přístup k datům – napojení na klíčové registry (NR-ZP, NRPZS, GINIS, ÚZIS).
- Zajištění efektivního řízení personálních kapacit na základě reálných a aktuálních dat.
- Zjednodušení komunikace mezi školenci, školiteli, pracovišti, IPVZ a MZ.
- Strategické plánování – využití výstupů systému pro cílená rozhodnutí v oblasti vzdělávání a zdravotní politiky.

Technické a legislativní ukotvení:

- Systém je informačním systémem veřejné správy (ISVS), § 43c zákona č. 95/2004 Sb.
- Všechny moduly (akreditace, školenci, evaluace, plánování) definovány zákonem v § 43d–43k.
- Provozovatelem systému je IPVZ, vlastníkem a správcem systému je Ministerstvo zdravotnictví.

Vývoj systému Administrace

Březen–říjen 2023: Přípravná a analytická fáze

- V březnu 2023 byl projekt zahájen v gesci IPVZ.
- Do října 2023 probíhala detailní procesní a datová analýza systému specializačního a nástavbového vzdělávání v ČR.
- Na základě závěrů analýzy zpracoval projektový tým návrh legislativní novely zákona č. 95/2004 Sb., která ukotvila systém Administrace jako informační systém veřejné správy (ISVS).
- Současně vzniklo rámcové zadání systému, včetně doporučení na technické řešení a architekturu

Říjen–prosinec 2023: Legislativní ukotvení a řízení projektu

- Novela zákona č. 95/2004 Sb. byla v říjnu 2023 schválena vládou a zařazena do legislativního procesu.
- V prosinci 2023 byla rámcová dokumentace systému schválena vedením Ministerstva zdravotnictví.
- Projekt získal souhlasná stanoviska NÚKIB a DIA, čímž byla splněna bezpečnostní a právní podmínka pro vznik ISVS.
- Na konci roku byli jmenováni členové řídicího výboru, včetně zástupců ÚZIS, FIT ČVUT, Asociace děkanů LF a IPVZ.

Leden–červen 2024: Vývoj základní datové platformy

- Vzhledem ke složitosti problematiky bylo rozhodnuto, že základní datovou platformu vyvine IPVZ vlastními kapacitami.
- Současně probíhaly práce na zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na rozšiřující moduly systému.
- V lednu až dubnu 2024 proběhly workshopy se zástupci LF, nemocnic a profesních organizací, během nichž byl prezentován návrh uživatelského rozhraní a připomínkovány jednotlivé funkcionality.
- V dubnu 2024 bylo uživatelské rozhraní pro agendu akreditací oficiálně schváleno Ministerstvem zdravotnictví.
- Dne 30. června 2024 byla dokončena základní datová platforma, zpřístupněna MZ ČR a úspěšně napojena na klíčové národní registry (NR-ZP, NRPZS, GINIS, ÚZIS aj.).
- K tomuto datu byly také předloženy všechny požadované dokumenty k prvnímu milníku projektu, který byl následně schválen kontrolním orgánem MZ i Evropskou komisí v rámci NPO.

Červenec–srpen 2024: Legislativní a veřejnoprávní završení (novela #1)

- července 2024 vstoupila v platnost novela zákona č. 95/2004 Sb., která v § 43c–43k definuje systém Administrace a jeho jednotlivé moduly jako součást právního rámce specializačního vzdělávání.
- Dne 28. srpna 2024 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví pracovní jednání se zástupci lékařských fakult a spolků mladých lékařů, kde byl představen aktuální stav projektu, návrh harmonogramu implementace i budoucí role jednotlivých uživatelů systému.
- Ve stejný den došlo také k vypsání veřejné zakázky (1. kolo – kvalifikace) na dodavatele Systému Administrace.

Říjen 2024–srpen 2025: Koordinace a přechod k realizaci

- 15. října 2024 byl stav projektu prezentován na jednání Vědecké rady IPVZ
- Na základě podnětu KOR a LF IPVZ připravil návrh technického API rozhraní, které umožní propojit informační systémy jednotlivých fakult (SIS) se systémem Administrace bez nutnosti zásadních úprav stávajících struktur. Uvedená dokumentace byla rozeslána všem LF skrze KOR 30. 4. 2025.
- Vyhlášeno 2.kolo veřejné zakázky na dodavatele systému – pro podání nabídek, následná jednání vyústila k podpisu smlouvy (28. 3. 2025) s dodavatelem Systému Administrace.
- Projekt je realizován v úzké spolupráci s koordinátory specializačního vzdělávání, odbornými společnostmi a spolky mladých lékařů
- Dne 15. července 2025 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví (zákon č. 236/2025 Sb.), která do právního rámce výslovně doplnila definici „Systému Administrace“ jako informačního systému pro administraci (centralizace a standardizace) vzdělávání ve zdravotnictví. Většina ustanovení dle tohoto zákona nabývá účinnosti 1. ledna 2026.

- Testování systému jednotlivých agend proběhne 15. října – 30. listopadu 2025 za součinnosti všech lékařských fakult a spolků Mladých lékařů a lékárníků. Cílem je ověřit funkčnost klíčových modulů, integraci se studijními informačními systémy prostřednictvím API rozhraní a připravenost uživatelů na ostrý provoz.
- Školení uživatelů nového informačního systému proběhne 3.–15. prosince 2025 a zaměří se na administrativní pracovníky, koordinátory vzdělávání i zástupce LF. Součástí bude praktický nácvik práce se systémem, řešení modelových situací a seznámení s podporou přes helpdesk a online manuály.
- Plné nasazení Systému Administrace do produkčního (ostrého) provozu je stanoveno na 1/2026.

Přínosy Systému Administrace

Projekt „Administrátor“ představuje první systémové řešení, které spojuje administrativu, správu kvality, řízení lidských zdrojů a strategické plánování v oblasti vzdělávání zdravotníků do jednoho celku.

Přínosy pro ministerstvo:

- Centralizovaný přehled o vzdělávacích kapacitách včetně regionálního a oborového členění.
- Predikce budoucích potřeb zdravotnického personálu – možnost cílené podpory ohrožených segmentů.
- Automatizovaná evidence všech klíčových údajů: akreditace, počty školenců, výkon školitelů, zpětná vazba.
- Podpora rozhodovacích procesů MZ na základě dat z jednoho jednotného zdroje.

Přínosy pro lékaře – školence:

- Elektronický přístup ke vzdělávacímu plánu.
- Online podání žádostí o zařazení do SPV, průběžné sledování postupu.
- Transparentní podmínky, dostupnost informací o vzdělávacím procesu a výstupech.

Přínosy pro školitele a zařízení:

- Zjednodušená administrativa – méně papírové agendy, automatické vykazování.
- Přehledné nástroje pro správu plánů školenců, elektronické hodnocení, podpora akreditací.
- Přístup k metodickým materiálům, aktualizacím a výkladovým stanoviskům v jednom prostředí.
- Technologické výhody
- Propojení s národními registry, využití NIA ID pro bezpečné přihlášení.
- Otevřená API architektura pro integraci s fakultními systémy.
- Modulární architektura s možností dalšího rozšíření dle vývoje legislativy a potřeb systému.

Příloha č. 1 – Technická specifikace Systému Administrace (verze 2.0 z 19.02.2025)
Příloha č. 2 – Přehled projektů IPVZ_31_07_25

Kapitola VIII. Zajištění personálních kapacit – kapacity a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

https://nzip.cz/koncepce2025#nlzp

Demografické stárnutí populace nelékařských zdravotnických pracovníků a již v současnosti zdokumentovaná omezená dostupnost kapacitně ohrožených profesí vyžaduje velmi zásadní a komplexní opatření vedoucí k rychlé nápravě. Tím nejzásadnějším je v červenci 2025 schválený dlouhodobý vládní program podpory výchovy všeobecných sester a dalších profesí NLZP. Tento program při zapojení 17 vysokých škol, v synergii s výchovou sester na vyšších odborných školách, přinese navýšení produkce absolventů v počtech, které mají potenciál vytvořit dostatečnou kapacitu pro zdravotní i sociálně zdravotní segmenty služeb. Dalšími významné kroky a opatření realizované v rámci přijaté koncepce směřují k zvyšování kompetencí NLZP, usnadnění systému vzdělávání a vytváření podmínek, za který nebudou pracovníci z veřejných zdravotních služeb odcházet. Hovoříme-li o nelékařských zdravotnických pracovnících (dále také „nelékaři"), jde o zdravotnické pracovníky s výjimkou lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Jde především o všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, radiologické asistenty, fyzioterapeuty, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty a další zdravotnické pracovníky.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Personální zajištění zdravotních služeb je nepochybně jedním z nejobtížnějších úkolů veřejného zdravotního systému ve většině vyspělých států. Jde o agendu vyžadující dlouhodobé plánování, na sebe navazující součinnost více resortů a také alokaci nezanedbatelných finančních zdrojů do vzdělávacího systému. Personální stabilizace často vyžaduje implementaci velmi komplexních a konkrétních opatření, což je případ i České republiky. České zdravotnictví bohužel v rostoucí míře limituje nedostatečná kapacita nelékařských zdravotnických pracovníků, a to ve více profesích. Dlouhodobě nedostatečná a klesající kapacita všeobecných sester, dětských sester, porodních asistentek, radiologických asistentů a dalších nelékařských zdravotnických profesí je v kontrastu se zvyšující se poptávkou stárnoucí české populace po zdravotních službách. Chybějící personální kapacity ohrožují v dalším desetiletém horizontu dostupnost i kvalitu péče.

Aktuálně dle dat Národního zdravotnického informačního systému ve zdravotnictví působí cca 83 tisíc sester a v různých oborech napříč systémem jich již nyní přibližně 3 tisíce schází. Velmi varující je také to, že další tisíce sester v dohledné době v zaměstnání pravděpodobně skončí z důvodu odchodu do důchodu. Více jak 12 tisíc všeobecných sester je ve věku nad 60 let a dalších 1 774 sester již dokonce přesáhlo věkovou hranici 70 let. Sestry chybí jak v akutní, tak i dlouhodobé a následné péči. Nejproblematičtější je pak situace v sociálních a zdravotně sociálních službách, kde věku 60 let dosahuje až pětina sester. Přitom jde o segment, který bude muset nevyhnutelně kapacitně růst s postupujícím demografickým stárnutím populace. Problematika se týká i dětských sester a porodních asistentek. Co se týče radiologických asistentů, v nadcházejících deseti letech bude odchod do důchodu hrozit u zhruba 32 procent dnešních kapacit, což znamená až 1250 úvazků. Objem na tuto odbornost vázaných výkonů přitom za posledních 10 let vrostl o téměř 22 procent, přičemž problém ještě umocňuje nerovnoměrná distribuce kapacit mezi poskytovateli. U cca padesáti poskytovatelů lůžkové péče již dnes není provoz techniky kryt odpovídajícím počtem úvazků radiologických asistentů. Celkově již nyní registrujeme chybějící kapacitu radiologických asistentů v objemu cca 200 úvazků.

Problémy s dostupnou kapacitou hrozí i v nemenší míře u odborností zdravotnický záchranář a nutriční terapeut. Zdravotničtí záchranáři sice nejsou ohroženi demografickým stárnutím, je ale třeba alespoň částečně kompenzovat ukončení vzdělávání této profese na vyšších odborných školách (VOŠ) v roce 2019, což přineslo výpadek pětileté produkce absolventů ve výši zhruba 700 zdravotnických záchranářů. Problémem je také velmi rozdílná úvazková kapacita mezi regiony, kdy se rozsah v přepočtu úvazků na 100 tisíc obyvatel pohybuje mezi 19,2 až 63,1. Celková chybějící kapacita zdravotnických záchranářů u zdravotnických záchranných služeb je cca 100 úvazků, v kapacitně poddimenzovaných regionech, jako je Moravskoslezský, Karlovarský, Olomoucký, Jihomoravský či Pardubický, pak existuje potenciál uplatnit dalších 500 až 600 úvazků. Další poptávku po této profesi generují nemocnice a segmenty řešící urgentní a zdravotně krizové situace v terénu. V tuto chvíli u nás záchranáře vzdělává deset škol, i když jen záchranných služeb je čtrnáct. Žádoucí je rovněž posílit kapacity nutričních terapeutů, kde sice nehrozí demografické stárnutí, ale jejich kapacity nestačí k pokrývání narůstajícího objemu zdravotních a zdravotně sociálních služeb.

Závěrem provedených datových auditů personálních kapacit je fakt, že po roce 2030 hrozí kritická situace v řadě nelékařských profesí, a proto je nutné v následujících letech věnovat pozornost posílení vzdělávacích kapacit a zejména navýšit počet studentů nejvíce ohrožených oborů na vysokých školách. Tento krok vychází z pozitivní zkušenosti s programem podpory výuky všeobecného lékařství, který byl zahájen v letech 2018–2019. Lékařské fakulty náročné parametry programu naplnily a počet studujících budoucích lékařů narostl o téměř 30 %. Byla tak připravena platforma, která má velký potenciál pokrýt rostoucí potřebu lékařů a také nahradit ztrátu kapacit z důvodů demografického stárnutí lékařů.

Iniciace podobného programu směřujícího k navýšení produkce vysokoškolsky vzdělaných nelékařů by významně napomohla řešení hrozících kapacitních rizik. Vzdělávání lékařů i nelékařů na vysokých školách je přitom velmi efektivní a vede k uplatnění absolventů v systému veřejného zdravotního pojištění. Pozitivní zprávou je, že v posledních letech

absolventi zdravotnických oborů nastupují do zaměstnání v oboru. Např. ze všeobecných sester, které získaly odbornou způsobilost mezi lety 2018 a 2022, jich nyní ve zdravotnictví aktivně pracuje více než 80 %, u praktických sester je to pouze 50 %, tato čísla ovšem mohou být zkreslená tím, že někteří absolventi ještě dále pokračují ve studiu (sestry bakalářky v magisterském navazujícím studiu a praktické sestry ve studiu připravujícím na výkon povolání všeobecné či dětské sestry, popř. jiného zdravotnického povolání). Část výpadku aktivních kapacit je rovněž způsobena mateřstvím mladých sester, které po dokončení vzdělávání zakládají rodinu.

Vzdělávání nelékařů je nastaveno dobře, je ale nutné neustále zlepšovat především vzájemnou prostupnost a provázanost vzdělávacích a studijních programů a zlepšit propojení vybraných nelékařských zdravotnických oborů a touto efektivní synchronizací zkrátit přípravu na výkon zdravotnického povolání. Problém je dědictví proběhlých reforem, kdy v řadě oborů máme jak bakalářské studium, tak odborné studium na vyšší odborné škole. Současně jsou v ČR i čtyřletá maturitní studia, která připravují absolventy na výkon „asistentských“ zdravotnických povolání (např. laboratorního asistenta, asistenta zubního technika), přičemž míra jejich využití je omezená. Máme tedy vlastně kombinaci systému německého a anglosaského. Zvláštností je pak studium sester, kdy vedle všeobecných sester a dětských sester vychováváme i praktické sestry.

I přes tyto limitace je pro systém velkou šancí relativně vysoký zájem o studium zdravotnických profesí mezi mladými lidmi. Aktuálně například na základě opatření krajů dokázaly VOŠ podstatně navýšit počet studujících v sesterských oborech, obdobně pozorujeme velký zájem o studium zdravotnických lyceí. Ministerstvo opakovaně oslovilo hejtmany krajů ve věci přijetí maximálního počtů při přijímacím řízení úspěšných zájemců o vzdělávání ve zdravotnických oborech. Některé střední a vyšší odborné školy již své kapacity podstatně navýšily. Nyní v ČR působí 35 VOŠ s produkcí 570 studentů ročně, k tomu máme 16 vysokých škol s produkcí 680 absolventů.

Cílem personální stabilizace resortu zdravotnictví ovšem nemůže být pouze zabezpečení odpovídajícího početního stavu, neméně významné je rovněž zajištění optimální struktury profesí, optimalizace jejich kompetencí a garance celoplošného pokrytí služeb ve všech regionech. Zde je problémem dlouhodobá absence plánování pracovních sil ve zdravotnictví. Dle map vzdělavatelů a map poskytovatelů zdravotní péče se ukazuje, že existují velké regionální oblasti, kde je více než jedna nemocnice, mnoho poskytovatelů ambulantní péče a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících zdravotní péči, ale přitom v této regionální oblasti je jen jeden vzdělavatel produkující všeobecné sestry v bakalářském studiu a jeden vzdělavatel vzdělávající všeobecné sestry na VOŠ. Produkce absolventů je tak nízká, že nemůže přirozeně saturovat obměnu zdravotnických pracovníků ve své spádové oblasti. U řady nelékařských profesí nadto evidujeme velmi významné rozdíly v dostupné kapacitě mezi regiony ČR, což souvisí s neoptimálně budovanou infrastrukturou služeb a do značné míry také s nižší atraktivitou některých oblastí pro čerstvě vystudované zdravotnické pracovníky.

Další výzvou je otázka kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků. Řadu méně odborných činností, zejména administrativních, stále musí zbytečně vykonávat zdravotničtí pracovníci. Tento problém je ale dán spíše neochotou vedení pracovišť měnit zaběhnuté

postupy a hledat cesty k větší efektivitě práce např. zapojením administrativních pracovníků, odborných pracovníků správy zdravotnických dat. Ministerstvo zdravotnictví reagovalo na podněty z praxe a od roku 2019 pořádá ve spolupráci s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví nový kurz Administrativní pracovník ve zdravotnictví a Koordinátor zdravotní péče. Díky těmto kurzům je možné ve zdravotnictví zaměstnat nezdravotnické pracovníky, kteří mohou lékařům a sestrám pomáhat s administrativou a zpracováním zdravotnických dat. Cílem je zdravotníkům od administrativy ulevit a umožnit jim věnovat více času pacientům.

Opatření realizovaná pro personální stabilizaci nelékařských zdravotnických profesí

Ministerstvo zdravotnictví zahrnulo stabilizaci pracovní síly ve zdravotnictví do svého strategického rámce Zdraví 2030 a zřídilo pro dlouhodobě udržitelný rozvoj personálních kapacit Strategickou skupinu pro personální zajištění resortu zdravotnictví, ve které jsou zastoupeni všichni relevantní zástupci vzdělavatelů, poskytovatelů, odborných společností, odborů, samosprávy, i plátců zdravotní péče. Ministerstvo tak ustavilo odbornou platformu, kde lze veškeré definované problémy řešit ve spolupráci s širokou odbornou veřejností.

Ministerstvo s cílem vytvoření sady nástrojů pro řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví využilo příležitost k zapojení do mezinárodního projektu Joint Action on HEalth woRkfOrce to meet health challEngeS, („JA HEROES“) v rámci programu EU pro zdraví. Společná akce JA HEROES si klade za cíl podpořit budování administrativní kapacity členských států a rozvoj znalostí o datových zdrojích, které jsou potřebné pro komplexnější plánování personálních kapacit ve zdravotnictví a budování kapacit pro účinné predikce a plánování personálních kapacit ve zdravotnictví. Ministerstvo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů mapuje personální kapacity, včetně datových zdrojů, a vytváří plánovací modely. Pilotní mapování, datové zdroje a modely plánování byly již provedeny u povolání fyzioterapeuta a v oblasti domácí péče. Připravují se pilotní modely pro povolání všeobecné sestry, radiologického asistenta, zdravotnického záchranáře. Cílem je zřídit Národní centrum pro plánování a forecasting pro HCW.

Problém s nedostatkem nelékařských zdravotnických pracovníků řeší ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a za podpory rektorů a děkanů škol vzdělávajících nelékařské zdravotnické pracovníky a odbornými společnostmi dlouhodobým programem na podporu výuky v kapacitně ohrožených oborech. Obdobně jako byl připraven dlouhodobý program pro podporu lékařských fakult připravující studenty „mediky“ na výkon povolání lékaře, iniciovalo ministerstvo přípravu programu na podporu výuky vybraných nelékařských profesí. Tento program, který již schválila vláda, bude realizován v letech 2026 až 2037 a jeho celková alokace je přes 12, 8 miliard korun. Produkce fakult bude posílena v ošetřovatelských oborech (Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence), a v oborech Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a Nutriční terapie a počítá s navýšením počtu studentů v prvních ročnících o minimálně 20 %, přičemž u programu Všeobecného ošetřovatelství se počítá s nárůstem až o 40 %. Součástí programu je také zajištění kvalitního pedagogického zázemí a odpovídajících mzdových podmínek pro

akademické pracovníky. K programu se aktivně přihlásilo 17 veřejných vysokoškolských vzdělavatelů s potenciálem pokrýt zvýšenou produkcí hrozící propad kapacit NLZP. Konkrétní parametry navrženého programu jsou následující:

- Program je navržen na dobu 12 let
- Finanční krytí se bude odvíjet od reálných počtů studujících, nejde tedy o paušální financování bez kontroly produkce
- Finanční model pokrývá nejen vlastní navýšení produkce, ale také dorovnání odměn vyučujících na průměrnou úroveň mezd všeobecných sester v akutních nemocnicích
- Program obsahuje prvky usnadňující prostupnost a navyšující kvalitu studia, např. klesající počet studentů na úvazek učitele apod.
- Při předpokládané celkové úspěšnosti studia 70 % má program potenciál během 12 let vychovat následující počty pracovníků:
    - Všeobecná sestra: 11 078
    - Porodní asistentka: 2 539
    - Dětská sestra: 1 547
    - Radiologický asistent: 1 728
    - Zdravot. záchranář: 3 573
    - Nutriční terapeut: 1 250.

Výše uvedená produkce odpovídá kapacitním potřebám zdravotnického systému a kryje očekávané odchody pracovníků do důchodu v následujících cca 10–12 letech. Výjimkou jsou všeobecné sestry, kde je potřebný objem nových absolventů odhadován minimálně na 24 000 úvazků. Vzdělávání v tomto oboru tedy nemůže probíhat jen na vysokých školách, neméně významná je produkce VOŠ. Aktuální roční produkce sester studujících na VOŠ je cca 570 a od roku 2021 vyšší odborné školy navýšily počet nově studujících o 40–50 %. Lze tedy předpokládat, že VOŠ v dalších 12 letech vychovají dalších cca 11 000 všeobecných sester.

Vedle toho je strategickým záměrem ministerstva co nejvíce **zprůchodnit systém kvalifikačního vzdělávání a následného profesního vzdělávání, včetně vzdělávání specializačního.** V nedávné době ministerstvo vydalo aktualizované vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Ošetřovatel a Praktická sestra. Ve spolupráci s MŠMT ministerstvo propojuje vybrané obory vzdělání kategorie H–M–N ve skupině oborů vzdělání 53 - Zdravotnictví ve vybraných středních a vyšších odborných školách. Již bylo vyhlášeno pokusné ověřování stupňovitého propojení v oborech:

- 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra pro absolventy oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, 53-41-H/01 Ošetřovatel,
- 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra pro absolventy oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, 53-41-H/01 Ošetřovatel,
- 53-41-M/02 Nutriční asistent, 53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut,
- 53-43-M/01 Laboratorní asistent a 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotnický laborant.

V plánu je připravit a vyhlásit pokusné ověřování v dalších odbornostech, a to konkrétně v oborech Asistent zubního technika – Diplomovaný zubní technik.

S využitím prostupnosti zdravotnických povolání a v rámci studia již získaných znalostí a dovedností je transpoziční novelou zákona č. 96/2004 Sb. umožněno studentům připravujících se na výkon povolání všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář vykonávat dříve v průběhu studiu zdravotnické povolání praktické sestry s nižšími kvalifikačními požadavky. Studentům je tak umožněno nabyté znalosti a dovednosti v průběhu studia využít v co nejvyšší možné míře, poznávat provoz zdravotnických zařízeních bezprostředněji a získávat zkušenosti z práce s jinými zdravotnickými pracovníky.

Ministerstvo apelovalo na zprůchodnění vzdělávání vyšších odborných (VOŠ) a vysokých škol tak, aby absolventi VOŠ nemuseli v podstatě opakovat své vzdělání v bakalářském studiu ve chvíli, kdy by měli zájem o studium magisterské. Ministerstvo podporuje vznik detašovaných pracovišť středních zdravotnických škol, event. vyšších odborných škol u fakultních nemocnic (již vzniklo detašované pracoviště ve FTN v Praze a v Jihočeském kraji).

Co se týče vysokoškolského studia ve zdravotnických oborech, ministerstvo udržuje dlouhodobou spolupráci s Národním akreditačním úřadem (NAU) a kontroluje pro NAU studijní programy, zda odpovídají právním předpisům z pohledu splnění minimálních požadavků na studijní programy regulovaných zdravotnických povolání. Obě instituce se zaměřují na kvalitu vzdělávání, zástupce ministerstva je rovněž pověřenou osobou pro výkon kontrolní činnosti NAU. Pravidelná spolupráce se vzdělavateli a vede k nastavení tzv. kvalifikačních standardů. Kvalifikačními standardy jsou podrobněji stanoveny minimální požadavky na studijní programy vysokých škol nebo vzdělávací programy vyšších odborných škol. Cílem je stanovit zejména minimální počty hodin teoretické a praktické přípravy a stanovit její nepodkročitelný rozsah tak, aby byla zajištěno kvalitní profesní vzdělávání na výkon zdravotnického povolání a absolventi daných programů byli odpovídajícím způsobem a kvalitně připraveni k výkonu povolání. V této souvislosti ministerstvo působí i jako mediátor mezi vzdělavateli a zástupci profesních organizací pro sbližování praktických požadavků současného zdravotnického systému a obsahu vzdělávání. V současné době probíhá revize kvalifikačního standardu Dětská sestra, ministerstvo z odborné veřejnosti obdrželo podněty k revizi kvalifikačních standardů pro Všeobecnou sestru a Porodní asistentku.

V rámci připravovaných inovací ve výuce se ministerstvo zabývalo četnými podněty na zrušení či nahrazení bakalářských prací. K tomuto podnětu již v roce 2022 proběhla diskuze s předsedkyní Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR, na podnět reagovaly všechny vysoké školy ve shodě, a to názorem k zachování závěrečných bakalářských prací, kromě vysoké školy ČVUT. V dalším období předpokládáme další diskuze. Samozřejmostí je podpora využívání moderních prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi, tato témata jsou obsažena v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů ve zdravotnictví (např. modely – low fidelity a high fidelity simulátory). Dalším inovativním opatřením ke stabilizaci počtu vzdělávaných zdravotnických pracovníků jsou stipendia. Ministerstvo umožnilo již v roce 2019 změnou zřizovacích listin všem svým státním příspěvkovým organizacím, aby bylo možné poskytovat stipendia studentům a studentkám zdravotnických oborů. Zároveň jsou realizovány různé podpůrné programy a stipendia prostřednictvím Krajů.

Ministerstvo jedná s MŠMT o obsahu vzdělávání oboru Zdravotnické lyceum a o možném uplatnění těchto absolventů ve zdravotnictví. Cílem je vytvořit podmínky, aby tito absolventi mohli ve zdravotnictví vykonávat činnosti administrativního pracovníka ve zdravotnictví či nejjednodušší činnosti odborného pracovníka správy zdravotnických informací apod. Je plánováno zařadit do vzdělávání ve zdravotnickém lyceu nejen tématiku k vykazování zdravotní péče, ale i koordinační a administrativní činnosti související s poskytováním zdravotní péče. Ve spolupráci s MŠMT proběhne ověřování zájmu a úspěšnosti studentů zdravotnických lyceí ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách a dále jsou se vzdělavateli diskutovány možnosti začlenění příslušného předmětu či témat do výuky.

Dalším nástrojem je modernizace specializačního vzdělávání přinášející jeho větší flexibilitu, větší prostupnost, provázanost modulového vzdělávání, stupňovité propojení vybraných oborů a zkrácení délky vzdělávání, modernizace organizace, metod, forem vzdělávání, zavádění on-line vzdělávání, e-learning, virtuální simulace, interdisciplinární vzdělávání, stipendia, finanční podpora, podpora mentorství.

Pro sdělení a zpřehlednění již dnes existující částečné provázanosti a prostupnosti oborů specializačního vzdělávání všeobecných sester zpracovalo ministerstvo společně s NCO NZO metodické doporučení, které přibližuje, co lze z jedné specializace započíst do druhé, demonstruje oblasti (okruhy) znalostí a dovedností, které všeobecná sestra v absolvovaném specializačním vzdělávání nezískala nebo získala v jiném rozsahu, a které může získat nejenom absolvováním dalšího specializačního vzdělávání, ale též absolvováním certifikovaných kurzů.

Dlouhodobě se také daří optimalizace specializačního vzdělávání, jedná se o podporu prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester mezi nejčastěji požadovanými obory prostřednictvím započítání předchozího vzdělávání, které povede ke zkrácení vzdělávací cesty v těchto oborech:

- Ošetřovatelské péče v interních oborech
- Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
- Ošetřovatelská péče v geriatrii
- Domácí a hospicová péče
- Intenzivní péče

Nově je zaměstnavatel svému zaměstnanci, který se vzdělává v oboru specializačního vzdělávání, povinen umožnit přípravu a vykonání zkoušky, a to v rozsahu nejméně 5 pracovních dnů.

Připravuje se plná elektronizace specializačního a nástavbového vzdělávání, která zdigitalizuje, urychlí a zjednoduší potřebné procesy, např. akreditační řízení, zařazování do specializačních oborů, přihlašování se k atestačním zkouškám. Systém administrace bude spuštěn k 1. lednu 2026 a aktuálně probíhají nezbytné přípravy pro digitalizaci jako jsou např. úpravy vzdělávacích programů. Potřebná elektronizace vzdělávání pomůže efektivněji využít kapacity školitelů i čas školenců a skutečně zlepšit kvalitu jejich vzdělávání, zároveň se očekává snížení administrativní zátěže a nastavení optimalizovaných procesů mezi jednotlivými subjekty.

Výstavba nového simulačního centra intenzivní medicíny ve FN Motol a dovybavení stávajících simulačních center lékařských fakult veřejných vysokých škol a zařazení simulací jako standardního vzdělávacího nástroje do systému vzdělávání zdravotnických pracovníků je dalším opatřením, které je realizováno pro kontinuální zvyšování kvality, dostupnosti a efektivity zdravotní péče.

Ministerstvo již umožňuje vzdělávání v kvalifikačních kurzech, certifikovaných kurzech nebo ve specializačním vzdělávání realizovat vedle denní formy též formou kombinovanou, teoretická část vzdělávání může probíhat formou distanční, praktickou část, resp. plnění stanoveného počtu zdravotních výkonů lze částečně plnit/nahradit simulací.

Mezi další opatření, která Ministerstvo pro nelékařské zdravotnické pracovníky dlouhodobě realizuje, patří zejména opatření v oblasti motivace, stabilizace a podpory specializačního vzdělávání prostřednictvím dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Hlavním cílem dotačního programu je podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí, stabilizace personální situace, získání kvalifikovaného a motivovaného personálu. Mladí zdravotníci jsou důležitou součástí všech pracovních týmů a finanční podpora jejich odborného vzdělávání je pro zdravotnická zařízení velmi důležitá. Současně pro podpořeného zaměstnance může být tato podpora základním předpokladem pro odborný profesní růst a jistotu zaměstnání.

Dotační program cíleně reaguje na dlouhodobý nedostatek pracovníků se specializovanou způsobilostí napříč zdravotnickým systémem v České republice, a to zejména v regionech a v klinicky náročnějších oborech (např. intenzivní péče, perioperační péče, ošetřovatelská péče v psychiatrii apod.).

Zároveň, novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, bude od ledna 2026 umožněno zdravotním pojišťovnám nově poskytovat dotace na vzdělávání zdravotnických pracovníků i z jejich fondů.

Mezi další doprovodná opatření k posílení personálních kapacit patří i podpora náboru zahraničních pracovníků. Za tímto účelem bylo zřízeno Kontaktní centrum – cizinci, které poskytuje potřebné informace zdravotnickým pracovníkům přicházejícím ze zahraničí a chtějí pracovat ve zdravotnictví v České republice. Kontaktní centrum pomáhá zahraničním zdravotníkům v průběhu celého adaptačního procesu, tj. od nostrifikace přes aprobační zkoušku až po uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR. Kontaktní centrum – cizinci je také poradenským pracovištěm pro všechny poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, kteří chtějí zahraničního zdravotníka zaměstnat.

Od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2025 realizuje za podpory Ministerstva zdravotnictví NCO NZO projekt Ověření dílčího řešení personální stabilizace ve zdravotnictví prostřednictvím pracovníků ze zahraničí. V projektu se ověřuje dílčí řešení personální stabilizace ve zdravotnictví prostřednictvím zapojení pracovníků ze zahraničí. Návrh je komplexní od náboru a motivace k práci ve zdravotnictví, přes odborné vzdělávání po uplatnění se na trhu práce v resortu zdravotnictví a zahrnuje jak podporu pracovníků ze zahraničí, tak podporu poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci projektu probíhají akreditované kvalifikační kurzy Ošetřovatel a Praktická sestra a nabízí se on-line kurz českého jazyka pro zahraniční zdravotníky, především

praktické a všeobecné sestry, ale i pro jiné zdravotnické pracovníky, připravující na aprobační zkoušku. Jedním z cílů projektu je zvýšit úspěšnost účastníků při aprobační zkoušce a tím zkrátit dobu jejich začlenění na trh práce. V rámci projektu je nabízeno i tzv. Modulové vzdělávání. Každý modul je koncipován jako teoreticko-praktický, využívá aktivizující metody a je přizpůsoben potřebám zahraničních zdravotnických pracovníků. Důraz je kladen na vědecky ověřené poznatky v oblasti ošetřovatelské péče, rozvoj znalostí, schopností a dovedností nezbytných pro poskytování bezpečné ošetřovatelské péče, včetně multikulturních aspektů. Jeden z modulů se například zaměřuje na dodržování zdravotnických standardů, používání moderních přístrojů a technologií v ošetřovatelské péči. Další modul se věnuje právním předpisům v ošetřovatelství a právní odpovědnosti nebo efektivní komunikaci s pacienty, jejich rodinami i spolupracovníky v multidisciplinárním týmu. Posiluje klíčové dovednosti, jako jsou řešení problémů, týmová i samostatná práce, dodržování postupů a odpovědnost při výkonu povolání. Součástí každého modulu je část věnovaná poskytování individuální ošetřovatelské péče a rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností u zahraničních pracovníků.

Dalším nezbytným krokem je efektivní využívání vzdělání a schopností nelékařských zdravotnických pracovníků a posílení týmové spolupráce. Nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou dnes významně vzdělanější, než tomu bylo na počátku století. Kvalifikační příprava se posunula ze středních škol na terciální tříletou či pětiletou odborně zaměřenou kvalifikační přípravu, která následně pokračuje profesním vzděláváním v certifikovaných kurzech, ve specializačním vzděláváním nebo dalšími navazujícími magisterskými či doktorskými studii na vysokých školách. Avšak oficiálně se míra působnosti těchto profesí vymezená legislativou v ČR nikterak nemění. V posledním období je odbornou veřejností diskutováno, jak je tento proces efektivní, resp. do jaké míry a jak efektivně využíváme vzdělávání a schopnosti jednotlivých členů zdravotnického týmu.

Zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, se nově ukotvila pravomoc nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí předepisovat vybrané zdravotnické prostředky. Současně novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 371/2021 Sb., se upravily okolnosti a podmínky, při jejichž splnění je umožněna úhrada ze zdravotního pojištění vybraných zdravotnických prostředků poskytovaných v rámci ošetřovatelské péče, pokud byly předepsány všeobecnou sestrou nebo dětskou sestrou.

Další posílení postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče se podařilo vyhláškou č. 158/2022 Sb., která upravila vyhlášku č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků provázáním činností některých zdravotnických pracovníků tak, aby bylo dosaženo co do rozsahu širší možné, a přitom kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Rozšířil se např. rozsah činností dětských sester, všeobecných sester, sester specialistek, zdravotnických záchranářů specialistů, zdravotnických pracovníků vykonávajících své povolání na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví.

Kompetence, konkrétně:

Všeobecná sestra

- výměna močového katetru u žen a dívek starších tří let, výměna periferního žilního katetru pacientům starším 3 let věku a odstranění periferního žilního katetru bez věkového omezení (samostatně bez indikace lékaře)
- podávání léčiv do epidurálního katetru pacientům starším 3 let věku (na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí)
- výchova a poradenství v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života, včetně prevence vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění, příprava programů ochrany a podpory zdraví a účastnit se v rozsahu své odborné způsobilosti jejich realizace (samostatně bez indikace lékaře)
- zpřesnění některých činností, aby je sestra mohla provádět samostatně bez spolupráce některých dalších osob, např. rehabilitační ošetřování může sestra provádět bez spolupráce s fyzioterapeutem

Dětská sestra

- zavádění periferního žilního katetru a odběr žilní krve se rozšiřuje i nedonošené novorozence (samostatně, na základě indikace lékaře)
- podávání léčiv do epidurálního katetru (na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí)
- výchova a poradenství v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života, včetně prevence vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění, příprava programů ochrany a podpory zdraví a účastnit se v rozsahu své odborné způsobilosti jejich realizace (samostatně bez indikace lékaře)

Zdravotnický záchranář

- vyhodnocování projevů onemocnění a rizikových faktorů a na základě diferenciální diagnostiky stanovení předběžné diagnózy
- provádění katetrizace močového měchýře žen a dívek starších 3 let (dříve až od 10 let)
- doplněny činnosti na akutní lůžkové péči intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu
- Dentální hygienistka
- provádění zubního rentgenu (na základě indikace zubního lékaře, který je aplikujícím odborníkem)

Psycholog ve zdravotnictví

- provádění systematické individuální, skupinové, emergentní a rodinné psychoterapii (pod odborným dohledem psychoterapeuta).

Dále došlo u dalších povolání k zpřesnění a doplnění činností na základě potřeb pracoviště, kde tito zdravotníci působí. Např. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pracující na úseku klinické hematologie a transfuzní služby může vykonávat činnosti spojené s výrobou transfuzních přípravků (pod odborným dohledem). Praktická sestra může i při poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů; poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem

zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta (pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením).

Sestra pro intenzivní péči

- péče o pacienta na domácí plicní ventilaci, včetně obsluhy zdravotnických prostředků, vyhodnocení ventilačních parametrů, výměny tracheostomické kanyly při komplikacích, poučení pacienta a jím určených osob o používání pomůcek a obsluze zdravotnických prostředků
- katetrizace močového měchýře mužů a nově chlapců starších 15 let věku
- zavádění Huberovy jehly do implantovaného portového katetru a provádět její odstranění
- zavedení a odstranění intraoseálního vstupu
- zahájení a vedení léčebné hypotermie a další.

Činnosti byly obdobně rozšířeny i pro další specialisty.

- Sestra pro péči v interních oborech § 60
- Sestra pro péči v chirurgických oborech 61 §
- Sestra pro péči v psychiatrii § 64
- Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu § 109
- Klinický psycholog § 122
- Dětský klinický psycholog § 123
- Klinický adiktolog § 163a

Byly stanoveny činnosti pro nové obory specialistů

- Perfuziolog a Sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii
- Perfuziolog (porodní asistentka)
- Perfuziolog (zdravotnický záchranář)
- Psychoterapeut
- Dětská sestra se specializovanou způsobilostí (např. dětská sestra pro perioperační péči, dětská sestra pro domácí a hospicovou péči).

S účinností vyhlášky č. 324/2024 Sb. se část lékařských kompetencí v léčbě ran přenesla na specializovanou sestru pro hojení ran, která může

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře může

- sledovat a analyzovat údaje o zdravotním stavu pacienta s nehojící se ránou, stomií a invazivním vstupem, včetně stavu hydratace a výživy,
- hodnotit aktuální stav kůže, rizika vzniku poškození a bolesti podle klasifikačních systémů,
- diagnostikovat a klasifikovat rány s využitím standardizovaných klasifikačních systémů,
- hodnotit a ošetřovat nehojící se ránu a její okolí podle zásad fázového hojení ran, včetně přípravy spodiny rány, oplachu a čištění rány neinvazivní technikou,
- doporučovat vhodné postupy ošetřování a metody léčby,

- vést dokumentaci o průběhu a výsledcích péče o nehojící se ránu, okolí stomie a invazivního vstupu a využívat ji k hodnocení efektivity péče a kvality ošetřovatelské péče o nehojící se ránu, okolí stomie a invazivního vstupu,
- provádět rehabilitační ošetřování u pacientů s nehojící se ránou nebo po amputačním výkonu, včetně prevence komplikací v důsledku imobility,
- edukovat pacienty, případně osoby blízké v péči o ránu, okolí stomie nebo invazivního vstupu, v použití zdravotnických prostředků, o rizicích v péči o ránu a významu výživy a hydratace,
- plánovat a koordinovat péči o pacienta s nehojící se ránou a stomií, včetně týmové spolupráce v péči o pacienta s nehojící se ránou a stomií,
- plánovat a koordinovat výzkum v oblasti péče o pacienta s nehojící se ránou a stomií, včetně hodnocení kvality a dopadů výzkumné činnosti;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může

- provádět odběr biologického materiálu z rány invazivní technikou,
- provádět čištění rány invazivní technikou,
- provádět ošetření nehojících se ran, okolí stomie a invazivního vstupu v průběhu léčby radioterapií,
- provádět ošetření nehojících se ran podtlakovou terapií a dalšími doplňkovými a přístrojovými metodami hojení ran,
- navrhovat další konziliární vyšetření a podílet se na nich.

Nově fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí a sestrám se specializovanou způsobilostí v domácí péči bude od 1. 1. 2026 umožněno upravovat či doplňovat indikaci péče vystavené ošetřujícím lékařem, pokud to lékař v rámci indikace umožní.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci Institutu posuzování zdravotního stavu budou nově podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění schváleného sněmovního tisku č. 796, vypracovávat **odborné hodnocení zdravotního stavu (posudky) pro účely příspěvku na péči samostatně,** nikoli pod odborným dohledem lékaře.

V blízké budoucnosti je žádoucí v těchto aktivitách pokračovat, inspirovat se osvědčenými zahraničními modely a rozšířit **kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků** o definice s jakou větší mírou samostatnosti budou moci vykonávat praxi, jak dalece budou moci některá vyšetření či ošetření sami indikovat bez indikací lékařů a jakým způsobem budou tyto kompetence formálně deklarovány ve vyhlášce, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Potenciál posilování kompetencí NLZP vidí ministerstvo v oblasti primární péče, preventivní péče zdravé populace a edukace a vyhodnocování péče pomocí národních standardizovaných protokolů u pacientů s chronickým onemocněním (např. osteoporózou, chronickou a nehojící se ránou, CHOPN, DM II.typu). Mnohé země již úspěšně implementovaly model tzv. Advanced practice nurses – sestru s pokročilou kompetencí, která bez nutnosti lékařské indikace např. samostatně provádí a interpretuje některá diagnostická vyšetření, předepisuje léky v rámci svých kompetencí. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že rozšíření kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků přináší celou řadu pozitiv –

zvyšuje se atraktivita profese, zefektivňuje se péči a zlepšuje se dostupnost služeb. V současné době za podpory odborných společností se kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků posilují především prostřednictvím certifikovaných kurzů.

Příklady certifikovaných kurzů:

- v předoperační, v anesteziologické a postanestetické/pooperační péči, v léčbě bolesti
- zavádění PICC a midline katétrů
- zavádění periferních žilních katétrů u pacientů s obtížným žilním přístupem s využitím ultrazvukové navigace
- péče o pacienty s extrakorporální oxygenací v IP (postupy přípravy na připojení, asistence u napojení, spuštění a příprava odpojení ECMO, včetně adekvátní oš. péče)
- asistence u méně náročných operačních výkonů
- poskytování psychoterapeutické konsultace
- poskytování psychosociální intervence
- zavádění suché jehly (fyzioterapeut)
- ultrazvuková prenatální a gynekologická diagnostika pro porodní asistentky
- multikulturní ošetřovatelství
- age management
- disease management chronických onemocnění

Ministerstvo se intenzivně věnuje též problematice zdravotně-sociálního pomezí, tedy oblasti, kde se prolínají zdravotní a sociální potřeby pacientů – zejména těch chronicky nemocných, seniorů a osob s omezenou soběstačností. V nedávné době resort zdravotnictví vydal např. stanovisko k **uplatnění zdravotnických pracovníků v sociálních službách a prostupnosti těchto profesí**, což je zásadní krok k posílení kapacit a produkce komunitní ošetřovatelské péče a sociálně zdravotní péče.

Konkrétně, odborná způsobilost k výkonu pracovníka v sociálních službách se získává dle ustanovení § 116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních službách, do kterého mohou vstoupit osoby s minimálně základním vzděláním. Nicméně ne všichni zájemci z řad nelékařských zdravotnických povolání musí akreditovaným kvalifikačním kurzem projít, pokud chtějí v sociálních službách pracovat. Povolání pracovníka v sociálních službách může vykonávat rovněž ten, kdo získal dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání:

- sanitáře, který absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář přede dnem 1. ledna 2007 (přechodné ustanovení § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách),
- ošetřovatele (§ 36 zákona č. 96/2004 Sb.),

- praktické sestry, všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, lékaře (tato povolání mají zároveň způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele)

Povolání pracovníka v sociálních službách mohou vykonávat rovněž osoby, které absolvovaly:

- část studia pro přípravu lékařů,
- část studia pro přípravu všeobecných sester, dětských sester či porodních asistentek,
- část studia pro přípravu zdravotnických záchranářů,
- část studia pro přípravu praktických sester (tyto osoby mají zároveň způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele).

Ministerstvo diskutuje se zástupci poskytovatelů domácí péče, zástupci zdravotních pojišťoven o podmínkách zapojení praktických sester do poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí.

Pro **zlepšení dostupnosti psychologických a psychoterapeutických služeb** ministerstvo realizovalo několik systémových změn. Jednak byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., ve kterém se zrušilo omezení realizace akreditovaného kvalifikačního kurzu pro povolání Psycholog ve zdravotnictví pouze vysokým školám. Ve spolupráci s IPVZ, Asociací klinických psychologů ČR a akreditovanými zařízeními (UP v Olomouci, FF UK v Praze, Pražská vysoká škola psychosociálních studií) ministerstvo aktualizovalo a zkrátilo vzorový vzdělávací program Psycholog ve zdravotnictví. Tento kvalifikační kurzy tak nyní nabízejí i jiná akreditovaná zařízení, např. IPVZ. Počet absolventů kvalifikačního kurzu v roce 2024 vzrostl oproti roku 2023 roce téměř čtyřnásobně.

Zároveň výše uvedenou novelou zákona došlo ke **zrušení zákonné podmínky pro délku specializačního vzdělávání u povolání klinický psycholog v délce 5 let**. Nový vzdělávací program zkracuje délku specializační přípravy na 4 roky, přičemž do programu byla nově vložena i odborná praxe o dětské pacienty.

Ministerstvo každoročně podporuje specializační vzdělávání **Psychologů ve zdravotnictví** prostřednictvím tzv. rezidenčních míst. V letošním roce došlo k navýšení celkové částky a zároveň bylo možno žádat o podporu v oborech specializačního vzdělávání Dětská klinická psychologie a Psychoterapie.

V listopadu 2022 došlo k rozšíření kompetencí vybraných nelékařských zdravotnických profesí též zavedením **třístupňového modelu psychoterapeutické péče**. Vedle lékařů s nástavbovou specializací a psychologů ve zdravotnictví s atestací v oboru psychoterapie mohou vybrané psychoterapeutické a psychosociální intervence poskytovat další nelékařské zdravotnické profese (např. sestry, adiktolog, zdravotně-sociální pracovníci) po prohloubení jejich kvalifikace v psychoterapii. V únoru 2023 ministerstvo vydalo minimální požadavky na rozsah a obsah vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Psychosociální intervence“ a minimální požadavky na rozsah a obsah vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Psychoterapeutická konzultace“.

Pro podporu vzdělávání a rozšiřování kompetencí sester **se připravila řada projektů**, například v oblasti poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí Zvyšování kvality

a dostupnosti domácí péče prostřednictvím zavádění nových metod a technologií (zkrácený název Domácí péče) zaměřený na tvorbu a pilotní ověření systémového řešení a koncepčního přístupu ke zvyšování kvality a dostupnosti domácí péče s využitím dostupných technologií 21. století a case managementu. Dalším projektem zaměřeným na podporu domácí péče jako integrované součásti zdravotně sociálních služeb s ohledem na měnící se demografickou strukturu obyvatelstva je projekt s názvem "KOPEC – komplexní domácí péče" financovaný z Programu domácí péče z Programu švýcarsko-české spolupráce. Realizaci programu zahájilo NCO NZO od 1. července 2025.

V návaznosti na posilování kompetencí a rozšiřování uplatnění nelékařských zdravotnických profesí je nutné zlepšovat **finanční ohodnocení nelékařských zdravotnických profesí**. Ve spolupráci s MPSV od 1. 1. 2023 došlo k narovnání odpočtu let praxe při zařazení zaměstnance do 11.–16. platové třídy (odstranění rozdílu mezi vzděláním na VŠ a VOŠ) a upraveny platové třídy nelékařských zdravotnických pracovníků. V souvislosti se snížením administrativní zátěže zdravotnických pracovníků do Katalogu prací s účinností od 1. 7. 2024 upraveno rozpětí platových tříd pro zaměstnance, kteří se zabývají vykazováním zdravotní péče a provádí činnosti Odborného pracovníka správy zdravotnických informací. Nově podle připravované novely Katalogu prací, zaměstnanci, kteří zajišťují a provádí praktického vyučování studentů připravujících se na výkon zdravotnického povolání a zajišťují a vedou adaptační proces nových zaměstnanců, budou zařazováni do 11. platové třídy. Novela umožní též všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře a nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří posuzují zdravotní stav pro účely příspěvku na péči zařazovat do 13. platové třídy.

Ministerstvo za podpory Výboru pro zdravotnictví PSP ČR opakovaně jednalo s MŠMT, aby podle § 122 odst. 1 školského zákona bylo možné za **produktivní činnost** považovat i praxi u zdravotnických oborů. MŠMT v tomto smyslu přislíbilo upravit metodický pokyn „Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, připravujícím se pro potřeby zaměstnavatele". Pokud tedy poskytovatel, u které praktické vyučování probíhá, shledá, že se jedná o produktivní činnost, může osobám, kteří tuto činnost vykonávají, poskytnout **odměnu (za odbornou praxi)** v souladu s definicí produktivní činností podle výše uvedeného zákona. Ministerstvo následně zveřejní aktuální informace na webu MZD, jakmile MŠMT učiní úpravy ve znění textu tak, aby bylo možné za produktivní činnost považovat i praxi u zdravotnických oborů.

Je nutné zaměřit pozornost i na **zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže zdravotnických pracovníků.** Pozornost je naplňována zaváděním systému psychosociální intervenční služby (dále jen „SPIS") nejenom u zdravotnických záchranných služeb, ale i poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují lůžkovou nebo ambulantní péči. SPIS je zajištěn prostřednictvím příspěvkové organizace v přímé řídící působnosti ministerstva NCO NZO v oblasti koordinační, organizační a vzdělávací. V roce 2022 byla NCO NZO poskytnuta částka 3 389 000 Kč jako účelová provozní dotace na pokrytí nákladů SPIS a pokrytí nákladů na provoz krizové linky, která byla zřízena v souvislosti s epidemickou situací na základě pověření ministerstva. Zároveň je připravována Koncepce vzdělávání SPIS.

Též je žádoucí řešit **nadlimitní a dlouhodobou zátěž pracovníků ve zdravotnictví** v souvislosti s pracovními podmínkami a soustavně vzdělávat zdravotnické pracovníky v prevenci vzniku muskuloskeletálních poruch (MSD) souvisejících s prací, zavádět podporu osvojením vhodných zvládacích technik s důrazem na souvislosti mezi MSD a psychosociálními rizikovými faktory.

Aktuálně NCO NZO s podporou ministerstva realizuje projekt s názvem Koncepce zavádění inovativních strategií ke zvýšení psychické a fyzické odolnosti zdravotníků vedoucí k posílení odolnosti zdravotního systému, kterým se rozšíří portfolio péče o zaměstnance prostřednictvím budování dalších týmů psychosociální podpory a vzdělávacích aktivit zdravotnických pracovníků např. v prevenci vzniku MSD.

Dalším projektem NCO NZO s podporovaným ministerstvem je projekt Supervize a kompetence všeobecných sester, dětských sester a porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, jehož cílem je vyškolení intervizorů a zavedení supervizních metod jako nástroje profesního růstu, podpory měkkých dovedností a programů snižující zátěž.

V neposlední řadě je na místě komplexně přehodnotit i **počet a složení ošetřovatelských týmů ve směnách.** Ministerstvo se zabývá složením ošetřovatelských týmů, a to nejenom v návaznosti na personální vyhlášku a minimální požadavky, ale i v rámci zlepšení pracovních podmínek nelékařských zdravotnických pracovníků. Od 1. 5. 2024 je připraveno spuštění pilotního měření náročnosti a nákladů ošetřovatelské zátěže, a to v úzké spolupráci s ÚZIS ČR a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb. Předmětem projektu je zmapování činností sester, resp. zhodnocení měření ošetřovatelské zátěže na jednotlivých pracovištích. Vedle oborů (pracovišť) se bude sledovat:

- časová náročnost poskytované péče dle vykázaných individuálních výkonů
- denní obrátka pacientů
- průměrná délka hospitalizace propuštěných pacientů daného pracoviště
- podíl standardních ošetřovacích dnů u pacientů sledovaných pracovišť
- důvod přijetí pacienta na sledované pracoviště
- vykázané kategorie pacienta
- počet vykázaných ošetřovacích dnů dle kalendářních dnů
- počet zemřelých pacientů na pracovišti

V závislosti na exaktně podchycenou náročnost péče je záměrem **upravit pracovní podmínky** nastavením optimálního profilu personálního zabezpečení ze stran ošetřovatelského personálu úpravou personální vyhlášky.

V rámci ošetřovatelských týmů je třeba věnovat zvýšenou pozornost absolventům, i těm zaměstnancům, kteří se vrací po přerušení výkonu povolání nebo mění typ pracoviště. Za tímto účelem vydalo ministerstvo v roce 2024 **Metodické doporučení postupu realizace a ukončení adaptačního procesu a doškolení**, které poskytuje zaměstnavatelům základní oporu v péči o nové zaměstnance.

Atraktivitu zdravotnických povolání podporujeme i prostřednictvím médií, podařilo se nám realizovat spolupráci s Českým rozhlasem a ve spolupráci s NCO NZO v Brně vznikly podcasty s názvem Studuj zdrávku.

Ministerstvo, jako uznání za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství, a v souladu s Nařízením vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví udělovaných Ministerstvem zdravotnictví, od roku 2022 každoročně uděluje **ocenění PhDr. Alice Garrigue Masarykové**. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 100 000 Kč. Od roku 2025 je ocenění rozšířeno na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a je možno udělit 3 ceny.

Pro zabezpečení kvality se připravují se **Národní standardizované operativní protokoly** (NSOP) v ošetřovatelství. Jde o klíčový krok k sjednocení a zlepšení kvality ošetřovatelské péče v České republice a v prevenci možných pochybení v klinické praxi. NSOP nahradí již vydané Národní ošetřovatelské postupy (NOP), které budou, dle nových procesních kroků průběžně aktualizovány a transformovány na NSOP. Národní standardizované operativní protokoly pro NLZP mají široké využití a přínosy.

Podařilo se vybudovat řadu funkčních týmů, poradních a pracovních skupin a korektní komunikační platformu složenou se zástupců stakeholderů, a to napříč zdravotnickými obory. Konkrétní poděkování náleží zejména poslankyním a členkám Výboru pro zdravotnictví PS PČR, paní prof. MUDr. Adámkové a PhDr. I. Mádlové, České asociaci sester zastoupenou paní prezidentkou PhDr. M. Šochmanovou, a Mgr. Danou Vaňkovou, zástupcům členů dalších odborných a profesních organizací, odborových organizací – p. Bc. D. Žitníkové, vzdělavatelům – prof. PhDr. A. Pokorné, PhDr. K. Štixovi, plátcům a příjemcům péče, kteří se v aktivní spolupráci s Ministerstvem podíleli a nadále podílí na identifikaci a řešení problémů. Nově budou do rozhodových procesů zapojení i mladí lidé, studenti připravující se na výkon zdravotnických povolání – iniciovali jsme vznik tzv. **Panelu mládeže** při Odborné radě pro ošetřovatelství.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Obsah nové strategie resortu v oblasti zajištění a stabilizace personálních kapacit nelékařských zdravotnických profesí zahrnuje zejména následující opatření a novely legislativních norem:

- Posílení personálních kapacit nelékařských oborů (vládní program)
- Kompetence NLZP
- Posílení postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče
- Uplatnění zdravotnických pracovníků v sociálních službách a prostupnosti těchto profesí
- Řešení nadlimitní a dlouhodobé zátěže pracovníků ve zdravotnictví
- Zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže zdravotnických pracovníků
- Vybudování funkční datové základny sledující a predikující potřebné kapacity nelékařských zdravotnických profesí v regionálně specifických modelech
- Modernizace vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů a zajištění vyšší prostupnosti na sebe navazujících úrovní vzdělávání, rychlejší uplatnění studentů v praxi

- Posílení spolupráce se vzdělavateli a revize tzv. kvalifikačních standardů, podmět Evropské komisi na úpravu Směrnice
- Zákon o valorizaci úhrad za státní pojištěnce
- Novela zákoníku práce
- Novela personální vyhlášky
- Novela katalogu prací
- Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických pracovnících
- Novela vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
- Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
- Novela vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Další cíle strategie do roku 2025

- Zvýšení prostupnosti a provázanosti vzdělávacích a studijních programů a vybraných oborů.
- Snazší uplatnění odborníků z jiných oborů ve zdravotnictví.
- Zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými obory/profesemi.
- Odborné diskuze o racionalizaci zdravotnických povolání ukotvených zákonem č. 96/2004 Sb.,
- Příprava na legislativní ukotvení nových oborů a povolání, zavedení povolání koordinátor zdravotní péče
- Realizace odborných platforem nad podmínkami a možnostmi implementace modelu tzv. Advanced practice nurses
- Odborné diskuze nad obsahem, možnou regulací a kontrolou celoživotního vzdělávání NLZP
- Plná elektronizace administrativy spojené se vzděláváním NLZP (program Administrátor implementovaný v specializačním i nadstavbovém vzdělávání)
- Zjednodušení a modernizace vzdělávacích programů a procesu akreditací, posílení prostupnosti na sebe navazujících úrovní vzdělávání
- Optimalizace specializačního vzdělávání
- Posílení samostatnosti, odpovědnosti a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků, příprava NLZP (jednodenní chirurgie, age management, disease management chronických onemocnění apod.)
- Připravená koncepce vzdělávání zavádění inovativních strategií ke zvýšení psychické a fyzické odolnosti zdravotníků
- Zapojení Panelu mládeže do rozhodovacích procesů
- Realizace programu na posílení personálních kapacit prostřednictvím navýšení počtu studentů v kapacitně ohrožených oborech na lékařských fakultách a dalších vysokých školách a pokračování v nastavených doprovodných opatřeních.
- Zavedený systém publikace a aktualizace Národních Standardizovaných Operativních protokolů (NSOP) v ošetřovatelství.

Kapitola IX. Elektronizace zdravotnictví

Vybrané aspekty budování systému eHealth

https://nzip.cz/koncepce2025#elektronizace

Aktualizovaná kapitola reflektuje vývoj, který v oblasti budování systému eHealth probíhá v mnoha dimenzích, a shrnuje hlavní dosažené výsledky. Jednotlivé kroky a rozvojové projekty aktuálně vycházejí zejména z přijetí zákona č. 236/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví („Novela zákona o elektronizaci“) s účinnosti od 1. ledna 2026. Kapitola dále popisuje opatření, která nutně vyplývají z aktualizace Národní strategie elektronického zdravotnictví pro období 2025-2035. Mezi již úspěšně realizovanými projekty zaměřenými na služby občanům dominuje zejména aplikace EZKarta, která zpřístupňuje na individuální bázi data o očkování a nově též záznamy o absolvovaných preventivních prohlídkách a vyšetřeních v programech screeningu.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Resortní strategie elektronizace českého zdravotnictví do roku 2025 navazuje na vybrané cíle Národní strategie elektronického zdravotnictví 2016–2026 a je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 („Zdraví 2030“), zejména s jeho Implementačním plánem 2.3 zaměřeným na digitalizaci zdravotnictví.

Stávající Národní strategie elektronického zdravotnictví, která byla vytvořena s cílem pokrýt období do roku 2026, představuje zásadní krok směrem k digitální transformaci českého zdravotnictví. Nicméně vzhledem k blížícímu se konci její platnosti právě probíhá její aktualizace do roku 2035. **Aktualizace Národní strategie EZ** bude reflektovat nejen dosavadní pokroky, ale především nové výzvy a technologické požadavky, jež se v oblasti zdravotních služeb a digitalizace objevily. Cílem tvorby aktualizované strategie elektronického zdravotnictví je vytvořit **ucelený a dlouhodobě udržitelný rámec, který umožní efektivní, bezpečnou a inovativní digitalizaci zdravotnického systému v České republice.**

Současně dochází také k prolongaci „Zdraví 2030“ do roku 2035[7]. Tato prolongace **určí směr rozvoje elektronizace zdravotnictví České republiky v nadcházejícím desetiletí**. Resortní strategie rovněž respektuje Informační koncepci ČR a Informační koncepci MZ ČR.

Dalším klíčovým řídicím dokumentem v oblasti elektronizace zdravotnictví, který zásadně ovlivňuje veškeré související procesy a strategické cíle Ministerstva zdravotnictví ČR, je **zákon č. 236/2025 Sb.**, kterým se mění **zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci** zdravotnictví („Novela zákona o elektronizaci“) s účinnosti od **1. ledna 2026**. Novela zákona o elektronizaci zdravotnictví přináší tři zásadní oblasti změn. První z nich představuje legislativní ukotvení komponent, které byly dosud uvedeny pouze v důvodové zprávě k původnímu zákonu, a nyní se stávají součástí závazného právního rámce. Druhou oblastí je doplnění stávajících ustanovení zákona, a to na základě praktických zkušeností z jeho dosavadní aplikace a vývoje v oblasti digitalizace. Třetí oblastí je zavedení zcela nových komponent, které reflektují aktuální technologický pokrok a nové požadavky na elektronizaci zdravotnictví.

V následujících letech bude oblast elektronizace zdravotnictví zásadně ovlivněna Nařízením o Evropském prostoru pro zdravotní údaje („EHDS“), které vstoupilo v platnost 26. března 2025 a odstartovalo přechodnou implementační fázi. Požadavky vyplývající z EHDS jsou promítnuty jak do resortní strategie, tak i do dalších řídicích dokumentů, včetně aktualizace Národní strategie elektronického zdravotnictví. Nařízení EHDS občanům umožní snadný a bezplatný přístup k jejich zdravotním údajům a zároveň podpoří sekundární využití těchto dat. Stanovuje rovněž jednotný právní a technický rámec pro elektronické zdravotní systémy napříč členskými státy EU. S ohledem na plnou účinnost části nařízení od března 2029 je nutné reflektovat legislativní požadavky EHDS již v současných plánech resortu zdravotnictví.

V rámci této kapitoly budou tak představeny klíčové komponenty elektronizace zdravotnictví, které mimo jiné vycházejí právě z aktualizované Národní strategie elektronického zdravotnictví, připravované prolongace Zdraví 2030, EHDS a novely zákona o elektronizaci zdravotnictví.

V současnosti lze vývoj v oblasti elektronizace zdravotnictví charakterizovat spíše jako postupný, s řadou dílčích pokroků. Ve zjednodušené formě lze informační systémy v českém zdravotnictví rozdělit na systémy centrální a systémy, které provozují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Mezi příklady plně funkčních centrálních systémů v českém zdravotnictví patří například eRecept a Národní zdravotnický informační systém. Oba tyto systémy ale plní pouze svoji vymezenou, byť podstatnou, centrální agendu a neposkytují širší podporu další digitalizaci v českém zdravotnictví, což odpovídá jejich původnímu zaměření.

Zásadní centrální systémy a na ně navázané služby dle definice zákona o elektronizaci zdravotnictví jsou teprve ve fázi zpracování. Tato skutečnost má přímý dopad na rozvoj digitalizace informačních systémů využívaných poskytovateli zdravotních služeb. I když zde digitalizace postupně nabývá na významu, často probíhá bez návaznosti na centrální řídicí a standardizační komponenty. I tuto problematiku zásadně řeší aktualizace Národní strategie EZ, jejímž cílem je právě vybudovat **moderní, propojený a důvěryhodný národní eHealth**

[7] Revokace usnesení 743/2020 ke Strategickému rámci rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 v souvislosti s aktualizací a prolongací dokumentu do roku 2035

systém, který propojí všechny poskytovatele zdravotních služeb, pacienty, zdravotnické pracovníky, zdravotní pojišťovny, státní instituce i technologické partnery, umožní přeshraniční sdílení zdravotních údajů jak v ČR, tak i v EU a vytvoří prostředí pro **bezpečné, efektivní a uživatelsky přívětivé poskytování zdravotních služeb**.

Další limitací elektronizace jsou v současnosti nejednoznačná pravidla pro vedení čistě elektronické zdravotnické dokumentace a pro poskytovatele zdravotních služeb obtížně aplikovatelná. Přitom právě tato dokumentace je klíčovým předpokladem pro další rozvoj elektronizace, efektivní sdílení informací a rozšiřování digitálních služeb ve zdravotnictví. Proto **zavedení jednotného, strukturovaného a standardizovaného formátu elektronické zdravotnické dokumentace představuje jeden z klíčových cílů elektronizace zdravotnictví.** Takový formát umožní efektivní sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, přispěje ke zvýšení kvality a bezpečnosti péče a zároveň podpoří využití zdravotnických dat pro řízení, výzkum i strategické plánování.

Jedním z hlavních omezení elektronizace zdravotnictví je dosud nedokončená standardizace základních typů zdravotnické dokumentace – jak z hlediska obsahu, tak komunikačních rozhraní. Přestože jsou informační systémy běžně využívány ve všech nemocnicích i většině ambulancí (včetně PACS), chybí jednotný datový formát a možnost efektivního přenosu informací mezi poskytovateli či směrem k pacientovi.

Informační systémy byly historicky vyvíjeny bez povinnosti používat jednotné standardy, což vedlo k jejich vzájemné nekompatibilitě. V důsledku toho není možné efektivně sdílet zdravotnickou dokumentaci ani při využití moderních integračních platforem. Absence legislativně ukotvených datových standardů po dlouhou dobu umožňovala různorodé přístupy výrobců systémů, což dále prohloubilo roztříštěnost celého prostředí.

Nicméně v rámci zákona o elektronizaci došlo k pozitivní změně, datové standardy byly legislativně ukotveny a nyní se postupně zavádějí[8], což do budoucna významně napomůže k efektivnímu sdílení zdravotní dokumentace.

Před řadou let se podařilo propojit poskytovatele, především lůžkového segmentu, pomocí dvou sítí tak, že dnes lze běžně v rámci České republiky i Slovenska zasílat obrazovou dokumentaci ve formátu DICOM mezi zdravotnickými zařízeními. Současný systém ovšem neumožňuje elektronické zasílání žádanek na vyšetření ani standardizovanou výměnu popisů a propouštěcích zpráv mezi zdravotnickými zařízeními. Standardy těchto dokumentů jsou však již připraveny a jejich implementace se očekává začátkem roku 2026.

Během epidemie COVID-19 vznikla a byla úspěšně nasazena mobilní aplikace **Tečka**, která občanům umožnila snadný přístup k informacím o očkování. Na tento úspěšný základ navázalo Ministerstvo zdravotnictví vývojem aplikace **EZKarta**, která dnes slouží jako digitální očkovací

[8] Elektronická dokumentace – typy určené k digitalizaci: propouštějící zpráva z nemocnice, žádanka obrazového vyšetření, laboratorní žádanka, ambulantní zpráva, zpráva z laboratorního vyšetření, zpráva ze zobrazovacího vyšetření, zpráva o výjezdu RZS, a pacientský souhrn.

průkaz a postupně se rozšiřuje o další elektronické zdravotnické služby. Patří mezi ně například přístup ke zdravotnické dokumentaci, elektronické žádanky či možnost komunikace s poskytovateli zdravotní péče.

Zdravotničtí pracovníci i pacienti jsou v současnosti často zatěžováni opakovaným vyplňováním a přepisováním stejných údajů, což zpomaluje procesy a snižuje komfort při poskytování i využívání zdravotní péče. Tato situace mimo jiné brzdí rozvoj elektronického objednávání na vyšetření, které by mohlo výrazně zjednodušit přístup ke zdravotním službám. Absence centrální platformy pro správu objednacích a čekacích lhůt na diagnostická, screeningová či plánovaná vyšetření a zákroky komplikuje koordinaci péče. Vytvoření takového systému významně přispěje k zvýšení dostupnosti zdravotních služeb, zlepšení organizace péče a snížení administrativní zátěže pro všechny zúčastněné.

Níže popsaná strategie popisuje základní kroky, které mohou tento stav v horizontu do konce roku 2025 zlepšit realizací konkrétních opatření.

Dobudování infrastruktury eHealth a centrálních služeb

Zásadním východiskem pro řízený a jednoznačný rozvoj elektronizace je reálná implementace informačních systémů a centrálních služeb, jak jsou definovány v zákoně o elektronizaci zdravotnictví. Vybudování této centrální infrastruktury nabídne infrastrukturní služby zejména poskytovatelům zdravotních služeb, na jejichž základě budou moci dále rozvíjet své informační služby a postupně začít nabízet digitální služby i občanům. Současně bude podpořena interoperabilita systémů jednotlivých poskytovatelů, což usnadní výměnu elektronické zdravotnické dokumentace.

Financování vybudování níže uvedených komponent je zajištěno prostřednictvím projektů Národního plánu obnovy (NPO). Tyto projekty již probíhají pod vedením Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem uvést zákonem definované komponenty do provozu do 1. 1. 2026.

Aktuálně probíhá na centrální úrovni vývoj a implementace klíčových informačních systémů zejména v oblastech: primární péče, surveillance infekčních nemocí, komunitní paliativní péče, preventivní programy a screeningy. Rovněž jsou dále udržovány a rozvíjeny IS, které byly vybudovány při zvládání epidemie COVID-19.

Kmenové zdravotnické registry

Mezi klíčové komponenty definované zákonem o elektronizaci zdravotnictví patří tzv. kmenové zdravotnické registry, které v České republice dosud chyběly. Jedná se o **Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb**, **Kmenový registr zdravotnických pracovníků** a **Kmenový registr pacientů**. Jejich hlavním cílem je zajistit správnost, aktuálnost a interoperabilitu dat, návaznost na základní národní registry a kompatibilitu s Evropským prostorem pro zdravotní data. Za naplnění těchto registrů budou odpovědné subjekty stanovené zákonem.

Všechny tři registry představují základní stavební kameny elektronizace zdravotnictví, protože umožní vytvoření jednotného identitního prostoru. Ten zajistí spolehlivou identifikaci subjektů a efektivní přidělování oprávnění v rámci elektronických služeb.

Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb obsahuje referenční údaje a identifikátory poskytovatelů, sdílené mezi klíčovými aktéry systému. Dále zahrnuje specifické informace, jako jsou ordinační doby, počty lůžek či přístrojové vybavení. Poskytovatelé budou mít povinnost do registru hlásit definované údaje, včetně ordinační doby a počtu lůžek u lůžkových zařízení.

Kmenový registr zdravotnických pracovníků slouží jako identitní základna pracovníků ve zdravotnictví. Obsahuje referenční údaje, informace pro autorizaci v rámci elektronických služeb a ověřené údaje o vzdělání a odbornosti, čímž nahradí potřebu fyzického dokládání diplomů či certifikátů. Zároveň bude sloužit jako nástroj pro předávání dat mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.

Kmenový registr pacientů bude shromažďovat základní údaje o všech pacientech a každému z nich přidělí jednoznačný, bezvýznamový identifikátor (RID). Primárně budou údaje do registru zapisovat zdravotní pojišťovny, sekundárně poskytovatelé zdravotních služeb. U občanů ČR bude registr propojen s Registrem obyvatel. Novela zákona zároveň ukládá porodnicím povinnost zapisovat novorozence do registru a tím jim přidělit centrální identifikátor.

Služba výměnných sítí

Další zásadní komponentou je **služba výměnných sítí**. Pod tímto pojmem se skrývá v zásadě platforma vzájemně propojených afinitních domén, která umožní propojení poskytovatelů zdravotních služeb a výměnu elektronické zdravotnické dokumentace. V novele zákona je tato služba rozšířena také o pacienta, poskytovatele sociálních služeb a zdravotní pojišťovny. Tato síť bude zajišťovat elektronickou komunikaci a výměnu dokumentů i napříč mezi jmenovanými subjekty. Prvek dočasného úložiště je klíčovou komponentou nezbytnou pro funkčnost sítě a zajistí dostupnost služby i pro poskytovatele a pacienty, kteří nejsou připojeni k internetu nepřetržitě. Rovněž tak je komponenta výměnných sítí součástí řešení eŽádanky a EZKarty, které mají v budoucnu poskytovat centrální služby.

Služby vytvářející důvěru – EZCA

Klíčovou roli v oblasti důvěryhodnosti sehrává **EZCA** – resortní certifikační autorita poskytující služby vytvářející důvěru ve zdravotnickém sektoru. Nabízí služby na úrovni zaručené a zprostředkovává služby na úrovni kvalifikované pro elektronické pečetě, časová razítka a elektronické podpisy.

Pro ověřování identity systém využívá autentizaci pomocí NIA (Národní identitní autorita) a ověření v Kmenovém registru zdravotnických pracovníků, čímž zajišťuje bezpečné a důvěryhodné elektronické operace v rámci zdravotnictví. Řešení EZCA je plně v souladu s požadavky evropského nařízení **eIDAS** a směrnice **NIS2**, což garantuje jeho kompatibilitu se současnými i budoucími standardy kybernetické bezpečnosti a digitální důvěry v EU.

Další komponenty

Mezi další komponenty centrální infrastruktury digitálního zdravotnictví patří Registr práv a mandátů a Katalog služeb elektronického zdravotnictví. Tyto prvky tvoří základní infrastrukturu pro bezpečné a efektivní fungování digitálního zdravotnictví.

Registr práv a mandátů je technickou komponentu integrovaného datového rozhraní resortu zdravotnictví a slouží k evidenci elektronických služeb ve zdravotnictví včetně jejich vazby na poskytovatele. Zároveň udržuje technické atributy nezbytné pro jejích bezpečné využívání.

Katalog služeb elektronického zdravotnictví je evidenční nástroj, který umožňuje správu registrovaných služeb elektronického zdravotnictví a řízení přístupu k nim prostřednictvím Registru práv a mandátů. Například umožňuje jedné osobě udělit jiné osobě mandát k přístupu ke konkrétní službě, jako je například „nahlížení do očkovací průkazky“.

Poskytování dat a digitálních služeb občanům

Na vybudování centrálních infrastrukturních služeb musí navazovat realizace konkrétních digitálních služeb pro občany. S ohledem na jejich význam a potřebnost bylo nezbytné zahájit jejich implementaci již nyní, aby služby občanům mohly být postupně na pozadí přepojovány na nově vznikající centrální komponenty.

Zároveň digitální služby zdravotnictví určené pro občany jsou klíčovou součástí jak novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, tak Národní strategie elektronického zdravotnictví 2025 až 2035. Jejich cílem je vytvořit digitální prostředí, které aktivně zapojuje občana do péče o vlastní zdraví prostřednictvím intuitivních nástrojů, jako je například Národní portál EZ.

Mezi konkrétní služby zaměřené na občany, které novela zákona přináší, patří zejména **Elektronická zdravotní karta (EZKarta)** a systém **elektronických žádanek (eŽádanka)**. Tyto nástroje mají za cíl zjednodušit přístup ke zdravotním informacím, zvýšit transparentnost a zefektivnit procesy ve zdravotní péči.

V první fázi jsou služby občanům postaveny na centrálně evidovaných datech, jako jsou Národní zdravotnický informační systém a registry orgánů ochrany veřejného zdraví. Tyto služby a nástroje, včetně aplikací, jsou však navrhovány s důrazem na potřebu reagovat na nové potřeby a úlohy v oblasti elektronického zdravotnictví.

Hlavními prostředky pro zpřístupnění těchto služeb občanům budou Národní portál elektronického zdravotnictví a mobilní aplikace EZ aplikace EZKarta, která bude zpřístupňovat vybrané služby.

Následující část kapitoly stručně představuje komponenty a služby pro občany financované z Národního plánu obnovy, které jsou zároveň zařazeny do prioritní fáze realizace aktualizované Národní strategie elektronického zdravotnictví 2025-2035, případně se musí zřídit na základě Novely zákona.

Zpřístupnění otevřených datových sad

Objem evidovaných zdravotních dat i s ohledem na úspěšnou digitalizaci centrálních sběrů, zejména do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) roste. Vzhledem k této dynamice je nezbytné zavádět nové metody, které umožní zpřístupnění těchto cenných data nejen státní správě, ale také občanům, případně široké veřejnosti. To umožní provádění nezávislých analýz nad zveřejňovanými daty i v nových oblastech. Od poloviny roku 2023 je

k dispozici nový modul pro prezentaci zdravotnických dat, který zahrnuje katalog výstupů, datové souhrny a datové zpravodajství. Tento nástroj významně přispívá k transparentnosti a informovanosti veřejnosti.

Příkladem pokročilé práce s daty je propojování a budování datového mostu a analytického zázemí mezi resorty Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato data, která se principiálně týkají každého občana nebyla dosud společně analyzována jako jeden celek.

Dalším klíčovým aspektem v oblasti sdílení a využívání zdravotních dat je EHDS. Toto nařízení má zásadní dopad na zveřejňování, sdílení a sekundární využití zdravotních údajů, a to nejen z NZISu, ale i obecně z celého resortu zdravotnictví. ÚZIS ČR, konkrétně NZIS, byl vybrán jako hlavní uzel pro komunikaci a sdílení těchto údajů do společného evropského prostoru. V rámci zpřístupňování dat občanům budou tedy v horizontu konce roku 2025 publikovány nové datové sady.

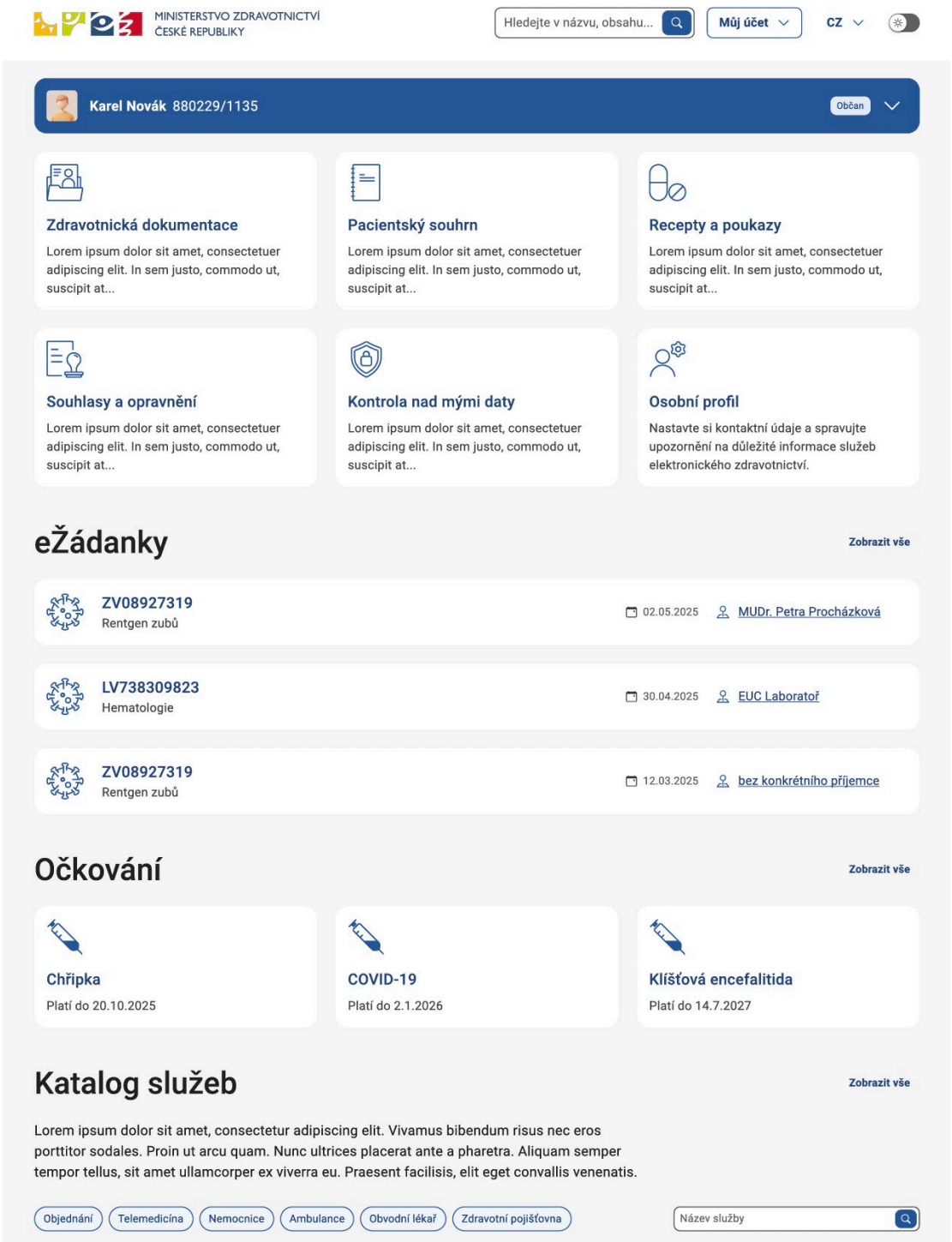
Klíčovou roli bude v této aktivitě hrát Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS ČR“), který zveřejnil ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy svoji koncepci zveřejňování dat, která je předmětem samostatného dokumentu „Koncepce sdílení a sekundárního vytěžování dat Národního zdravotnického informačního systému“. Tato koncepce nastavuje udržitelný a bezpečný systém využívání zdravotnických dat nejen pro zajištění péče, ale i pro výzkumné, analytické, plánovací a strategické účely. Cílem je efektivní využití dat NZIS pro výzkum, veřejné řízení a inovace při zachování vysokého standardu ochrany osobních údajů.

Národní portál elektronického zdravotnictví

Národní portál elektronického zdravotnictví (NPEZ) je centrální službou dle zákona 325/2021Sb sloužící jako hlavní přístupový bod k elektronickému zdravotnictví. NPEZ bude zajišťovat zabezpečený přístup k digitálním službám podle typu uživatele – je určen jak pro občany, tak pro zdravotnické pracovníky. Služby dostupné prostřednictvím portálu budou buď přímo integrovány, nebo zpřístupněny prostřednictvím ověřených externích odkazů. Občanům nabídne NPEZ přístup k ověřeným službám, oficiálním informacím o zdraví a možnost nahlížet do vlastních zdravotních záznamů po přihlášení. Zdravotnickým pracovníkům umožní práci s elektronickou zdravotní dokumentací, pacientskými souhrny a elektronickými žádankami.

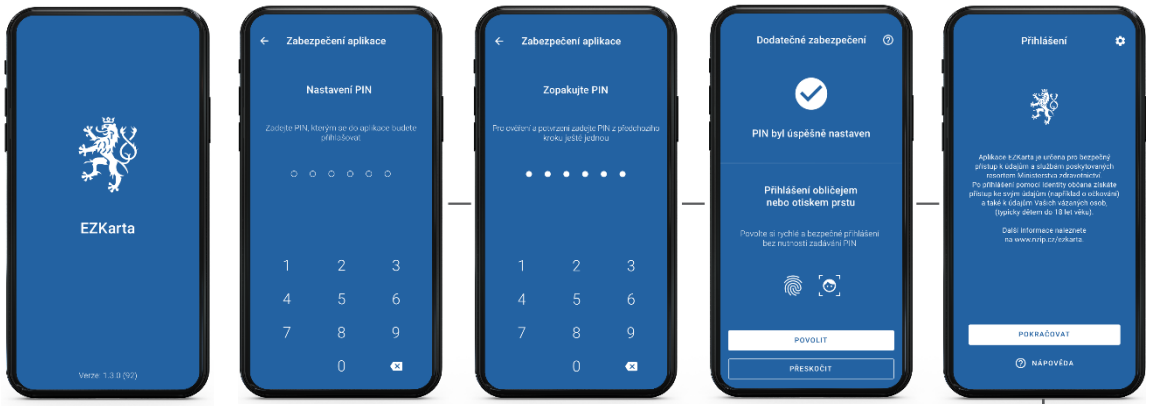
Portál bude rovněž poskytovat externí služby, včetně možnosti publikace služeb třetích stran – například i ze strany vaší organizace. Umožní zobrazení vlastních dat a služeb přímo v prostředí portálu, které budou dostupné všem pacientům v České republice.

V dalších fázích vývoje se nabídka služeb Národního portálu elektronického zdravotnictví (NPEZ) bude postupně rozšiřovat v souladu s potřebami uživatelů, a to jak občanů, tak zdravotnických pracovníků.



Elektronická zdravotní karta (EZKarta)

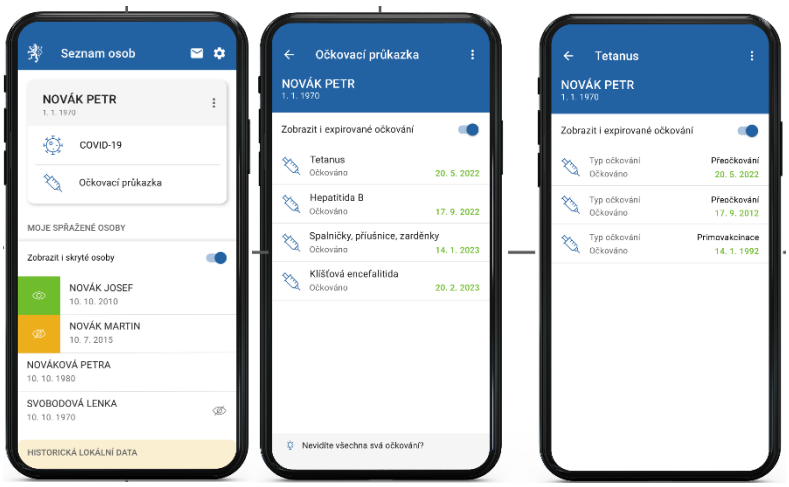
EZKarta vznikla transformací původní aplikace Tečka sloužící pro ověření bezinfekčnosti obyvatel a přináší rozšířené funkce i vyšší úroveň zabezpečení. Na rozdíl od původního jednoúčelové aplikace EZKarta poskytuje vysokou úroveň zabezpečení pro přístup k datům. Přihlášení je možné výhradně prostřednictvím Národní identitní autority, čímž je zajištěna ochrana osobních údajů. EZKarta je tak jednoznačně svázána s konkrétní osobou, která se bezpečně identifikuje a získává přístup ke službám a údajům, na něž má oprávnění.



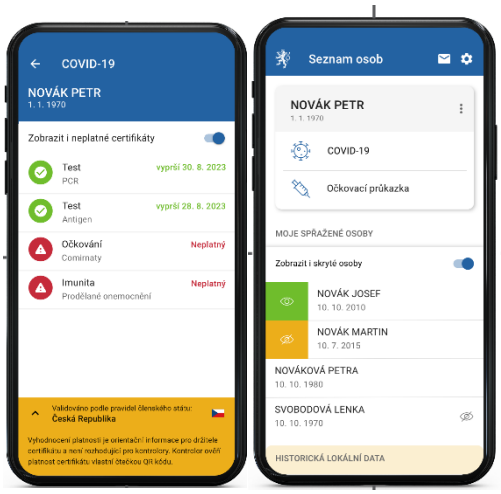
EZKarta je **mobilní aplikací**, která má za cíl přiblížit digitální služby resortu občanům. První službou, kterou nabízí, je **očkovací průkazka**. Cílem je postupně nabízet občanům další služby které se týkají péče o zdraví každého občana.

Základní novou funkcí EZKarty je zaznamenání provedených očkování u praktického lékaře, které může být zobecněno na jakéhokoli poskytovatele zdravotních služeb. Každý občan vidí v aplikaci veškerá svá očkování, která mu byla aplikována od 1. 1. 2023 a to včetně očkování proti onemocnění COVID-19. Automaticky také vidí rodič očkovací průkazku svých dětí do 18 let. Na základě explicitně uděleného mandátu jinou osobou pak vidí občan také očkovací průkazku této osoby.

Další novou funkcí je možnost sdílení obsahu očkovací průkazky s ošetřujícím lékařem. Pokud tedy přicházím do nemocnice či ordinace na plánované či akutní ošetření, které vyžaduje rychlé ověření stavu mých očkování (například tetanus), je možné údaje o očkování nasdílet s mým ošetřujícím lékařem.



Funkce pro uchovávání, zobrazování a ověřování covidových certifikátů zůstává v aplikaci EZKarty zachována jako samostatná sekce napojená na portál ocko.uzis.cz. Očekává se, že očkování proti COVID-19 se postupně stane běžnou součástí očkovacího průkazu. Zobrazení certifikátů jiných osob je řízeno systémem mandátů a spřažených osob – rodiče tak automaticky vidí certifikáty svých dětí do 18 let nebo osob, které jim udělily oprávnění.



Notifikační funkce

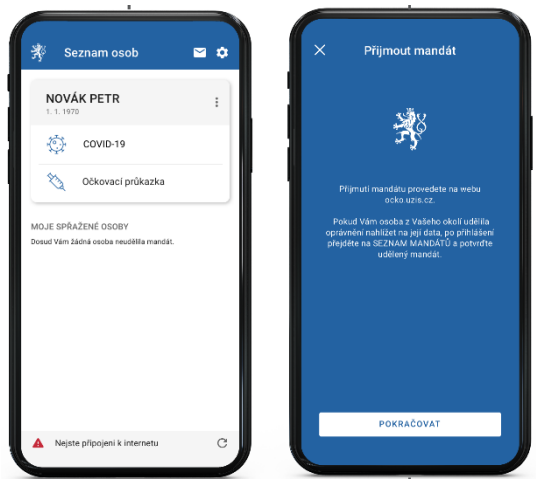
Aplikace EZKarty byla rozšířena o funkci zasílání notifikací. Díky této funkci mohou uživatelé obdržet jak cílené, tak obecné informace, např. informování o novinkách v aplikaci. Dalším plánovaným rozšíření je zavedení zdravotních notifikací a připomínek, které občany včas upozorní na klíčové aspekty zdravotní péče. Automatizovaný systém tak pomůže zajistit upozornění na důležité zdravotní úkony, jako jsou očkování, preventivní prohlídky či lékařská doporučení. EZKarta tímto způsobem podporuje prevenci a kontinuální péči o zdraví.

Do budoucna se počítá i s využitím této funkce v krizových situacích, například při opakování pandemie typu COVID-19 nebo při jiném ohrožení či hygienickém riziku. V takových případech bude možné občany neprodleně a cíleně informovat. Zprávy mohou být odesílány přímo z Ministerstva zdravotnictví nebo z dalších pověřených organizací, jako jsou zdravotní pojišťovny, nemocnice nebo lékaři – prostřednictvím zabezpečeného API přístupu.

Udělování mandátů

S rozšiřováním funkcí aplikace EZKarta roste i potřeba efektního sdílení dat – například možnost udělit mandát jiné osobě pro zobrazení vlastního očkovacího průkazu. Typickým příkladem může být situace, kdy chce senior umožnit svým dětem, nebo vnoučatům zobrazit obsah očkovací průkazky.

EZKarta proto ve spolupráci s portálem ocko.uzis.cz umožňuje přidělovat (a odebírat) mandáty k obsaženým funkcím i dalším osobám. Aktuálně se správa mandátů vztahuje na očkovací průkaz a covidové certifikáty. Do budoucna se počítá s rozšířením udělovaní mandátů i na nové funkce, které budou do aplikace přibývat. Předpokládá se přepojení správy všech mandátů pod registr práv a mandátů dle zákona č. 236/ 2025, kterým se mění zákon č. 325/2021Sb, zákon o elektronizaci zdravotnictví.



Další rozvoj EZKarty

EZKarta se bude postupně rozvíjet v synergii s rozvojem elektronizace zdravotnictví, zejména s rozvojem centrálních služeb, případně s rozvojem standardizace, která zavede porovnatelné, centrálně integrovatelné funkce elektronizace zdravotnictví.

Mezi nové plánované funkce v horizontu této strategie do konce roku 2025 spadá například elektronický přístup občanů k jejich datům, tedy výpisy informací z centrální resortních systémů, zejména Národního zdravotnického informačního systému a systému eRecept. Tato služba poskytne občanovi přihlášenému přes funkcionalitu Identita občana výpis z centrálních evidencí (vybraných registrů Národního zdravotnického informačního systému), ve kterých je jednoznačně ztotožněn. V zásadě postupně občan získá dle svého práva údaje o něm vedené v centrálních evidencích resortu zdravotnictví jako např. informace o hospitalizacích pacienta.

V další fázi budou do aplikace EZKarta postupně přidávány nové funkce, které dále rozšíří její využití. Mezi ně patří:

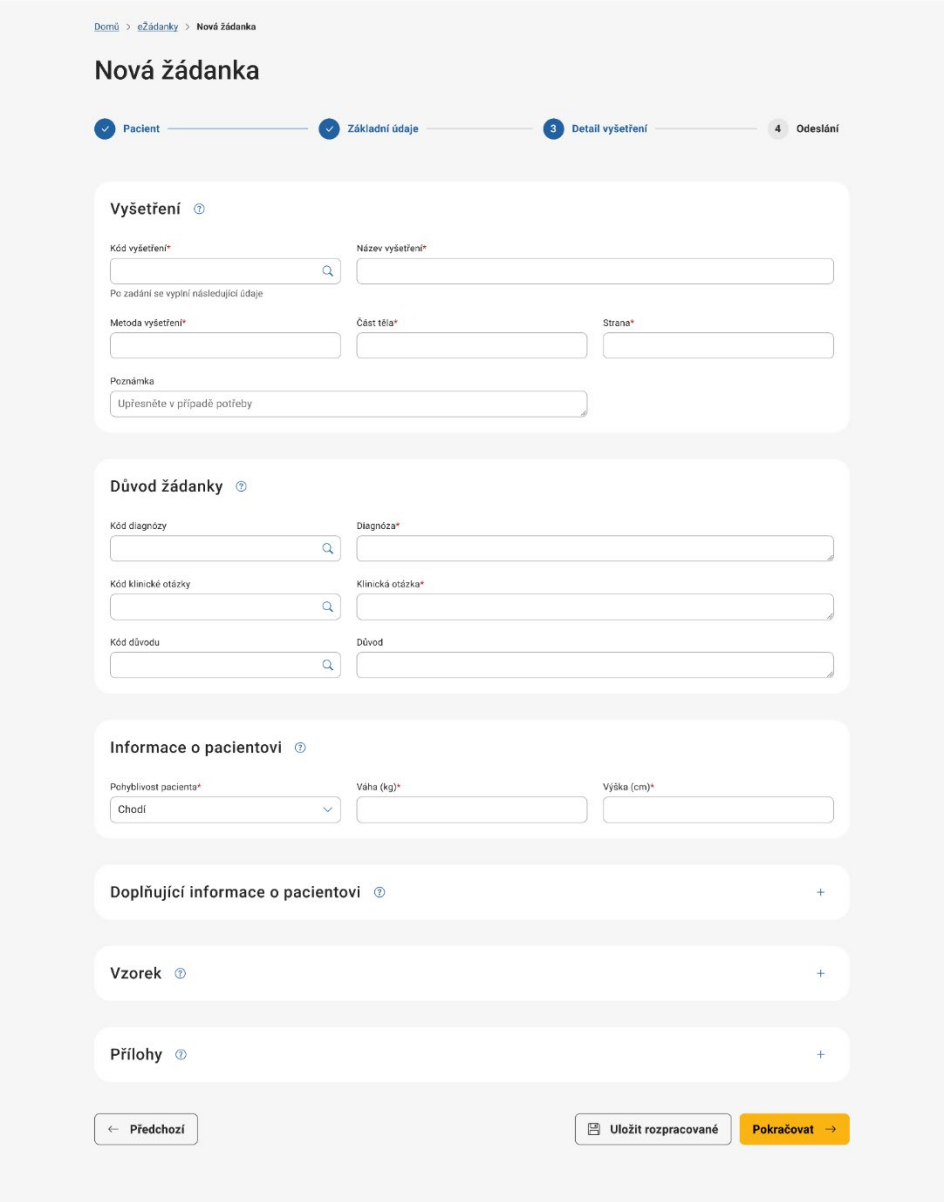
- Informační služba „Rozcestník MZČR“, která usnadní přístup ke zprávám a informacím od resortních orgánů. Tato služba bude přizpůsobena konkrétnímu uživateli – například zdravotnickým pracovníkům nabídne relevantní odkazy.
- e-Mapa poskytovatelů zdravotních služeb, zobrazující vybrané údaje o poskytovatelích v mapovém podkladu České republiky, včetně jejich kapacitní dostupnosti. Data budou čerpána z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.
- Zasílání e-zpráv od poskytovatelů zdravotních služeb pacientům, s možností aktivace ze strany pacienta (opt-in).
- Mapa kapacitní dostupnosti ambulantních služeb.
- e-Management screeningových programů, včetně elektronického zvaní klientů, notifikací a možnosti e-objednávání (registrace a rezervace).
- Sdílení zdravotní dokumentace, zejména parametricky standardizovaných forem elektronické zdravotnické dokumentace (eZD).

Sdílení zdravotnické dokumentace bude záviset na dokončení centrálních služeb dle zákona č. 236/2025, kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví. Občan tak bude mít v aplikaci EZKarta přístup ke své elektronické zdravotnické dokumentaci, případně

přímý odkaz ke stažení konkrétních dokumentů, jako jsou propouštěcí zprávy, laboratorní výsledky nebo e-žádanky – pokud mu je daný poskytovatel zpřístupní.

eŽádanka – efektivní předávání péče mezi poskytovateli zdravotních služeb

Zavedení jednotné, centrálně řízené a strukturované trojcestné elektronické žádanky přinese výhody jak občanům, tak poskytovatelům zdravotních služeb. Cílem je vytvoření centrálního systému, který výrazně zjednoduší a zpřehlední proces předávání péče mezi jednotlivými poskytovateli. Pacienti budou mít k systému přístup prostřednictvím Národního portálu EZ nebo z aplikace EZKarta. Poskytovatelé zdravotních služeb se připojí buď přes své vlastní informační systémy, nebo rovněž přes Národní portál EZ. Výsledek vyšetření bude automaticky načten do Národního portálu EZ a EZkarty. Výsledek bude přístupný tomu, kdo žádanku vydal, registrujícímu praktickému lékaři a pacientovi.



Hlavní přínosy eŽádanky zahrnují jednoznačnou identifikaci žádanek a vzorků, zpřehlednění zdravotnických dat, možnost vystavení adresné i neadresné žádanky, zlepšení dostupnosti zdravotní péče, přehlednost a dostupnost statistik, a standardizaci žádanek. Zároveň eŽádanka podpoří monitoring objednacích dob, podpoří efektivitu péče díky eliminaci duplicitních vyšetření a v budoucnu umožní zveřejnění čekacích lhůt i vytvoření centrálního objednávacího systému. Informace o poskytnutí vyžádané zdravotní péče budou zpřístupněny zdravotní pojišťovně pacienta. V první fázi budou vyvinuty eŽádanky na laboratorní a obrazová vyšetření.

Digitalizace screeningových programů

Národní screeningové centrum plánuje vytvoření komplexního informačního systému PREV-IS, který zefektivní řízení a analýzu preventivních a screeningových programů. Systém bude propojen s centrálním rezervačním systémem, který umožní pacientům pohodlně rezervovat termíny na screeningová vyšetření online. Přístup k rezervacím i screeningovým záznamům bude možný právě i prostřednictvím NPEZ a EZKarty.

EZKarta bude rozšířena o funkce zasílání personalizovaných notifikací a připomínek k preventivním prohlídkám a screeningům, čímž se podpoří aktivní role občanů v péči o jejich zdraví. Poskytovatelé zdravotních služeb získají možnost v reálném čase ověřovat absolvování vyšetření a nahlížet do základních výsledků.

Interoperabilita poskytovatelů zdravotních služeb

Nezbytnou výchozí podmínkou interoperability poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti zdravotnické dokumentace je její vedení v elektronické podobě. Zjednodušení této agendy zavádí Zákon č. 240/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Další zásadní podmínkou je implementace centrálních služeb elektronického zdravotnictví, které umožní jednoznačnou identifikaci subjektů, včetně pacientů.

Jedním z dosud nejvíce zásadních českého systému eHealth je nedostatečná parametrizace zdravotnické dokumentace blokující efektivní datovou komunikaci v rámci resortu. Tato situace se však rychle mění. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s NCEZ a HL7 ČR zveřejnilo sedm národních standardů založených na HL7 FHIR R4 a zahájilo veřejná připomínková řízení. Současně byla novelizována legislativa – konkrétně zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, jehož účinnost byla po konzultaci s odbornou veřejností posunuta na 1. 1. 2026. Tato novela povýší vybrané FHIR profily na právně závazné rozhraní pro výměnu elektronických zdravotnických záznamů.

V první fázi se standardizace zaměřuje na prioritní typy zdravotnické dokumentace, jak je definuje i nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data. Konkrétně se jedná o propouštěcí zprávu, zprávu z laboratorního vyšetření, zprávu z obrazového vyšetření, laboratorní žádanku, žádanku obrazového vyšetření, záznam o výjezdu RZS a pacientský souhrn.

Pro zajištění plné interoperability mezi poskytovateli je kromě obsahové a komunikační standardizace nezbytné také zapojení dalších komponent elektronického zdravotnictví. Patří sem: kmenové registry, systém výměnných sítí a koncové služby pro pacienty.

Zvyšování kybernetické bezpečnosti

Kontinuální zvyšování kybernetické bezpečnosti centrálních systémů i informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb je nezbytnou podmínkou pro bezpečnou realizaci dalších cílů, které spočívají v budování elektronických služeb a strategii otevírání centrálních datových zdrojů. Bez zabezpečených procesů a infrastruktury není možné tyto služby odpovědně budovat navíc v prostředí, kdy se intenzita počtu kybernetických útoků i s ohledem na mezinárodní situaci zvyšuje a stávají se více rizikovými.

Nezbytnost zvyšování požadavků na kybernetickou bezpečnost je dána i přijetím směrnice o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. Česká republika implementovala text této evropské směrnice do nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který se stane účinným od 1. listopadu 2025.

MZ ČR si klade za cíl dlouhodobě zvyšovat ochranu zdravotnických informačních systémů, osobních údajů pacientů i kritické infrastruktury zdravotnictví v souladu s aktuální platnou legislativou a bezpečnostními požadavky, jako jsou směrnice NIS2, GDPR nebo CER, doplněné dalšími relevantními standardy. Klíčovými oblastmi v této oblasti jsou zabezpečení jednotlivých přístupů do systémů, posílení odolnosti proti všem formám kybernetických útoků, efektivní řízení bezpečnostních incidentů a kontinuální vzdělávání všech pracovníků resortu zdravotnictví v kybernetické bezpečnosti. Aktualizace Národní strategie EZ klade důraz na prevenci, edukaci a včasnou detekci hrozeb, čímž nejen zvyšuje povědomí o ochraně dat, ale také přispívá ke kontinuitě a kvalitě poskytované zdravotní péče.

V současné době MZ realizuje a připravuje několik zásadních projektů, které významně ovlivňují schopnosti a rozsah realizace této oblasti. Jedná se zejména o projekty z NPO, které podpoří posílení centrální kybernetické infrastruktury spravované ÚZIS ČR a rovněž podpoří zavedení a aktualizaci bezpečnostních procesů prostřednictvím centrálních projektů MZ ČR. Tyto aktivity zajišťují splnění všech formálních a metodických požadavků na kybernetickou bezpečnost, včetně tvorby metodik, dokumentace, mapování aktiv a hodnocení rizik, a zároveň přispívají ke zvýšení kompetencí zaměstnanců úřadu v této oblasti.

Digitální gramotnost a osvěta – vzdělávání v éře eHealth

Mezi klíčové aktivity v oblasti elektronizace zdravotnictví patří vzdělávání a osvěta v oblasti digitalizace zdravotnictví, což je rovněž zohledněno v Národní strategii EZ. Informovanost musí předcházet reálnému spuštění komponent elektronizace. Pomocí této aktivity je zajistit připravenost všech uživatelů elektronického zdravotnictví na změny vyplývající z digitalizace a tím podpořit bezpečné a efektivní využívání digitálních služeb v systému zdravotní péče.

V roce 2024 byla zahájena osvěta doprovázená přípravou komunikační strategie, zapojením interních kapacit a partnerů a rovněž přípravou cílené mediální kampaně. Pro účel zajištění

informovanosti veřejnosti a zdravotnických pracovníků byla zřízena komunikační platforma www.digitalizovanezdravi.cz. V roce 2025 se osvěta o elektronizaci zdravotnictví zaměří na informovanost prostřednictvím prezentací, periodik a kapacit MZ.

V budoucnu bude vzdělávání a osvěta zaměřena na poskytování informací o možnostech zpřístupnění elektronické zdravotní dokumentace se zaměřením na ochranu dat a osobních údajů. Budou připravována specifická opatření digitální gramotnosti zaměřená na osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněných občanů s přihlédnutím na WCAG (Pravidla pro tvorbu bezbariérového webu). U zdravotnických pracovníků bude podporováno systematické vzdělávání zaměřené na používání digitálních nástrojů, moderních technologií a práci s interoperabilními systémy. Důraz bude kladen na aplikovatelnost získaných znalostí v klinické praxi. Tyto nástroje budou využívat existující platformy (např. Národní zdravotnický informační portál – NZIP) a budou poskytovány zdarma pro široké publikum.

Součástí procesu příprav a realizace projektů elektronizace zdravotnictví je i dostatečná prezentace cílů, dopadů, benefitů podle informovanosti. Pro podporu veřejnosti – včetně odborné – je nutná prezentace ve srozumitelné a koncentrované podobě.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Realizované kroky

1. Přijetí zákona č. 236/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví („Novela zákona o elektronizaci“) s účinnosti od 1. ledna 2026
2. Aktualizace Národní strategie elektronického zdravotnictví pro období 2025–2035
3. Prolongace Strategického rámce Zdraví 2030 do roku 2035
4. Realizace standardu definující požadavky na technická řešení určená k poskytování telemedicínských zdravotních služeb
5. Realizace popisu standardů výměnných sítí pro akreditované afinitní domény
6. Spuštění testovacího rozhraní kmenových registrů pacientů
7. Zřízení Výboru pro umělou inteligenci ve zdravotnictví
8. Funkční resortní katalog otevřených dat a publikace široké sady otevřených datových sad v tomto katalogu. Finalizace a naplnění „Koncepce sdílení a sekundárního vytěžování dat Národního zdravotnického informačního systému“.

Cíle koncepce do roku 2025

1. Vybudované a plně funkční centrální komponenty a další infrastrukturní služby definované zákonem č. 325/2021Sb, zákon o elektronizaci zdravotnictví.
2. Spuštění Národní platformy elektronického zdravotnictví (NPEZ) jako klíčové komponenty infrastruktury elektronického zdravotnictví.
3. Nově vybudované elektronické služby občanům, dostupné v EZKartě. Postupné rozšiřování jejich funkcí.
    a. Rozcestník MZ ČR a mapa poskytovatelů
    b. Výpisy z centrálních registrů NZIS
    c. Online centrální objednávání na screeningové vyšetření

    d. Elektronické zasílání žádanek a propouštěcích zpráv
4. Zavedení obsahových a komunikačních standardů pro informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb.
    a. Platné standardy pro prioritní typy EZD
    b. Elektronizace komunikace mezi nemocnicemi
5. Implementace datových standardů a elektronických nástrojů posilujících plynulost navazujících segmentů péče, zejména v oblasti rychlé diagnostiky a zahájení léčby vážných onemocnění, v dlouhodobé péči kombinující lůžkový a nelůžkový segment a v sociálně-zdravotních službách.
6. Legislativně ukotvené zjednodušené vedení čistě elektronické zdravotnické dokumentace u poskytovatelů zdravotních služeb.
7. Zavedení Katalogu služeb elektronického zdravotnictví (KSEZ) a jeho integrace do NPEZ.
8. Posílení KB centrálních systémů a informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb.
9. Zajistit komplexní přípravu pro implementaci EHDS prostřednictvím provedení právní, technické a organizační analýzy. Vyhodnotit aktuální stav národní infrastruktury, identifikovat mezery v interoperabilitě, standardech a kybernetické bezpečnosti, a navrhnout harmonogram zavedení.
10. Zajištěni připravenosti všech uživatelů elektronického zdravotnictví na změny vyplývající z digitalizace zdravotnictví.

Kapitola X. Legislativa a dotační politika jako nástroj změny

https://nzip.cz/koncepce2025#legislativa

Aktualizovaná kapitola shrnuje nejnovější vývoj v oblasti zdravotnické legislativy a klíčových dotačních programů. Kapitola je doplněna věcnými přílohami s přehledy přijatých norem a realizovaných projektů / dotačních titulů.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Analýza stávajícího stavu a východiska koncepce

Legislativa

Principiální cíle a reformní kroky představené strategie nelze naplnit bez odpovídajícího legislativního zázemí. Zejména vývoj klíčových komponent infrastruktury elektronického zdravotnictví vyžaduje novelizaci příslušných zákonů a totéž platí pro inovace v oblasti sociálně zdravotních služeb a úhradových mechanismů. Ministerstvo zdravotnictví plánuje do konce volebního období prosadit několik důležitých legislativních záměrů, mezi jejichž hlavní cíle patří:

- lepší dostupnost zdravotních služeb pro pacienty a vyšší podpora činností zaměřených na předcházení vzniku nemocí,
- zajištění dostatku pracovníků vykonávajících jednotlivá zdravotnické povolání dle oborové a regionální potřebnosti,
- podpora lepšího sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb a díky tomu omezení zbytečných či duplicitních případů poskytování zdravotních služeb,
- snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb,
- optimalizace a reorganizace systému hygienické služby,
- zvýšení odpovědnosti zdravotních pojišťoven za funkční a hospodárné nastavení sítě smluvních poskytovatelů za pomoci účinných nástrojů.

V oblasti poskytování zdravotních služeb a výkonu zdravotnických povolání strategie:

- zracionalizuje požadavky na vzdělávání zdravotnických pracovníků bez snížení kvality a očekávaného výstupu vzdělávacího procesu,

- omezí stávající hypertrofované požadavky na posuzování zdravotní způsobilosti v případech, kdy to není nezbytné, ani potřebné,
- podpoří bezpečné poskytování telemedicínských zdravotních služeb,
- usnadní využití údajů vzniklých při poskytování zdravotních služeb pro vědu a výzkum bez snížení standardu ochrany osobních údajů.

V oblasti financování zdravotních služeb a systému veřejného zdravotního pojištění strategie zejména:

- rozšíří možnosti aktivit zdravotních pojišťoven v oblasti prevence, např. tím, že umožní pojištěncům čerpat vyšší prostředky z fondu prevence v případě, kdy budou řádně pečovat o své zdraví (např. preventivní prohlídky, screeningy, očkování atd.)
- umožní zdravotním pojišťovnám poskytovat příspěvky (stipendia, dotace) na předatestační vzdělávání lékařů, což posílí jejich možnost ovlivňovat síť poskytovatelů zdravotních služeb a tím zajišťovat dostupnost zdravotních služeb ve všech regionech ČR – zdravotní pojišťovny tedy budou mít možnost ovlivnit počet lékařů vzdělávajících se v jednotlivých odbornostech a zároveň cílit finanční prostředky tam, kde bude potenciálně riziko snížení dostupnosti péče v příslušné odbornosti,
- zreviduje rozsah nároku a výši úhrad hrazených služeb v oblasti stomatologické péče tak, aby byla zajištěna vyšší ochota zubních lékařů uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami
- zjednoduší možnost pro čerpání zdravotních služeb v zahraničí, zejména tak, aby tyto služby mohli čerpat pojištěnci v příhraničních oblastech se zhoršenou dostupností v některých oborech zdravotních služeb

V oblasti elektronizace zdravotnictví a podpory digitálních služeb strategie zejména:

- dokončí přípravu a zprovozníme integrované datové rozhraní zdravotnictví včetně kmenových registrů, služeb vytvářejících důvěru a centrálních služeb elektronického zdravotnictví,
- transformuje stávající mobilní aplikaci Tečka na univerzální aplikaci pro přístup k elektronickým službám ve zdravotnictví tak, že nebude pouhým elektronickým očkovacím průkazem, ale jednotnou branou ke všem elektronicky vedeným údajům daného pacienta a k dalším užitečným informacím,
- vydá standardy elektronického zdravotnictví, které umožní interoperabilitu rozdílných informačních systémů, a tedy usnadní potřebný přenos dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a dalšími příjemci dat,
- spustí službu eŽádanka, která primárně usnadní objednávání pacientů k indikovaným zdravotním službám a sekundární přinese významné informaci o dostupnosti zdravotních služeb nebo čekacích dobách a také usnadní redukci zbytečných případů poskytování zdravotních služeb.

V oblasti ochrany veřejného zdraví strategie zejména:

- zřídí nový ústřední orgán Státní hygienickou službu, která bude nástupnickou organizací pro krajské hygienické stanice a hygienickou stanici hlavního města Prahy, který umožní

efektivní jednotné řízení a metodické vedení v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru,

- zefektivní poskytování souvisejících nezbytných laboratorních služeb novým uspořádáním organizace a obsahu činnosti zdravotních ústavů,
- podpoří lepší, snadnější a přesnější sběr dat o infekčních nemocech novými nástroji elektronické komunikace.

Dotační politika

MZ ČR, ač není řídicím orgánem žádného operačního programu financovaného z EU fondů, umí používat tyto zdroje pro podporu rozvoje infrastruktury a pro tvorbu a realizaci systémových kroků v resortu. MZ totiž dodává podklady pro nastavení dotací v rámci operačních programů řízených jinými ministerstvy – konkrétně Ministerstvem pro místní rozvoj v případě Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen „IROP“, investiční prostředky) a Ministerstvem práce a sociálních věcí v případě Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“, neinvestiční prostředky), v rámci něhož jsou MZ a jeho organizace (např. ÚZIS, IPVZ, NCO NZO a NÚDZ) příjemci a tedy realizátory projektů, které by měly přispět k vyrovnávání se se současnými i budoucími výzvami českého zdravotnictví, tedy především s demografickým stárnutím jak populace obecně, tak zdravotnických pracovníků. Velkým tématem je rovněž i duševní zdraví včetně prevence v této oblasti.

MZ se stalo také tzv. vlastníkem pilíře č. 6 „Zdraví a odolnost obyvatel“, jež se skládá ze dvou komponent Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), konkrétně se jedná o oblast 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče, celkem je rozdělováno cca 12,5 mld. Kč. Primárním cílem komponent je především posílení odolnosti systému zdravotní péče s důrazem na péči onkologickou. Komponenty v sobě zahrnují realizaci projektů zaměřených na výstavbu nových či úpravu stávajících zdravotnických zařízení, podporu vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků, podporu rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech, podporu preventivních screeningových programů a rozvoj specializované hematoonkologické a onkologické péče. NPO je založen na realizaci reforem a investic v dané oblasti, jejichž plnění je následně vyhodnocováno skrze plnění nastavených cílů a milníků. V případě oblasti zdraví je nezbytné ze strany resortu plnit celkem 14 milníků a cílů, aby bylo úspěšně dosaženo všech reforem a investic s tím, že k 31. červenci 2025 byly již úspěšně splněny 4 z nich.

Vedle výše uvedených evropských dotačních nástrojů samozřejmě existují ještě národní dotační prostředky, jež cílí na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci zdravotnické infrastruktury prostřednictvím tzv. Státních programů reprodukce majetku. Programy jsou zaměřeny především na modernizaci a obnovu zdravotnické infrastruktury a obnovu a pořízení zdravotnické přístrojové techniky. Výjimečně je podpora poskytnuta i do oblasti pomocných a obslužných provozů, a to většinou při rozsáhlejších akcích, kde tyto provozy jsou součástí většího celku. Podstatná je mimo jiné i otázka efektivnosti a návratnosti takové investice. V tomto období je plánována a postupně se rozbíhá řada investičních akcí, mezi ty nejvýznamnější i co do finančních prostředků patří Strategické investice Ministerstva zdravotnictví. Strategické investiční akce jsou zaměřené na obnovu stávající infrastruktury, na

udržení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu a na vytvoření moderního a komfortního prostředí pro pacienta a jsou aktuálně připraveny k postupné realizaci.

Koordinované nastavení dotační politiky a realizace projektů společně s dalšími aktivitami zejména v legislativní oblasti a oblasti nastavení úhrad má sloužit k dosažení cílů stanovených v hlavních strategických dokumentech resortu tedy Zdraví 2030 a rovněž i Národního onkologického plánu České republiky 2030, který vznikl v rámci výše uvedené komponenty 6.2 NPO, která následně slouží pro jeho realizaci.

MZ využívá potenciálu jednotlivých nástrojů jednak jako impulsu k dosažení cílového stavu u poskytovatelů zdravotní péče, kdy poskytnutí dotace je motivací k jejich žádoucímu chování např. v oblasti optimalizace lůžkového fondu, a jednak jako možnosti získání prostředků pro realizaci nových průkopnických kroků v jednotlivých oblastech.

Shrnutí stavu k 31. červenci 2025 a kroky do budoucna

V uplynulých letech představovaly investice z EU fondů významný zdroj financování infrastruktury ve zdravotnictví, předpokládáme také, že tomu bude i do budoucna, byť v omezenější míře vzhledem k předpokládanému snížení objemu prostředků dostupných pro ČR. MZ se proto intenzivně zapojilo do přípravy a vyjednávání dalšího programového období 2028+ s tím, že předpokládanou prioritou pro investiční podporu zřejmě budou představovat služby na zdravotně sociálním pomezí, což je plně v souladu s nastoupeným trendem odklonu od financování projektů v oblasti akutní lůžkové péče. V materiálu Strategický rámec politiky soudržnosti 2028+ v ČR, který na začátku července 2025 vzala na vědomí vláda, je podpora zdravotnictví obsažena v obou variantách priorit ČR, v ekonomické se jedná o téma zlepšení dostupnosti a kvality sociálních a zdravotních služeb, v širší variantě priorit jsou pak navíc zohledněna témata:1) podpora odborného vzdělávání a motivace pracovníků v sociálních a zdravotních službách, 2) dokončení systému e-health, 3) zavádění služeb včasné detekce a intervence duševních onemocnění a 4) posílení primární a sekundární prevence zdraví. Právě poslední téma se svými ekonomickými dopady nejen na sektor zdravotnictví, ale obecně na udržitelnost hospodářství jako celku rezonuje i v přijaté Hospodářské strategii České republiky: Česko do top 10, konkrétní kroky v podobě projektů jsou obsaženy v jejím Implementačním plánu.

Do zdravotnictví (a především právě do akutní péče) z evropských prostředků zamířilo v nedávné době velké množství dotací, kdy nejvýznamnější podporu představoval investiční nástroj REACT-EU za 22 mld. Kč, v rámci kterého musela být realizace všech projektů dokončena do konce roku 2023. V rámci tohoto nástroje byla podpořena síť urgentních příjmů, tj. síť nemocnic zajišťujících základní regionální dostupnost zdravotní péče. Tato podpora umožnila podstatný rozvoj oborů navazujících bezprostředně na urgentní příjem. Samotná podpora vzniku a modernizace urgentních příjmů je zajištěna z výzev IROP vyhlášených v prosinci 2024 o objemu celkem cca 5 mld. Kč, jejichž nastavení mimo jiné umožňuje zřizovatelům nemocnic na základě dat o využití zařízení rozhodnout o efektivním využití prostředků cílených tam, kde je urgentní příjem dostatečně využíván pacienty.

Na závěr lze obecně konstatovat, že dotační nástroje především investičního charakteru pomáhají zvyšovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče, kdy z pohledu MZ je např. jednou z dílčích priorit řízený rozvoj onkologické péče v Karlovarském kraji, který je financován z dotace NPO. Ale rovněž systémové projekty realizované MZ se ukázaly a ukazují s ohledem na své výstupy zejména např. v oblasti paliativní péče a zakotvení multidisciplinárních nemocničních paliativních týmů v systému zdravotní péče jako vhodné nástroje změny.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Mezi nejvýznamnější návrhy právních předpisů k realizaci legislativních záměrů Ministerstva zdravotnictví patří zejména:

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů – projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony – nyní po meziresortním připomínkovém řízení
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – nyní po meziresortním připomínkovém řízení
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, a další související zákony – nyní v meziresortním připomínkovém řízení
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů – nyní po vnitřním připomínkovém řízení
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony – nyní po vnitřním připomínkovém řízení
- Návrh zákona o úhradách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění – nyní po vnitřním připomínkovém řízení

Realizované a připravované aktivity dotační politiky mají přispívat zejména ke zvýšení kvality a dostupnosti péče v definovaných segmentech, k posílení preventivních programů a k dosažení především následujících specifických cílů Zdraví 2030:

- **Zdraví 2030 / Cíl 2.1: Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví**
    - Jako klíčové pro zajištění udržitelnosti zdravotnictví a kvality péče pro stárnoucí obyvatelstvo je vnímána nutnost provést změny na zdravotně-sociálním pomezí. Pomocí investičních prostředků z IROP je podporována lůžková následná péče s tím, že kromě cíle v podobě zvyšování kvality péče o nejzranitelnější pacienty je záměrem výzev rovněž transformace lůžkového fondu, v jedné z aktivit může získat dotaci pouze poskytovatel zdravotních služeb, který zruší 20 akutních lůžek a naopak zřídí 20 následných lůžek

převážně pro geriatrické pacienty. Další podmínkou je zajištění skutečně integrované péče včetně zabezpečení návazné dostupnosti zdravotních a sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta. IROP rovněž podporoval stavební projekty a projekty na pořízení vybavení u poskytovatelů paliativní péče, a právě v této oblasti je vidět provázanost aktivit a zároveň kontinuita podpory tohoto důležitého segmentu péče, neboť zároveň je MZ realizátorem projektu OPZ+, jehož cílem je vznik strategie rozvoje paliativní péče a zároveň šíření obecných paliativních přístupů především do oblasti primární péče.

- Nově se mezi priority systémové podpory dostává i domácí péče, pro niž byl vytvořen samostatný program v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce o objemu cca 250 mil. Kč. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti neustále odkládaných kroků v oblasti zdravotně sociálního pomezí začalo MZ s realizací projektu KRAPL na zmapování a plánování služeb v tomto segmentu, a to na krajské úrovni, kdy se v rámci tvorby metodik a postupů aktivně setkávají všichni partneři a rovněž přímo vznikají 2 krajské zdravotně sociální plány – konkrétně v Jihomoravském a Královehradeckém kraji. Nedílnou podmínkou úspěšnosti veškerých snah pak je propojení dat obou sektorů, což je předmětem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a ÚZIS s názvem *Zpracování sociálních a zdravotních dat pro využití v praxi*.
- MZ i nadále pokračuje v reformě péče o duševní zdraví, o čemž svědčí výzvy IROP na podporu této oblasti – konkrétně pro poskytovatele akutní lůžkové péče, kde je podmínkou přiznání dotace vznik 10 dětských lůžek nebo 20 lůžek pro dospělé a pro centra duševního zdraví a stacionáře. Rovněž OPZ+ vyhlašuje výzvy přímo pro poskytovatele péče o duševní zdraví, první z nich zaměřená na vznik nových CDZ byla vyhlášena v červnu 2025, s druhou pro stacionáře a psychiatrické nemocnice se chystá na podzim. Reforma péče o duševní zdraví pokračuje i díky projektům MZ. Jedná se o systémové projekty např. na rozvoj akutní psychiatrické péče včetně zajištění dostupnosti akutních psychiatrických ambulancí. V souladu s reformou péče o duševní zdraví se aktivity MZ přesouvají i do oblasti prevence, s ohledem na situaci v oblasti dětského duševního zdraví se konkrétně jedná o šíření přejatého mezinárodního evidence-based rodičovského programu TripleP, jehož cílem je minimalizace vzniku výchovných problémů u dětí a případně i intervence v případě, že se objeví.

- **Zdraví 2030 / Cíl 2.2: Personální stabilizace resortu zdravotnictví**
  - Aktivity v této oblasti řeší i s ohledem na nastavení výše uvedeného specifického cíle Zdraví 2030 velmi široké téma od vytvoření administrativního systému pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků, které je nyní realizováno IPVZ díky dotaci z NPO a které má vysoký potenciál pro zjednodušení atestačního vzdělávání jak z pohledu studentů, tak jednotlivých zapojených organizací, až po realizaci projektů na konkrétní vzdělávání především v oborech, které se vyznačují regionálními rozdíly v jejich dostupnosti. Tyto projekty jsou realizovány ze strany IPVZ a NCO NZO, kdy obě

organizace zároveň realizují projekty mající přispět alespoň částečně k personální stabilizaci resortu zdravotnictví díky komplexnímu přístupu k pracovníkům ze zahraničí.
    - Ostatně problém s nedostatkem zdravotnických pracovníků v následujícím období budou muset řešit i další evropské země, MZ se proto společně s ÚZIS, NCO NZO a partnerem v podobě Univerzity Karlovy do tzv. společné akce v rámci programu EU4Health se zkráceným názvem HEROES, jejímž předmětem je především vyvinout účinné nástroje a metody pro plánování pracovních sil ve zdravotnictví.
- **Zdraví 2030 / Cíl 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti**
    - Významná oblast podpory směřují do oblasti primární a sekundární prevence a rozvoje datové a komunikační platformy resortu vůči laické i odborné veřejnosti. Dominantní část projektů je podpořena z OPZ+, systémové infrastrukturní projekty a rozvoj centrální IT infrastruktury pro řízení projektů prevence jsou podpořeny i z projektů NPO.
    - Přehled úspěšně obhájených a již implementovaných projektů, a rovněž projektů řešených, přináší příloha kapitoly I tohoto dokumentu. Celkem bylo a je podpořeno více než 20 pilotních projektů nových programů prevence, z nejvýznamnějších (a již uvedených do praxe) lze zmínit např. populační program screeningu karcinomu plic nebo program včasného záchytu karcinomu prostaty.
- **Zdraví 2030 / Cíl 2.3: Digitalizace zdravotnictví**
    - Projekty a dotace přispívají k dosažení cílů i v této oblasti, kdy aktuálně dochází primárně z evropských prostředků k podpoře projektů zaměřených na kybernetickou bezpečnost, eHealth a interoperabilitu. Tyto oblasti jsou podporovány z Národního plánu obnovy a IROP. Elektronizace zdravotnictví je zásadním tématem i pro resort samotný, neboť právě Ministerstvo zdravotnictví by mělo být autoritou, jež nastaví jednotné standardy elektronizace v resortu a parametry interoperability systémů. Z tohoto důvodu je realizováno několik systémových projektů z NPO, jež mají za úkol dané nastavit.

Souhrn realizovaných kroků 31. 7. 2025

1. Byly vyhlášeny všechny plánované výzvy IROP ze strany MMR díky zajištění podkladů od MZ a spolupráce s relevantními partnery – celkem se jedná o prostředky ve výši 9,5 mld. Kč ze strany EU s povinným spolufinancováním z národních zdrojů (např. státní rozpočet nebo soukromé prostředky) ve výši 2,7 mld. Kč, tj. **cca 12,3 mld. Kč do investic do vybraných oborů českého zdravotnictví.** Peníze putují nejen do nemocnic, ale i do hospiců lůžkových a mobilních, a do center duševního zdraví, a už nyní přináší konkrétní dopady. Např. díky výzvám do oblasti akutní psychiatrické lůžkové péče by mělo v následujících letech vzniknout minimálně 255 nových lůžek, z nichž dokonce 110 bude určeno pro dětské pacienty.

2. **Začala realizace celkem 10 systémových projektů Ministerstva zdravotnictví podpořená z OPZ+ celkem za 300 mil. Kč.** Tyto projekty se zaměřují na zdravotně-sociálního pomezí a podporu péče a prevence v oblasti duševního zdraví. V tomto kontextu je pak výjimečný projekt, jehož cílem je zkvalitnění nutriční péče a zlepšení poskytované stravy v nemocnicích, kdy přizpůsobení výživy každého pacienta jeho reálným potřebám má vést k rychlejší rekonvalescenci a snížení míry komplikací, a tak potažmo i zkrácení doby hospitalizace.
3. **Začala realizace dalších systémových projektů OPZ+ organizací v přímé působnosti MZ** – tj. ÚZIS – zejména zaměřených na screeningové programy, ale i primární prevenci – konkrétně realizace programu včasného záchytu dětí s nadváhou a realizace programu BUĎ FIT 24 (BF24) s cílem podpory zdravého životního stylu u dětí ve věku 6–11 let, NCO NZO a IPVZ – projekty přispívající k personální stabilizaci zdravotnictví, tj. nejen zaměřené na samotnou přípravu vzdělávání a jeho realizaci, ale i např. na systémové kroky nutné pro efektivní využití pracovníků z třetích zemí.
4. **Byla zřízena Koncepční pracovní skupina pro přípravu budoucího programového období kohezní politiky EU 2028+**, jejímž úkolem bude v partnerském konsensu relevantních stakeholderů z řad krajů, obcí, plátců péče, ale i pacientských organizací stanovit priority pro financování z EU fondů a dále pak rozpracovat do konkrétních podporovaných opatření.
5. **Oblast zdravotnictví je dostatečně zohledněna v rámci priorit pro financování z EU fondů v Strategickém rámci politiky soudržnosti 2028+ v ČR**, který na začátku července 2025 vzala na vědomí vláda.
6. **Byl vyjednán s MF a donorským státem a následně odstartován Program domácí péče financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce**, jehož součástí jsou dva předdefinované projekty realizované ÚZIS a NCO NZO. ÚZIS se zaměří na vytvoření referenční sítě poskytovatelů domácí péče, na základě dat pak navrhne úpravy úhradových mechanismů. Projekt NCO NZO bude primárně určen na vzdělávání jak poskytovatelů péče, tak např. i neformálních pečujících.
7. **Bylo předběžné dohodnuto s MF a norskými donory pokračování programu Zdraví tentokrát už 4. Finančních mechanismů EHP a Norska, tentokrát pro zpožděné období 2021-2028.** Celkem se bude jednat o 25 mil. EUR od donorských států, s českým spolufinancováním jde v závislosti na kurzu až o 0,75 mld. Kč, a to k využití do konce roku 2031. Určeny jsou pro témata antimikrobiální rezistence a dětského duševního zdraví.
8. V rámci Národního plánu obnovy byla již nyní v rámci realizace projektů **vytvořena základní platforma elektronického informačního systému řízení, správy a hodnocení vzdělávání zdravotnických pracovníků**, která by po rozvoji všech modulů měla zásadně zlepšit administraci specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků v České republice. Rovněž byl spuštěn program na časný záchyt karcinomu plic a zahájena podpora preventivních screeningů kolorektálního karcinomu. V rámci podpory rehabilitační péče byl vystavěn a zprovozněn nový pavilon v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech.

- **V posledních cca dvou letech se podařilo nastartovat strategické investice do největších nemocnic,** v září tohoto roku bude již ukončena akce *IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit,* investiční akce *FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B* zahájila realizaci v říjnu 2024, investiční akce *„FN Hradec Králové –*

modernizace chirurgických oborů“ zahájila realizaci v březnu 2025 a v současné době stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem.

Další cíle pro dotační politiku v nejbližších cca 2 letech

1. Zajištění rozsáhlejší propagace realizace systémových projektů MZ zejména v oblasti zdrav-soc pomezí s ohledem na nutnost zapojení všech relevantních stakeholderů (např. projekt KRAPL) a také nového projektu Podpora rozvoje zdravotní péče o dětské duševní zdraví, jehož záměrem je nalákat nové profesionály do tohoto typu péče.
2. Nastavení konsensuální podoby programu Zdraví v rámci 4. Finančního mechanismu EHP a Norska a jeho vyjednání s MF a donorskými státy, v oblasti dětského duševního zdraví je cílem začít v mezisektorové spolupráci realizovat účinné a ověřené preventivní programy a dále vytvořit systém forenzní psychiatrické péče o děti.
3. Zapojení se do přípravy dalších podkladů pro podobu evropské kohezní politiky 2028+ a zajištění dostatečných důkazů o efektivitě podpory zdravotnictví z EU fondů včetně vytvoření jednotných regionálních analýz zdravotnictví na úrovni krajů.
4. Zkoumání možnosti využití doplňkové podpory investic do zdravotnictví ve formě tzv. finančních nástrojů z EU fondů např. při budování kapacit zdravotně-sociálních služeb
5. Postupná realizace projektů NPO vedoucí k úspěšnému vykazování plnění milníků a cílů. Jedná se zejména o dostavbu velkých investičních akcí: Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny Brno, Simulačního centra intenzivní medicíny v Praze, Motolského onkologického centra aj.

Kapitola XI. Zdravotnický výzkum

Dostupnost informací pro občany, posílení zdravotní gramotnosti

https://nzip.cz/koncepce2025#vyzkum

Analýza stávajícího stavu a východiska koncepce

Národní strategie pro oblast zdravotnického výzkumu je detailně popsána v **Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030** (dále Koncepce výzkumu). Zde jsou mimo jiné definovány také tematické priority výzkumu, vývoje a inovací v oblasti zdravotnictví.

Hlavními nástroji financování VaVaI ve zdravotnictví jsou **institucionální podpora**, **účelová podpora** poskytovaná Ministerstvem zdravotnictví prostřednictvím **Agentury pro zdravotnický výzkum ČR** a účelová podpora poskytovaná dalšími poskytovateli podpory.

Institucionální podporu (IPO) výzkumným organizacím (VO) aktivním v oblasti zdravotnického výzkumu poskytují v současnosti MZ ČR formou podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DKRVO), tj. fakultních nemocnic a dalších výzkumně orientovaných zdravotnických zařízení. Prostředky IPO jsou indexově alokovány jednotlivým VO na základě jejich hodnocení, které plně implementuje principy všech pěti modulů **Metodiky M17+** (vstupní hodnocení VO proběhlo v roce 2024). V roce 2024 došlo meziročně k poklesu prostředků přidělených ze SR na podporu DKRVO MZ ČR ze 750 mil. na 690 mil. Kč. Tento **významný meziroční pokles prostředků DKRVO (-8 %)** byl částečně kompenzován resortem a výzkumným organizacím MZ ČR bylo rozděleno cestou IPO celkem 708 mil. Kč. Na rok 2025 byl rozpočet na podporu DKRVO MZ ČR ze prostředků SR navýšen na 718 mil. Kč, ale stále nedosáhl výše před redukcí v roce 2024. Návrh rozpočtu na rok 2026, v této chvíli schválený Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) počítá na podporu DKRVO MZ ČR s navýšením o 57 mil. Kč, celkem tedy s částkou 775 mil. Kč. Pokud bude tento návrh SR schválen, **pokles z roku 2024 by měl být kompenzován a současně mělo dojít i k jeho navýšení.**

Dominantním nástrojem **účelové podpory** zdravotnického výzkumu v ČR je v současnosti **Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030** (dále Program). Plnění Programu umožňuje podporu všech stěžejních institucionálních segmentů zdravotnického výzkumu, tj. fakultních nemocnic a dalších výzkumné organizací MZ ČR, vysokých škol (a zejména jejich lékařských fakult), zařízení a ústavů Akademie věd (zejména v oblasti přírodních věd).

Na implementaci Programu a koordinaci aktivit spojených s účelovou podporou v rámci resortu, MZ ČR zřizuje **Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR)**. Toto AZV ČR zajišťuje především realizací veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů, které tematicky navazující na cíle Programu a potažmo Koncepce výzkumu a komplexně podporující prioritní témata zdravotnického výzkumu v ČR. V roce 2024 a 2025 AZV ČR pracovala s rozpočtem cca **1,2 mld. Kč**, což kromě podpory běžících projektů umožnilo v rámci nové veřejné soutěže (VES) 2025 **podporu přibližně každého pátého projektu** (23 % pro standardní projekty, 19 % pro projekty v rámci podprogramu pro juniorní výzkumníky). Hodnocení VES2026 právě probíhá, ale předpokládáme, že dle současných projekcí by měl i v této soutěži rozpočet umožnit podporu přibližně každého pátého projektu. Počínaje VES2026 je délka trvání projektů prodloužená z 44 měsíců na 48 měsíců se zahájením financování již od ledna prvního roku řešení. AZV ČR dále zodpovídá za vlastní přípravu Programu podpory, jeho evaluace a obecně komunikaci s RVVI a její Mezinárodní radou.

Od září 2023 z pověření MZ ČR zajišťuje AZV agendu týkající se zapojení českých vědců do **Evropských partnerství v oblasti zdraví (EU partnerství)**. Pro tuto oblast jsme společně s MZ ČR připravili **Podprogram 3 „Evropská partnerství v oblasti zdraví“** schválený vládou ČR dne 22. května 2024. Celkové výdaje za dobu trvání Podprogramu 3 v letech 2025–2030 se předpokládají ve výši **338 milionů korun** z výdajů SR. ČR se již prostřednictvím MZ a AZV oficiálně zapojila do 6 spolufinancovaných Evropských partnerství (ERA4Health, THCS, ERDERA, PerMed, EUP OH AMR, EP BE-READY NOW). Jedná se o EU partnerství zaměřená na problematiku vzácných onemocnění, personalizované medicíny, transformace zdravotních systému, nekomerčního klinického hodnocení, antibiotické rezistence, nebo pandemické připravenosti. V roce 2024 a 2025 jsme se zapojili do 4 výzev následujících EU partnerství: ERA4Health, THCS, ERDERA a PerMed. V těchto výzvách se ucházelo o podporu jako součást evropských konsorcií více než 40 projektů s českým partnerem.

Důležitým nástrojem pro realizaci Koncepce výzkumu je od roku 2022 také Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – **EXCELES**, který je umožněn díky Národnímu plánu obnovy, a který Česká republika realizuje v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU a implementován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Tento program byl zacílen na koncentraci výzkumných kapacit ve vybraných prioritních tématech zdravotnického výzkumu a umožnil vybudování pěti **národních ústavů** – Národního ústavu pro výzkum rakoviny, Národního institutu virologie a bakteriologie, Národního ústavu pro neurologický výzkum, Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, a Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

V návaznosti na vznik těchto Národních ústavů a plánovaného ukončení jejich financování ze strany MŠMT v roce 2025, připravila AZV ČR ve spolupráci s MZ ČR **Podprogram 4: Podpora národních autorit v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu,** který schválila vláda ČR svým usnesením z 30. dubna 2025, a který má zajistit navazující financovaní pro nově vytvořené národní ústavy na období 2026–2030 s předpokládanou **rozpočtovou alokací 750 mil. Kč**.

K naplňování cílů Koncepce kromě samotného Programu přispívá i účelová podpora poskytovaná Grantovou agenturou České republiky (GA ČR), Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a v omezené míře i dalšími poskytovateli, podpora z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na rozvoj **infrastrukturních podmínek pro rozvoj zdravotnického výzkumu** a v neposlední řadě podpora na rozvoj výzkumných infrastruktur a mezinárodní spolupráce poskytovaná z prostředků MŠMT.

Mezinárodní srovnání výdajů státního rozpočtu na podporu zdravotnického výzkumu a vývoje ukazuje, že státní podpora zdravotnického výzkumu a vývoje v ČR bohužel zaostává nejen za vyspělými státy EU, jako je Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a Německo, ale v relativním vyjádření i za sousedními zeměmi střední a jižní Evropy, konkrétně Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem. Celková částka ze státního rozpočtu na podporu vědy a výzkumu dedikovaná na podporu zdravotnického výzkumu v České republice je zhruba 12 %, přičemž například v Rakousku je to 20 %, v Nizozemí dokonce téměř 30 %.

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 (Příloha 1), která je **národním strategickým dokumentem pro oblast zdravotnického výzkumu**, byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2022 č. 1050. Tato Koncepce výzkumu přímo navazuje na „Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022“ a dále ji rozvíjí. Proto je nedílnou součástí Koncepce i zhodnocení toho, jak byla stávající koncepce plněna, kapitola č. 6 „Zhodnocení plnění stávající koncepce na léta 2016 až 2022“, detailně potom Přílohách Koncepce (Příloha 2). V příloze č. 1 „Závěry průběžného zhodnocení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015–2022 a Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022“. Je nutné zdůraznit, že se jedná o problematiku, která je realizována řadou institucí příslušných k různým zřizovatelům na straně příjemců a řadou rozpočtových kapitol na straně poskytovatelů. Detailní analýza financování zdravotnického výzkumu je zpracována v příloze č. 2 „Analýza podpory zdravotnického výzkumu v ČR“.

Koncepce zdravotnického výzkumu vychází primárně z potřeb rozvoje zdravotnického systému v ČR a cílů stanovených ve strategických dokumentech pro oblast zdravotní péče. Základní směr pro strategickou orientaci Koncepce tvoří především Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Priority VaVaI“) a Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027. Z hlediska mezinárodního kontextu a souvisejících mezinárodních závazků přispívá Koncepce k naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v oblasti cíle udržitelného rozvoje „Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku“. Koncepce rovněž reflektuje cíle pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru a související cíle podpory rámcového programu Horizont Evropa. Soulad a návaznosti na strategické dokumenty ČR a EU jsou v Koncepci zpracovány v kapitole č. 4 „Návaznosti Koncepce na další strategické dokumenty a zabezpečení jejich cílů“.

Tematické priority výzkumu, vývoje a inovací pro Koncepci výzkumu (kapitola č. 7) byly definovány členy Komise pro přípravu koncepce a Panelem garantů tematických priorit. Ti identifikovali nejvýznamnější výzkumné oblasti a témata pro jednotlivé obory v České republice. Postup přípravy Koncepce výzkumu včetně definice priorit je detailně popsán v kapitole č. 11 „Postup přípravy Koncepce“. Z hlediska Koncepce je v Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací celá jedna priorita, priorita č. 5: Zdravá populace, zaměřena na zdravotnický, zejména aplikovaný, výzkum a vývoj. Kromě aktualizace a obsahového rozšíření tematických priorit obsažených již ve minulé verzi, byly do nové Koncepce výzkumu zařazeny i některé zcela nové priority. Jako příklad lze uvést, zařazení rozsáhlé tematické priority **Veřejné zdraví** reagující na situaci, které čelil celý svět, v souvislosti s pandemií Covid-19. Další tematické priority jsou detailně popsány v části věnované Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030. Koncepce zároveň reflektuje i strategie v podpoře zdravotnického výzkumu ve vyspělých zemích, které jsou popsány v kapitole č.5 „Analýza zdravotnického výzkumu v zahraničí “ a podrobněji v příloze č. 3 „Zahraniční přístupy k podpoře zdravotnického výzkumu“. Implementaci Koncepce se věnuje kapitola č. 8 „Zabezpečení realizace Koncepce“, která mimo jiné poukazuje na nutnost navýšení podpory zdravotnického výzkumu v ČR. Indikátory plnění a systém evaluace Koncepce jsou definovány v kapitole č. 10 „Kontrola a hodnocení realizace Koncepce“.

S prioritami Koncepce výzkumu významně korespondují i strategická **VaVaI témata v aplikačních odvětvích** v rámci domény specializace **DS06 Pokročilá medicína a léčiva RIS3 strategie,** kterými jsou Personalizovaná a precizní medicína, Telemedicína, eHEALTH a AI, Zdravotnické prostředky, Inovativní produkty a řešení pro farmaceutický a biotechnologický průmysl, Prevence, ochrana veřejného zdraví a odolnost zdravotního systému (viz Příloha 1. Karty tematických oblasti RIS3, https://www.ris3.cz/analyzy-a-dokumenty/zakladni-dokumenty).

Institucionální podpora pro výzkumné organizace MZ ČR

Institucionální podporu výzkumným organizacím aktivním v oblasti zdravotnického výzkumu poskytují v současnosti především MZ ČR (podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj fakultních nemocnic a dalších výzkumně orientovaných zdravotnických zařízení), MŠMT (podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj vysokých škol a jejich lékařských a přírodovědeckých fakult) a AV ČR (podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj ústavů AV ČR aktivních v oblasti zdravotnického výzkumu).

Účelem institucionální podpory je především vytvoření stabilních a předvídatelných podmínek pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DKRVO). Současně však systém poskytování institucionální podpory musí vytvářet určité stimuly pro rozvoj komponent systému zdravotnického výzkumu v souladu s cíli Koncepce výzkumu. V této souvislosti je již realizováno pravidelné hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ s důrazem na sledování vývoje v oblasti kvality výzkumu, mezinárodní spolupráce, přenosu výsledků zdravotnického výzkumu do praxe a vytváření podmínek pro rozvoj personálních kapacit pro zdravotnický výzkum, specificky pak pro rozvoj vědeckých kariér mladých výzkumníků. **Metodika pro hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví**

(dále jen „Metodika“) stanovuje základní principy, postup, rozsah a indikátory hodnocení výzkumných organizací, přičemž plně implementuje principy **Metodiky M17+** (Příloha 3). Metodika je v souladu s povinností poskytovatele hodnotit výzkumné organizace, jak to vyplývá z *„Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“* schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „Metodika M17+“). **V roce 2023 proběhlo vstupní hodnocení** VO MZ ČR dle Metodiky. V souladu s Metodikou M17+ Odborný poradní orgán poskytovatele (OPO, Komise pro institucionální podporu) MZ ČR zhodnotil VO v segmentu resortu v pěti modulech: M1 – Kvalita vybraných výsledků, M2 – Výkonnost výzkumu, M3 – Společenská relevance, M4 – Viabilita výzkumu, M5 – Strategie a koncepce. V případě modulů M1 a M2 byly využity výsledky hodnocení na národní úrovni provedené a zveřejněné RVVI. Hodnocení v modulech M3-M5 provedl OPO na základě podkladů definovaných touto metodikou a sebe-evaluačních zpráv dodaných výzkumnými organizacemi. Hodnotící protokol jednotlivých VO ze vstupního hodnocení dle Metodiky byl zveřejněn na internetových stránkách MZ ČR. Z celkem 19 VO resortu bylo deset škálováno jako A, čtyři jako B a 5 jako C. V roce 2024 proběhl sběr dat a první průběžné hodnocení VO dle Metodiky M17+, nyní probíhá sběr dat za rok 2024 a letos proběhne další kolo průběžného hodnocení.

Výsledky hodnocení výzkumných organizací realizovaného MZ byly následně zohledněny při **alokaci podpory na DKRVO** tak, aby hodnocené výzkumné organizace byly dostatečně motivovány k realizaci žádoucích systémových změn, zároveň ale, aby výše institucionální podpory zůstala pro výzkumné organizace dostatečně předvídatelná a umožňovala realizaci dlouhodobějších strategických cílů výzkumných organizací. Bohužel meziročně došlo k poklesu prostředků přidělených ze SR na podporu DKRVO MZ ČR o 8 %, a toto bylo třeba zohlednit při alokaci prostředků jednotlivým VO. Na základě doporučení OPO byla alokace prostředků vztažena k částkám z roku 2023 následujícím způsobem: VO hodnocené jako A (100 %), B (90 %), C 65 %), D (60 %). Bližší informace k alokacím DKRVO jsou k dispozici na stránkách MZ ČR (https://mzd.gov.cz/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-institucionalni-podpory-na-rok-2024-na-dlouhodoby-koncepcni-rozvoj-vyzkumne-organizace/). V roce 2025 navýšení prostředků DKRVO umožnilo navýšení rozpočtu VO hodnoceným jako A o cca 0,5 mil. Kč, B o 0,25 mil. Kč, VO hodnocené jako C zůstaly na rozpočtu z roku 2024 (https://mzd.gov.cz/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-institucionalni-podpory-na-dlouhodoby-koncepcni-rozvoj-vyzkumne-organizace-na-rok-2025/).

Účelová podpora zdravotnického výzkumu v ČR

Dominantním nástrojem účelové podpory zdravotnického výzkumu je program na podporu zdravotnického výzkumu vyhlašovaný MZ ČR a implementovaný **Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR** (https://www.azvcr.cz). Jedná se o program bezprostředně navazující na cíle Koncepce výzkumu a komplexně podporující prioritní témata zdravotnického výzkumu. Do roku 2026 bude účelová podpora MZ poskytována prostřednictví Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (kód „NU“), který byl schválen usnesením vlády ze dne 11. března 2019 č. 171. Tento program vychází z Koncepce zdravotnického výzkumu platné do roku 2022, nicméně s ohledem na kontinuitu prioritních

témat a strategických cílů předchozí a nové Koncepce výzkumu (do roku 2030), bude tento program přispívat rovněž k naplňování cílů v oblasti rozvoje zdravotnického výzkumu stanovených v koncepci nové.

Od roku 2024 je již realizován navazující resortní program MZ ČR, **Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030** (Příloha 4, viz dále)**,** který již plně vychází z cílů nové Koncepce výzkumu (viz výše) a je jedním ze stěžejních nástrojů její realizace. Vedle resortního programu MZ ČR na podporu zdravotnického výzkumu je rozvoj biomedicínského výzkumu podporován také z rozpočtových kapitol dalších poskytovatelů účelové podpory. Jak vyplývá z analýzy podpory zdravotnického výzkumu v ČR, mezi nejvýznamnější další poskytovatele účelové podpory patří Grantová agentura ČR (GAČR), Technologická agentura ČR (TAČR) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pro jednotlivé kategorie výzkumu určené k podpoře jednotlivých poskytovatelů by mělo být vycházeno především ze správného definičního vymezení těchto kategorií. Při monitoringu VaVaI aktivit v rámci EU je vycházeno z definic obsažených v tzv. **Frascatiho manuálu** (dokumentu OECD), s tímto definičním vymezením pracuje i MZ ČR. **Základní výzkum** je experimentální nebo teoretická práce prováděná primárně za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na žádné konkrétní uplatnění nebo využití v praxi (oblast podporovaná GAČR). **Aplikovaný výzkum** je původní zkoumání prováděné s cílem získání nových poznatků. Je však primárně zaměřen na konkrétní praktický záměr nebo cíl. V rámci základního výzkumu budou „nové poznatky o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností“ směřovat do oblasti lékařských věd a v oblasti aplikovaného výzkumu bude „konkrétní praktický záměr a cíl“ logicky směřovat do oblasti zdravotnictví (oblast podporovaná AZV ČR). **Experimentální vývoj** je systematická práce čerpající z poznatků z výzkumu a z praktických zkušeností a produkující další poznatky, která je zaměřena na vytváření nových produktů nebo postupů, nebo na zlepšení stávajících produktů nebo postupů, v tomto případě pro oblast zdravotnictví (oblast podporovaná TAČR). MZČR bude ve spolupráci s GAČR komunikovat rozvoj základního výzkumu v oblasti lékařských věd, který vytváří nepostradatelnou znalostní základnu pro navazující výzkumné a vzdělávací aktivity. Podpora poskytovaná AZV ČR je zaměřená na aplikovaný zdravotnický výzkum. Současně bude kladen důraz na koordinaci aktivit GAČR a AZV při podpoře translačního výzkumu a výzkumu na pomezí základního a aplikovaného tak, aby podpora efektivně pokrývala všechny fáze zdravotnického výzkumu. TAČR bude jako poskytovatel zaměřen především na podporu pokročilejších fází aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zdravotnictví.

Ve spolupráci s MŠMT jsou systematicky rozvíjeny infrastrukturní podmínky pro špičkový zdravotnický výzkum, a to jak prostřednictvím investic z **Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)**, tak i skrze dlouhodobou podporu provozu velkých **výzkumných infrastruktur**. Důležitým nástrojem pro realizaci Koncepce výzkumu je od roku 2022 také Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – **EXCELES**, který je umožněn díky Národnímu plánu obnovy, a který Česká republika realizuje v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU. Tento program byl zacílen na koncentraci výzkumných kapacit ve vybraných prioritních oblastech zdravotnického výzkumu a umožnil vybudování pěti **Národních ústavů** v příslušných oblastech

(Národní ústav pro výzkum rakoviny, Národní institut virologie a bakteriologie, Národní ústav pro neurologický výzkum, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění).

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na období 2024–2030

Program (Příloha 4) je hlavním nástrojem naplňování Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 (viz výše, Příloha 1 a 2).

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět k zajištění a dalšímu rozvoji mezinárodně kompetitivního zdravotnického výzkumu České republiky, jehož úroveň bude srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie. Realizace Programu následně přispěje k zajištění vývoje prakticky využitelných výsledků pro potřeby zdravotnictví, a to v oblasti veřejného zdraví, objasňování patogeneze a rozvoje chorob, či hledání inovativních řešení pro medicínu, se zřetelem k dodržení maximální efektivity užití veřejných prostředků. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu budou mít výsledky Programu pozitivní dopad na zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice a napomůžou k celkovému zlepšování lidského zdraví, ať už v kontextu české populace, tak potenciálně v celosvětovém rozměru. Program je členěn do **tří hlavních tematických celků** reflektujících strategické oblasti zdravotnického výzkumu v České republice: **Veřejné zdraví**; **Patogeneze a rozvoj chorob**; **Inovativní řešení pro medicínu**, které se dále člení na **25 podoblastí** (Veřejné zdraví –

7 podoblastí, Patogeneze a rozvoj chorob – 9 podoblastí, Inovativní řešení pro medicínu – 9 podoblastí), jež se případně dále člení na specifičtější podoblasti (viz v rámci oblasti Veřejného zdraví vyčleněná podoblast Podpora zdraví a prevence dále dělena na 7 specifických odvětví). Tematické podoblasti jsou charakterizované vlastními úžeji pojatými specifickými cíli, a to vždy jedním obligatorním cílem hlavním a dalšími fakultativními cíli vedlejšími (jednotlivou podoblast blíže určuje až 6 vedlejších cílů). Tematické vymezení Programu je plně v souladu a vychází z **Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací**, resp. z Priority 5: Zdravá populace.

Projekty navržené do tohoto Programu musí být zařazeny do jedné či více z těchto podoblastí a zajišťovat plnění jednoho či více dílčích cílů Programu. Podrobný popis podoblastí a jednotlivých dílčích cílů je uveden v Koncepci výzkumu (Příloha 1), v kapitole 7. MZ ČR si ovšem vyhrazuje právo podpořit i projekty, které nebudou do těchto podoblastí spadat, upřesňuje vždy požadavky na odborné zaměření návrhů projektů, tj. i charakteristiku jednotlivých cílů v zadávacích dokumentacích při vyhlášení jednotlivých veřejných soutěží.

Program je členěn na **tři Podprogramy**, kdy v rámci dvou prvních Podprogramů kritériem pro rozdělení je doba od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu řešiteli. **Podprogram 1 (standardní projekty)** je hlavním nástrojem podpory a je na něj alokováno 90 %

rozpočtu v rámci dané veřejné soutěže. Z dosavadní praxe a zkušeností vyplývá, že se kontinuálně zvyšuje věk řešitelů projektů, proto je **Podprogram 2 (juniorské projekty)** zaměřen na zvýhodnění projektů, jejichž řešiteli budou juniorní výzkumní pracovníci, kteří splňují podmínku, že v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Na Podprogram 2 je určena alokace 10 % rozpočtu. Odborným zaměřením budou oba Podprogramy naplňovat cíle tohoto Programu uvedené výše.

Nový **Podprogram 3 „Evropská partnerství v oblasti zdraví“** je potom zaměřen na zdravotnický výzkum v oblastech vytyčených v rámci Evropských partnerství (viz kapitola níže). Celkové výdaje za dobu trvání Podprogramu 3 v letech 2025–2030 se předpokládají ve výši **338 milionů korun** z výdajů SR. ČR se již prostřednictvím MZ a AZV oficiálně zapojila do 6 spolufinancovaných Evropských partnerství (ERA4Health, THCS, ERDERA, PerMed, EUP OH AMR, EP BE-READY NOW).

V návaznosti na vznik Národních ústavů a plánovaného ukončení jejich financování ze strany MŠMT v roce 2025, připravila AZV ČR ve spolupráci s MZ ČR **Podprogram 4: Podpora národních autorit v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu,** který schválila vláda ČR svým usnesením z 30. dubna 2025, a který má zajistit navazující financovaní pro nově vytvořené národní ústavy (viz kapitola níže) na období 2026–2030 s předpokládanou **rozpočtovou alokací 750 mil. Kč**.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR) (https://www.azvcr.cz) je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ ČR. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je administrativně-organizační zajištění účelové podpory aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. **Kancelář AZV ČR** pro agenturu zajišťuje veškerou administrativně-organizační činnost související s veřejnými soutěžemi ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Mezi řídící a kontrolní orgány AZV ČR patří předseda, předsednictvo (7 členů), vědecká rada (16 členů), kontrolní rada (7 členů), odborné hodnotící panely (125 odborných panelistů). Detailní vymezení činnosti AZV ČR a jejich orgánů je dostupné ve statutu Agentury (https://www.azvcr.cz/dokumenty/).

AZV ČR byla zřízena 1. dubna 2014 Ministerstvem zdravotnictví a letos slaví **10 let svojí existence** (Příloha 5). Za dobu své již jedenáctileté existence AZV ČR, která svou činností navázala na Interní grantovou agenturu Ministerstva zdravotnictví ČR, podpořila více než **1140 projektů** z oblasti aplikovaného zdravotnického výzkumu v celkové výši přesahující **12,7 miliardy korun**. Tyto projekty vedly ke vzniku více než 4400 odborných publikací s IF (více než 40 % v časopisech Q1, více než 10 % v časopisech D1) a 50 patentů. Výsledky mnohých z těchto projektů nacházejí uplatnění v každodenní klinické praxi a pomáhají tak zlepšovat prevenci, diagnostiku nebo léčbu našich spoluobčanů (Příloha 6). Řešitelům nejkvalitnějších projektů přitom již šestým rokem po sobě ministr zdravotnictví předal ocenění za vynikající výsledky

v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji (Příloha 5). Kromě toho byly poprvé uděleny i Ceny předsedy AZV ČR, které budou udělovány vždy při významných událostech v životě AZV ČR, tentokrát její desetileté výročí. Vybraná analytická data o činnosti AZV ČR jsou uvedena v Přílohách 5,7.

Zde je uvedeno několik změn v činnosti AZV ČR z posledních tří let:

- Kompletně jsme změnili **hodnotící proces projektů** v rámci veřejných soutěží, kterým jsme se přiblížili hodnotícím principům používaným v rámci výzev Horizont Evropa.
- Vyjasnili jsme definici toho, co je **aplikovaný výzkum ve zdravotnictví** (viz Frascati manuál OECD).
- Stali jsme se **plně dvojjazyční**, strategické dokumenty, Koncepce, Program podpory, zadávací dokumentace veřejných soutěží, internetové stránky i systém na podávání projektových návrhů ISVP jsou nyní v češtině i angličtině.
- Při hodnocení projektů **posuzujeme výhradně kvalitu nikoliv kvantitu**, pro vynikající hodnocení závěrečné zprávy stačí jedna excelentní publikace. Zrušili jsme očekávané počty výsledků.
- Zabývali jsme se **rodinnou politikou** a začali zohledňovat při podávání návrhů projektů přerušení kariéry vzniklé z důvodu mateřské, rodičovské dovolené apod., což umožnilo navýšení počtu řešitelek v juniorském Podprogramu 2 (meziroční nárůst téměř o třetinu).
- Zabývali jsme se **výzkumnými daty, genderem v HR i genderovou dimenzí ve výzkumu**, vše je k dispozici v zadávací dokumentaci poslední veřejné soutěže a v sekci FAQ našeho webu (https://www.azvcr.cz/casto-kladene-dotazy/).
- **Navýšili jsme počet panelistek v našich odborných hodnotících panelech z 18 % na 34% v roce 2025, přičemž celkový počet panelistů/panelistek s h-indexem vyšším než 20 se zvýšil z 39% na 62%.**
- Zvýšili jsme **transparentnost hodnotícího procesu** (https://www.azvcr.cz/informacni-materialy/) a kromě posudků zpravodajů a externích hodnotitelů jsou k dispozici navrhovatelům také zdůvodnění bodování odborných panelů po prvním a druhém kole hodnocení. Odborné hodnotící panely mají nově možnost změnit celkové hodnocení až o 20% a případně tak korigovat odlehlé a podezřelé posudky. Vytvořili jsme **Příručku pro panelistky a panelisty** (Příloha 8), která je k dispozici i navrhovatelům, aby byla všem dostupná detailní pravidla hodnotícího procesu.
- **Externí hodnotitelé jsou nyní výhradně zahraniční.**
- Snažíme se **debyrokratizovat naši činnost**, ve veřejné soutěži 2023 jsme z formálních důvodů vyloučili pouze 2 ze 440 doručených projektových návrhů, a to proto, že byly doručeny kompletně v českém jazyce. **Rozsah zadávací dokumentace jsme zkrátili o více než čtvrtinu**. Pro VES 2026 byla zadávací dokumentace navíc rozdělena, přičemž druhým dokumentem jsou tzv. Všeobecná pravidla. Rozdělení umožní větší přehlednost a flexibilnější možnost změn při řešení projektu.
- Od VES 2026 jsme **zrušili každoroční povinnost věcné průběžné zprávy**, která je nyní povinná pouze po dvou letech, tedy v polovině řešení projektu.
- Podepsali jsme Memorandum o spolupráci s CZECRIN (klíčovou infrastrukturou podporující realizaci akademického klinického výzkumu v České republice), abychom jasně deklarovali, že **chceme podporovat nekomerční klinická hodno**cení. Spolupráci

jsme navázali také s velkou výzkumnou infrastrukturou BBMRI.cz, která sdružuje síť členských biobank napříč celou Českou republikou.
- Od VES2025 již vědci mohou oficiálně odnášet svoje granty při změně svého zaměstnavatele (změna příjemce).
- Jako kancelář jsme implementovali **Plán genderové rovnosti** (https://www.azvcr.cz/wp-content/uploads/2025/05/AZV_brozura_genderova-rovnost.pdf)
- Snažíme se více komunikovat všemi směry, máme **komunikační strategii**, novou vizuální identitu, jsme na sociálních sítích, pořádáme semináře a školení pro navrhovatele a panelisty, každoroční konferenci nejlépe hodnocených projektů, účastníme se popularizačních akci jako např. Noc vědců apod.
- Od září 2023, z pověření ministerstva zdravotnictví, organizačně zajišťujeme agendu týkající se zapojení českých vědců do EU partnerství v oblasti zdraví.

Evropská partnerství v oblasti zdraví

EU partnerství představují mechanismus pro zacílení podpory a koordinaci veřejných a soukromých investic do výzkumných a inovačních aktivit v prioritních tématech EU. Zapojení do evropských partnerství představuje významnou příležitost pro české vědce, jak navýšit excelenci svého výzkumu v rámci mezinárodní spolupráce, což současně znamená i přínos pro Českou republiku jakožto členský stát. **Podpora EU partnerství je proto jedním z významných nástrojů na podporu excelence**.

AZV ČR ve spolupráci s MZ ČR učinila veškeré nezbytné kroky a nyní **je již ČR oficiálním partnerem celkem 6 spolufinancovaných Evropských partnerství v oblasti zdraví** – Panedmic Preparedness, European Rare Diseases Alliance, One Health Antimicorbial Resistance, Personalised Medicine, ERA for Health Research a také Transforming Health and Care Systems. Jedná se o EU partnerství zaměřená na problematiku vzácných onemocnění, personalizované medicíny, transformace zdravotních systému, nekomerčního klinického hodnocení, antibiotické rezistence, nebo pandemické připravenosti.

V rámci svých aktivit AZV ČR uspořádala pro navrhovatele řadu informační seminářů, s cílem poskytnout základní vhled do Evropských partnerství v oblasti zdraví včetně jejich definice, typů, podmínek zapojení či způsobů financování. V tomto ohledu AZV ČR rovněž připravila **metodiku** (https://www.azvcr.cz/wp-content/uploads/2024/11/Metodika_2.-pracovni-verze_FINAL.pdf), detailněji popisující jednotlivé kroky od samotného vzniku evropských partnerství až po zahájení a vyhlašování nadnárodních spolufinancovaných výzev.

V roce 2024 a 2025 jsme se zapojili do 4 výzev následujících EU partnerství: ERA4Health, THCS, ERDERA a PerMed a v těchto výzvách se ucházelo o podporu jako součást evropských konsorcií **více než 40 projektů s českým partnerem**.

Národní autority v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu

Důležitým nástrojem pro realizaci Koncepce výzkumu je od roku 2022 také Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – **EXCELES**,

který je umožněn díky Národnímu plánu obnovy (https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-exceles-komponenta-5-1-narodniho-planu-obnovy), a který Česká republika realizuje v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU a implementován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Tento program byl zacílen na koncentraci výzkumných kapacit ve vybraných prioritních tématech zdravotnického výzkumu a umožnil vybudování pěti **Národních ústavů** – Národního ústavu pro výzkum rakoviny, Národního institutu virologie a bakteriologie, Národního ústavu pro neurologický výzkum, Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, a Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

Národní ústav pro výzkum rakoviny (https://www.nuvr.cz)

Výzkum nádorových onemocnění, který zaujímá přibližně 25 % celého biomedicínského výzkumu v České republice, má u nás dlouholetou tradici a jeho současné výsledky jsou v mezinárodním srovnání nadprůměrné. Základní a translační onkologický výzkum ovšem doposud neměl jasnou strukturu, jako je tomu v případě onkologie klinické, která je v resortu zdravotnictví koordinována prostřednictvím sítě Komplexních a Národních onkologických center. I z toho důvodu vznikl Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR, National Institute for Cancer Research), který českému onkologickému výzkumu pomáhá maximálně využít dostupné výzkumné infrastruktury a lidský potenciál. Propojením již spolupracujících pracovišť, která provádějí excelentní základní, aplikovaný a klinický výzkum v onkologii a jež se tematicky, technologicky a infrastrukturně doplňují, vznikla celorepubliková síť, NÚVR propojující ve 3 uzlech – Praze, Brně a Olomouci – dohromady 11 výzkumných institucí a 71 excelentních výzkumných týmů, které jsou rozděleny do 5 výzkumných programů pokrývajících celý inovační řetězec, tedy základní, aplikovaný a translační výzkum v onkologii. Hlavním koordinátorem a příjemcem projektu NUVR je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Národní ústav pro neurologický výzkum (https://www.ninr.cz)

Národní ústav pro neurologický výzkum (National Institute for Neurological Research – NINR) je výzkumná platforma propojující excelentní neurologické týmy z 11 předních vědeckých institucí v ČR ze sedmi měst napříč celou ČR. Cílem NINR je podpořit výzkum především neurodegenerativních onemocnění. Neurologické poruchy jsou nejčastější příčinou invalidity a druhou nejčastější příčinou úmrtí. V souvislosti se stárnutím populace také dochází k celosvětovému nárůstu výskytu neurodegenerativních chorob. Přitom podrobnosti o příčinách a rozvoji těchto chorob často nejsou dosud známé, a tak neexistuje ani jejich preventivní či kauzální terapie. Z těchto důvodů lze předpokládat, že zdravotní a ekonomický dopad neurodegenerativních onemocnění na naši společnost bude enormní. NINR tedy reaguje na aktuální trendy a potřeby a prostřednictvím integrace úsilí špičkových vědců přispěje k zmírnění negativních dopadů neurodegenerací na společnost i ekonomiku. V NINR je zapojeno přes 250 preklinických i klinických výzkumníků, kteří se podílí na multidisciplinárním výzkumu neurodegenerace u řady neurologických onemocnění. Hlavním příjemcem a koordinátorem projektu je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Národní institut virologie a bakteriologie (https://nivb.cz)

Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB) koncentruje základní a aplikovaný výzkum patogenů s výrazným socio-ekonomickým dopadem. Výsledky činnosti NIVB vědecky přispějí k hledání cest zmírnění negativních dopadů těchto infekčních chorob na společnost, posílení odolnosti populace a v důsledku i ekonomiky. NIVB propojuje 8 výzkumných institucí a 30 excelentních výzkumných týmů, které jsou rozděleny do 3 výzkumných programů s cílem přispět k urychlení vývoje léčiv a vakcín proti virovým a bakteriálním onemocněním. Hlavním příjemcem a koordinátorem projektu je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. v Praze.

Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (https://cardia.ikem.cz)

Cardia propojuje více než 100 excelentních a vzájemně se doplňujících vědeckých pracovníků z celkem 5 významných výzkumných organizací v ČR, čímž tvoří komplexní národní výzkumnou platformu (institut) zahrnující experimentální, preklinické, translační a klinické výzkumné aktivity v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, jejich nejčastějších rizikových faktorů, jako je obezita a diabetes, a souvisejících chronických komplikací. To napomůže v konečném důsledku účinněji předcházet a léčit tato onemocnění na základě přenosu poznatků získaných experimentálním výzkumem do nových léčebných postupů a opatření. A to takovým přístupem, který bude optimalizován situaci v české populaci. Hlavním příjemcem a koordinátorem projektu je Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (https://www.syri.cz/)

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – krátce SYRI – je virtuální vědecký hub, který sdružuje odborníky z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR. Jeho cílem je propojit vědce, kteří by spolu jinak nespolupracovali, a nabízet řešení a doporučení v reálném čase. Sociální vědci budou zkoumat rizikové situace a zmírňovat problémy, které tyto mimořádné události, jako je pandemie covid-19, válka na Ukrajině, inflace a zdražování nebo klimatické změna v kontextu lidského zdraví, přinášejí. Poslední roky jasně ukázaly, jak je současná doba k rizikovým situacím náchylná. Socioekonomické nerovnosti se prohlubují, proto je jedním z cílů SYRI poskytovat data tak, aby se podle nich mohli politici správně rozhodovat. Institut umožňující podobné hloubkové analýzy v ČR dosud chyběl. Hlavním příjemcem a koordinátorem projektu je Masarykova univerzita v Brně.

Financování zdravotnického výzkumu

Hlavními nástroji financování Koncepce výzkumu jsou institucionální podpora relevantních VO, účelová podpora poskytovaná MZČR prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a účelová podpora poskytovaná dalšími poskytovateli podpory.

Mezinárodní srovnání výdajů státního rozpočtu na zdravotnický výzkum a vývoj bohužel ukazuje, že státní podpora zdravotnického výzkumu a vývoje v ČR zaostává nejen za vyspělými státy EU, jako je Nizozemsko, Švédsko, Rakousko a Německo, ale v relativním vyjádření i za sousedními zeměmi střední a jižní Evropy, konkrétně Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem. **Všechny zde uvedené analýzy končí rokem 2020 (Příloha 9). Je potřeba dodat, že v posledních třech letech došlo ke globálnímu poklesu financování vědy ze SR s významným dopadem na všechny segmenty VaVaI. Z hlediska dynamiky je pro ČR negativní i určitý pokles podílu výdajů státního rozpočtu na zdravotnický výzkum a vývoj na celkových výdajích státního rozpočtu na výzkum a vývoj v posledních deseti letech, a to ze 14 % v roce 2010 na 12 % v roce 2020, přičemž například v Rakousku je to 20 %, v Nizozemí dokonce téměř 30 % podílu SR jdoucího na podporu VaVaI.** Podpora zdravotnického výzkum a vývoje v ČR posledních 15 let rostla (analýzy do roku 2020), tempo růstu této podpory však zaostávalo za tempem růstu celkových výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Podíl podpory zdravotnického výzkum a vývoje ze SR tak v ČR klesal. V oblasti podpory výzkum a vývoje zaměřeného na všeobecný rozvoj znalostí klesl od roku 2010 podíl výzkum v oblasti lékařských věd z 14 % na 7 %. Naproti tomu vzrostl podíl podpory výzkum v oblasti přírodních věd, které v určitých oblastech napomáhají rozvoji znalostí pro zdravotnictví a zdravotnický výzkum a vývoj.

Nová Koncepce výzkumu si klade reálný, avšak dostatečně ambiciózní plán budoucího financování zdravotnického výzkum v ČR směrem k růstu podílu podpory zdravotnického výzkum v systému na úroveň vyspělých zemí Evropy (Příloha 1, Příloha 9).

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Realizované kroky

- MZČR zajistilo ve spolupráci s AZV ČR přípravu národní Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030 a Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030, což umožňuje kontinuální podporu strategických oblastí zdravotnického výzkumu cestou **účelové podpory** do roku 2030.
- MZČR implementovalo vlastní Metodiku pro hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví, která plně zohledňuje principy **Metodiky M17+** a provedla vstupní hodnocení všech výzkumných organizací v rámci resortu. Současně byl vytvořen indexový alokační klíč institucionální podpory pro VO na základě jejich škálování. Resort tak naplnil zákonnou povinnost a je v souladu s povinností poskytovatele na hodnocení výzkumných organizací, čímž je pro VO MZČR umožněno financování cestou **institucionální podpory**.
- MZČR nadále implementuje Program podpory skrze **AZV ČR.** AZV ČR provedla řadu zásadních změn vedoucích ke zkvalitnění hodnotícího procesu, zvýšení transparentnosti hodnocení, debyrokratizace své činnosti, vstřícnosti směrem k zahraničním vědcům pracujícím v ČR, zohledňování rodinné politiky a podpoře excelence.
- AZV ČR byla pověřena koordinací oblasti **Evropských partnerství v oblasti zdraví.**
- Vláda ČR schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030, který spočívá v jeho rozšíření o **Podprogram 3: Evropská**

partnerství v oblasti zdraví. Na realizaci tohoto programu se podařilo zajistit **navýšení rozpočtu** o celkem 25 mil. Kč v roce 2025, a dále 75 mil. Kč ročně v rámci střednědobého výhledu.

- AZV ČR rovněž připravila **metodiku pro Evropská partnerství v oblasti zdraví.**
- Pro zajištění kvality a konkurenceschopnosti zdravotnického výzkumu v ČR AZV ČR a MZČR **pokročily v zajištění udržitelnosti Národních ústavů** podpořených programem EXCELES a připravila **Podprogram 4: Podpora národních autorit v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu,** který schválila vláda ČR svým usnesením z 30. dubna 2025, a který má zajistit navazující financovaní pro nově vytvořené národní ústavy na období 2026-2030 s předpokládanou **rozpočtovou alokací 750 mil. Kč**.

Cíle koncepce do roku 2025

- Pro zajištění stability a konkurenceschopnosti zdravotnického výzkumu v ČR je nezbytné **zajistit stabilní a předvídatelné financování cestou IPO** pro VO MZČR. Do roku 2024 trval kontinuální meziroční nárůst v rozpočtové kapitole Rozvoj výzkumných organizací (IPO pro MZČR). MZČR bude usilovat o kompenzaci meziročního propadu z tohoto roku v rámci rozpočtu na rok 2026 a historický aplikovaný 3% meziroční nárůst, a to i v rámci střednědobého výhledu SR.
- MZČR bude i nadále implementovat Program skrze **AZV ČR** a **spolupracovat s dalšími poskytovateli na vymezení účelové podpory pro oblast zdravotnického výzkumu v ČR**. Současně budou diskutovány mechanismy pro účinné využívání výsledků z projektů podpořených AZV ČR v navazujících projektech TAČR směřujících k dotažení výsledků aplikovaného výzkumu do praktických aplikací a jejich uplatnění v praxi.
- MZČR bude usilovat o zajištění udržitelnosti současného míry účelové podpory, tj. podpory přibližně každého pátého projektového návrhu podaného do věřejné soutěže. Aby toto bylo umožněno je třeba **navýšit celkovou míry účelové podpory** na Programy ze SR z důvodu (i) kontinuálně narůstajícího zájmu o „juniorský“ Podprogram 2, na který byla historicky alokováno 10% rozpočtu Programu, aniž by došlo k jeho adekvátnímu navýšení ze strany SR, (ii) z důvodů přechodu z projektů trvajících 44 měsíců (začátek vždy v květnu prvního roku řešení) na 48 měsíců dlouhé projekty (začátek financování již od ledna), což je plánováno již v rámci soutěže VES2026.
- MZČR bude dále usilovat o zajištění financování na realizace vládou schváleného **Podprogramu 4: Podpora národních autorit v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu**, na jehož realizaci ve svém návrhu rozpočtu RVVI schválila 150 mil. Kč na rok 2026.
- I přes podfinancovanost zdravotnického výzkumu v ČR, a to a jak ve srovnání s jinými státy EU, tak jinými segmenty VaVaI v ČR (Příloha 9) dosahuje zdravotnický výzkum v ČR nadprůměrných výsledků při mezinárodním srovnání. MZČR bude proto i v roce 2025/2026 usilovat o **navyšování podílu rozpočtu VaVaI určeného na podporu zdravotnického výzkumu v ČR** s cílem dosáhnout navýšení ze současných 12 % na 20 % v roce 2030 v souladu s Koncepcí výzkumu.

Kapitola XII. Komunikace

Dostupnost informací pro občany, posílení zdravotní gramotnosti

https://nzip.cz/koncepce2025#komunikace

Aktualizovaná verze kapitoly se opírá zejména o výstupy nově připravené a zveřejněné resortní Koncepce sdílení a zpřístupňování dat, která nad daty Národního zdravotnického informačního systému otevřela zcela nový režim zpřístupňování dat a informací. V datovém zpravodajství Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP.CZ) je publikováno více než 300 otevřených datových sad, datových souhrnů a interaktivních portálů. Byla pilotována a úspěšně implementována technologie vzdálených analýz na bázi syntetických dat. Bylo dokončena meziresortní integrace dat MPSV a MZD, a to již i na bázi připravené a schválené legislativy. Všechny zmíněné výstupy, a rovněž výsledky mnoha dalších níže popsaných vývojových kroků, jsou plně dostupné na ústředním portálu www.nzip.cz.

Aktualizace textu k 1. 8. 2025

Původní analýza stavu a aktualizovaná východiska koncepce

Komunikace informací, vysvětlování reforem a edukace k zdravému životnímu stylu jsou a musí být každodenní náplní činnosti všech institucí odpovědných za organizaci a rozvoj zdravotních služeb. Zejména informacemi podložená propagace prevence vážných onemocnění a vysvětlování podstaty a přínosu běžících programů včasného záchytu vážných onemocnění jsou z tohoto hlediska zcela zásadní. V digitální éře, kde jsou v nejrůznějších médiích volně dostupná nekonečná kvanta zdravotnických informací, je pro laika často nemožné se orientovat, informace třídit a identifikovat zdroje nevalidní, zkreslené nebo dokonce dezinformační. Proto je dnes již dlouhodobou strategií resortu vývoj vlastních komunikačních platforem, včetně webových portálů nesoucích značku ministerstva zdravotnictví a publikujících výhradně ověřené a odborně garantované informace pro všechny cílové skupiny pacientů a občanů obecně.

Komunikace zaměřená na odbornou veřejnost je v strategii resortu rozvíjena samostatně a pokrývá dvě zásadní modality. Strategie musí umožnit svobodnou a kritickou výměnu informací a připravovaných či prováděných reforem na nekomerčních a otevřených odborných konferencích, které musí být provázeny odpovídající publikační aktivitou. Druhým, a v poslední době velmi aktuálním, směrem je otevírání a sdílení zdravotnických dat k sekundárnímu využití pro manažerské i vědecko-výzkumné účely. V obou těchto oblastech zpracoval resort

zdravotnictví zcela novou koncepci, která mimo jiné systém připravuje na nové legislativní zázemí v oblasti správy veřejných dat, včetně evropského nařízení týkajícího se sdílení dat (EHDS[9]).

Nově připravená Koncepce sdílení a zpřístupňování dat[10] (dále jen „Koncepce“) usiluje o pokrytí všech těchto strategických oblastí prostřednictvím datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který je páteřním systémem centralizace zdravotnických dat v ČR. Koncepce popisuje klíčové postupy a nástroje, které jsou nezbytné pro budování dlouhodobě udržitelného systému sdílení, zveřejňování a sekundárního využívání dat NZIS. Základem je vize, která vymezuje reálně dosažitelný plán pro období 2024 až 2026 a následnou udržitelnost procesů souvisejících s přípravou, sdílením a užíváním dat všech komponent a dílčích registrů NZIS. Zpřístupňování zdravotnických dat má svá významná specifika, včetně právních a etických aspektů. Z těchto důvodů Koncepce nedefinuje pouze technické aspekty samotné přípravy dat, ale určuje i odpovědné institucionální zajištění a legislativní zázemí dané agendy, postupy schvalování a odborné oponentury. Jde o obecný dokument, který se orientuje na velmi široké spektrum cílových skupin, potenciálně zainteresovaných v sekundárním využití zdravotnických dat (komerční a akademická sféra, vědecko-výzkumné infrastruktury, média, pracovní skupiny veřejných orgánů, krajské samosprávy, odborná i laická veřejnost a další).

Cílem Koncepce je ustavit metodický základ pro bezpečné a trvale udržitelné sdílení a sekundární využívání dat NZIS. Koncepce definuje legislativně podložené režimy a formy zpřístupňování datových zdrojů NZIS a popisuje procesy, kterými jsou tyto agendy kontrolovány a řízeny Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) jako správcem NZIS. Primárním cílem je maximální možné zpřístupnění všech komponent NZIS odborné i laické veřejnosti a bezbariérový přístup k co nejširšímu sekundárnímu využívání dat pro statistické a výzkumné účely.

Koncepce pracuje s různými formami zveřejňování dat NZIS, přičemž zásadně rozlišuje datové zdroje dle zákona veřejné, které lze publikovat v plně otevřeném formátu bez úprav, a datové zdroje v primární podobně neveřejné, které je nutné před publikací upravit, případně je lze sdílet dálkovým přístupem pouze pro zákonem určené instituce (čtenáře). Úpravou dat se rozumí zejména různé formy agregace chránící osobní data subjektů údajů nebo publikace syntetických dat, či již zpracovaných statistických ukazatelů. Koncepce dále popisuje i formy sdílení a plánovaného zpřístupňování, které jsou ve zdravotnictví neméně významné a žádoucí. Jde například o přímé zpřístupnění dat zákonem určeným institucím za účelem řízení zdravotní péče, publikace zásadních statistických ukazatelů ve formátu resortních referenčních statistik opatřených detailním popisem a referenční interpretací apod.

[9] Evropský prostor pro zdravotní data (https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_cs)

[10] Dušek L., Komenda M., et al. Koncepce sdílení a sekundárního vytěžování dat Národního zdravotnického informačního systému. *Národní zdravotnický informační portál* [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2025 [cit. 2025-08-25]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/2375-koncepce-sdileni-a-sekundarniho-vytezovani-dat-nzis. ISSN 2695-0340.

Koncepce rovněž definuje rozhodovací a kontrolní procesy, kterým jakékoli zpřístupňování dat NZIS musí podléhat. Důvodem je zejména značná různorodost komponent NZIS, v jejímž důsledku není možné konkrétní formy uvolňování dat paušálně a trvale přiřadit jednotlivým datovým zdrojům. Řešení konkrétních zadání tak vždy bude do značné míry původní a bude vyžadovat jistou formu originální přípravy a předzpracování dat. Hlavním klíčem, který rozhoduje o zvoleném postupu, obsahu a formě publikace dat, je nezbytná ochrana osobních údajů bránící přímé i nepřímé identifikaci pacientů a zdravotnických pracovníků.

Připravená Koncepce ustavuje Radu Národního zdravotnického informačního systému jako zásadní odborné těleso kultivující pravidla a procesy uvolňování dat NZIS. Vzhledem k resortnímu rozsahu a meziresortnímu přesahu činnosti Radu jmenuje ministr zdravotnictví jako zásadní poradní orgán pro oblast uvolňování a sekundárního zpracování dat NZIS. Rada NZIS představuje odborné těleso pro strategické metodické vedení a dlouhodobou optimalizaci využívání dat NZIS. Ve své činnosti bude navazovat na již dlouhodobě ustavené a funkční úrovně kontroly obsahu a režimů využívání dat NZIS. Jde zejména o odborné rady garantů jednotlivých agend a registrů NZIS[11], které jsou sestaveny z předních odborníků pro daný registr relevantních odborných společností. ÚZIS ČR jako správce NZIS rovněž ustavil interní organizační strukturu a systém řízení správy dat NZIS tak, aby zajistil všechny v Koncepci stanovené kompetence. Jde zejména o Komunikační a datové centrum NZIS, které je pro realizaci Koncepce hlavním koordinačním týmem.

Dlouhodobě funkční, a pro realizaci Koncepce rovněž podstatná, je resortní Rada Národního zdravotnického informačního portálu[12], který Koncepce ustanovuje hlavní publikační platformou pro datové zpravodajství NZIS.

Metodika sdílení a sekundárního zpracování dat NZIS musí respektovat fakt, že ne všechny režimy zpracování a publikace dat mohou být paušálně aplikovány na všechny komponenty NZIS. Formy zveřejnění dat a informací musí být v souladu s platnou legislativou (zejména se zákonem o zdravotních službách). Z tohoto pohledu je zcela zásadní kategorizace jednotlivých komponent NZIS, která je dána zejména zákonným účelem a citlivostí primárně sbíraných dat. Oba zmíněné faktory nejvíce určují možný režim sdílení a zveřejňování dat a informací z NZIS.

I. Zdroje dat otevřené v režimu otevřených dat bez úprav.

- Tato kategorie sdružuje komponenty NZIS s veřejně dostupnými primárními daty. Přímé otevření primárních dat je jediným režimem, který předpokládá plné otevření dat bez úprav, pro vzdálené strojové zpracování bez omezení. Režim přímého otevření primárního obsahu databází v podobě vyhovující ustanovení z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů (§ 3a odst. 5) musí být pro daný informační systém či zdroj dat explicitně povolen a určen zákonem. Vzhledem k citlivosti zdravotních dat jde spíše o výjimečný režim publikování, při kterém jsou zveřejňovány primární řádkové záznamy databází bez jakýchkoli předběžných úprav, anonymizace apod. Tento režim je principiálně vhodný zejména pro charakteristiky „neživých objektů“, které nemají vazbu k osobním údajům, např. charakteristiky poskytovatelů dle výčtu v zákoně o zdravotních

[1111] https://www.nzip.cz/agendy-a-datove-zdroje-nzis
[12] https://www.nzip.cz/kdo-jsme#rada

službách, přístroje či zdravotní prostředky/léky a pro jejich charakteristiky typu dostupnost, indikace či kvantita využívání.

II. Zdroje pro zpřístupnění dat dálkovým přístupem zákonem určenému čtenáři (instituci).

- Jde o režim nastavení přístupu k definovaným datům pro zákonem určené čtenáře a v zákonem určeném rozsahu. Jedná se o institucionální přístupy, kdy správce (poskytovatel dat) a přistupující instituce (uživatel dat) definují datová rozhraní, technické aspekty a zabezpečení přístupu a také nastavení časových režimů. Je-li zpřístupnění pro konkrétní instituci jasně dáno zákonem, není nutné vlastní realizaci podmiňovat vzájemnou smlouvou, nicméně detailní metodická dokumentace je pro implementaci nezbytná.
- Tento režim podporuje zejména institucionální sdílení primárních dat nezbytných pro samotné poskytování a řízení zdravotních služeb a pro rozvoj elektronického zdravotnictví. Jde o vysoce citlivé komponenty NZIS pracující s osobními daty pacientů sbíranými za účelem řízení péče. Příkladem mohou být např. registr osob odmítajících posmrtný odběr orgánů či registr osob vyloučených z dárcovství krve, které jsou zřízeny a využívány pro rozhodování o péči zákonem určenými subjekty. Další oblastí, která zvyšuje význam plánovaných a přímých přístupů k datům pro určené čtenáře, je rozvíjející se segment vzdáleného monitoringu pacientů a telemedicíny.
- Režim nastavení přístupu k definovaným primárním datům je vymezen pouze pro zákonem o zdravotních službách určené čtenáře a v zákonem určeném rozsahu. Data podléhající tomuto režimu jsou neveřejná, čímž ovšem není vyloučeno jejich statistické zpracování. Sumární a obecné statistiky (např. kolik osob odmítá posmrtný odběr orgánů, kolik osob a poskytovatelů využívá jaké telemedicínské nástroje apod.) mohou být i v tomto režimu zpracovávány a zveřejňovány.
- Za dálkový přístup k primárním datům lze považovat i přístup do vznikajících Kmenových registrů dle zákona 325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictví. Dle tohoto zákona mají oprávněné osoby, kde hlavním skupinou jsou poskytovatelé zdravotní péče, přístup do Kmenového registru pacientů k ověření svého pacientského kmenu a do Kmenového registru zdravotnických pracovníků k ověření dosažené odbornosti zaměstnávaných osob. Kmenový registr zdravotnických pracovníků přejímá data z Národního registru zdravotnických pracovníků, který je součástí NZIS. Kmenový registr pacientů je zase propojen s Registrem obyvatel (ROB) a zprostředkovává tak přístup poskytovatelů k informačnímu systému základních registrů. Do kmenových registrů má přístup taktéž samotný subjekt údajů, tedy pacient, resp. zdravotnický pracovník, k záznamu o něm vedeném.

III. Zdroje dle zákona neveřejných dat, zpřístupňovaných po nezbytných úpravách.

- Tato kategorie komponent NZIS neumožňuje přímé publikování primárních dat v otevřeném formátu. Sdílení a zveřejňování těchto dat lze realizovat následujícími režimy:

A. Zpřístupnění dat po nezbytných úpravách a agregacích.

- Jde o nejběžnější formu zveřejňování dat NZIS. Příkladem úprav mohou být různé formy kódování chybějících hodnot, korekce chybných záznamů, agregace záznamů přes věkové kategorie pacientů, dopočet standardizujících proměnných apod. Datové sady a souhrny jsou publikovány včetně popisu parametrů pro definované cílové subjekty či kohorty subjektů, metadat a pravidel pro následné aktualizace. Forma zveřejnění musí vylučovat jakoukoli přímou či nepřímou identifikaci fyzické osoby. Podmínkou zveřejnění

je dodržení standardizované metodiky při tvorbě datových sad, odborná oponentura či schválení týkající se obsahových, legislativních a technických aspektů.

- Spektrum výsledných forem takto upravených dat je relativně široké. Nejčastějším **v**ýstupem úprav jsou ke zveřejnění připravené, plně anonymizované datové sady nebo agregované datové souhrny, které mohou být dle potřeby doplněny statistickými komentovanými souhrny či zprávami (publikace, ročenky). Výstupy mohou zahrnovat i robustní statistické zpracování ve formátu již vyčíslených statistik a ukazatelů, které obvykle vyžadují referenční interpretaci. Typickým příkladem jsou data určená pro zpracování s cílem ovlivnit chování cílových subjektů, např. data o kvalitě péče, nežádoucích účincích či účinnosti terapie apod.
- Publikaci statistik charakterizujících skupinu (kohortu) subjektů/objektů (region či časová perioda, kohorta pacientů, skupina zdravotních výkonů, kategorie poskytovatelů apod.) lze v tomto módu vnímat jako metodicky komentovanou publikaci informací a znalostí. Uživatel získá přehledové statistiky, metodiky a postupy výpočtu. Zvláštním formátem jsou referenční resortní statistiky, jejichž seznam je schvalován v prováděcím předpise (vyhláška dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů) Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR). Tyto statistiky musí být povinně vybaveny referenční interpretací a mohou být publikovány s určením konkrétního poskytovatele či zdravotní pojišťovny. Pro zveřejnění v tomto režimu jsou prioritně vybírána data a ukazatele s vysokým rizikem chybné interpretace, která by mohla vést k nevratným a chybným rozhodnutím na straně pacientů, poskytovatelů či regulátorů. Jako příklad lze uvést nemocniční mortalitu jako údaj vyžadující sofistikované analytické zpracování a interpretaci. Publikace již zpracovaných dat ve formě referenčních statistik však nijak nebrání jejich doplnění zdrojovými daty v otevřeném formátu.

B. Zveřejnění struktury a obsahu databází formou syntetických dat.

- Tento režim umožňuje uživatelům komplexní seznámení se strukturou dat a s jejich informačním potenciálem. Na základě studia syntetických dat je možné připravit nejen vlastní návrhy statistických výstupů, ale také návrhy nových agregovaných datových sad či datových souhrnů. Skripty a algoritmické postupy připravené na bázi syntetických dat následně správce realizuje nad původními daty daných komponent NZIS a výstupy předává uživateli, vždy po nezbytné kontrole zaměřené na ochranu osobních dat. Poskytování těchto výstupů může mít různou podobu, od přípravy ad hoc připravených datových sad až po režim zpracování předpřipravených dat na místě u správce (režim vědecko-výzkumné spolupráce).

Pro jakýkoli výše uvedený režim uvolňování dat NZIS je striktně vyžadována regulace zákonem, včetně stanoveného oprávněného rozsahu sbíraných a hodnocených dat. Publikovaná data musí vždy odpovídat zákonem danému účelu NZIS. Obecně platí, že údaje obsažené v NZIS jsou neveřejné, pokud zákon nestanoví jinak (zákon o zdravotních službách). Všechny výstupy zpracování dat NZIS jsou typicky autorským dílem, které by mělo projít plnohodnotnou oponenturou (připomínkovým řízením) a mělo by nést jasné vymezení licenčních pravidel pro korektní citaci v odborných publikacích a jiných výstupech.

Národní zdravotnický informační systém (NZIS)

Zajištění udržitelnosti a dalšího rozvoje NZIS je principiálním úkolem a cílem datové a komunikační strategie resortu. NZIS je jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovávány údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších osob předávajících údaje do NZIS. Postup a podmínky správy a přístup k těmto údajům jsou komplexně upraveny v § 70–78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů. V navržené koncepci hodnocení hrají zásadní roli zejména následující klíčové komponenty (registry, statistická šetření) NZIS:

- **Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)** zajišťuje hodnocení vybavenosti, výkonnosti a výsledků poskytovatelů, včetně systému self-benchmarkingu. Parametry NRPZS jsou stanoveny v § 74 odst. 1 a 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. NRPZS je, obecně vzato, registrem veřejným s tím, že zákon explicitně (§ 74 odst. 3 písm. a) stanoví části, které zveřejnit nelze a z uvedeného důvodu se neobjevují v jeho veřejné části. Jsou jimi parametry chránící osobní údaje fyzických osob či respektující neveřejný charakter správního řízení v případě stejnopisů dokumentů vydaných v jeho rámci či údaje týkající se konkrétní obsazenosti lůžek u poskytovatelů. Dále zákon v následujících písmenech téhož paragrafu stanoví explicitně okruh osob oprávněných k přístupu k úplnému obsahu NRPZS. Zpravodajské jednotky NRPZS jsou pak uvedeny v § 75, stejně tak i lhůta pro předávání údajů, která je lhůtou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku údaje nebo o jeho změně zpravodajská jednotka dozví.
- **Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP)** zajišťuje zejména reprezentativní hodnocení personálních kapacit dostupnosti zdravotních služeb. Parametry NRZP jsou stanoveny v § 76 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. NRZP je registrem neveřejným, zákon explicitně uvádí ve svém § 75 odst. 2 okruh osob, které jsou oprávněny k přístupu. Zpravodajské jednotky jsou pak stanoveny § 77, stejně tak i lhůta pro předávání údajů, která je lhůtou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku údaje nebo o jeho změně zpravodajská jednotka dozví.
- **Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS)** umožňuje hodnocení obsahu poskytované péče dle administrativních výkazů v rámci veřejného zdravotního pojištění. Jde o systém mapující komplexní trajektorii pacientů v systému zdravotních služeb s potenciálem hodnotit místní i časovou dostupnost, včetně dodržení klinických doporučených postupů. Parametry NRHZS jsou stanoveny v § 77a odst. 1 až 4 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. NRHZS je registrem neveřejným, zákon explicitně uvádí ve svém § 77a odst. 5 pouze zdravotní pojišťovny, které jsou oprávněny k přístupu. Zpravodajské jednotky jsou pak stanoveny § 77a odst. 2 a 4. Jsou jimi zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb v případě laboratorních výsledků. Lhůta pro předávání údajů je stanovena v prováděcí vyhlášce č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů.
- **Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP).** Právní úprava obsahu NRHOSP je upravena v příloze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, údaje vztahující se k hospitalizaci, o přijetí, diagnostické údaje o průběhu a léčbě nemoci (operace, komplikace, nákazy apod.), osobní anamnéza, stav pacienta při propuštění a potřeba dalších zdravotních služeb, údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele poskytujícího lůžkovou péči.
- **Klasifikační systém CZ-DRG a jeho referenční databáze.** Hodnocení zátěže, výkonnosti, výsledků a reálných nákladů akutní lůžkové péče se v ČR opírá o legislativně ukotvený a plně udržitelný systém

DRG. Systém CZ-DRG je vyvíjen a spravován na základě pověření Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) dle § 41a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velkým přínosem v této oblasti je dlouhodobě funkční referenční síť nemocnic, které každoročně generují referenční databázi všech hospitalizačních případů s vysokým rozlišením obsahu péče a nákladových položek.

- **List o prohlídce zemřelého (LPZ)** je základním zdrojem informací o úmrtí. Bezodkladně po prohlídce zemřelého jej vyplňuje prohlížející lékař, který kromě základních sociodemografických charakteristik zaznamenává také posloupnost příčin vedoucích ke smrti (od roku 1994 kódováno pomocí MKN-10).
- **Statistické výkazy a výběrová průřezová šetření.** Jde o významný nástroj využitelný pro hodnocení zpětné vazby pacientů či jejich blízkých v hodnocení zdravotních služeb a poskytovatelů. Velmi významný datový zdroj pokrývající administrativně obtížně dosažitelné hodnocení kvality života pacientů, spokojenosti s poskytovanými službami či s jejich dostupností. Mezi nejvýznamnější formy šetření patří mezinárodně standardizované průzkumy jako například evropská výběrová šetření o zdraví:
    - **Šetření EHIS** (European Health Interview Survey). Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS) je důležitou součástí zdravotnické statistiky v mezinárodním měřítku. Realizace tohoto šetření je pro země EU povinná, a to dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První vlna šetření EHIS byla realizována dle jednotné metodiky na dobrovolné bázi v letech 2006–2009 a druhá vlna šetření EHIS v rozmezí let 2013–2015 ve všech zemích EU28. Třetí vlna šetření byla realizována v roce 2019. Metodicky je realizace výběrových šetření koordinována v rámci Technické skupiny TG HIS při Eurostatu, složené ze zástupců členských zemí.
    - **Šetření EHES** (European Health Examination Survey). Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace s lékařským vyšetřením je zaměřeno především na srdečně-cévní onemocnění; sledování vybraných ukazatelů patří mezi indikátory navržené WHO pro splnění cíle snížit předčasnou intenzitu úmrtnosti na chronická onemocnění vhodnými preventivními aktivitami. Úkolem EHES je tak monitorovat situaci v populaci a poskytovat informace potřebné pro zlepšení zdravotního stavu, snížení nákladů na léčbu onemocnění a jejich komplikací a zvýšení produktivity populace v ekonomicky aktivním věku. Hlavním metodikem v provedení lékařských vyšetření s odběrem žilní krve je v rámci Evropy koordinační centrum pro realizaci EHES, Institut pro zdraví a sociální péči (THL) v Helsinkách. Pomáhá budovat síť EHES ve státech EU a usiluje o zajištění standardizovaného a vysoce kvalitního sběru dat prostřednictvím národních šetření s lékařským vyšetřením. Je realizováno v cca 15 zemích Evropy.
- **Zdravotní registry NZIS[13].** V rámci přípravy této Koncepce byl proveden audit obsahu stávajících zdravotnických registrů NZIS s cílem vytěžit informace a ukazatele reprezentativně popisující hlavní problémy zdravotního stavu obyvatel ČR. V generování různých forem datových souhrnů budou využita data zejména následujících zdravotních registrů:
    - Národní registr hospitalizovaných
    - Národní onkologický registr
    - Národní diabetologický registr
    - Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí
    - Národní registr úrazů
    - Národní registr intenzivní péče
    - Národní registr kloubních náhrad
    - Národní registr reprodukčního zdraví
    - Národní registr nemocí z povolání
    - Národní registr léčby uživatelů drog
    - Národní registr pitev a toxikologických vyšetření
    - Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve

[13] https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry

Národní zdravotnický informační portál (NZIP)

Ústřední a jednotnou resortní platformou pro zveřejňování dat NZIS bude Národní zdravotnický informační portál[14] (NZIP). NZIP si klade za dlouhodobý cíl zajištění srozumitelné komunikace mezi jednotlivými aktéry péče o zdraví, občany – pacienty, zástupci veřejné správy a odbornými společnostmi: (i) veřejná správa prostřednictvím NZIP sděluje veřejnosti potřebné informace z českého zdravotnictví, (ii) veřejnost prostřednictvím NZIP poskytuje zpětnou vazbu, která témata nejsou dostatečně informačně pokryta, a to včetně hodnocení kvality již publikovaného obsahu v podobě článků a externích zdrojů. Nedílnou součástí NZIP je také interaktivní mapa zdravotní péče, kde lze vyhledat nejbližšího poskytovatele a usnadnit tak propojení potenciálních pacientů se zdravotními problémy s jejich lékařem/specialistou.

NZIP byl spuštěn 23. července 2020, kdy se konala tisková konference ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. K srpnu 2025 bylo na portálu 1 770 popisných článků, 366 externích doporučených zdrojů, 36 naučných her, 7 443 rejstříkových pojmů a 40 279 odborníků a zdravotnických zařízení. Obsah NZIP je rozdělen na základní sekce o životních situacích, prevenci a zdravém životním stylu, informacích o nemocech.

Hlavními garanty obsahu jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Projekt NZIP a jeho řešitelský tým (management, vývojový tým, autorský tým, tým garantů, tým recenzentů, analytický tým, datový tým, finanční management, tým pro marketing a propagaci) jsou financovány z:

- Projekt NZIP I (2021–2023): Operační program Zaměstnanost (prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa, investiční priorita 4.1: Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy).
- Projekt NZIP II (2023–2026): Operační program Zaměstnanost plus, investiční priorita 2.2 Sociální začleňování.

Dlouhodobým záměrem je NZIP zařadit mezi klíčové a nosné priority MZ ČR, které budou mít manažerskou i finanční podporu veřejné správy po skončení výše uvedených projektů.

V rámci sjednocování publikovaných informací z oblasti datového zpravodajství NZIS je aktuálně (srpen 2025) připravena zcela nová sekce na NZIP[15], kde jsou průběžně zveřejňovány a odkazovány nosné zprávy, statistické souhrny, analytické reporty a aktuality. Nedílnou součástí jsou otevřené datové sady z konkrétních registrů NZIS, které jsou kontinuálně publikovány v Katalogu zdravotnických dat[16]. Dále jsou dle aktuální potřeby zveřejňovány datové sady obsahující administrativní data MZ ČR a především data z vybraných centrálních registrů NZIS. Přehled dostupných výstupů nad daty NZIS, které jsou zveřejněny v katalogu, je uveden níže:

[14] Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2025 [cit. 25. 8. 2025]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
[15] https://www.nzip.cz/data-nzis
[16] https://www.nzip.cz/modul/datove-zpravodajstvi/katalog-dat

- Otevřená data (typicky formát CSV), 142 výstupů
- Datové souhrny (typicky formát XLSX), 146 výstupů
- Ročenky, publikace, analytické studie (typicky formát PDF), 26 výstupů
- Interaktivní vizualizace a infografiky, 49 výstupů
- Analytické webové portály, 8 výstupů

Kromě statické publikace vybraných výstupů určených pro širokou i odbornou veřejnost jsou vyvíjeny interaktivní webové portály pro dedikovaná a ucelená témata (např. psychiatrie[17], screeningy[18]). Pro vhodné výstupy jsou navrženy a implementovány dynamické vizualizace v podobě infografik přímo jako součást obsahu NZIP, která srozumitelně a názorně ilustruje klíčové závěry nad dostupnými daty.

Role NZIP v Koncepci je zásadní, a to zejména v následujících oblastech:

1. NZIP představuje strukturované publikační médium, zahrnující jak sekce pro širokou veřejnost, tak obsahově komplementární odborné zpravodajství NZIS. Jde o portál, na kterém jsou a budou zveřejňovány všechny datové a statistické výstupy NZIS popsané v Koncepci – publikace na jedné platformě zásadně přispívá k přehlednosti a transparentnosti výstupů.
2. NZIP slouží jako vstupní brána k podávání podnětů a žádostí na výstupy NZIS, včetně autorských návrhů nových datových sad či souhrnů (případně návrhů na modifikaci již publikovaných výstupů).
3. NZIP provazuje publikované datové a statistické výstupy s dalšími klíčovými, daty podmíněnými, agendami, jako jsou publikované klinické doporučené postupy, indikátory kvality péče, hodnocení preventivních programů apod.
4. Obsah NZIP je základnou pro zpětné hodnocení dopadu již publikovaných výstupů, ať již metrikami citovanosti, návštěvnosti či stahování, nebo sledováním následných využití a interpretací.
5. NZIP je rozcestníkem pro prezentaci a komunikaci relevantních kampaňových nebo úzce zaměřených témat napříč zdravotním systémem v ČR.
6. Kontrola návštěvnosti, vyhledávání témat a zájmu odborných i laických uživatelů NZIP usnadňuje predikce potřeb pro výstupy NZIS a umožňuje efektivní zacílení budoucích výstupů.

Sběr, zpřístupňování a sdílení zdravotnických dat ovšem není možné koncepčně rozvíjet bez pevné vazby na systém poskytování zdravotních služeb, tedy bez ukotvení ve zdravotnictví samotném. Tento fakt je tak zřejmý, že bývá paradoxně často přehlížen. Pokud nebude zajištěn plně standardizovaný a administrativně nenáročný sběr samotných primárních dat v klinické praxi, budou kvalitní centralizovaná data existovat jen v omezené míře, což může komplikovat jejich další využitelnost. Proto se Koncepce věnuje i aspektům souvisejícím se standardizací sběru dat, interoperabilitě klinických informačních systémů a elektronizaci zdravotnictví. Zajištění potřebných vstupních zdrojů v podobě robustní IT infrastruktury a personálních

[17] https://psychiatrie.uzis.cz/
[18] https://nsc.uzis.cz/data/

kapacit pro sběr a management dat je zásadní podmínkou systematického a dlouhodobě udržitelného rozvoje zpřístupňování zdravotnických dat.

Systém syntetických dat NZIS

Jedním z klíčových nástrojů pro zajištění bezpečného, spravedlivého a odborně relevantního sdílení zdravotnických dat je inovativní systém syntetických dat NZIS[19], který vyvíjený a provozovaný ÚZIS ČR, a tvoří nedílnou součást Koncepce. Tento systém je strategickou komponentou datové infrastruktury resortu a tvoří jeden ze základních pilířů připravenosti ČR na implementaci Evropského prostoru pro zdravotní data (EHDS). Syntetická data představují uměle generovanou datovou sadu, která je odvozena ze struktur reálných dat NZIS, avšak neobsahuje žádné skutečné záznamy. Tato metoda zajišťuje vysokou míru ochrany soukromí a zároveň umožňuje expertní komunitě simulovat a připravovat analytické postupy nad uměle vytvořenou databází bez nutnosti přímého přístupu k citlivým údajům.

Tento systém umožňuje odborné komunitě navrhovat SQL skripty, které jsou následně – po splnění metodických, technických a bezpečnostních požadavků – zpracovány ÚZIS ČR nad primárními daty NZIS. Výstupem jsou agregované a plně anonymizované datové výstupy, které zaručují naprostou ochranu osobních údajů a minimalizují riziko identifikace jednotlivce. Zmíněný přístup přináší následující strategické výhody:

- Bezpečné sdílení zdravotnických dat v souladu s právními předpisy ČR a EU a zcela v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů.
- Otevřený a transparentní přístup k odborné veřejnosti prostřednictvím NZIP s jasně definovanými pravidly přístupu a zpracování.
- Spravedlivé a jednotné řízení požadavků, kde každý žadatel má rovné podmínky a transparentní informace o stavu své žádosti.
- Budování datové komunity a znalostního ekosystému prostřednictvím pravidelných odborných setkání, konzultací a sdílení osvědčených postupů mezi ÚZIS ČR a akademickým, výzkumným a analytickým sektorem.

Systém syntetických dat NZIS tak již dnes naplňuje vybrané principy EHDS – především koncept sekundárního využití zdravotních dat v bezpečném, spravedlivém a transparentním prostředí. Jeho další rozvoj představuje zásadní předpoklad pro integraci ČR do evropských datových infrastruktur a posilování postavení českého zdravotnictví v oblasti datové vědy a výzkumu. Aby byla zajištěna vyváženost mezi otevřeností a ochranou dat, byly stanoveny následující tři úrovně zveřejňování výstupů:

Úroveň 1 – Přehledová informace o žádosti

- Zveřejňuje se základní informace o schválené žádosti.
- Součástí je rozlišení, zda je žadatelem fyzická nebo právnická osoba.
- Tato úroveň podporuje transparentnost a přehled o tom, jakým způsobem jsou syntetická data využívána.

[19] https://www.nzip.cz/clanek/2230-synteticka-data-nzis

Úroveň 2 – Datové výstupy

- Datové výstupy jsou zveřejňovány vždy s odstupem 6 měsíců od jejich poskytnutí žadateli.
- Publikace probíhá v souladu s metodickým popisem v Katalogu zdravotnických dat a s ohledem na ochranu osobních údajů.
- Tento přístup zajišťuje, že výsledky zpracování dat jsou dostupné širší odborné komunitě a mohou být dále využívány.

Úroveň 3 – SQL skript

- Volitelná možnost zveřejnění SQL skriptu, kterou si volí samotný žadatel.
- Při explicitním souhlasu žadatele může být SQL skript publikován v odborném periodiku NZIS Open Journal[20], a to po 6 měsících od předání dat žadateli.
- Součástí publikace je rozšířený abstrakt a vazba na příslušný datový výstup v Katalogu zdravotnických dat.

Systém byl oficiálně spuštěn v květnu 2025 a aktuálně (srpen 2025) bylo žadateli podáno 29 žádostí a z toho 21 vypořádáno předáním dat.

Realizované kroky a cíle koncepce do roku 2025

Základní pilíře nové informační a komunikační strategie resortu jsou následující:

1. **Rozvoj a zajištění udržitelnosti Národního zdravotnického informačního systému**
    a. Ustavení Komunikačního a datového centra NZIS společně s odbornou meziresortní Radou, ve které budou zastoupeni experti úzce spolupracujících resort, zejména MPSV a MV ČR (DIA).
        i. Splněno v únoru 2025
    b. Jmenování pozice resortního koordinátora pro sdílení a sekundární využívání zdravotnických dat.
        i. Splněno v květnu 2025
    c. Zajištění rozvoje a vzájemné interoperability dílčích komponent NZIS s následujícími prioritními úkoly:
        i. Funkční datové a IT zázemí pro hodnocení dostupnosti, výkonnosti a nákladovosti akutní lůžkové péče, zabudování infrastruktury systému CZ-DRG.
        ii. Příprava pro referenční hodnocení dostupnosti, výkonnosti a nákladovosti segmentů následné a dlouhodobé lůžkové péče a dále klíčových segmentů komunitní ošetřovatelské péče (odbornosti 913, 925, 926).

[20] NZIS Open Journal. *Národní zdravotnický informační portál* [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2025. Dostupné z: https://www.nzip.cz/journal. ISSN 2695-0340.

iii. Dokončení vývoje informačního systému pro mapování a predikce personálních kapacit v lůžkové i nelůžkové péči.
iv. Dokončení vývoje portálu zdravotnických ukazatelů jako základního nástroje pro podporu zdravotních politik jednotlivých krajů.

2. **Rozvoj Národního zdravotnického informačního portálu[21] (NZIP) jako elektronického publikačního média posilujícího zdravotnickou informovanost a gramotnost včetně nástroje pro otevírání a sdílení zdravotnických dat pro odbornou veřejnost**
    a. Budování NZIP započalo v letech 2018/2019 a současná strategie MZ ČR usiluje o jeho trvalou udržitelnost a rozvoj – pro tento účel byly získány i prostředky z projektů EU.
    b. NZIP je plošnou komunikační platformou, která má za cíl posilovat zdravotní gramotnost občanů a přinášet ověřené informace z oblasti veřejného zdraví.
    c. NZIP je nově rozvíjen o odborně orientované sekce.

3. **Nová koncepce sdílení a sekundárního využívání zdravotnických dat**
    a. Byla dopracována zcela nová koncepce sdílení a sekundárního využívání dat NZIS – po recenzních řízeních byla publikována v květnu 2025.
    b. Touto koncepcí se resort připravil i na přicházející evropskou standardizaci v dané oblasti, včetně EHDS.

4. **Implementace syntetických dat NZIS pro pokročilé analytické výstupy**
    a. Publikace plnohodnotné dokumentace k syntetickým datům NZIS zahrnující informační a metodické materiály.
        i. Splněno v květnu 2025
    b. Příprava a zveřejnění kompletního procesního schématu pro zpracování a evidenci žádostí o syntetická data NZIS včetně jejich publikace na NZIP.
        i. Splněno v květnu 2025
5. **Ustavení platformy (dílem nových) konferencí resortu, zaměřených na laickou i odbornou veřejnost**
    a. Resort nově ustavil 7 národních konferencí, které pokrývají všechna klíčová témata strategie rozvoje zdravotnictví.
    b. Cílem je vybudovat tradici každoročně opakovaných národních konferencí jako zdroje ověřených a garantovaných informací.
    c. Zásadní je, že jde o platformu nekomerční, v maximální možné míře založenou na podpoře získanými granty.

[21] www.nzip.cz

Další cíle strategie do roku 2025

1) Každoroční realizace ustavených resortních konferencí pro laickou a odbornou veřejnost
2) Zavedené a pravidelně aktualizované vydávání vyhlášek o resortních referenčních statistikách a publikace těchto statistik včetně klíčových ukazatelů dostupnosti a kvality péče
3) Implementována nová koncepce otevírání a sekundárního sdílení zdravotnických dat s garancí Rady Národního zdravotnického informačního systému pro meziresortní spolupráci v této oblasti
4) Implementován inovativní systém syntetických dat NZIS do praxe včetně podrobné dokumentace a online nástrojů pro zprocesování žádostí o data.
5) Dokončené prioritní úkoly dalšího rozvoje NZIS, zejména systému pro mapování a predikce personálních kapacit ve zdravotnictví a systémů pro hodnocení dostupnosti a výkonnosti všech segmentů zdravotní péče
6) Doplnění obsahu na NZIP tak, aby pokrýval všechny základní segmenty zdravotní péče a všechna témata významná pro veřejné zdraví
7) Nastavení systematického a efektivního procesu sdílení dat NZIS včetně posílení informačních a komunikačních kanálů směrem ke klíčovým cílovým skupinám.

Vybrané literární zdroje

https://nzip.cz/koncepce2025#literatura

Babaei N, Zamanzadeh V, Valizadeh L, Lotfi M, Kousha A, Samad-Soltani T, Avazeh M.: Virtual care in the health care system: A concept analysis. Scand J Caring Sci. 2023 Nov 27. doi: 10.1111/scs.13227. Online ahead of print.

Beard JR, Officer A, de Carvalho IA, Sadana R, Pot AM, Michel JP, Lloyd-Sherlock P, Epping-Jordan JE, Peeters GMEEG, Mahanani WR, Thiyagarajan JA, Chatterji S.: The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. Lancet. 2016 May 21;387(10033):2145-2154. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00516-4.

BMJ Glob Health. 2023 Jul;8(7):e012668. doi: 10.1136/bmjgh-2023-012668.

Braveman P, Starfield B, Geiger HJ.: World Health Report 2000: how it removes equity from the agenda for public health monitoring and policy. BMJ. 2001 Sep 22;323(7314):678-81. doi: 10.1136/bmj.323.7314.678.

Collins TE, Akselrod S, Atun R, Bennett S, Ogbuoji O, Hanson M, Dubois G, Shakarishvili A, Kalnina I, Requejo J, Mosneaga A, Watabe A, Berlina D, Allen LN.:

Converging global health agendas and universal health coverage: financing whole-of-government action through UHC. Lancet Glob Health. 2023 Dec;11(12):e1978-e1985. doi: 10.1016/S2214-109X(23)00489-8.

El Taguri A, Nasef A.: The French Health Care System; What can We Learn? Libyan J Med. 2008 Dec 1;3(4):186-91. doi: 10.4176/081009.

Fierlbeck K.: Health Care and the Fate of Social Europe. J Health Polit Policy Law. 2021 Feb 1;46(1):1-22. doi: 10.1215/03616878-8706579.

Goyal M.: Telemedicine and technology: A need for the health-care system. Ayu. 2021 Apr-Jun;42(2):67-68. doi: 10.4103/ayu.ayu_5_23. Epub 2023 Mar 16.

Hone T, Macinko J, Millett C.: Revisiting Alma-Ata: what is the role of primary health care in achieving the Sustainable Development Goals? Lancet. 2018 Oct 20;392(10156):1461-1472. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31829-4.

Kronick R. The promise and peril of health systems. Health Serv Res. 2020 Dec;55 Suppl 3(Suppl 3):1027-1030. doi: 10.1111/1475-6773.13595.

Mhazo AT, Maponga CC.: Retracing loss of momentum for primary health care: can renewed political interest in the context of COVID-19 be a turning point?

Reeve J, Byng R.: Realising the full potential of primary care: uniting the 'two faces' of generalism. Br J Gen Pract. 2017 Jul;67(660):292-293. doi: 10.3399/bjgp17X691589.

Rudnicka E, Napierała P, Podfigurna A, Męczekalski B, Smolarczyk R, Grymowicz M.: The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Maturitas. 2020 Sep;139:6-11. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.05.018. Epub 2020 May 26.

Savel RH, Munro CL.: The Health of Our Health Care System. Am J Crit Care. 2018 Jul;27(4):258-260. doi: 10.4037/ajcc2018521.

Signorelli C, Odone A, Oradini-Alacreu A, Pelissero G. Universal Health Coverage in Italy: lights and shades of the Italian National Health Service which celebrated its 40th anniversary. Health Policy. 2020 Jan;124(1):69-74.

Smarżewska D, Wereda WS, Jończyk JA. Assessment of the Health Care System in Poland and Other OECD Countries Using the Hellwig Method. Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 13;19(24):16733. doi: 10.3390/ijerph192416733.

Tennankore K, Jones J, Miller A, Adib A, Mathew S, Rasic D, Cookey J.: Transforming healthcare delivery: a descriptive study of a novel provider-to-provider virtual care platform. Front Public Health. 2023 Dec 8;11:1284566. doi: 10.3389/fpubh.2023.1284566. eCollection 2023. PMID: 38155888

The Lancet. Health-care system staffing: a universal shortfall. Lancet. 2018 Nov 24;392(10161):2238. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32973-8.

Van der Stuyft P, Unger JP. Improving the performance of health systems: the World Health Report as go-between for scientific evidence and ideological discourse. Trop Med Int Health. 2000 Oct;5(10):675-7.

Walter Ricciardi, Rosanna Tarricone: The evolution of the Italian National Health Service. Lancet 2021; 398: 2193–206

Ward ZJ, Atun R, King G, Sequeira Dmello B, Goldie SJ.: A simulation-based comparative effectiveness analysis of policies to improve global maternal health outcomes. Nat Med. 2023 May;29(5):1262-1272. doi: 10.1038/s41591-023-02311-w. Epub 2023 Apr 20.

Zarulli V, Sopina E, Toffolutti V, Lenart A.: Health care system efficiency and life expectancy: A 140-country study. PLoS One. 2021 Jul 9;16(7):e0253450. doi: 10.1371/journal.pone.0253450. eCollection 2021.